

Fluir Psicotrans. Una apuesta conversacional sobre los sistemas de vida vinculares de jóvenes con experiencia de vida trans en Manizales y Bogotá.

Mariana Velandia Nova

Trabajo de tesis

Área de Investigación Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente

Línea Dinámicas y representaciones de lo urbano

Tutor Thierry Lulle

Programa de Psicología

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad Externado de Colombia

Abril de 2023

Índice

Agradecimientos	4
Presentimientos	5
Introducción	9
Estructura capitular	16
Caleidoscopio de género: la gran fragmentación	20
Un desafío de optometría: Asignación de sexo por los genitales	26
¿Hay una meta para llegar a ser?	31
Sistemas de producción corporal: Asignación de sexo por las hormonas	44
Preguntas frecuentes	53
Mi derecho nominal: Asignación de sexo por nombre	55
Acróstico para ti	56
Naturaleza: Alta tecnología y otros visajes políticos	59
Bricolage del Determinismo Biológico VS Construccinismo	65
La artificialidad del sexo y el género	68
Las epistemes	71
Los mitos y rituales	73
Colores extraoficiales	80
Hackear el sistema: devenir queer	86
More Soul, teoría de la carne	91
Punto de vista: Somewhere over the rainbow	91
Un dolor compartido: la convergencia de sistemas que discriminan	94
Los miedos	110
¿Por qué teorizamos?: sobre la ética psicológica transfeminista	111
Modelos de intervención psicológica	118
El rifirrafe:	124
Puntos de conversación entre lxs científicxs:	124
Puntos de convergencia entre lxs científicxs:	124
Puntos de divergencia entre lxs científicxs:	125
Reflexiones propias:	125
Los miedos	133
Prácticas psicológicas desfavorables para el acompañamiento de jóvenes trans	134
Prácticas psicológicas favorables para el acompañamiento de jóvenes trans	136
Cuiranderismo	142
Gaia y otros sistemas vinculares	150

Familias, mundos posibles	153
Políticas Postmortem Transfeministas.....	160
Conversar para convivir en armonía.....	160
Lxs borradx y la transhistoria.....	166
Territorios Indomptables.....	170
Gracias otra vez.....	175
Bibliografía	176
Otros recursos	189
Anexos	191
Andar de nuevo.....	193

Agradecimientos

Agradezco:

A la Universa por la vida que experimento.

A Whitney, Tauriel, Alba, Victor, Jacob, Alice, Yamile y Cataleya, Sara, Miguel, Salomé, Laura W y a todas Las Guapas de Manizales por su generosidad y apertura conversacional este trabajo es por ustedes, gracias por mostrarme la valentía de ser unx mismx y por su compromiso por crear con los procesos organizativos un mundo más cuidadoso y confortable para la humanidad. Así mismo quiero agradecer a la organización El Faro y Armario Abierto en Manizales que me abrieron las puertas para conectar y conversar sobre la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+; a la Fundación GAAT, a los enlaces territoriales de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, al Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDS - G Sebastián Romero en Bogotá.

Al sol de medianoche, Moon, por tu amorosa compañía, por tu mirada tranquila, por mostrarme cómo acorazonar, por todas las conversaciones que tejemos a diario, por cuestionarte conmigo, por sostener mi mano, por tu presencia. A mi abuela por sostenerme con la magia de sus comidas, por su apoyo, por su risa, por enseñarme a amar con rebeldía. A mi madre por mostrarme la fuerza del movimiento, por su alegría y por su cuidado como premisa de vida, por enseñarme a descubrir otros horizontes. A mi papá que me recuerda el valor que hay en luchar por la justicia. A doña Marie, don Germán, G y la señora Pepi por su abrazo, calidez, amor y generosidad en todo este tiempo. A mi hermani por ser cómplice. A mis titis Patty, Marce, Nan por su cuidado y su humor. Esto también es por las nuevas generaciones de mi familia Isa y Feli por una vida más libre.

A mis amigxs, mis hermanxs del camino K, Kari, Cris, Mich, Dani G, Dani C, Caro, Majo, Ann, la Tati, Marce, Juli, Dani Casas por construir conmigo familia, por danzar y cantar la vida. A mis profesorxs por su acompañamiento, por sus preguntas, por su entusiasmo al pedagogizar la vida a todxs y cada unx, al profe Thierry Lulle por acompañarme en este proceso con amabilidad.

A Marybell, a mi terapeuta, a la profe Alanis, al Teatro Queer.

A Gaia y a Simón por detonar ternura al mil.

Gracias a ti por leerme, ahora si está completa.

Presentimientos

No necesito disfraz

Aquí está mi cara

Hablo por mi diferencia

Defiendo lo que soy

Y no soy tan raro

Me apesta la injusticia

Manifiesto (Hablo por mi diferencia) Pedro Lemebel

Tengo una fotografía mental que me acompaña constantemente, soy pequeña, no sé cuántos años tengo con exactitud, estoy en el carro y en un semáforo veo niños que sostienen carteles y le pregunto a mi mamá: -Mami ¿Por qué esos niños están ahí? -. Mi mamá me dice: -Ah porque son desplazados-. Me quedo con esa palabra, una palabra que en realidad no entiendo, lo que sí comprendo, son sus expresiones, están tristes. Tengo más fotos, pero en estas, ya sé leer, y mis ojos corren tan rápido por esos carteles antes de que cambie la luz del semáforo, y ahí ya tengo más información, ya sé de dónde vienen, pero no sé por qué. Y lloro porque pienso ¿por qué no están jugando?

Luego, pude nombrar ese sentir: injusticia. A pesar de que luego estudié sobre el conflicto armado en Colombia y sobre el desplazamiento, ninguna explicación me quitaba ese sentimiento, podían tener las teorías más sofisticadas, los conceptos mejor contruidos, me daba igual. No era justo por donde se le viera.

Desde ese momento comencé a ser muy consciente sobre ese sentir con otras situaciones, por ejemplo: cuando era niña morbosearon a mi mamá en una gasolinera y les hice pistola a los cabrones esos teniendo; cuando en mi adolescencia (no hace mucho años) me metí varias veces en esas “discusiones de pareja” viendo que el man le iba a pegar a la nena en el peatonal y ellas sumidas en ese círculo de violencia los defienden; cuando a mi hermano lo criticaban por tener una rutina de cuidado de su físico más estricta que la de todas en la casa; cuando yo misma no supe cómo marcar límites y permití que en una relación de seis meses no se me quisiera con respeto.

En el inicio de este trabajo de tesis, comencé a reconocirme como una mujer lesbiana y atravesé una situación difícil con mi familia de origen, situación que ha tenido que vivir muchas

personas sexualmente diversas en el mundo, detonando en mí momentos de ansiedad y tristeza, así que decidí no estar presente en reuniones familiares, y si estaba, de una forma poco asertiva les decía que no iba a permitir comentarios del tipo “estás confundida” o “es una etapa”.

En un momento, dejé de juzgarlos de conservadores y dejé de ponerme en el rol de la maestra, tipo, ven yo te enseño que las personas sexo-género son “normales” con estudios, datos y cifras; a fuerza trataba de que me aceptaran sin peros o condiciones. Poner este límite cuidadoso conmigo me trajo paz mental, sentí que estuve lejos de mi familia de origen algunos años, tenía claro que no iba a sacrificarme en su nombre, no iba fallarme en mi sentir y no iba a impedirme ser.

En este proceso, notaba como poco a poco mi familia de origen dejó de hacer estos comentarios, decidieron amarme y respetaron a la persona que yo había escogido como mi pareja, yo también trabajaba en no responder a la defensiva porque esto no permitía la conexión, entré a terapia y pude organizar mejor mi sentir; de este modo, con tranquilidad nos acercamos más. Además, pude conversar con mi mamá sobre el dolor que nos habíamos causado mutuamente y fué liberador, así reconstruimos nuestro lazo y en la actualidad siento nuestro vínculo muy fuerte (fortalecido). Sé que lo que permitió que de nuevo pudiésemos estar juntxs es la decisión de amar, con esto me refiero a permitir que el otro emerja en su legitimidad.

Esta situación que relato movilizó todo mi sistema vincular, de pronto, mi sistema de familia de origen no se nutrió en esos años, debo decir que fue mi pareja, su familia y mis amigxs - hermanxs del camino- quienes se convirtieron en mi familia elegida y con su amor me sostuvieron para seguir adelante, además de mi abuela que siendo mi cómplice me hizo saber que no estaba sola.

Entonces sabrás que el momento en el que escribo, es otro momento de mi vida, escribo desde mi adultez, en realidad, no me sentí preparada para escribir esta tesis estando en conflicto con mi familia, ahora me siento lista para decir. Me enamoré con locura y tomé la fuerza para decidir quién yo quería ser, luché por mi autonomía, incluso una vez obtuve mi primer trabajo con contrato laboral me fuí de mi casa. Lo relato porque los tránsitos de género son una decisión autónoma, sobre una decisión sobre sí mismxs y la adolescencia es vital en este proceso.

Según la teoría del ciclo de vida hay unas continuidades y discontinuidades en el proceso del vivir humano y se han señalado socialmente algunos momentos que reestructuran drásticamente los sistemas vinculares: cuando se forma una pareja, cuando se tienen hijxs, cuando se abandona la casa de lxs cuidadores, cuando se deja el mercado laboral (se pensionan las personas). Dicho esto, también existen otros momentos que configuran una discontinuidad, por ejemplo: cuando un miembro de la familia tiene una ruptura con un sistema de creencias que lleva años consolidándose.

En esos años, comencé a compartir estas experiencias con muchas personas que se reconocían como sexo y género diversas por lo que quise indagar sobre cómo se movilizaban los sistemas de lxs otrxs. En esta búsqueda, hice prácticas en Red Somos y me dí cuenta que la T de lo LGBTI eran las personas que experimentaban más sufrimiento y una mayor cantidad de acciones que vulneraban sus derechos.

La situación por la que atravesé es diferente a las condiciones de vulneración de derechos a las que se ven enfrentadas las personas trans, en especial, las mujeres trans, y en especial las mujeres trans empobrecidas y racializadas. En esta relación tengo una posición privilegiada¹ por mi lugar de origen, los recursos económicos con los que contaba y la formación educativa que estaba cursando, todo esto por la forma en cómo puedo ser leída en diferentes relaciones institucionalizadas. A la par, esto no me amputa mi fuerte deseo por hacer que los derechos sean derechos y no privilegios; por tener un compromiso por trabajar para que las condiciones de vida de las personas sean dignas; por sentir el dolor que hay detrás de la ventana y que me mira a los ojos; por hablar sobre las consecuencias de la discriminación, así como los caminos para la reconstrucción del tejido social.

Debo decir también, que en un punto de esta investigación tuve una sensación de ser una impostora y tuve vergüenza porque constantemente escuchaba a mis amix trans decir que la academia sólo quería conectar con ellxs para que los hicieran objetos de investigación y yo pensaba: vengo de la academia y de ninguna manera quiero que eso suceda. Después de reflexionar algún tiempo sobre esto, pienso que el reconocimiento propio como una persona cisgénero no impide que sea una activista transfeminista, de hecho, el transfeminismo es

¹ Según la APA el privilegio hace referencia a *fuentes no ganadas de estatus social, poder y ventaja institucionalizada que experimentan los individuos en virtud de sus identidades sociales culturalmente valoradas y dominantes* (APA, 2015.p.3).

la apuesta epistemológica que elegí para esta investigación y para integrar y organizar mi experiencia lésbica frente a la discriminación. Eso nunca dejó de conectarme y en vez de huir o pensar que en algún momento se me iba a juzgar por no ser trans, decidí conectar y hacer de manera rigurosa y cuidadosa este trabajo de grado, que para mí ha sido un camino encarnado en el que me encontré con personas maravillosas a quienes agradezco profundamente.

Adicional a lo dicho, realizo este trabajo porque sé que las familias necesitan apoyo, sé que mi familia de origen lo precisaba y yo también; con alegría puedo decir que por encima de sus creencias eligieron amarme, sin embargo, no todas las familias lo hacen y necesitan ayuda, en especial cuando las personas que realizan el tránsito de género son niñxs y adolescentes, en la adultez es diferente. Esta experiencia me permitió saber que hay esperanza, que cada vez existen organizaciones que acompañan a las familias, que existen pares formados que hacen acompañamientos sensibles y que en el ámbito público se han hecho avances increíbles.

Lo hago para honrar la resiliencia de las organizaciones sociales y los procesos comunitarios que nutren la existencia de personas excluidas de sus sistemas vinculares desde tempranas edades. Es en conjunto y en red que arman una estrategia contra el odio, como bien lo pude vivenciar con la Organización El Faro, la Red Comunitaria Trans, Armario Abierto, la Liga de la Salud Trans, Liberarte, la Fundación GAAT y Corporación Red Somos.

Lo hago por el dolor que produce saber que el sistema privilegia unas vidas sobre otras, según la CIDH el 80% de las mujeres trans que son asesinadas tienen de 35 años o menos así mismo afirman que *“el denominador común de esta violencia es la idea que tiene el perpetrador de que la víctima ha transgredido las normas de género aceptadas”* (CIDH, 2014. p1 y p. 3).

Me duele cada vez que alguien quiere manosear/justificar la vulneración de los derechos humanos a través de la discriminación porque eso convoca al desprecio por el otro y nos desconecta como seres humanos². Me duele abrir el chat de whatsapp que tengo con una

² La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe *Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales* (2020) señala su preocupación frente a la vulneración de los derechos humanos de las personas con experiencia de vida trans frente a su expectativa de vida la cual ronda a los 35 años. Así, afirma:

“Congruentemente, la información recolectada por la CIDH entre 2013 y 2014, arrojó como resultado que el 80% de las personas trans asesinadas durante un período de 15 meses tenía 35 años o menos. En este sentido, se ha señalado que esta expectativa de vida que acompaña a la mayoría de las mujeres trans explica el hecho de que falten generaciones mayores de los 30, lo que puede afectar directamente a las

lideresa trans en Manizales, ella me escribe cuando asesinan a una persona trans por prejuicio en Caldas y me rompe que me escriba tan seguido. Fuck that shit.

Me duele,

Me duele tu dolor.

Este dolor me moviliza.

Introducción

Eh, yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Makeup de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrella', yo me transformo

Saoko de Rosalía

El documento que tienes en tus manos es la llegada a una conversación no terminada, aquí te cuento lo que he alcanzado a oír y decir sobre el carácter maleable, performático, plástico del ser humano en su dimensión sexual. Este trabajo investigativo se realizó desde el año 2016 al año 2022 me di cuenta que tenía muchas cosas escritas y que estos escritos debían ser actualizados constantemente no sólo por toda la producción investigativa que se hace sobre este tema año a año sino porque en estos años hubo diferentes avances jurídicos como las tutelas interpuestas por Mike Duran en el año 2019 y Dani García en el año 2021 para cambiar el componente de sexo en la cédula bajo las categorías de transgénero y no binario; la exclusión del capítulo de Trastornos de identidad sexual de la onceava edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11) y la aparición de la disforia de género como un apartado del capítulo Condiciones relacionadas con la salud sexual, quitándole la connotación de trastorno; la publicación de los lineamientos de atención en salud a personas trans del Ministerio del Interior; la creación de la Liga de la Salud Trans; la realización de las ediciones de YoMarchoTrans; la consolidación de una red de colectivos y organizaciones a nivel nacional que acompañan y asesoran a personas trans en el fortalecimiento de su bienestar y la garantía y restitución de sus derechos, entre otras coyunturas.

jóvenes que carecen de las orientaciones de las personas mayores que les ayuden a entrever un momento más allá del presente inmediato y una dimensión que trascienda la individualidad” (pág. 51).

Así que aquello que me proponía a realizar en los años 2016 y 2017 cambió, ya que, para estos años tenía el propósito de explorar la percepción sobre los espacios de cuidado y de peligro para la población trans en la ciudad de Bogotá por esto hice cuatro entrevistas que correspondían a este cometido; en los años 2018 y 2019 cambié los objetivos y los instrumentos y me fuí a la ciudad de Manizales con el propósito de explorar la percepción de jóvenes sobre cómo se configuraban diferentes sistemas interaccionales en su vivencia de tránsito de género.

En este orden de ideas, viajé a Manizales a conocer estas organizaciones, dicté un taller para Armario Abierto e hice vínculos con la Organización El Faro recorriendo la ciudad con el líder de jóvenes y una madre lideresa, además realicé una entrevista a una voluntaria mujer trans de la organización. Y lxs chicxs entrevistados de la ciudad de Manizales y del municipio de Arauca, Caldas, hacen parte del grupo de jóvenes y sus familias de la misma organización, por protección a sus identidades sus nombres han sido modificados y sus edades son correspondientes al año en 2019 que fue el momento en el que se realizaron las entrevistas.

En ese sentido, En total se realizaron once (11) entrevistas distribuidas de la siguiente manera: Se realizaron cinco (5) entrevistas a jóvenes con experiencia de vida trans entre los 14 y los 28 años y una (1) entrevista a unx niñx de 11 años junto con su principal cuidadora, su madre; de lxs cuales 3 residían en el casco urbano de Manizales y 3 en el casco urbano del municipio de Arauca, Caldas; 5 vivían con su familia de origen; y 1 vivía independiente; 4 de ellxs se encontraban cursando bachillerato; 1 cursaba primaria y 1 participante era estudiante universitarix.

Adicionalmente, la Organización El Faro tiene como objetivo acompañar a jóvenes con experiencia de vida trans y sus familias en la ciudad de Manizales y municipios aledaños en los retos, dilemas y tensiones emergentes de proceso de tránsito de género en contextos limitantes para el desarrollo del ser humano. De este modo, El Faro es un interlocutor entre las familias y otras instituciones como colegios y hospitales haciendo acciones de prevención del daño como: sensibilización en género, pedagogía en acompañamiento sensible para personas que realizan un tránsito de género y conversaciones sobre la diversidad humana en espacios de toma de decisión; todo esto con el objetivo de aportar conocimientos y herramientas que fortalezcan el cuidado en estos contextos en los que interactúan lxs jóvenes.

También, tienen espacios de convergencia entre las familias, en los cuales lxs cuidadorxs principales pueden compartir dudas, retos y alternativas de solución que les hayan funcionado

en el pasado, este grupo funciona desde la inteligencia colectiva co-creando acciones desde la escucha y el apoyo del otrx, de este modo, hacen frente al estigma que puedan vivenciar en los diferentes sistemas en los que se movilizan.

Por otra parte, lxs chicxs llegan a El Faro por la comunicación entre pares, son ellxs quienes se dan consejo mutuamente frente a dilemas como: comunicación con sus principales cuidadores sobre su decisión de tránsito de género; técnicas y prácticas para estilizar el cuerpo de acuerdo con la proyección de cada persona; herramientas para afrontar situaciones difíciles e incómodas en el espacio público. Por lo tanto, El Faro tiene un grupo de apoyo entre pares que cumple con dos acciones: tener un sentido de pertenencia a un grupo de base comunitaria y compartir experiencias singulares que amplía su marco de referencia al darse cuenta de que existen otras personas que viven una experiencia con la cual pueden interpelarse.

De forma interna El Faro cuenta con un equipo de voluntarios profesionales que atienden y acompañan a jóvenes y sus familias, facilitan los diálogos de los grupos de apoyo de las familias y lxs jóvenes, y realizan acciones en espacios de incidencia territorial y política. Estas acciones son muy poderosas porque contribuyen a que la vida de lxs jóvenes siga su curso fuera de círculos de pobreza, exclusión y vulneración de derechos. Además, contribuyen al cierre de brechas sociales pedagogizando la vida para el amor.

De este modo, me gustaría hacer una breve introducción de cada unx de los chicxs con lxs que conversé y quienes con sus historias y experiencia hicieron posible este trabajo, señalo que el este escrito ha sido enviado al representante actual 2023 de la Organización El Faro y ha sido compartido con lxs jóvenes entrevistadx.

Leila (11 años) es una niña que se autoreconoce como tal, reside en el municipio de Arauca, nuestro encuentro conversacional se realiza con su principal cuidadora en la casa de una persona cercana a la familia, en un ambiente cómodo y sin interrupciones. Leila ocupa el lugar de la menor de las hijas, cuenta con una hermana y un sobrino, todas las personas descritas viven con ella. Además, cuenta con el apoyo económico de su padre. Leila recibe medicación psiquiátrica y tiene un diagnóstico de trastorno afectivo-bipolar. Con el apoyo de El Faro han podido mediar diálogos importantes con el colegio y por lo tanto, sigue realizando sus estudios. Lito (17 años) es un joven, reside en el municipio de Arauca y participa de un proceso de base comunitaria de apoyo entre pares de personas trans. Su red de apoyo familiar está conformada

por su madre, su padre, una tía y sus hermanos y hermanas, tiene una hija y se encuentra estudiando. A su vez, considera a sus amigos y amigas como parte fundamental de su familia. Se encuentra realizando su tránsito de género con la transformación de su nombre, vestimenta y apariencia física adicionalmente está comenzando a realizar un proceso de transición con profesionales médicos para acceder a Terapia de Reemplazo Hormonal.

Thalia (16 años) es una joven lideresa, reside en el municipio de Arauca y participa de un proceso de base comunitaria de apoyo entre pares de personas trans. Su red de apoyo familiar está conformada por su madre, su padre y sus hermanos, es la menor de sus hermanos y se encuentra estudiando. Nuestro encuentro conversacional se realiza en su casa bajo el consentimiento de su madre en un espacio íntimo y sin la presencia de otras personas. Menciona que el colegio es un lugar en el que disfruta estar, menciona a sus compañeros y compañeras como personas importantes. Por otra parte, realiza su tránsito de género dentro del sistema médico nombra a los profesionales en sexología como funcionarios que le ayudan a organizar la experiencia de tránsito. Thalia tiene diagnosticado un trastorno afectivo-bipolar y recibe tratamiento psiquiátrico por el mismo.

Emilia (23 años) es una joven universitaria y lideresa, reside en la ciudad de Manizales y asesora a jóvenes con experiencia de vida trans que acuden a ella en busca de consejo. Su red de apoyo está conformada por amigos y amigas y sus parejas sentimentales. Vive de manera independiente. La relación con su madre y su padre es lejana y no participan de su proceso de acompañamiento al tránsito de género, el cual comenzó en la adolescencia temprana sin un acompañamiento médico, cuando sale de casa encuentra un entorno de cuidado con otras personas con experiencia de vida trans y en los procesos de base comunitaria. Actualmente, realiza su tránsito de género dentro del sistema de salud. Nuestro encuentro conversacional se realizó en un café de la ciudad.

Anastacia (16 años) es una joven, reside en la ciudad de Manizales y participa de un proceso de base comunitaria de apoyo entre pares de personas trans. Su red de apoyo familiar está conformada por su madre, su padre y sus hermanos y hermanas. A su vez, considera a sus amigas como parte fundamental de su proceso de tránsito de género, son quienes le aconsejan y con quienes comparte la mayor parte del tiempo, le gusta escuchar pop, rap y jazz. Nuestro encuentro conversacional se realiza en su casa bajo el consentimiento de su madre en un espacio íntimo y sin la presencia de otras personas. Por otra parte, realiza su tránsito de género

dentro del sistema médico y se encuentra iniciando el proceso de administración de bloqueadores hormonales. Para ella los profesionales de la salud que la han acompañado de manera más presente son lxs sexólogos.

Sam (26 años) es una joven profesional residente de la ciudad de Manizales y participa de un proceso de base comunitaria de apoyo entre pares de personas trans. Su red de apoyo familiar está conformada por su madre y su madre, a la vez ha recibido el apoyo de la familia extensa, es hija única. Su proceso de tránsito comenzó en la adolescencia temprana sin un acompañamiento médico y lo realizó de manera artesanal, en la actualidad realiza su tránsito de género de la mano de un equipo de especialistas médicos. Sam (26 años, Manizales) considera que los estereotipos de género le han permitido conectar con los otros por ejemplo compartiendo responsabilidades delegadas a las mujeres de la casa. Al mismo tiempo, siente que su libertad frente a salir con amigxs y tener novio se ha visto más limitada por el cumplimiento de los roles de género. Nuestro encuentro conversacional se realizó en la sala de su casa en un espacio íntimo y sin la presencia cercana de otras personas.

Por otra parte, se realizaron dos (2) entrevistas a jóvenes con experiencia de vida trans en Bogotá, universitarios que vivían con sus familias de origen, por protección a sus identidades sus nombres han sido modificados y sus edades son correspondientes al año en 2019 que fue el momento en el que se realizaron las entrevistas:

Antonio (22 años) es un joven universitario residente de la ciudad de Bogotá y participa de un proceso de base comunitaria de hombres trans. Su red de apoyo familiar está conformada por su mamá, su papá, su abuela y sus dos hermanos; en un principio cuando Antonio le comunica a su madre a sus 17 años que quiere iniciar el tránsito ella reacciona con mucha confusión y rabia, al poco tiempo ella busca ayuda psicológica para comprender mejor este proceso, cuestión que hizo pensar a Antonio que su madre lo apoyaba. Por otra parte, el padre de Antonio no cuestionó su decisión y fue un mediador conversacional con la madre. A su vez, Antonio es el mayor de 3 hermanos, uno de ellos tiene una capacidad funcional diversa, a veces siente que se ha convertido en El hombre de la casa y debe responder por su familia. Al mismo tiempo, referencia a sus amigxs como un sistema de apoyo importante en el acompañamiento y disfrute de la vida en su adolescencia y adultez. Nuestro encuentro conversacional se realizó en un café solitario de la ciudad de Bogotá, lo cual hizo más amena nuestra conversación.

Rosalía (21 años) es una joven universitaria residente de la ciudad de Bogotá y participa de un proceso de base comunitaria de apoyo entre pares de personas trans. Su red de apoyo familiar está conformada por su padre, su madre y su abuela, es hija única. Ha tenido algunos conflictos con su familia extensa, relata que tiene un círculo de amigxs de la Universidad y otros grupos a los que pertenece. Comienza a realizar su proceso de tránsito en la Universidad. Nuestro encuentro conversacional se realizó en un café solitario de la ciudad de Bogotá, lo cual hizo más amena nuestra conversación.

Para un total de ocho (8) entrevistas a jóvenes con experiencia de vida trans, de lxs cuales 2 se autoidentificaron como hombres trans y 6 se autoidentificaron como mujeres trans. Por otra parte, Se realizó una (1) entrevista a dos funcionarios de la Secretaría de Integración Social de Bogotá encargados del componente de territorialización LGBTI. Se realizó una (1) entrevista a una lideresa de la organización Armario Abierto en Manizales, la cual es una organización de base comunitaria conformada en por mujeres activistas universitarias docentes de la academia y por mujeres trans trabajadoras sexuales del sector de la Galería con especificidad en la calle de las Guapas. Se realizó una (1) entrevista a la representante de ese momento de organización GAAT en Bogotá, la cual es una organización de base comunitaria que su principal foco es la garantía de los derechos de las personas trans, el apoyo psicosocial y comunitario a las personas con experiencia de vida trans y la investigación social en la ciudad de Bogotá.

Cada entrevista contó con el consentimiento informado (ver anexo 1) en la entrevista a los funcionarios de la secretaria de integración social se contó con un mapa de la ciudad (ver anexo 2) y las entrevistas a lxs jóvenes de manera informal se realizó un mapa de redes para seguir el hilo de la conversación sobre los sistemas vinculares (ver anexo 3). Mis principales fuentes de información son las voces de lxs chicxs con lxs que conversé, a ellxs gracias por su generosidad.

En el proceso de la realización del Estado de conocimiento, el cual a mi modo de ver realicé en cada etapa de la construcción de esta tesis, inicié por indagar con los siguientes tesauros de búsqueda *“transgénero”, “transexual”, “género no conforme”, “reasignación sexual”, “queer”, “Hermafrodita”, “Sodomia”, “sodomita”, “burdel”, “casa de lenocinio”, “homosexual”, “uranistas”, “androginia”, “travesti”, “identidad política”, “sexualidad”* en

Ebscohost, JSTOR, Dialnet y Redalyc. Los Tesauros para buscar información en las revistas de la época fueron: “*Hermafroditas*”, “*gay*”, “*invertidos*”, “*felipitos*”, “*sodomía*”.

En la base de datos de la American Psychological Association (APA) los tesauros de búsqueda fueron “*Transgender*” “*Gender identity*” “*Sexual minority groups*” en las investigaciones aparecen diferentes palabras clave: “*género no conforme*” “*LGBTIQ*” “*gender diverse*” “*nonbinary individuals*” “*genderqueer*” “*binary transgender*”. Además, consulté los registros del Archivo General de la Nación, la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Archive.org, DigitalTransgenderArchive.net, National LGBTQIA+ Health Education Center un programa de Fenway Institute.

En la sustentación del proyecto, una de las recomendaciones de mi jurada Alanis Bello fue indagar sobre investigaciones locales de personas trans dándome algunos referentes Blas Radi, Andrea García, Silvia Prieto. Amplié mis horizontes de conocimiento con el trabajo de Memoria Travesti de Fundación Santa Maria y los informes de Sentiido, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Mi actualización frente a las coyunturas se realizó por medio de la revisión a las siguientes cuentas de Instagram: GAAT, Red comunitaria trans, Dany la Trany, ColombiaTransHistory, la Casa de lxs locxs, Alienhadas, Causa Justa, De machos a hombres y Liberarte.

También debo decir que las voces que me interpelaron fueron las de las lideresas Trans del barrio Santa fé en Bogotá y las Guapas en Manizales; mis compañerxs del Teatro Queer; y lxs artistas Drag Queen y Drag King.

Esta investigación comenzó en Bogotá, me di cuenta que Bogotá era una ciudad receptora de migrantes personas trans víctimas del conflicto o desplazadas de sus hogares, me empecé a preguntar, ¿qué sucedía en otras ciudades intermedias respecto al bienestar de las personas trans? De este modo, tras el envío de mi propuesta a diferentes organizaciones, la Organización El Faro en Manizales me abrió las puertas y todo este proceso se dió en mayor medida de su mano.

Estructura capitular

En la escritura del trabajo se triangularon las siguientes fuentes: las entrevistas; el horizonte teórico-metodológico con la teoría de sistemas desde la psicología y el transfeminismo o teoría queer; mi propia experiencia en la deconstrucción y reflexión sobre el sistema sexo-género actual con la finalidad de reconocirme como investigadora psicóloga parte del entramado relacional.

Este trabajo cuenta con dos partes, en la primera parte se abordan las creencias y los conocimientos que son ingredientes de la interacción humana, ésta última de acuerdo con Ángela Hernández y Fernando Bravo (2015) tiene operadores del vínculo: la episteme, el ritual y el mito. En cuanto a la episteme se define como el conocimiento compartido por un grupo para orientarse y ordenar el mundo; el ritual, genera signos que permiten la comunicación y la pertenencia social; por último, el mito es el organizador de la cohesión de los grupos humanos en el tiempo y que son transmitidos de generación en generación.

La finalidad de abordar los operadores del vínculo es porque éstos operan en la autonomía y la autodeterminación de lxs sujetxs a diferentes niveles de realidad. Por su parte, las creencias pueden promover la conexión consigo mismxs, con los otros y con la vida, al mismo tiempo, pueden promover la desconexión con la vida y la división del tejido social; y esto ocurre de manera compleja y en simultáneo en los procesos de tránsito de género.

Debo expresar mi preocupación por la discriminación que se vivencia el proceso de tránsito de género y la precarización de la vida de muchas personas que se autoreconocen como trans, sobretudo cuando son expulsadx en la infancia y adolescencia de sus hogares, además de reflexionar sobre el ejercicio de la psicología y el rol del psicólogx en los procesos de tránsito de género. Es por esto que, me ha interesado conocer cuáles fueron las condiciones que configuran dichas creencias y éstas como se actualizan para visualizar mundos posibles y alternativas de cambio.

En ese sentido, la creencia de que *en el mundo sólo hay hombres y mujeres de manera natural y cualquier ser que quiera desafiar dicho orden debe ser normalizado*, está hecha de epistemes, mitos y rituales, en los que les sigo la pista desde la emergencia de la clínica (binomio médico-legal como institución) y la episteme encarnada en el principio de la modernidad en el que la

verdad se encuentra en aquello que se puede observar, preguntándome de la mano de Foucault si es necesario pensar en un sexo verdadero en el capítulo **Un desafío de optometría: Asignación de sexo por los genitales**.

Esta creencia también es operada por el mito del progreso en el cual se piensa que el desarrollo es determinado, lineal y en búsqueda del mejoramiento parametrizado del sistema capitalista patriarcal. En el capítulo **¿Hay una meta para llegar a ser?** Se pone bajo lupa este mito y se reflexiona sobre la cualidad dinámica del ser humano como proceso emergente indeterminado, el escenario se complejiza cuando se reportan menos casos de discriminación cuando se cree que las personas no han elegido su orientación sexual o su identidad de género, y que no se puede escoger frente a la “naturaleza”.

En este orden de ideas en el capítulo **Naturaleza: Alta tecnología y otros visajes políticos** se aborda la episteme: *el sexo es determinado biológicamente y el género construido socialmente*; aquí se examina cómo la biología se vuelve el estudio de la naturaleza y cómo se piensa que en la naturaleza se encuentra la verdad; además de pensar quiénes tienen el poder de acceder a la verdad, esto ha supuesto otorgar a los hombres un poder correccional y de acceso a la ciencia, es decir, al conocimiento válido.

En el capítulo **La artificialidad del sexo y del género** se exponen los rituales que configuran el género con especificidad el binarismo de género y su constante verificación para validar el buen comportamiento de las personas; la obligatoriedad de cumplimiento de los rituales de género se vuelven requisitos por cumplir que el sistema médico fiscaliza con la manera en cómo se realizaba el diagnóstico de disforia de género. Al mismo tiempo, esto desdibuja las decisiones de las personas vivenciando un tránsito de género respecto a la gestión del mismo.

¿Si todo es co-construido entonces qué puede trascender dicha construcción? Es así como en **Colores extraoficiales** se encuentran casos de otras culturas en la que no se piensa la fluidez de género como una identidad o una construcción social sino como un elemento constitutivo del orden espiritual. A la vez, en occidente los tránsitos de género no binarios y las personas intersexuales desafían el orden de lo identitario, acaso ¿lo que sigue es el despliegue de categorías identitarias sin fin? También se relata cómo estos límites de género de manera personal los he desafiado con la experiencia drag y la toma de medicina ancestral.

Para cerrar esta primera parte se encuentra un ejercicio de imaginaria en **Hackear el sistema: devenir queer** ¿qué pasaría si un día el género desaparece y ya no se asigna en los documentos administrativos? ¿qué sucedería en el orden de lo social? Estas y otras preguntas se encuentran en este capítulo a manera de ampliar las posibilidades de elaboración de conocimiento.

En la segunda parte, expongo cómo se movilizan e interactúan los sistemas sociales: academia, comunitario, familia, político, administrativo territorial a un nivel macro respecto al tránsito de género y cómo estos sistemas retroalimentan lo micro y al revés, en un movimiento de ida y vuelta de información. Es así como se exponen las entrevistas a lxs jóvenes en un nivel de realidad micro y éstas se conjugan con las pautas interaccionales de los sistemas a nivel macro, de acuerdo con el principio hologramático de la complejidad en el que el todo está en la parte y la parte en el todo comprendiendo que, es esta relación lo que permite la emergencia del fenómeno.

Debo resalta que pienso que lo humano emerge en la conexión entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural (bio-psico-socio-cultural), por lo tanto, el malestar de género como fenómeno psicológico se configura de esa forma en algunos procesos de tránsito de género. Así mismo, considero que procurar el camino para hacer de este proceso más armónico tiene su emergencia en el mismo sistema que lo genera si se realizan los cambios que lo posibiliten.

En los capítulos **More Soul, teoría de la carne** y **Un dolor compartido: la convergencia de sistemas que discriminan** abordaremos los efectos del ejercicio profesional de la psicología en los procesos de tránsito de género apelando a que nuestro rol como psicólogxs es investigar e intervenir en sistemas sociales humanos para promover el bienestar, la justicia social y la equidad. Por lo que me propongo abordar varios frentes de acción:

1. Investigar sobre las consecuencias que traen las creencias binarias y la negación de la transformación del ser humano como condición de su existencia.
2. Investigar sobre los efectos de la discriminación estructural en la configuración de la salud de las personas.
3. Investigar sobre modelos de atención humanizada y justa para promover la libertad y la autonomía de las personas.

La responsabilidad que tenemos como psicólogxs al teorizar es una responsabilidad ética ¿qué tanto lo que pienso y acciono como psicólogx amplía la autonomía de las personas y armoniza la convivencia entre las personas? ¿qué tanto aporta mi ejercicio como psicólogx a imaginar alternativas y mundos posibles cuando se precisa de una reestructuración de la vida como en el caso de los tránsitos de género? Todo esto se encuentra en **¿Por qué teorizamos?: sobre la ética psicológica transfeminista.**

El capítulo **Modelos de intervención psicológica** se escribe a modo de ejercicio de actualización sobre los modelos usados actualmente en el acompañamiento y atención a personas vivenciando un tránsito de género. Sumado a esto las creencias que vimos en la primera parte, en muchos casos son compartidas por profesionales de la salud y psicólogxs en ejercicio, las cuales pueden constituirse como barreras de acceso a la salud o en prácticas psicológicas favorables que promueven la salud de las personas vivenciando un tránsito de género.

Frente a la discriminación, la vulneración de derechos y la precarización de la vida de las personas trans se han hecho redes como un acto de resiliencia entre personas trans desde lo comunitario, en las que se acompañan la experiencia vivida y se tejen grupos que permiten condiciones dignas de existencia. Es por esto que en **Cuiranderismo** vemos cómo estas familias escogidas sostienen emocionalmente los procesos y emergen modelos de acompañamiento a pares.

En el capítulo **Gaia y otros sistemas vinculares** es la introducción a la comprensión del ser humano de manera distribuida y múltiple, pensado para mí desde los principios de la complejidad con la teoría de sistemas y el transfeminismo, en este capítulo se encuentra el abordaje del movimiento de los sistemas: familia, político, y administrativo territorial.

En **Familias, mundos posibles** se habla de la incertidumbre y la indeterminación en los procesos de tránsito de género, de acuerdo con la teoría del ciclo vital, existen momentos de reorganización del sistema familiar como lo es: la conformación de la pareja, el ingreso de lxs hijxs al colegio, las mudanzas, la salida de lxs hijxs de casa, entre estos momentos, se encuentra el proceso de tránsito de género. En consecuencia, el sistema familiar requiere acompañamiento para fijar una ruta de navegación y que las familias puedan converger como red en el proceso.

Sayak Valencia es quien ha hablado sobre las **Políticas Postmortem** haciendo referencia a las acciones posteriores a la exposición desmedida de la violencia y cómo las personas logran re-elaborar y estructurar los procesos. La política en Colombia no es ajena a los procesos de tránsito de género, por el contrario, pensar en política es pensar sobre la gestión de la vida y la muerte de las personas, sobre las existencias que se privilegian y la concentración de la riqueza que precariza la vida de todxs. El abordaje **Transfeminista** es para cuestionar el orden establecido que se queda corto frente a la diversidad de vidas que existimos. Por lo tanto, en este capítulo se aborda la relación política – diversidad sexual y de género.

Por último, en el capítulo **Territorios indomptables** se comprende que el sistema binario de género ha recluso a las personas que se atreven a cuestionarlo, asignándoles unos espacios de precarización de la vida, el transfeminismo como episteme cuestiona el ordenamiento de la ciudad por género, clase, etnia, edad, volviendo extraña “la normalidad” ¿por qué existen las zonas de tolerancia? ¿acaso son guetos de la diferencia para que no se mezcle con lo blanco? Al mismo tiempo, se relacionan los tránsitos de género con el derecho a la ciudad comprendido como la capacidad de movilidad humana de territorios físicos y corporales.

Caleidoscopio de género: la gran fragmentación

Cisgenderwoman

Cisgenderman

Man/male

Woman/female

Cisgender

Cisgenderhormonallyintersexwoman

Cisgenderwomanandrogynousleaning

Demigirl

Intersexwoman

Woman,intersex-adjacent

Transgenderwoman

Transgenderman

Transgendermantwospirits

Transgender

Bigender

Gendermale,sexfemale

Transmasculinne

Transsexualman

Transsexualwoman

Nonbinary

Agender

Genderfluid

Nonbinarygenderqueer

Agender,nonbinary

Demigirl

Agenderdemiboy

Agenderflux

Bigender,nonbinary,genderqueer

Omnigender

Bigender

Intersex

Multigender³

La Gran T se refiere a personas trans (travesti, transformista, transgénero, transexual) y nombro todas estas categorías de enunciación precisamente por las particularidades del tránsito. En el capítulo *Utopía de ser* del libro *Otros cuerpos, otras sexualidades* de José Fernando Serrano recopila una serie de historias de personas disidentes del sexo y del género en Colombia, verso una de ellas por la riqueza de las categorías que se encuentran. Susana una *travesti del closet* como se ha denominado narra las diferentes experiencias de tránsito remitiéndose a su experiencia de travestismo personal. Así cuenta:

“Sonia me hablaba de transformismo, de travestismo e incluía otra categoría que necesitaba una cirugía de genitales: la transexualidad. En tan poco tiempo, me había hablado de tres estados diferentes: el primero, el transformismo, en el que el nacido varón se disfraza de mujer por un tiempo relativamente corto, para una fiesta, un show, y para ese momento se pone un nombre femenino, pero en su vida diaria desempeña un rol masculino. El término transformista ha hecho referencia en sus orígenes al actor o payaso que hace mutaciones en sus trajes y en los tipos que representa. El segundo, el travestismo, en el que el hombre siente un deseo profundo de ser mujer, con ciertas diferencias de la típica fémina que conocemos. Ella se pone hormonas, hace ciertas transformaciones en su cuerpo, se viste de mujer todo el tiempo, cambia de nombre en la cédula y se denomina "travesti". (Talero en Serrano, 2006).

De la misma forma, expresa otras formas de tránsito como lo son *travesti de clóset* que es un hombre heterosexual que tiene momentos de expresión femenina y más allá de una identidad es una práctica de expresión de su sexualidad de forma oculta; *andrógino* ligado en este libro a un tránsito de género fuera del sistema binario; *drag queen* y *drag king* que son personas transformistas que llevan al extremo la feminidad y la masculinidad; *queer* que significa raro y al parecer engloba esta diferencia, aunque no hay una precisión sobre si ésta categoría es una identidad.

Dicho esto, la gran T supone un gran espectro de experiencias de tránsitos, tal como afirma Andrea García en su trabajo *Tacones, siliconas, hormonas y otras críticas al sistema sexo-*

³ Todas estas denominaciones han sido las que he encontrado en varios artículos de investigación científica en inglés.

*género: “Se tratan más de categorías prácticas de reconocimiento que de categorías rígidas para el análisis científico o de taxonomías que surgen exclusivamente de las instituciones de poder que patologizan, definen y clasifican la diferencia.”*⁴(García, 2009 p. 121).

Al mismo tiempo, muchas personas no se identifican con estas categorías por una decisión política. Por ejemplo: Manuel Velandia en su discurso ante el Congreso de la República⁵ en el año 2022 afirma que no se identifica como homosexual porque esta categoría viene desde el ámbito médico patologizante y tampoco como gay porque eso significa persona alegre o persona de ambiente, así que se reconoce como marica desde su posición política.

Mientras leía *El arcoíris de la evolución: Diversidad, género y sexualidad en la naturaleza y en las personas* de Joan Roughgarden que a medida que he buscado información sobre estudios con personas transgénero he notado que existe cada vez más un interés por hacer más exhaustiva la clasificación de la diversidad sexual humana basada en diferentes tópicos: la experiencia de vida, las hormonas, la genética, la fisiología.

Me he encontrado que en algunas ocasiones la finalidad de esta categorización es develar y registrar la diversidad biológico-cultural que somos como seres humanos; en otras la defensa de los derechos humanos; en otras realizar una organización físico-química y organizarnos como si fuésemos una tabla periódica. En una charla que dí una persona intervino y dijo: partamos del hecho de que existen hombres y mujeres ¿en qué se fundamenta esta idea? ¿de dónde viene?

Roughgarden aborda estas preguntas en el libro mencionado con anterioridad con mucha lucidez, al respecto la autora dice que en el siglo XIX se estaba empezando a realizar la clasificación de los elementos químicos, sin embargo, las expediciones de diferentes científicxs se encontraban con que los animales de una misma especie tenían características muy distintas y se comportaban diferente de un territorio a otro, así que se dieron cuenta que precisaban de otro tipo de registro, uno que pudiese estar en la misma escala y complejidad.

“En los tiempos de Darwin estaba empezando a consolidarse el sistema de clasificación de Linneo, basado en filos, géneros, especies y demás. Los naturalistas

⁴ Al menos en el ámbito académico, los estudios cada vez más se alejan de posturas patologizantes, sobre todo desde el año 2018 debido a que la Organización Mundial de la Salud saca la disforia de género de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y declara que hace parte de una condición de la sexualidad humana.

⁵ Manuel A. Velandia (28 de junio de 2022). Reconocimientos líderes LGBTIQ+ Colombia, junio 28 de 2022. . [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ctRPb01qfYw&t=197s>

organizaban expediciones a lugares remotos para recolectar especímenes para museos y después encasillarlos en el sistema de clasificación linneano. A la vez que esto ocurría, los físicos estaban desarrollando la tabla periódica de los elementos —su sistema de clasificación para las especies físicas—, y los químicos estaban clasificando fórmulas para diversas sustancias basándose en sus enlaces químicos. Pero la clasificación biológica equivalente a la clasificación física no funcionaba muy bien.” (p.40).

¿Qué sucedió con la diversidad sexual en todas estas expediciones? Su registro quedó en el binarismo con el que operaba la humanidad. Sin embargo, en la actualidad la sexualidad no se refiere con exclusividad al tamaño de los gametos (óvulos y espermatozoides), de hecho, cuando la biología surgía como una disciplina de conocimiento científico la clasificación se daba desde la observación externa. Leer tantas categorías me parece maravilloso justo porque esto implica que el binarismo es eso, una ficción con la que hemos operado desde un acuerdo social desde hace algunos siglos.

Ahora bien, también deseo que esto no busque ser un listado de categorías identitarias leídas bajo el esencialismo y el determinismo biológico-médico. La complejidad va mucho más allá de pretender clasificar nuevamente los seres humanos y crear nuevos sistemas de control y dominación, por el contrario, considero que es una gran revolución saber que “todo esto se ha salido de las manos” y que este caleidoscopio es lo que somos.

Es así como necesitamos volver a pensar cómo hemos leído el mundo. En este orden de ideas, la bióloga colombiana Brigitte Baptiste dió una charla TED en Río de Janeiro titulada “Nada más queer que la naturaleza” en la que ha expuesto cómo la teoría queer es una constante invitación a pensar la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos dentro de nuestros ecosistemas, además de subrayar que ha sido la diversidad la que ha permitido nuestra supervivencia y adaptación a los medios.

Por consiguiente, me ha parecido interesante poder explorar las lógicas de clasificación de la diversidad humana desde la historia reciente desde su historicidad y cómo éstas coexisten en la actualidad con otros sistemas de comprensión de la sexualidad humana.

Un desafío de optometría: Asignación de sexo por los genitales

Cuando nací, mi madre, mi padre, y otros miembros de mi familia pensaban que iba a ser un varón, diseñaron mi llegada con un nombre masculino; sin embargo, en el parto, el equipo médico cambió de parecer al ver que no cumplía con el tamaño genital esperado y anunciaron ¡Es niña!. ¿Cómo podían cambiar tan fácilmente esta decisión por una inspección genital observable? y ¿Cómo ese dictamen (casi accidental) generalmente se concebía socialmente como definitivo, no reversible, ni transitable, ni cuestionable? y ¿Desde cuándo los médicos podían decidir sobre mi sexo? y entonces yo ¿Cuándo podría yo escoger?. Jum y ahora, ¿Cómo me llamarían? y ¡no es un detalle menor! porque no debía quedarme yo en la nada, no había tiempo para que fuese cosa sino que fuese alguien, y tendrían menos de 10 minutos para sustituir todos los artefactos comprados para decir ella es...

El médico tiene el poder de brindar su concepto sobre la asignación de sexo, **la cual no sólo se ejerce al momento de nacer, sino que pasa por un proceso de verificación a lo largo de la vida**, veamos algunos ejemplos. Michel Foucault (1985) en su libro *Herculine Barbin. Llamada Alexina B* se pregunta “¿Verdaderamente tenemos necesidad de un sexo verdadero?” (p.11) refiriéndose al sexo verdadero como aquel que está oculto por la naturaleza en la infancia. Así, expone que para la medicina del siglo XIX las personas intersexuales fueron de gran interés, llamadas hermafroditas para esa época, y su definición radicaba en la yuxtaposición de los sexos o la posesión de ambos sexos diferenciados. Se pensaba que uno de esos sexos en el desarrollo corporal de la persona tendría mayor preponderancia en la adultez y así se configuraría como el sexo verdadero, el cual podía ser sustituido por el sexo natal. Por este motivo, cuando las personas “hermafroditas” alcanzaban una edad adulta, podían escoger su sexo verdadero sin posibilidad de revertir dicha decisión.

Éstas son las raíces por las cuales se habla de “estados intersexuales” porque justo se significa como un momento de ambigüedad que en algún tiempo de la vida de esa persona va a “resolverse”, lo mismo podríamos decir de los procesos de tránsito de género, en los que tradicionalmente se espera que la persona decida hacia qué orilla transitar: hombre o mujer. En este libro de Foucault se encuentra el relato personal de Alexina o, como también le decían, Camille, en el que cuenta sus memorias desde la infancia, nacida en 1838 en un pueblo de Francia permaneció en una escuela de niñas hasta los 15 años, luego, va a otra institución en la que se forma como institutriz hasta los 20 años. Así, nos sigue contando que para este año

comienza a ejercer su profesión en otra ciudad y tiene una relación erótico-afectiva con una compañera, Sara:

“¡Lo que sentía por Sara no era amistad, era una verdadera pasión! (...) Entonces me deslizaba furtivamente junto a mi amiga, prometiéndome no turbar su sueño de ángel, pero ¿podía contemplar ese dulce rostro sin acercar a él mis labios?” (p.63).

Es importante mencionar que, para esta época la homosexualidad era una práctica sexual pero no era una identidad, así en Testo Yonki, Paul B Preciado (2020) dice *“Aquello que hasta ahora eran simples prácticas sexuales se transforman en identidades y en condiciones políticas que deben ser estudiadas, repertoriadas, perseguidas, castigadas, curadas.” (p. 62).*

Posteriormente, Alexina relata que en algunos momentos sentía dolores en el cuerpo, por lo cual Sara le sugirió una revisión médica. De este modo, Foucault adjunta en su libro el reporte del médico que la revisó: Chesnet, sobre su encuentro con Alexina:

“Habiéndose quejado de vivos dolores que sentía en la ingle izquierda, se decidió someterla a la visita de un médico, quien no pudo reprimir, a la vista de los órganos genitales, la expresión de su sorpresa”. (Foucault, 1985, p.136)

El médico dedica algunas páginas a describir la morfología de Alexina desde sus rasgos faciales hasta sus genitales. Luego de esta descripción llega a la siguiente conclusión:

“¿Es Alexina una mujer? Ella tiene una vulva, labios mayores, una uretra femenina, independiente de una especie de pene imperforado, el cual ¿no será un clítoris monstruosamente desarrollado? Existe una vagina, muy corta en verdad, muy estrecha, pero al fin y al cabo ¿qué es sino una vagina? Estos son atributos completamente femeninos: sí, pero Alexina no ha reglado jamás, todo el exterior de su cuerpo es el de un hombre, mis exploraciones no han podido encontrar la matriz. Sus gustos, sus inclinaciones, le atraen hacia las mujeres. Por la noche, sensaciones voluptuosas son seguidas de un derramamiento espermático, su ropa interior aparece manchada y almidonada. Para acabar, en fin, se encuentran al tacto unos cuerpos ovoides, un cordón de vasos espermáticos en un escroto dividido... He aquí los verdaderos testimonios del sexo; podemos concluir y decir: Alexina es un hombre, hermafrodita sin duda, pero con predominancia evidente del sexo masculino” (Ibid, p.138).

Para ese momento histórico, Alexina no cumple con la cualidad suprema de la mujer: ser madre. Jamás ha menstruado y el médico no encuentra un útero. Esto automáticamente la convertirá en un hombre a la edad de 22 años. Alexina renuncia a su trabajo como institutriz, rompe su relación con Sara, configura una nueva vida en la que debe obedecer a los rituales masculinos, y porta un nuevo nombre: Abel. Finalmente, el manuscrito de sus memorias es encontrado por el médico que le hace la autopsia luego de suicidarse a sus 29 años, parece que a su escrito le faltaran algunas partes de su último año de vida, en el cual se sentía muy solx y en una situación económica precaria. Alexina no pudo decidir sobre su cuerpo, el poder lo tenían el médico y el sacerdote.

Lamento profundamente el que hayas muerto solx en una habitación de París en 1868, te hicieron creer que ya no merecías amor ni una vida digna, y a forma de presagio, Alexina, el año de tu muerte, es el mismo año en que la homosexualidad entra en los manuales para ser castigada.

En la Revista de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (1943) se publicó un artículo del doctor Ramón Gonzalez R titulado *Un caso de Hermafroditismo*⁶ en el que expone que recibió el caso de un hombre joven en Santa Rosa de Cabal que asiste a su consulta por una hernia en la ingle y que requiere operación. El doctor al hacer la cirugía se da cuenta que el hombre cuenta con útero, ovarios y trompas uterinas; y es así como todo el equipo médico decide hacer una intervención para eliminarlos, así se encuentra el siguiente concepto en el reporte:

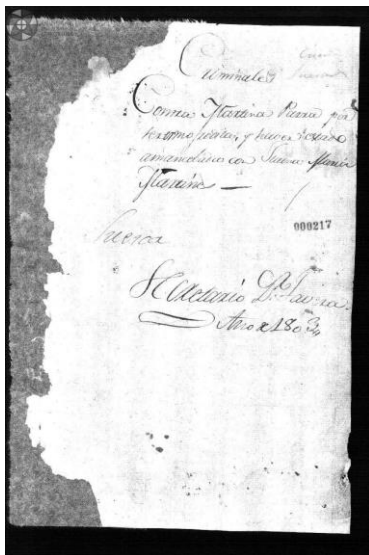
“Se practicó la incisión de costumbre para la operación de la hernia inguinal. Al abrir el saco herniario se observó que estaba vacío, su contenido se había reducido en la cavidad abdominal. Al explorar el cuello para cerrarlo se observó en el fondo un órgano móvil grueso que no correspondía a intestino ni a epiplón; lo tomamos con una pinza tratando de exteriorizar y con gran facilidad podemos extraerlo pues daba margen para ello. Una vez afuera procedimos a examinarlo y con sorpresa notamos que se trataba de un útero bien desarrollado de dimensiones poco menores que el de una mujer adulta, con ligamentos anchos normales, trompas de dimensiones normales insertadas en los cuernos uterinos y dos órganos ovales en el sitio correspondientes

⁶ Este artículo se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/24634/25209>

a los ovarios. (...) En presencia de este caso de hermafroditismo con elementos tan precisos y bien desarrollados uno y otro sexo, resolvimos eliminar la parte femenina eliminando las trompas y el útero conservando intactos los testículos y los cordones que estaban cubiertos por las dos láminas del ligamento ancho. Se practicó una histerectomía subtotal con salpinguectomía bilateral procediéndose enseguida a colocarlos testículos en la bolsa derecha terminandola intervención con la reconstrucción de los dos planos del canal inguinal.” (p.714)

De esta manera, removieron cualquier signo de “feminidad” en el cuerpo del consultante, a pesar de que la intervención tenía que ver únicamente con una hernia en la ingle, y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué pensamiento subyace a la decisión médica de realizar la histerectomía sin el consentimiento de Ramón, siendo éste un procedimiento separado de la cirugía de la ingle? ¿Por qué el equipo médico dinamitó la posibilidad reproductora de Ramón?⁷

Quise entonces indagar si existían otros registros en Colombia del siglo XIX y me encontré con los registros Criminales que tiene el Archivo General de la Nación de Colombia, hay uno que llamó mi atención escrito en 1804 en Colombia y sentencia de la siguiente manera:⁸



“Contra Martina Parra por hermafrodita y haber estado amancebada con Juana María Martínez” en el que se asegura que Martina Parra tenía relaciones sexuales con Juana María Martínez y que ella se había fijado en que tenía vulva y un pene relata una persona de la parroquia: *“que tiene las parte de la muger pero que al tiempo de pecar se sale un miembro como de hombre y conavira como tal pero que tiene menstruación”* Así, encierran a Martina Parra a la cárcel, más adelante encontramos un documento de Miguel de Islas en el que emite un concepto

⁷ En la actualidad, estos actos son un delito porque no se cuenta con el consentimiento de la persona, tal y como se expone en la Ley 23 de 1981 en el que se dispone las Normas en Materia de Ética Médica en su artículo 15:

“El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueden afectar física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.”

⁸ Archivo General de la Nación de Colombia Sección Sección Colonia Fondo Criminales (Juicios):SC.19 Legajo Criminales (Juicios):SC. 19 Nivel Unidad documental Título y Signatura Criminales (Juicios): SC.19 - CRIMINALES-JUICIOS:SC.19,96, D.3 Fecha inicial y fecha final 1804 -En el texto se lee: Criminales: Comia Martina Parra por hermafrodito y haber estado emancebada con Juana María Martínez

en que dice que Martina Parra no es un hombre sino que su miembro es el clítoris y por lo tanto Martina puede salir de la cárcel.

La situación anteriormente expuesta, de acuerdo con los registros llevó un año de investigación por parte de las autoridades de la época. De lo que se sabe no era castigado como tal el ser hermafrodita sino el engaño. Es decir, si las personas a sabiendas de lo que ya “eran” ocultaban “La verdad” porque estaban engañando a la sociedad y esto era lo que constituía el crimen. En este caso, Martina Parra no fue criminalizada explícitamente por hermafrodita⁹ sino por engañar a Juana María Martínez en un primer momento sobre su sexo.

Para el siglo XIX el cuerpo humano ya se encuentra en dominio del conocimiento público y del poder institucional: se publican expedientes médicos (revisión de la anatomía); documentos jurídicos (publicación de actas de cambio de nombre y registros de nacimiento); y textos noticiosos (divulgación sobre aspectos de la sexualidad de las personas). Para este caso, a Martina Parra la revisaron dos médicos Miguel de Isla y Honorato Vila quienes fueron promotores de la carrera de Medicina en 1802, ellos emitieron un concepto en el que afirmaban que Martina Parra era una mujer haciendo una explicación detallada de sus genitales.

Al respecto encontré un artículo de Carolina Botero (2001) llamado *Homoerotismo femenino en la Nueva Granada (1745-1822)* en el repositorio de Revistas de la Universidad Nacional, esta autora tiene una idea muy interesante sobre el caso anteriormente descrito:

“El asunto de interés para las instancias de poder no fue el amancebamiento por más de un año entre dos mujeres . Por el contrario, eso no tuvo la menor repercusión. Para los sabios lo que estaba en juego, más allá de la homoeroticidad , era el hecho científico de encontrar una hermafrodita, un ser que para tantos, solo pertenecía a la imaginación.” (p.41).

Hasta el momento, hemos visto algunos hilos sobre la genitalidad como máxima verdad para la asignación sexual, ahora veámos cómo este paradigma opera con las nuevas tecnologías de comprobación de la verdad sobre un sexo genital construido.

⁹ En los registros criminales del virreinato de Nueva Granada si aparece la sodomía masculina como un delito basado en la idea del *pecado nefando* y de *crímenes contra natura*. Es posible que bajo estas dos categorías se encuentre más información al respecto.

¿Hay una meta para llegar a ser?

A principios del siglo XX, la sexualidad humana era comprendida desde diferentes miradas que coexistían, por un lado, el psicoanálisis tenía un marco de comprensión desde la patología y la anomalía, es por esto que, Freud en su libro *Tres ensayos sobre teoría sexual* (1905) comienza exponiendo las patologías de la sexualidad en dos vías: al objeto y al fin. Algunas de las anomalías que señala es la de los invertidos (se refería a las personas homosexuales) y las hermafroditas mentales (se refería a las personas transexuales llamadas para la época: eunucos¹⁰); esta teoría tiene un correlato biológico con el cerebro humano, Freud en su obra, trató de vincular los procesos psicológicos y sociales a alguna parte del cerebro todavía desde una mirada dual y binaria del ser humano: mente-cuerpo/ consciente-inconsciente.

Otra mirada fué la de los médicos europeos de Dinamarca y Alemania quienes se preocuparon por tener una comprensión sobre la sexualidad humana desde el registro y la clasificación de las experiencias de sus pacientes, fueron estos teóricos quienes hicieron una taxonomía sexual o un espectro sexual en donde los extremos eran : hombres y mujeres y en medio un espectro de personas con diferentes experiencias, a quienes generalmente denominaron que vivían en estados intersexuales apelando a que su desarrollo sexual no estaba completo, esta división amplió el marco de comprensión sobre la diversidad humana y tuvieron más libertad para atender los malestares de las personas.

Al mismo tiempo, siguieron replicando una lógica normalizadora de los cuerpos frente al binario hombre-mujer, con la cual seguimos operando. Con esto me refiero a que desde una orilla diferente también se comenzaron a realizar prácticas de intervención corporal que no todas las personas querían realizarse para tener una validación sobre su identidad. Por ejemplo, el médico pediatra John Money realizó varias intervenciones a bebés intersexuales en los que intervino su genitalidad, tal es el caso muy documentado de David Reimer¹¹, el cual causó mucha controversia ya que se puso en escena el debate si se podía construir la identidad del ser hombre o mujer por medio de la crianza o si la identidad era una característica de nacimiento.

¹⁰Esta categoría todavía aparece en estudios recientes (Kayla Vale , Thomas W. Johnson , Maren S. Jansen , B. Keith Lawson , Tucker Lieberman , KH Willette y Richard J. Wassersug. 2010).

¹¹ Comúnmente se conoce como el caso John/Joan. La cadena BBC reportó el caso y los debates clínicos alrededor de este. Para mayor información, consultar aquí: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101125_cambio_genero_sexualidad_men.shtml
Descrito también en el libro de Judith Butler llamado *Deshacer el género*.

La versión que más circula sobre el caso de David Reimer nos cuenta que todo comenzó con una pareja de granjeros que vivían en Canadá y tuvieron dos hijos gemelos que a los meses de su nacimiento presentaron problemas al orinar, de este modo, los médicos hicieron la circuncisión a ambos bebés, sin embargo, en la operación de David hubo negligencia médica y quemaron su pene. Es por esto que el médico John Money contactó a la familia o al revés (no es claro este asunto) y les sugirió que David fuese socializado como Brenda bajo el compromiso de que la pareja no le contara a David lo sucedido. Es así como David fué monitoreado por años por el doctor Money, quien lo expuso como un caso de éxito, pero David en realidad pasaba por episodios de ansiedad y depresión profunda, cuestiones que no fueron registradas en su momento porque podían ser utilizadas para desacreditar los procesos de tránsito de género incluidas las intervenciones corporales.

Por otra parte, en Estados Unidos el doctor Harry Benjamin¹² realizaba estudios sobre el funcionamiento de las hormonas para la intervención en procesos de tránsito de género junto con Alfred Kinsey. En su libro *El Fenómeno Transexual* expone que los psicólogos conocen desde hace mucho tiempo el deseo de cambiar de sexo por parte de sus pacientes y han descrito dichos malestares como inversión de los roles sexuales. De este modo, la idea de hacer cirugías que permitieran una modificación corporal¹³ como la feminización o masculinización del cuerpo se realizaban para llevar a los pacientes a una normalización psíquica y corporal¹⁴.

De este modo, el sexo antes considerado como estático, puede modificarse. Una de las versión más comunes que encontré sobre los primeros registros que se tienen sobre las cirugías de afirmación de género databan entre los años 1920 y 1930¹⁵, siendo uno de los casos más famosos el de Lili Elbe¹⁶, una pintora danesa de principios del siglo XX, su historia fué

¹² Fue el primer director de la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) en español: Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero

¹³ En Colombia, la sentencia T771 de 2013 establece el derecho de las personas transgénero a acceder a los servicios de salud, específicamente el Tratamiento para reafirmación sexual quirúrgica o cambio de sexo.

¹⁴ Al mismo tiempo, Hirshfield sexólogo alemán declara en su libro *Travesti* que “trasvestirse se consideraba beneficioso para la salud mental”, entiéndase que se refiere a vestirse de acuerdo a la autonomía de cada persona.

¹⁵ Se encuentran casos de un registro un poco más masivo hacia 1950 debido a que Europa se reconstruye después de la segunda guerra mundial, y en la cual, el nazismo restringió todo avance científico sobre la sexualidad y restringe los espacios sociales de interacción homoerótica como los cabarets. Existen otros registros de las primeras cirugías de reafirmación de género genital en otros países como los de Christine Jorgensen (USA); Roberta Cowell (Reino Unido); Michael Dillon (Inglaterra); Waldirene Nogueira (Brasil).

¹⁶ Para más información se puede consultar el siguiente libro *Astounding Case of the Man Who Was Changed Into a Woman*. Clipping. 1933. *Digital Transgender Archive*, <https://www.digitaltransgenderarchive.net/files/r207tp49k> (accessed May 10, 2022).

retratada en la película *The Danish Girl* (Hooper, 2015). En 1930 Lili decidió practicarse diferentes cirugías para realizar su tránsito de género, entre ellas la cirugía de “cambio de sexo”

e implantación de útero, realizadas en la primera Clínica de Sexualidad (Institut für Sexualwissenschaft) en Alemania dirigida por el doctor Magnus Hirschfeld.



Sin embargo, en el libro *Others of my Kind* (2020) lxs autores exponen que en 1912 el cirujano berlinés Richard Mùhsam realizó operaciones de reafirmación de género (p.135). Para las mujeres trans estas intervenciones eran más sencillas de realizar (la castración) por el avance de la ciencia y porque pudiendo asumir muchos riesgos lo podían realizar sin un médico y sobrevivir; práctica que actualmente se realiza por la desigualdad social colombiana y las barreras que existen en el acceso a la salud para las personas trans.

“Quería eliminar mi testosterona de raíz. Estaba sola y dije: “¡Hay que hacerlo!”. Me compré un cuchillo bonito que brillaba por todos lados. Tenía un bisturí de esos que cortan papel lija grueso, cordel transparente y un espejo chiquito.” (Relato La canción que quiero ofrecerte de Lorena Daza con la colaboración de Mariana Restrepo del libro Encorazonadas. Memorias trans desde el barrio Santa fé, 2020).

Sin embargo, los hombres trans debían recurrir a los médicos para poder hacerse la mastectomía y la extirpación del útero. Es importante señalar que antes de las cirugías de reafirmación de género genital existían personas que se travestían como bien se relató en el apartado anterior. Por ejemplo, en Colombia se encuentran algunos registros, en el artículo de Carolina Botero (2001) llamado *Homoerotismo femenino en la Nueva Granada (1745-1822)* se enuncian mujeres que se vestían de atuendos utilizados en oficios que realizaban en su mayoría hombres, tal es el caso de la mulata Jonatás que se encuentra en la historia como la

esclava de Manuela Saenz, la libertadora, de Jonatás se decía que siempre iba vestida de soldado.¹⁷

Desde los relatos de los cronistas acerca de las Amazonas se sabe que estos arquetipos ya existían. Tres de las mujeres tienen rasgos masculinos (...) Las características de estas mujeres en la Nueva Granada oscilan entre llevar ropas de hombre, dedicarse a los oficios y a la subsistencia sin recurrir a los hombres, participar en las tertulias e incluso en ciertas acciones militares independentistas. (p. 37).

Al respecto, me pregunto ¿Cuál es la episteme que conduce a la práctica de la cirugía de reafirmación de género? Me encontré con la producción escrita del doctor Hirschfeld en la cual expone su teoría de los tipos sexuales intermedios. En su libro *Sexualpathologie* (1917) muestra que existen dentro del desarrollo sexual dos extremos considerados como “normales” y que los estadios intermedios son anomalías provocadas por un desbalance hormonal en el proceso de crecimiento de los seres humanos, así afirma: “una de las leyes más importantes del desarrollo sexual cuyo conocimiento es esencial para la relación entre los trastornos sexuales consiste en que los signos sexuales del hombre y de la mujer no son inmediatamente reconocibles como tales, sino que se desarrollan a partir de una base indiferenciada común a todos los seres humanos” (Hirschfeld. 1917. p.2). Es así como a lo largo del libro se encuentran casos de sus pacientes (p. 10; p.81; p.74; p.175; p. 189; p. 197) que encarnan los tipos sexuales intermedios: Hermafroditismo, Androginia, Homosexualidad y Travestismo.

Uno de estos casos es el de un joven llamado A que es descrito como un varón pero que según Hirschfeld¹⁸ no cumple con todas las características asociadas a lo que produciría las células de Leydig¹⁹ o células intersticiales en un cuerpo humano, entre esas, el tamaño testicular, así que el médico le propone a A hacer un implante de testículos, que ya se habían realizado con anterioridad en 1915 por el doctor Steinach en Viena a excombatientes de la primera guerra mundial.

¹⁷ Quintero, Inés, Mirar tras la ventana, Testimonios de Viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo XIX. Transcripción de Boussingault (1822-23), Alter Libris y secretaria UCV, p. 158. Disponible en el siguiente enlace: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/53100/Homoerotismo%20femenino.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

¹⁸ Encuentro interesante la manera en cómo narran la descripción anatómica de estos cuerpos que hoy por hoy se denominaría como intersexuales.

¹⁹ Son células del tejido del testículo que producen esteroides.

Es así como Hirschfeld²⁰ vislumbra que podrían existir intervenciones quirúrgicas u hormonales para propender el bienestar de personas denominadas para la época como hermafroditas y eunucos, y que de acuerdo con sus ideas el malestar se disminuye si la persona volvía al curso del desarrollo sexual “normal” que no sólo se restringe a el ser varón o hembra sino al desarrollo vinculado con la adultez. Éste último aspecto será muy importante, ya que, las personas que no se encontraban con características como: el tamaño genital esperado, la anatomía asignada a hombres y a mujeres, incluso el comportamiento deseado socialmente; serían infantilizadas, en tanto, no lograban la madurez sexual y no podían tomar sus propias decisiones.

De alguna manera, al pasar el tiempo esta concepción se volvió una idea universalizante y de obligatorio cumplimiento, de este modo, se elaboraron una serie de requisitos y pasos para lograr el reconocimiento de una identidad a la que le atañen el concepto de “verdadera”, es decir, que para ser reconocida como una mujer o un hombre trans se debía haberse hormonado, realizado el cambio de nombre y el componente de sexo en los documentos, realizado intervenciones quirúrgicas. Cuando la prensa se enteró de la existencia de Christine Jorgensen contactaron a los médicos que la habían revisado y descubrieron que no tenía vagina, así que, escribieron en los periódicos que era un hombre alterado y que no era una verdadera mujer. El caso de Christine Jorgensen ha sido uno de los más seguidos y monitoreados por la prensa, lo cual, hizo que fuese un tema conversacional de orden público en Estados Unidos a mitad del siglo XX.

Luego de esto, Jorgensen viajó a Dinamarca para realizarse una orquiectomía²¹ y posteriormente, una vaginoplastia, procedimientos que ya se habían realizado con anterioridad. Es importante resaltar que la identidad de género de Jorgensen fué continuamente interrogada, así en una entrevista a una revista de la época la BBC señala que se le preguntó "¿Es usted mujer?", respondió: *"Parece suponer que todas las personas son hombres o mujeres... Cada persona es en realidad ambas cosas en diversos grados... Yo soy más mujer que hombre"* (BBC, 2022).

²⁰ Al mismo tiempo, es importante señalar que Hirschfeld hace parte de un movimiento de conocimiento sobre la sexualidad, encuentro a Karl Heinrich Ulrichs, un activista que produjo una serie de libros científicos y de literatura sobre el amor homosexual entre hombres llamados Uranistas; Margaret Sanger la fundadora de Planned Parenthood Federation of America; Alfred C. Kinsey quien realizó estudios sobre la sexualidad humana, realizando escalos sobre los grados de heterosexualidad y homosexualidad. Harold Gillies científico cirujano plástico que realizó una faloplastia a Michael Dilloquien

²¹ Orquiectomía es una intervención quirúrgica en la que se extirpan parcial o totalmente uno o dos testículos.

En la actualidad, estos requisitos sobre las cirugías de reafirmación de género genital para reconocer una identidad diversa están caducados y van en contra de la ley colombiana porque son acciones discriminatorias. Así como tampoco se necesita de un procedimiento hormonal o estético para ser reconocidx jurídicamente como una persona trans. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el documento *Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans: Un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans en Colombia* (2018), se encuentra:

“Le digo yo ‘cuando te refieras a mi refiérete como una mujer transexual’, y ella me dijo ‘ah pero entonces ya estás reasignada’ y yo ‘no, yo no tengo por qué responder a ti si yo soy reasignada o no para que tú me sigas transexual, simplemente dime transexual y ya, porque yo no tengo que abrir las piernas para que tú me digas transexual. [mujer trans, Cali]” (Min Interior, 2018p.14).²²

Esto a su vez refleja que el sistema médico opera desde el paradigma sexo-género binario basada en la verificación genital, lo transgresor que puede ser no identificarlo en el ejercicio profesional médico, es que se cree que ésta es una idea configuradora de todas las experiencias de tránsito de género. En este hilo, Simón Torres del consultorio psicológico Liberarte resalta que cada tránsito es distinto, no hay una receta, y por tanto, hay personas que son trans sin hacer ningún tipo de intervención y personas trans que se reconocen como no binarias. Al respecto la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) en las *Normas de atención para la salud de personas trans y con variabilidad de género* (2012) señala:

Los y las profesionales de salud mental no deben imponer una visión binaria del género. Deben indicar amplios márgenes para que las personas usuarias de sus servicios exploren diferentes opciones de expresión de género. Las intervenciones hormonales quirúrgicas pueden ser apropiadas para algunos/as adolescentes, pero no para otros/as. (p.18).

Esto no desdibuja con que muchas personas trans tienen la creencia de que el ser una mujer o un hombre de manera “definitiva” o “completa” es realizándose una intervención de

²² Este comentario se da en el marco de una pregunta sobre barreras de acceso a los servicios de salud.

reafirmación de género genital²³ y en cualquier caso deben estar todas las garantías para el cumplimiento de sus derechos:

Yo voy a ser mujer y me quiero hormonar y me voy a operar y no sé lo que tenga que hacer pero otras personas empiezan a dudar y empiezan a sentir que están en contra de uno como que quieren evitar ese cambio. Por ejemplo, el endocrino me preguntó que hasta donde yo quería llegar, yo dije yo quiero llegar a ser 100% mujer, ¿está segura? porque yo le dije que la vagina pues que se operan queda sensible, y el me dijo es mentira eso no queda sensible es un cuento chino. (Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales).

En la conversación con Anastacia se identifican tres aspectos importantes por analizar, los cuales están consignados en la columna de observación; en la segunda columna se encuentran las recomendaciones del Min Interior y PAIIS; finalmente, en la tercera columna un análisis propio al respecto.

Observación	Recomendaciones del Min Interior y PAIIS ²⁴	Análisis
Los profesionales de la salud pueden realizar intervenciones desde la creencia de alcanzar un tránsito de género binario y estereotipado, dicha creencia no permite ver la diversidad de cuerpos y de tránsitos posibles.	Es importante poder re enfocar la pregunta, que el endocrino le hace a Anastacia: “¿Hasta dónde quiere llegar?” significa que si hay una meta o un objetivo final. De acuerdo con este documento las preguntas deben tocar ciertos temas fundamentales:	Los tránsitos de género no pueden entenderse como el transcurrir de un punto de A, a un punto B para todxs las personas. Se ha descrito con bastante profundidad que los tránsitos son diversos existen personas que sólo quieren realizarse terapia de reemplazo hormonal (TRH) o no se quieren hacer TRH y

²³ En los estudios en inglés se encuentran como top surgery y bottom surgery para referirse a las cirugías que se hacen del ombligo para arriba como top surgery (cirugías de arriba) y las cirugías que se hacen del ombligo para abajo como bottom surgery (cirugías de abajo).

²⁴ El documento citado es: Ministerio del interior & PAIIS (2018). Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans*: un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans* en Colombia. Bogotá: Ministerio del interior.

	*Sobre las necesidades de las personas trans para sentirse realizadas y satisfechas con sus cuerpos. (p.124) *Sobre las redes de apoyo con las que cuenta cada persona. (p.88) *Sobre las expectativas y deseos sobre el ejercicio de la paternidad y la maternidad, ya que, a largo plazo, por las intervenciones se puede impedir esa posibilidad (p. 60) *Sobre los fármacos y los procedimientos artesanales que se hayan realizado con anterioridad. preguntas pertinentes es conocer qué fármacos ha tomado con anterioridad y si se ha realizado intervenciones artesanales (p.112).	quieren hacer un tránsito social de su expresión de género o quieren hacer eso más una intervención quirúrgica o varias. En fin, existen un montón de caminos posibles que no se pueden reducir a una receta. Por lo tanto, no existe esto de ser 100% mujer u hombre. Lo que al día de hoy tenemos es la escala del famoso médico pediatra y endocrinólogo Tanner sobre el desarrollo sexual, la cual es una escala que mide las diferencias físicas de acuerdo con el desarrollo sexual.
De lo expresado por Anastacia se infiere que relaciona el tener dudas sobre	En el documento se encuentran estas recomendaciones:	Este punto es fundamental porque tiene que ver con lo esencial del consentimiento

los procedimientos con poner en duda su decisión de tránsito de género. Esto supone un riesgo por no contar con la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones sobre su tránsito.	“b) reconocer los miedos de las personas trans* como parte de su condición humana y no como una amenaza para el tránsito de género; c) brindar soluciones y posibilidades más que un camino único” (157-158)	informado, las dudas sobre los procedimientos son clave para que las personas sepan cuáles son los factores beneficiosos, de riesgo y consecuencias que puede tener realizar una intervención de reafirmación de género cualquiera que esta sea.
En el momento en que Anastacia habla sobre sus dudas sobre la vaginoplastia se denota que el profesional a cargo no cuenta con la información suficiente para atender esta pregunta, y por el contrario, puede promover que Anastacia busque fuentes de información no formales para encontrar respuestas.	En el documento se encuentran estas recomendaciones: “En este sentido, se debe informar sobre aspectos relacionados con la procreación, la sensibilidad, el funcionamiento sexual, la morfología y fisiología final” (p.160). La desinformación puede provenir de una creencia y no de los datos y por lo tanto puede desincentivar la realización del procedimiento.	Esta recomendación del Min Interior existe para que las personas trans no recurran a información no científica o no calificada, que causan confusiones respecto a los procedimientos. Por ejemplo, en la entrevista con Anastacia que comenta: <i>“estaba leyendo el testimonio de otras transexuales o transgénero otras mujeres que han pasado por ese tránsito que si queda sensible y que han podido llegar hasta el orgasmo y que queda sensible, de hecho, que es trans y habló justamente de la primera vez que tuvo relaciones que perdió la virginidad y ella dijo que</i>

		<i>quedaba totalmente sensible que ella llegaba al orgasmo masturbándose y que ya la pareja que intente llegar a ese orgasmo es más complicado pero que si quedaba sensible.”</i> Esto evidencia que Anastacia recurrió a una fuente informal para obtener información de una decisión que es crucial para ella.
--	--	--

Cuadro de elaboración propia

En la conversación con Antonio (22 años. Bogotá) expone su punto de vista sobre su decisión al realizarse una intervención quirúrgica mediada por el acceso a la misma:

No, digamos que cuando empecé yo quería llegar a la faloplastia y ya y después no (...) yo digo que a medida que uno se va metiendo como en el tránsito e ir conociendo otros tránsitos, y siendo consciente de todos estos discursos de género, de que, del falocentrismo y que el pene no es ser hombre y todo eso y ya viendo como muy lejos una cirugía; pues uno como que también se adapta y reconoce y se para con la realidad y dice: "no, esto soy yo ya " que también la faloplastia es súper complicada son muchas cirugías, pues pierdes también la sensibilidad, sino la haces a través de tu EPS que son como en 20 años pues te toca pagar un montón de plata, y pues todas las personas o los hombres trans que yo conozco ninguno es, ninguno tiene mucho plata que digamos y también en reconocimiento al cuerpo, a través también de las experiencias con otras personas, es decir, como no tengo que pasar a hacer lo que se supone es hombre; yo soy un hombre y soy así y este es mi cuerpo y ya pues la faloplastia se ve como muy lejos y no tiene como tantos pros.

Aunque hay personas que les hace mucha ilusión y es crucial pues para mí, no. No sé si lanzarme a hacer esa comparación de "para la mayoría, no" porque claro que siempre

se, muestran los tránsitos en documentales, en todo lado de ah se hizo la faloplastia y ya terminó, ya es un hombre trans, no; o sea la mayoría que digo yo el 80% de los hombres trans estamos solo hormonados, muy pocos acceden muy fácilmente a cirugías.

Antonio expone que una de las barreras en salud son los tiempos, cuando resalta que por la EPS es muy demorado y que si se quiere realizar por particular implica tener recursos económicos suficientes para cubrirla. Es importante resaltar que las intervenciones de reafirmación de género genital están amparadas por la T-918 de 2012, sentencia que afirma que la EPS debe autorizar las cirugías de reasignación de sexo a las personas que precisen de ellas garantizando tener una vida en autonomía y dignidad. También, es importante decir que la faloplastia es una de las opciones que tienen las personas trans para realizar una intervención quirúrgica de genitales “masculinos”, la otra opción que se encuentra en nuestro país es la Metaidoioplastia la cual consiste en alargar el clítoris y la uretra para formar un pene de aproximadamente 5 cm.

De acuerdo con los lineamientos de la WPATH sobre las cirugías de afirmación de género muestran que éstas son muy seguras, que los efectos posteriores pueden tratarse de manera ambulatoria y que el porcentaje de arrepentimiento en adultos es del 0 a 4% (E. Coleman, et al. 2022. p. 128). En el estudio *Tendencias temporales en la cirugía de afirmación de género entre pacientes transgénero en los Estados Unidos* se encontró que mediante la revisión de la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados de USA de 37.827 casos de cirugía de afirmación de género genital desde el año 2000 hasta el año 2014 no se reportó ningún caso de muerte por la intervención. Adicionalmente, setenta y nueve estudios que tenían muestras pequeñas y falta de grupos de control/comparación reportaron que la mayoría de las personas trans que se realizaron un tratamiento quirúrgico de reafirmación de género genital están satisfechos con los resultados (Christienne, Carmesi & Barlow, 2022).

Quiero resaltar que no acceder al sistema de salud con la promoción de movimientos y leyes llamadas antigénero tienen repercusiones gravísimas para el bienestar de las personas trans y sus familias; además de representar un costo a mediano o largo plazo para el sistema de salud. De acuerdo con la encuesta realizada a 238 personas trans en el país, se reportó que el 65,6% admitieron que algún prestador les negó la atención en salud (Min Interior y PAIIS, 2018. p.100). Una de las consecuencias graves encontradas ha sido la realización de procedimientos

artesanales, los cuales, sería importante calcular cuál es su coste para el Sistema de Salud vigente.

*Yo soy real*²⁵ dice Candy Ferocity en el ballroom luego de que Pray Tell le dijera que tiene el cuerpo moldeado por una toalla y otros concursantes se burlaran nuevamente de ella, este es el segundo intento de Candy para concursar en la categoría *cuerpos sensuales*, con anterioridad le han dicho que no tenía el cuerpo que se necesitaba para ganar la categoría porque su cuerpo no era *juicy*; también le han dicho que si exprimieran su cuerpo éste no alcanzaría para un vaso de limonada. En su primer intento, Candy sale llorando y Angel le dice que sabe lo que significa sentir presión por no tener un cuerpo con curvas, luego vemos a Angel y a Candy yendo a consultar una doctora que es reconocida porque ha inyectado silicona a otras chicas les dice que: “se dedica a ayudar a otras chicas que como tu no tienen cómo pagar este tipo de procedimientos” Candy pregunta ¿no me dejará las nalgas llenas de bolas? frente a lo cual la doctora le dice que no. Angel dice que no quiere ese silicón en la sangre y le dice a Candy:- ¿Conoces a Lisa? la que anda agitada, eso no es asma, querida-.

Sin embargo, ninguna de las dos tiene para pagar mil dólares, por lo que salen del consultorio sin realizarse ninguna intervención. Posteriormente, Candy va donde una mujer que inyecta silicón de manera artesanal, ella le dice a Candy: -no lograrán pasar sin curvas, mírame los hombres se la pasan encima-. esta mujer cobra la mitad que la doctora, es decir, quinientos dólares, Candy se sorprende y le pregunta por qué cobra la mitad y ella responde que mientras la doctora le compra la silicona a un médico blanco de los suburbios, ella compra la misma silicona en Honduras por unos pesos. Candy se convence y voltea las nalgas sobre un sofá desteñido, todo el lugar parece muy sucio para este procedimiento, Angel al ver el lugar dice con voz tímida que esperará a ver los resultados en Candy para hacerse ella el procedimiento. No sabemos cuánto tiempo ha pasado y Candy tiene fiebre por la intervención que se hizo. Al igual que Candy existen muchas personas trans que se realizan procedimientos artesanales, los cuales por definición son aquellas intervenciones que están fuera del sistema de salud y que generalmente son asesoradas por un par desde la intención de mejorar la autoestima y disminuir la discriminación. Lo que el costo que esto representa son los efectos a la salud que pueden traer estos procedimientos de tipo artesanal.

²⁵ Este es el cuarto capítulo de la primera temporada de la serie Pose. Serie que está ambientada en los años 80's y 90's en Nueva York.

Por eso es esencial que:

1. No se sigan reproduciendo los discursos sobre la “normalidad” del sexo basado en un argumento médico biologicista.
2. Poner bajo cuestionamiento la forma en cómo hemos venido operando, asignando el sexo a partir de los genitales. Un asunto todavía vigente y por el cual se debate en términos políticos.
3. Comprender muy bien cuál es el ejercicio de lxs profesionales a cargo de la atención de personas trans que necesitan no dar por sentada información, sino que se pregunte sobre las necesidades de las personas, para brindar el mejor acompañamiento posible.
4. Hacer un ejercicio reflexivo sobre las creencias sobre la asignación sexual y la construcción del género que hacemos todas las personas.

Sistemas de producción corporal: Asignación de sexo por las hormonas

La forma en cómo las sociedades patriarcales han ejercido el control sobre el cuerpo ha cambiado en el tiempo, ya que, los sistemas se actualizan por la retroalimentación (postulado de la cibernética), y es así, como Preciado (2020) subraya que Foucault en *Historia de la sexualidad* teoriza sobre los sistemas de opresión por épocas: Régimen Soberano (antes- siglo XVIII) y Régimen Disciplinario (siglo XIX); Preciado propone comprender los procesos de producción de la sexualidad bajo el Régimen Farmacopornográfico (siglo XX), en donde el control no deviene de un externo, llamado sacerdote o médico sino del interior, con sustancias bioquímicas comprimidas a disposición de toda la población, entre estas sustancias menciona la píldora, el viagra, el prozac, la testosterona, los estrógenos, etc; y que tienen una característica fundamental: se autoadministran.

La Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) se suscribe bajo este movimiento o régimen farmacopornográfico y de la consolidación de la endocrinología como disciplina. En 1889 el doctor y científico Brown-Sequard declaró que se había rejuvenecido inyectándose una mezcla de extracto testicular de perros y cerdos “*El factor conclusivo fue que las inyecciones habían incrementado su fuerza y la longitud de su chorro de orina había aumentado un 25%*” (Botero,F y Acevedo, J. 2019. p.5) cuestión que me hace gracia de solo imaginarme al doctor Brown midiendo el alcance de su orina. Desde la antigüedad griega se sabía la correlación entre la masculinidad y los testículos, se ha registrado que los griegos considerados como ciudadanos castraban a los esclavos, de ahí viene la palabra eunuco, que significa guardián de la cama, figura que se conservó siglos después y a quienes los reyes tenían confianza para atender a “sus mujeres” porque habían sido desprovistos de la masculinidad. Como ya se había mencionado con anterioridad el fisiólogo y endocrinólogo Eugen Steinach realizaba trasplantes de testículos para los heridos en guerra luego de haberlo probado con conejillos de indias. En el artículo “Descubrimiento de la testosterona” (Jácome, A. 2009) nos cuenta adicionalmente que éste realizó en 1920 experimentos con extracto de sustancias de los testículos de ratas, al igual que Koch que para ese mismo año coló testículos de toros, estudio por el cual se le concedió el premio de Endocrinología.

El alma de este nacimiento endocrinológico permeó el siglo XX, se continuaron realizando experimentos extrayendo orina humana e inyectandola en otros animales para ver sus efectos y viceversa, así encontraron el compuesto de los estrógenos y su uso. Por ejemplo, en 1950, la

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología publicaría en su primer número el artículo *Diagnóstico del sexo del feto durante el embarazo* escrito por el doctor L.P.Klotz en 1949 en el que expone que basado en el método de Ascheim- Zondeck aplicado en conejos se podía conocer el sexo del feto. Este método consistía en poner una muestra de orina de la persona gestante en los testículos de una rata o en las orejas de un conejo, si los testículos se inflamaban o no daba como resultado un sexo u otro. Este método no sólo fue utilizado con estos fines sino para hacer pruebas de embarazo o detectar cáncer uterino. Al encontrar esto, me dá curiosidad pensar ¿Cómo una reacción de orden químico, fisiológico podía determinar el sexo biológico de un ser humano? y ¿Será que siempre hemos pensado en el dimorfismo sexual del binario macho/hembra o desde cuándo empezamos a leer el mundo de esta manera? ¿Considerarías tú que hoy en día el dimorfismo sexual binario está en quiebra?

Uno de los hilos históricos de la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) estuvo vinculada con el tratamiento de la menopausia. En 1942 la Administración de drogas y alimentos (siglas en inglés FDA) de Estados Unidos aprobó el uso de estrógeno equino conjugado (siglas en inglés CE) para el alivio de síntomas negativos de la menopausia -descritos de esa manera para la época- también usado para el cáncer de próstata en hombres, al mismo tiempo, hubo varios casos de muerte por tromboembolia así que se dejó de lado la investigación por algunos años (Sayegh, R., Awwad, JT. 2017. p.). Posteriormente, en 1963 el médico Robert A Wilson y la enfermera Thelma Wilson²⁶ (eran esposos) publicaron un artículo llamado *El destino de la mujer postmenopáusica no tratada: una llamada para el mantenimiento de los estrógenos adecuados desde la pubertad hasta la tumba* el artículo comienza diciendo “*se debe enfrentar la desagradable verdad de que todas las mujeres posmenopáusicas son castradas (...) los hombres no viven tanto como le llamado sexo débil*” (p.347).

En este artículo y en el libro *Feminine Forever*, los Wilson exponen que tienen la cura para que las mujeres, en palabras castas, no sean desechables para los hombres cuando empiezan su menopausia y sigan siendo mujeres, patologizando el envejecimiento femenino. Su solución ante este problema era lo que se empezó a llamar la terapia de reemplazo de estrógeno (sus siglas en inglés son ERT). Al respecto Houck, J (2003) en su artículo “*¿Qué quieren estas*

²⁶ Robert A. Wilson and Thelma A. Wilson, "The Fate of the Nontreated Postmeno- pausal Woman: A Plea for the Maintenance of Adequate Estrogen from Puberty to the Grave," J. Amer. Geriat. Soc., 1963, 11: 347-62, quotation on p. 3

*mujeres?": Respuestas feministas a "Feminine Forever", 1963-1980*²⁷ expone el componente misógino de esta idea al leer la menopausia como una enfermedad, ella expone citándolos: *"la menopausia no sólo les roba la salud, sino también la juventud, la feminidad y la sexualidad"* (p.104). Uno de los aspectos llamativos de este artículo es que las opiniones sobre los Wilson dentro del movimiento feminista estuvieron divididas, unas resaltaron la importancia de haber encontrado una cura frente al malestar que experimentaban las mujeres durante la menopausia mientras otras propusieron abordar la menopausia desde el feminismo y reflexionar sobre la relación médico-paciente.

La gestión de la salud de las mujeres sobre la menopausia, no fue el único asunto donde hubo una división de opiniones respecto a la autonomía del cuerpo de las mujeres, otro tema en disputa fue el control sobre la reproducción. Una de las grandes píldoras fue la pastilla anticonceptiva, su existencia ha permitido que las mujeres puedan tener control sobre la fecundación y gestionar la reproducción. Al mismo tiempo, Preciado nos cuenta que fundamentalmente la píldora se creó para que las mujeres negras no tuvieran hijos, es decir, expone un origen racista de la píldora:

"La primera píldora anticonceptiva fue inventada, casi por error, por Gregory Pincus y los laboratorios Searle en 1951 (...) descubrimos con sorpresa que la píldora emerge en el marco de una investigación experimental de ayuda a la procreación de familias blancas católicas estériles (...) Los procesos de investigación y de evaluación de su eficacia técnica deja al descubierto sus raíces coloniales: la acción y la eficacia de la primera píldora anticonceptiva será evaluada en la Isla de Puerto Rico (...) La píldora funciona como una pieza semiótico-material (...) clave dentro de la gramática racista cultural occidental, obsesionada por la contaminación de los linajes, la pureza de la raza, la separación de los sexos y el control de los géneros (p. 131-132)

Entonces, la píldora tiene una raíz colonizadora, patriarcal y racista, de la idiotez mencionada como "supremacía blanca" y quiero decir con esto, que el blanco no es respecto al color de la piel sino a la posición social que legitima la concentración del poder de unxs sobre otrxs de manera asimétrica. Adicionalmente, no se han hecho muchos avances al respecto, hasta la fecha, si hacemos un balance entre los métodos anticonceptivos para hombres y mujeres: 1.

²⁷ "What Do These Women Want?": Feminist Responses to "Feminine Forever", 1963-1980. *Bulletin of the History of Medicine*, 77(1), 103-132. <http://www.jstor.org/stable/44447695>

No hay ningún método hormonal anticonceptivo para los hombres y 2. Hay dos métodos anticonceptivos para hombres y el resto para las mujeres.

Con esto, se denota que la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) no surge para las personas trans y en la actualidad esta terapia atiende a diferentes casos vinculados con la menopausia, el cáncer, la fertilidad.

Cristina²⁸ La Veneno está de vuelta en Valencia, España luego de salir de la cárcel, Valeria que es su fan logra conocerla y frecuentemente va a la casa de Paca -mejor amiga de Cristina- allí Valeria conoce a otras mujeres trans y una de ellas le da las hormonas que le ha recetado su doctor, así Valeria empieza a hormonarse de forma oculta, luego vemos que Valeria aún con miedo a ser rechazada, le cuenta a su madre que quiere empezar a hacer su tránsito de género. Lo mismo pasa con Cristina que es asesorada por una mujer trans que asiste al hospital y trabajaba en el Parque del Oeste en Madrid. Andrea García (2009) sostiene que *“en los contextos travestis son comunes la automedicación y el consumo de altas dosis de hormonas femeninas: estrógenos, etinilestradiol y progesterona en pastillas o inyecciones, así como la realización de implantes caseros y artesanales a base de aceites de cocina o siliconas industriales en el cuerpo.”* (p.139).

Se ha encontrado que la razón de la administración de hormonas se debe a que se quiere minimizar los efectos adversos como la discriminación y se ha relacionado con un aumento de la autoestima y confianza.

“No, nadie, yo siempre fui sola. Mi mamá me echó de la casa como a los 18 años, ella nunca me acogió, ella si fue desde que yo empecé a tomar hormonas la primera semana a los 14 años, ella se dió cuenta de todo y nunca me apoyó y ella pues no, yo a veces lo asimila o anda con dos adelante y dos hacia atrás.” (Entrevista con Emilia, 23 años, Manizales)

También, en las entrevistas se encontró que lxs jóvenes no tenían información sobre los efectos a la salud que podría traer autoadministrarse hormonas sin la supervisión de unx especialista, los riesgos que esto puede traer atienden a toda persona que consuma hormonas independientemente del fin con el que lo haga. Esto, es muy importante tenerlo en el horizonte porque lleva décadas de investigación y pueden traer consecuencias muy graves para la salud:

²⁸ Esto se ve en el segundo, tercer y cuarto capítulo de la primera temporada de la serie Veneno.

“Enfermedad tromboembólica, disfunción hepática, desarrollo de hipertensión, cálculos biliares, migrañas, retención de líquidos, además de otras condiciones relacionadas con el empleo de dosis elevadas de estrógenos como alteraciones en la producción de prolactina, resistencia a la insulina y desarrollo de tumores dependientes de dicha hormona” (Min Interior y PAIIS, 2018. p.35)

En esta entrevista se encuentra que la administración de hormonas se realizó de manera oculta y se buscaba tener un mecanismo que impidiera o bloqueara el proceso de masculinización hormonal. Además, se debe tener en cuenta que muchos medicamentos utilizados para hormonarse son de venta libre y de fácil acceso.

Tenía trece años y por mi parte tomaba hormonas a escondidas por eso no desarrollé ciertas características como manzana de Adán, voz grave, vello en el cuerpo. Entonces, pero interrumpido y no era vigilado por esa área de la salud. Pero ya como tal totalmente vigilado pues controlado en endocrinología y pues ya con los profesionales de psicología y psiquiatría desde hace un año y medio por la EPS con el apoyo de mis padres, pues mi familia, mis amigos, mi entorno social, mis vecinos” (Entrevista con Anastacia, 16 años, Manizales).

Según, Tangpricha, V., & den Heijer, M. (2017) se ha encontrado que los riesgos de la TRH son mínimos cuando existe supervisión. En Colombia, la sentencia T-771 de 2013 declara que las transformaciones corporales de las personas trans no son de carácter estético, sino funcional. Adicionalmente, dice que ser trans no puede comprenderse como una enfermedad o un trastorno mental, las barreras para acceder a la salud, pone en riesgo la vida de las personas. En el año 2022 salió la sentencia T-218 que aborda el acceso a los tratamientos hormonales afirmativos de género para menores de edad, cuestión que me parece fundamental abordar porque los relatos expuestos con anterioridad pertenecen a la adolescencia de estas personas y es de denotar que las intervenciones en adolescentes tienen otro proceso que se relaciona con la administración de bloqueadores de pubertad.

A grandes rasgos lo sucedido es que un joven de 16 años interpuso una tutela debido a que había sido diagnosticado con disforia de género, estaba asistiendo a las consultas con especialistas, y la endocrinóloga pediátrica le dijo que la terapia hormonal era para mayores de

edad, cuestión que representó una vulneración a sus derechos²⁹. Adicionalmente, no hay ninguna reglamentación que exprese que se debe cumplir la mayoría de edad para realizar estos procedimientos, por el contrario, se debe hacer una evaluación sobre la facultad de la persona para dar un consentimiento informado sobre las intervenciones, incluso, si es preciso hacerlo de manera escrita, pero esto no se correlaciona obligatoriamente con la edad, es decir, la edad es un factor, pero no el único. Con la misma edad de este joven no veo a alguien pegando gritos en el cielo cuando una joven de 16 años queda embarazada y ejerce la maternidad.

Siendo este el escenario, -como se explicará en el capítulo correspondiente a salud- el consentimiento debe tener según la ley tres requisitos: libre, informado y cualificado. Frente a este último criterio tiene que ver con la información suministrada al paciente para tomar una decisión, esto implica explicar las complejidades de las intervenciones (implicaciones y efectos) y cómo funciona el sistema de salud.

En consecuencia, me parece relevante esbozar los siguientes puntos de acuerdo al caso presentado:

1. La idoneidad de la intervención es una que tenga evidencia médica disponible. Es crucial conocer cuáles son las evidencias médicas sobre la TRH en adolescentes. Los beneficios de la supresión de la pubertad se realizan para dar atención de los sentimientos angustiosos de los adolescentes y sus cuidadores por no haber una conformidad con la imagen corporal deseada. (Vrouenraets, et al 2022 & Vries, et al 2021). Además, se ha estudiado que si se accede de manera pronta a la TRH hay más satisfacción con la vida en comparación con las personas que lo hacen tardíamente (Vries et al, 2011). En ese sentido, le profesional tratante debe atender a las necesidades de las personas trans por encima del gasto que podría suponer su intervención al sistema de salud. (Mejía, J. 2021).
2. Existen dos términos diferentes: la supresión de la pubertad (en inglés sus siglas son PS) y el tratamiento de afirmación de género (en inglés Gender Affirming Medical Treatment GAMT). Es importante hacer esta diferenciación debido a que el tratamiento GAMT conlleva efectos irreversibles en la masculinización como engrosamiento de la

²⁹ Es de puntualizar que otras ocasiones en la que se ha debatido sobre la capacidad de decisión sobre procedimientos médicos ya se ha realizado con anterioridad, frente a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia.

voz y aumento del tamaño del clítoris; y en la feminización el crecimiento mamario y la infertilidad. Al respecto el estudio de Vrouenraets et al (2021) afirma que este proceso se desarrolló como un mecanismo para “*brindar tiempo para la exploración antes de buscar un tratamiento médico de afirmación de género (GAMT) con efectos irreversibles*” (p. 428) un tiempo para lxs adolescentes, lxs cuidadores (para el acoplamiento al nuevo rol de género asumido por su hijx) y lxs médicos (para la realización de un diagnóstico mejor desarrollado).

3. La edad no es la única variable para que alguien tome una decisión sobre la TRH así lo dice la Corte Constitucional en la T-218 de 2022 “*no impongan condicionamientos de edad para el suministro de tratamientos hormonales de afirmación de género a personas menores de edad*”.³⁰ esto como una medida de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad. Para la Corte Constitucional un menor NNA tiene la autonomía para decidir sobre su cuerpo.
4. Es importante reconocer la magnitud de los procedimientos, es por esto por lo que, se recomienda revisar el artículo *Género disfórico/género incongruente. Terapia hormonal en adultos*³¹ en las que se exponen los efectos de la terapia hormonal en mujeres y hombres trans, las hormonas que se usan para la TRH y recomendaciones sobre el seguimiento de la TRH. Frente a esto se tomarán dos tablas del estudio *Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans: Un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans en Colombia* (MinInterior y PAIIS, 2018. p.146 y 149) que exponen los efectos en el tiempo de la feminización y de la masculinización.

³⁰ Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-218-22.htm>

³¹ Sierra Osorio, AM, Rivera, MA, & Tovar, H. (2018). Género disfórico/género incongruente. Terapia hormonal en adultos. *Revista Colombiana De Endocrinología, Diabetes & Metabolismo* , 5 (4), 32–36. <https://doi.org/10.53853/encr.5.4.452>

TABLA 3²²: Efectos* en el tiempo del tratamiento de masculinización**

Efecto	Inicio esperado	Máximo efecto	Reversibilidad
Aumento de grasa en la piel/acné	1 a 6 meses	1 a 2 años	Reversible
Crecimiento de vello facial y corporal ¹	6 a 12 meses	4 a 5 años	Irreversible
Alopecia androgénica ¹	6 a 12 meses	Variable	Irreversible
Aumento de masa muscular/fuerza	6 a 12 meses	2 a 5 años	Reversible
Redistribución de grasa corporal	1 a 6 meses	2 a 5 años	Reversible
Ausencia de la menstruación	1 a 6 meses	²	Reversible
Aumento del tamaño del clitoris	3 a 6 meses	1 a 2 años	Irreversible
Atrofia vaginal	3 a 6 meses	1 a 2 años	Reversible
Engrosamiento de la voz ¹	3 a 12 meses	1 a 2 años	Irreversible
Infertilidad	Variable	Variable	Irreversible
** Tabla adaptada de Endocrine Society [190-191].			
*** Diferentes autores confirman estos efectos [24,37,116,179,183,185,187,189,190,191,193,202,203,204,205,206,207,208].			
1. Dependen de factores hereditarios y de la edad			
2. La menorragia requiere diagnóstico y tratamiento por ginecología			

TABLA 5²²: Efectos* en el tiempo del tratamiento de feminización.**

Efecto	Inicio esperado	Máximo efecto	Reversibilidad
Redistribución de grasa corporal	3 a 6 meses	2 a 3 años	Reversible
Suavización de la piel	3 a 6 meses	Desconocido	Reversible
Disminución de la oleosidad de la piel	3 a 6 meses	Desconocido	Variable
Disminución de la libido	1 a 3 meses	1 a 2 años	Reversible
Disminución de erecciones espontáneas	1 a 3 meses	3 a 6 meses	Variable
Disfunción sexual masculina	Variable	Variable	Variable
Crecimiento mamario	3 a 6 meses	2 a 3 años	Irreversible
Disminución del volumen testicular	3 a 6 meses	2 a 3 años	Variable
Disminución de producción de esperma	Variable	Variable	Variable
Pérdida y crecimiento desacelerado de vello facial y corporal ¹	6 a 12 meses	+ de 3 años	Reversible
Alopecia androgénica [No hay rebrote]	Pérdida se detiene a los 6-12 meses	²	Reversible
Infertilidad	Variable	Variable	Irreversible
** Tabla adaptada de Endocrine Society [190-191].			
*** Dependen de factores hereditarios y de la edad. Diferentes autores confirman estos efectos [24,37,116,179,183,185,187,188,189,190,191,193,202,203,204,205,206,208,214].			
1. La eliminación completa del vello facial y corporal requiere tratamiento láser			
2. La pérdida de pelo puede ocurrir si se suspenden los estrógenos.			

Las hormonas para los hombres trans³² son la testosterona parenteral y transdérmica y para mujeres trans son los estrógenos y los antiandrógenos. Dicho esto, es preciso estar al tanto del seguimiento de los procedimientos en cuanto a la TRH para personas trans, a continuación realizo un cuadro que expone de manera gráfica la información sobre las recomendaciones del artículo citado con anterioridad (Sierra Osorio, AM, Rivera, MA, & Tovar, H. 2018.p36) y las

³² Las hormonas que son para personas trans se encuentran en el estudio de Min Interior y PAIIS en las páginas 145 y 148. En este documento también encontrarás el listado de los exámenes que se deben realizar para empezar el proceso de TRH en las páginas 141, 142 y 143.

consignadas en el documento *Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans: Un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans en Colombia* (MinInterior y PAIIS, 2018. p.140 y 141).

Mujeres Transgénero	Hombres Transgénero
Evaluar a la paciente cada tres meses durante el primer año y luego una o dos veces al año para controlar los signos de feminización o masculinización y desarrollo de reacciones adversas.	
Lograr metas bioquímicas del tratamiento.	
Una correcta evaluación clínica para generar un diagnóstico acertado, teniendo conocimiento en: -Los exámenes de laboratorio mínimos que se deben hacer a personas que están en terapia de reemplazo hormonal (TRH). -Analizar los cambios observados en los valores de laboratorio de personas trans en TRH. -Los esquemas, efectos y riesgos de la TRH en personas adultas, niños, niñas y adolescentes.	
Una correcta intervención individual, teniendo en cuenta un análisis situacional puntual de la persona que consulta, con el fin de proponerle un plan de tratamiento fundamentado en la evidencia científica más relevante hasta el momento.	
Si está recibiendo manejo con espironolactona, debemos medir electrolitos, particularmente el potasio, cada tres meses durante el primer año y anualmente a partir de entonces.	Medir hematocrito o hemoglobina al inicio del tratamiento y cada tres meses durante el primer año y luego una o dos veces al año.
Se recomiendan exámenes rutinarios para detección de cáncer (todos los tejidos presentes), como en individuos no	Realizar examen de mama anual, sub y periareolar si se realiza mastectomía. Si la mastectomía no se realiza, considerar mamografías según lo

transgénero.	recomendado por la Sociedad Americana del Cáncer.
Considerar medir DMO al inicio del tratamiento. En personas de bajo riesgo, el examen de detección de osteoporosis debe realizarse a los 60 años o en aquellos que no cumplen con la terapia hormonal	Detección de osteoporosis debe realizarse en aquellos que dejan de recibir tratamiento con testosterona, que no cumplen con la terapia hormonal o que desarrollen riesgos de pérdida ósea
	Monitorear peso, presión arterial y lípidos a intervalos regulares (individualizando cada caso).

Cuadro de elaboración propia

Preguntas frecuentes

Esta noción de “el verdadero sexo” permea aún la lógica con la que se pregunta sobre la identidad sexual³³. Son incontables las entrevistas a personas trans en las que les preguntan ¿Cómo te diste cuenta de que eras mujer u hombre? Generalmente la pregunta afirma y se refiere a ¿Cómo se develó esa identidad en ti, anteriormente ocultada?

Por la forma en cómo el discurso naturalista se ha configurado como origen de todo, verdadero y estático, las respuestas tendencialmente han tenido este tinte. Muchas de ellas son: “yo nací así”, o “desde que estaba pequeñx jugaba con... o no me sentía conforme con mi genitalidad...u odiaba mi cuerpo... o no me vestía de tal forma... o no me atraía...”. Así mismo, se encuentran opiniones del tipo “nacé en el cuerpo equivocado”, respuesta que también llama mi atención porque habla del error cometido por la naturaleza, y es allí donde hay una paradoja porque es la misma naturaleza la que ha engañado a la naturaleza, y para el siglo XX se torna entonces

³³ Para el siglo XIX el término usado era la personalidad.

una cuestión sobre el origen y la confiabilidad de las pruebas, ya no sobre los genitales, sino sobre los genes.

Sin embargo, la primera parte de la pregunta me llama la atención, que es sobre el darse cuenta. ¿Cómo te diste cuenta de que tú eras tú? y ¿Cuándo decidiste cambiar tu modo de vivir? Es aquí cuando estas preguntas abordan un mínimo de oportunidad de decisión sobre el cuerpo y sobre sí y aparece en el escenario con mayor fuerza otra epistemología: el construccionismo.

Mi derecho nominal: Asignación de sexo por nombre

Pasaron 16 años hasta que alguien tomó la lista y dijo código 36 ¿Qué nombre quieres que ponga? afortunadamente no dió ninguna sugerencia no pedida y rápido, antes de que lo pensara, le dije: Mariano. Así, tuve escrito el nombre que yo elegí en la chaqueta de mi promoción. Era más que un saco de la promoción del colegio, ésa era yo reportando mi no conformidad con la estaticidad, yo me lo podía quitar y poner, podía ser ambos nombres y a la vez ninguno.

Emilia me mira y me dice: ... “-y la chaqueta de la prom, yo estaba en once, y la chaqueta de la prom tenía que tener el apodo que uno quisiera, el nombre, yo me llamo Emilia, entonces yo, Emi. (refiriéndose a la rectora de su colegio dice lo que ella le dijo)

Rectora: - tiene que quitarle ese nombre por el nombre que es

Emilia relata: -y yoo no me pintaba el pelo, pero me tuve que pintar el pelo.

Rectora: y no puede decir que es mujer

Emilia relata: y yo en ese tiempo. En ese tiempo todavía no existía la ley que existe ahora para las niñas de los colegios nada de uniformes ni nada, yo fui a secretaría de educación y nada. (...) Y ella me iba a echar y una de las condiciones para que no me echara fue que me llevaran a un psicólogo porque yo tenía problemas”

¿Cómo era eso posible? Emilia no sólo pasó por un psicólogo sino por una serie de instituciones y de situaciones que buscaban “normalizar” su existencia y con esto erradicar la identidad de Emilia como Emilia. Foucault ha señalado en sus libros que el nombre es un significante que nos posibilita habitar el mundo frente a nosotros y el otrx. Recuerdo que mi padre cambió su nombre a otro nombre masculino, en ese sentido, el cambio de nombre no parece un problema, pero ¿Cuán distinto hubiese sido si lo hubiese cambiado a un nombre femenino? ¿Con qué situaciones se habría enfrentado? ¿Se le hubiese pedido modificar su apariencia por su nombre?

El lenguaje no sólo es un campo de disputa, es la oportunidad para crear mundos y como el mismo Preciado (2019) lo escribió para cruzar fronteras.

El cambio de nombre es una arista de lo que Judith Butler³⁴ nombra *el carácter performativo del género*, básicamente sostiene que el ser humano es performativo por el atravesamiento de

³⁴ Ver Butler, J. (1999). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós: España.

las creencias, de los rituales y de los gestos socialmente compartidos. Es importante denotar que la performance no pertenece a un medio en específico, no significa que porque traduce performática aluda a lo público, por el contrario, es más una condición humana y cada vez esta barrera entre lo público y privado, es borrosa con las redes sociales y la internet ya hace muchos años. Ahora bien, existen por supuesto unas instituciones de verificación de la identidad que a pesar de su tecnificación siguen conviviendo con instituciones de antaño. Una de estas instituciones es tener un documento de identidad vinculada con la pertenencia a un territorio (estado-nación).

Un ejemplo³⁵ de lo descrito con anterioridad sucedió en el año 2013, la artista performática y DJ Lady Zunga³⁶, decidió cambiar su nombre en su cédula por el siguiente: ABCDFG HIJKLMN; y tener como apellido: OPQRST UVWXYZ. En una entrevista, Lady, como también prefería que la llamaran, cuenta que pasó por tres notarías para hacer este proceso, aún con la existencia de las sentencias, su cambio de nombre fué negado en dos notarías. Así mismo, Lady le dijo a la BBC que “Siempre me estaban clasificando con letras: que LGTB, que HC (hardcore), BDSM, entonces quise que mi nombre significara que yo soy todo eso, pero a la vez soy nada”. De esta manera, Lady devela de una forma muy creativa que la institución jurídica es un aparato de producción y de verificación de las identidades y que las organiza desde el género, el sexo, pero también el idioma, el territorio, la edad, la movilidad social; lo problemático deviene de haberle negado en dos oportunidades a Lady, su nombre, por una suerte de moralidad social de cómo las personas deberían llamarse. Es entonces, estas notarías las que le han fallado a Lady y a toda persona que no cumpla con el estándar.

Acróstico para ti

A de Abierta

B de Borrada de facebook más de una vez

C de Cyborg, callejera

D de ¿De cuánto cuesta ser?

³⁵ Otro ejemplo fué el de Paul Preciado, quien en su libro “Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce” narra cómo fué el proceso para escoger su nombre, así, nos cuenta que en algún momento pensó escoger el nombre de Marcos devenido del subcomandante Marcos del EZLN quién anunció en el año 2014 dejaría de existir Marcos para ser Galeano, éste nombre le era apetecido porque era como una máscara. Sin embargo y posteriormente se decidió por el nombre de Paul, un nombre que le llegó en sueños y con el que se sintió cómodo. Así, las firmas en los artículos que escribía dieron cuenta de su proceso de tránsito.

³⁶ Para ampliar información revisar el siguiente artículo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150219_sociedad_nombre_ladyzunga_amv

E de ElectroPunk
F de Fenómeno, fetish
G de Gata a lo Hello Kitty
H de Hago lo que quiero
I de Informal
J de Jirafa
K de Kitsch
L de Latex
M de Mágica, monstruo
N de Ni una más
Ñ de Ñame como yo quiero, así a lo mal habla'o
O de Oh-culta
P de Pinchar o de pichar también
Q de ¿Qué pasa si no me defino?
R de Reina, ¿no Lady?, rediseño
S de Suelta
T de Transformación, tacones, tecno
U de Ultravioleta
V de Vistosa
W de Welcome back
X de XX, XY, es muy equis esto de definimos con el DNA o DNI
Y de ¿Y qué?
Z de Zunga, zorra.

Gracias Lady por tu valentía y por compartir tu performance. El primer derecho luchado y concedido para las personas trans ha sido la libertad de escoger un nombre. El nombre es una decisión personal y es un derecho³⁷ escogerlo consagrado en la sentencia T-594 de 1993 cada persona puede escoger el nombre que desee “sin importar si no corresponde con su sexo”; de acuerdo con la sentencia T-1033 del 2008 se puede cambiar el nombre por segunda vez; adicionalmente la sentencia T-977 de 2012 declara que el cambio de nombre no es vinculante

³⁷ En este link de la página web de la ONG Temblores, encontrarás el paso a paso del cambio del componente sexo tanto para personas mayores de edad como menores de edad. Link: <https://www.temblores.org/cambio-de-componente-de-sexo>

Estas son las tarifas oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el año 2021: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/resolucion_1656_del_24_de_febrero_de_2021.pdf expedidas en la Resolución 1656 del 24 de febrero del 2021.

con la orientación sexual. Todo esto en correspondencia al respeto por la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia).

La profesora e investigadora social Alanis Bello, quien me inspira amor,compasión y compromiso con la educación, dijo en una entrevista para Sentiido que:

“En mis trabajos yo exijo que me llamen Alanis porque es el nombre que yo elegí. Exijo que mi cuenta de correo y todos los documentos estén a ese nombre, así por ahora no quiera cambiar el nombre masculino que me otorgó mi familia. Sin embargo, un día, un ingeniero de sistemas me dijo que yo ponía en crisis el sistema porque estaba usando dos identidades. Yo le respondí que no estaba atentando contra nadie pero mucha gente nos ve como personas que ponemos en crisis a las instituciones.

Todos los fracasos de la humanidad son producto de pensar de manera binaria: “malos” y “buenos”, “negros” y “blancos”, “hombres” y “mujeres”, “heterosexuales” y “homosexuales”, lo que no permite otras pluralidades. Las personas que hacemos tránsitos tenemos que explicarnos todo el tiempo para poder sobrevivir. Somos máquinas pedagógicas con patas. Nos la pasamos explicando por qué no deben matarnos, por qué no deben clasificarnos, por qué no pueden jodernos. Es una situación tan desgastante que repercute en nuestra salud mental. Vivimos estresadas, con miedo de salir a la calle, de que nos peguen, nos maten, nos violen y no nos amen.” (Bello, 2019)

El sistema no se actualizó se quedó en el Windows 1.0, el ingeniero se equivoca al culparte, es él quién tiene la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios. ¿Qué pasaría si habitamos una sociedad que comprenda el devenir del yo como múltiple? ¿Por qué no ponerse un nombre cada tanto? ¿Por qué no tener un nombre colectivo en el que la individualidad se difumine?

Existen otros campos en los que el cambio de nombre tiene una mayor flexibilidad y aceptación social. Nadie se atreve a negar que Bad Bunny se llama Bad Bunny, en realidad, no es que él no sea Benito, él es Benito y Bad Bunny; así como bell hooks, decidió tener el nombre de su abuela y quitar las mayúsculas al mismo, no deja de ser Gloria. Justamente es el arte un espacio de libertad, en el que cada quién tiene el derecho de moldear su identidad, incluso ésto es deseable. Así que la defensa por la autonomía de la elección de nombre es imprescindible para cualquier persona que se lo pregunte.

Naturaleza: Alta tecnología y otros visajes políticos

Lxs mitá y mitá, lxs two spirits, lxs tercer género, lxs disidentes del género, lxs travas, lxs travestis, lxs transgénero, marica, bollera, torta, que se te quiebra la pierna y todo ese plumaje de dónde salió.

Tener una comprensión sobre las epistemes subyacentes y su historicidad nos permite saber desde qué lugar operan ciertos procesos y fenómenos. En este apartado pretendo comprender ¿Cuáles son las raíces epistemológicas de los buses discriminatorios “las niñas son XX y los niños XXY” o de las expresiones “es biología no ideología? ¿De dónde viene decir “es una mujer o un hombre por naturaleza”? ¿De dónde salió la noción de ideología de género?

En mi investigación me he encontrado que las dos grandes ideas que subsisten a los principales argumentos discriminatorios hacia las personas trans se constituyeron como los pilares científicos del siglo XVI:

Los hombres acceden al conocimiento científico, por lo tanto, son los portadores de La Verdad
y
La Verdad se encuentra en La Naturaleza

A modo de introducción de la primera premisa: los hombres acceden al conocimiento científico, por lo tanto, son los portadores de La Verdad; en los casos anteriormente expuestos son el médico y el clérigo los que deciden sobre el sexo de Alexina, Ramón y Martina. Estas premisas no se agotan en una cuestión sobre el sexo, sino que es la forma en cómo los científicos europeos se relacionaron con la forma de conocer el mundo desde el siglo XVI y que ha perdurado hasta la actualidad. En el libro Testo Yonki (2008) Preciado citando a Starhawk³⁸ (2003) expone que el genocidio a las “brujas” se relacionaron con otros cambios importantes, por ejemplo, que las prácticas de conocimiento se sumergieran en un proceso de profesionalización, en el que se pagaban a expertos con licencias para realizar ciertos trabajos como el de la partería.

Para el siglo XVI existían mujeres que ocupaban trabajos en la mayoría de los sectores de la economía europea. A la vez, existieron mujeres que tuvieron este tipo de profesionalización.

³⁸Starhawk (2003). Femmes, magie et politique. Les emprecheurs de penser en rond. Paris.

Sin embargo, desde la mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII las mujeres fueron poco a poco excluidas de los trabajos que ocupaban, con especialidad el de la partería, de este modo, Silvia Federicci señala: *“A principios del siglo XVII, comenzaron a aparecer los primeros hombres parteros y, en cuestión de un siglo, la obstetricia había caído casi completamente bajo control estatal”* (2004. p. 252). En consecuencia, el Estado tenía el control de la procreación y por tanto del cuerpo femenino su las mujeres eran quemadas en la hoguera *del mismo modo que los cercamientos expropiaron las tierras comunales al campesinado, la caza de brujas expropió los cuerpos de las mujeres”* (ibid.).

Ese poder de control también es de carácter correccional, una de las últimas escenas de la película *Boy’s dont cry* (1999), inspirada en hechos reales, muestra a Brandon Teena (un chico trans) antes de ser violado sexualmente - y asesinado en la vida real- a quien hacen pasar por un exámen de comprobación de su “verdadero sexo” cuándo el violador le baja los pantalones y su genitalidad “revela” que es una “mujer”. En el sistema heteronormativo los hombres son educados para tener el poder correccional sobre el cuerpo de las mujeres y más allá de esto, fromados para crear una identidad de la masculinidad basada en el odio por la feminidad. En este caso, Brandon es castigadx por el colectivo masculino. La genitalidad entonces es el veredicto final y la violación su forma correccional para eliminar a Brandon.

A la par, este mecanismo de control sucedió con el “género” y con otras ficciones de la diferencia³⁹ como “la raza” o “la clase social” por esto es importante saber cómo se configuraron. Al respecto, Donna Haraway (2004) en su texto *Testigo Modesto* dice esto que me parece ¡WOW!:

“Como indica la crítica literaria afroamericana Margo Hendricks (1992, 1994 y 1996), el concepto de “ser inglés” también estaba en juego en este periodo, por ejemplo, en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Además, anota, la historia del “ser inglés” fue parte de la historia de las formaciones raciales y genéricas modernas, basadas aún en linaje, cortesía y nación más que en color y fisionomía. Pero los discursos de “raza” que se cocinaron en ese caldero, que mezclaba naciones y cuerpos en discursos de linaje, fueron más que útiles en los siglos siguientes para demarcar los cuerpos diversamente sexuados de los pueblos “de color” a través del globo de las siempre inestablemente consolidadas posiciones de sujeto de los investigadores

³⁹ Digo ficciones porque son construcciones que fueron estrategias del sistema de colonización patriarcal en diferentes épocas. Sé que esta noción de ficción la han retomado una variedad de Autorxs como concepto.

cortes y auto-invisibles. El género y la raza no existieron nunca separados y nunca se trató de sujetos preformados provistos de genitales extraños y colores curiosos. En la raza y el género se trata de categorías relacionales, entremezcladas, proteicas y casi imposibles de separar analíticamente. Las formaciones (no las esencias) de raza, clase, sexo y género fueron, desde el principio, máquinas peligrosas e inestables para salvaguardar las ficciones y poderes principales de la masculinidad cortés europea. No ser masculino es no ser cortés, ser oscuro es ser rebelde. Tales metáforas han sido de enorme importancia en la constitución de qué puede contar como conocimiento.” (p. 21).⁴⁰

Lo anterior es importante porque Haraway expone que el Hombre de la Ciencia es el hombre cortés y que para acceder a la verdad debe cumplir con ciertas características como: la asexualidad (no erotismo), el control de las pasiones, la tranquilidad, la heterosexualidad y el ser “blanco”. Por lo tanto, las mujeres no podían participar de la ciencia europea, al estar vinculadas con lo “salvaje” y el descontrol de las pasiones; las mujeres que podían estar más próximas a una esfera sobre el conocimiento eran las herejes (mujeres laicas), las monjas, las brujas (mujeres con conocimiento de medicina) o las “trasvestidas”.⁴¹

Haraway (2004) retomando a Elizabeth Potter (2001) ilustran que ese hombre de la ciencia estaba volcado al logos su castración era la objetividad, de una forma apacible y fuera de las pasiones tenía la virtud de ver lo exterior, la naturaleza, y hablar de ella. Por el contrario, las mujeres, vinculadas con las pasiones, la naturaleza, lo salvaje eran los objetos de observación *“la modestia femenina era del cuerpo, la nueva virtud masculina tenía que ser la de la mente”* (Haraway, 2004. p. 22) y como ya he relatado con anterioridad, al mismo tiempo, las mujeres fueron poco a poco desposeídas del conocimiento sobre su cuerpo, con una técnica de horror: la caza de brujas. Esto como genocidio al interior de Europa y al mismo tiempo sucedió en el Abya Ayala con los pueblos indígenas. Esta configuración dotó a los hombres del poder del conocimiento y de la violencia para “dominar” a la “naturaleza”.

⁴⁰ Para conocer las relaciones constitutivas de género, raza y clase, Las Mayoras en este tema son las feministas negras, indígenas y chicanas, sólo expongo aquí a las que me he acercado: Angela Davis, Ochy Curiel, Gloria Anzaldúa, Yuderlys Espinosa, Mara Riveros, Cherríe Moraga, Silvia Paredes Cusicanqui, Kimberlé Crenshaw, Patricia Bell Collins, bell hooks, Audre Lorde, Sojourner Truth, Julieta Paredes.

⁴¹ Así, se denota que la sexualidad del hombre comienza a ser investigada científicamente, adicionalmente aparecen otros seres que desde los griegos hasta la modernidad en la historia occidental no eran reconocidos en su existencia política: las mujeres.

Esta visión sobre el yo “oculto” que puede ser develado por la razón es parte del romanticismo (Gergen 2007, p.43) así mismo, para ser develado se buscaba que la verdad fuera *observable* (empirismo). Además de esto, la sexualidad se vuelve de materia confesional y en poder de la institucionalidad, Foucault (2019) se pregunta “¿Cómo es que el hombre occidental fue destinado a volcar su deseo en palabras, para decirse y decir a otros su verdad más propia, la más íntima? ¿Cómo se ha convertido en sujeto de deseo y en animal de confesión?”. (Foucault, 2019. p. 4).

Una de las recomendaciones existentes para la atención de personas trans en el ámbito de la salud es que lx paciente sea participante activo de su proceso, esto se ha podido lograr luego de que el tránsito de género se despatologizara en 2018, es así como, las personas ganan autonomía y poder de decisión sobre cuerpo, además, en un doble sentido se encuadra el rol del médico como acompañante que sostiene una expertise en algún aspecto para que la persona pueda alimentar su bienestar.

Ahora veamos la segunda relación: la Verdad se encuentra en La Naturaleza. La ciencia que se configuró para acceder a la naturaleza fué la biología. En este mismo hilo, Donna Haraway en su libro Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza (1991) señala que:

1. A principios del XVIII: la biología cuenta historias sobre los orígenes, sobre la génesis y sobre la naturaleza. (p.114)
2. La constitución del sexo y del género como objetos privilegiados del conocimiento es una herramienta en la búsqueda del yo. Esta construcción regenera la infinita regresión de la búsqueda de un sujeto ilusorio que paradójicamente, suele terminar con el descubrimiento del objeto totalitario: la naturaleza, el gen, la palabra. (p.125)
3. La biología evolucionista en los siglos XIX y XX forma parte de los debates públicos sobre el lugar del hombre en la naturaleza -es decir, sobre la naturaleza de la política y la sociedad- (p.138).

Por lo cual, si la verdad se encuentra en la Naturaleza ésta misma la contiene como “historia inicial” y es desde la observación externa y objetiva que la podemos conocer. Por ello es importante comprender estas historias de origen que se han narrado desde la ciencia occidental porque en ellas encontramos los paradigmas desde dónde son pensadas y creadas.

En la entrevista con Sam (26 años, Manizales) ella cuenta cómo el psiquiatra le pregunta: “Entonces el me hizo preguntas de: desde mi niñez, que sentiste, desde

cuándo, por qué crees que lo quieres, qué te hace pensar que lo odias. Entonces yo le explico: doctor yo no miro básicamente lo que tengo ahí y me baño con ropa interior y si estoy frente a un espejo ni lo miro, para tocarlo me lavo las manos, me da asco total, desde que tenía como 14 años, yo me decía a mí mismo tengo un tumor porque yo me lo sentía como un tumor y entonces se fueron dando cuenta que no es delirio ni esquizofrenia sino una disforia y un rechazo total hacia una genitalidad que no debe estar ahí.”

Encontré que la autora del libro *El arcoíris de la evolución: Diversidad, género y sexualidad en la naturaleza y en las personas* Joan Roughgarden, se propuso cuestionar una de las ideas pilares de Darwin: la selección sexual; al encontrar que ésta había sido construida por un hombre inglés, religioso, del siglo XIX y que su teoría obedece a una época en donde, hacía sentido que los hombres fueran: machos fuertes con un deseo sexual inagotable y las mujeres: hembras dóciles y sumisas sin deseo sexual. Así, en este maravilloso libro analiza cómo operaran los estereotipos de género y la reproducción que utiliza el sexo en otras especies; además, muestra cómo la lectura que hemos hecho de otras especies está cargada de nuestra propia lectura humana. De este modo la autora señala:

“Utilizar categorías biológicas como si fueran categorías sociales es un error conocido como <<esencialismo>>. El esencialismo equivale a escurrir el bulto. En lugar de asumir la responsabilidad de a quien se considera socialmente un hombre o una mujer, la gente recurre a la ciencia intentando utilizar los criterios biológicos de un macho para definir un hombre y los criterios biológicos de una hembra para definir a una mujer. “(Roughgarden. 2004.)

En el libro expone que lo único que hace que en biología se piense en un binarismo sexual de macho-hembra es la diferencia que hay en el tamaño de los gametos: óvulos y espermatozoides. Sin embargo, expone que hay especies que tienen la posibilidad de producir ambos gametos o de cambiarlos de acuerdo con las necesidades reproductivas o de poseerlos y no ser parte de la reproducción. Me encontré entonces con ese gran arcoíris del que somos parte como especie perteneciente al fenómeno de la vida. A modo de ejemplificar un poco sobre cómo los estereotipos de género permean los discursos sobre el comportamiento de otras especies, voy a transcribir un video de National Geographic titulado “Las jacanas: hembras insaciables”:

*“Otras especies tienen todo el sexo que quieren sin correr ningún riesgo. Si existe una verdadera inversión de estereotipos sexuales entre la hembra y el macho es sin duda ésta, por todo el trópico algunas ágiles aves también están de orgía, éste es el desinhibido estilo de la jacana y éstas. las hembras de largas patas dispuestas a aparearse con cuantos más machos mejor, es sexo sin tregua, los machos parecen encantados de complacerlas, pero aunque solo alcanzan la mitad del tamaño que sus parejas tienen que hacer el doble de trabajo. Las jacanas no son como la mayoría de los pájaros en su mundo, el del macho, es el trabajo que nunca termina. Los padres tienen que proporcionar mucho más que esperma, se quedan sólo en casa para construir y defender los nidos, empollar los huevos y criar a los polluelos; mientras las madres encuentran un amante y otro y otro; a veces pueden practicar sexo con hasta cuatro machos en una hora. Pero este vecindario da para más que solo el simple cotilleo sobre promiscuidad de las aves de las marismas (...) entretanto la madre sigue ocupada con un vecino en una sola temporada podrá tener hasta treinta parejas distintas, este entorno exige tal animación sexual (...)”.*⁴²

Como vemos esta narración tiene el paradigma de la diferencia sexual Darwiniano en el que las hembras jacanas al igual que las hembras humanas deben quedarse en la casa siendo responsables de la crianza, además se sitúa a las jacanas como un caso excepcional a “la regla”. Por otra parte, la monogamia sigue siendo el sistema regulador de las especies en tanto no es normal que las jacanas tengan una reproducción tan activa, de este modo se usan los términos orgía y amante.

Cabe resaltar que según lo que muestra Roughgarden ni la monogamia, ni la hembra cuidadora de las crías, ni el macho que va en busca de recursos de supervivencia, son lo común en las especies animales y tampoco representan la mayoría.

Un gran point de la idea de la separación entre unxs y otrxs por características de acuerdo al tamaño de los gametos ha sido la cualidad para reproducirnos (generar vida) como especie, sin embargo, las tecnologías reproductivas han entrado al escenario borrando dicha separación (cabe resaltar que, esto funciona bajo la lógica occidental porque la separación binaria no ha estado en todo el mundo) tal como pasa en otras especies existen personas que pueden poseer

⁴² Transcripción propia del video Raul Espert. (2010). Las jacanas: Hembras insaciables. [Archivo de Video]. Recuperado de: <https://www.dailymotion.com/video/xdxch4>

los gametos sin participar de la reproducción o puede que existan problemas en la reproducción y contar con los de otros sujetos para su fertilización o se pueden trasplantar órganos que posibiliten la reproducción. La reproducción sexual por definición se refiere a que deben estar involucrados ambos gametos, quiénes los tengan y cómo se realice la reproducción es otra cuestión.

Es así como necesitamos volver a pensar cómo hemos leído el mundo. En este orden de ideas, la bióloga colombiana Brigitte Baptiste dió una charla TED en Rio Plata titulada “Nada más queer que la naturaleza” en la que ha expuesto cómo la teoría queer es una constante invitación a pensar la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos dentro de nuestros ecosistemas, además de subrayar que ha sido la diversidad la que ha permitido nuestra supervivencia y adaptación a los medios.

Bricolage del Determinismo Biológico VS Construccinismo

Y dice así:

-“No se puede corregir a la naturaleza árbol que nace volteado jamás su tronco endereza” dice el Gran Varón-.

-En el mismo sentido Macklemore le responde: -”And I can't change. Even if I tried. Even if I wanted to " pero antes dice: -”The right-wing conservatives think its a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made, rewiring of a pre-disposition. Playing God”⁴³

- Pero, ¿de cuál Dios hablas? dicen las Pussy Riots: - Дева Мария, Матерь Божья, стань феминисткой! Дева Мария с нами в протестах!⁴⁴.-

⁴³ Primera parte: Y no puedo cambiar. Aunque lo intente. Aunque quisiera. Segunda parte: Los conservadores de derecha creen que es una decisión. Y que se puede curar con algún tratamiento y la religión Hecho por el hombre, recableado de una predisposición. Jugando a ser Dios.

⁴⁴ Traducción: Virgen María, Madre de Dios, ¡hazte feminista! El cinturón de la virgen no impide las manifestaciones. ¡La virgen María está con nosotros en las protestas!

-Viene Alaska y le dice al Gran Varón que entiende su punto: -“Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora”- pero no está del todo de acuerdo con Macklemore y dice: -” Mi destino es el que yo decido. El que yo elijo para mí”-.

-Mariana dice: Es importante diferenciar que una de las cualidades de la vida es el cambio, pero es distinto entender la posibilidad de cambiar: 1. en función de cumplir con la norma o con el “deber ser” y 2. con la autonomía sobre la vida de cada quién, de vivir una vida auténtica. Y apunto: ambos discursos de lo natural y lo construido se han utilizado para la opresión o el amor y la libertad.

- Mientras Sophie Xenon pincha un beat acerca de lo hermoso y celestial que podría ser el que todxs nos reconociéramos trans tal como lo dijo para Teen Vogue.

- La vida es una fiesta, dice Arca: -Rompe si tú quieres gozadera y de la buena, no hay manera que te pelas esta fiesta vamos allá, con todo quiero verlas en la pista transformistas boten chispas las bujarras en la cara y más na.

-Lady Gaga canta: - “Whether you're broke or evergreen. You're Black, white, beige, chola descent. You're Lebanese, you're Orient'. Whether life's disabilities left you outcast, bullied, or teased. Rejoice and love yourself today. 'Cause, baby, you were born this way. No matter gay, straight, or bi', lesbian, transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter Black, white or beige, chola, or Orient' made. I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm beautiful in my way 'cause God makes no mistakes”⁴⁵

-Mariana dice: - Que los caminos hacia una u otra identidad sean caleidoscopios y no autopistas con muros que no se pueden pasar.

-Arca le responde: -What a treat It is to be Nonbinary, Ma chérie.⁴⁶

⁴⁵ Traducción: Ya sea que estés quebrada o que seas eterna. Eres negra, blanca, beige, descendiente de chola. Eres libanesa, eres de Oriente. Ya sea que las discapacidades de la vida te hayan dejado marginado, acosado o burlado. Alégrate y ámate hoy. Porque, nena, naciste así. No importa si eres gay, heterosexual o bi', lesbiana o transexual. Estoy en el camino correcto, nena, nací para sobrevivir. No importa que sea negro, blanco o beige, chola u oriental. Estoy en el buen camino, nena, he nacido para ser valiente. Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores.

⁴⁶ Traducción: Qué placer es ser no binario, mi amor.

-De fondo se escucha la Mamá de Frank Ocean dejándole una nota de voz por el WhatsApp: Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else, don't try to act like someone else, be yourself. Be secure with yourself. Rely and trust upon your own decisions. On your own beliefs⁴⁷

-Alok Vaid-Menon está de acuerdo con ella y dice: Two people can look similar and be completely different genders. Gender is not what people look like to other people, it is what we know ourselves to be. No one else should be able to tell you who you are, that's for you to decide.

⁴⁷ Es la canción "Be Yourself" del álbum Blonde de Frank Ocean. Traducción: No intentes ser otra persona. Sé tú mismx que eso es suficiente. No intentes ser otra persona. No intentes ser como otra persona, no intentes actuar como otra persona, sé tú mismx. Sé seguro de ti mismx. Confía en tus propias decisiones. En tus propias creencias.

La artificialidad del sexo y el género

Victor Frankenstein está en su laboratorio clandestino inaugurando a un ser a partir de restos o más bien como dice Shelly, dando forma a algo que no puede crear, el límite entre lo “natural” y lo “artificial” un recuerdo de lo que habla Susy Shock en Yo monstruo mio “Ni varon ni mujer ni XXI ni H2O (...) mi bella monstruosidad mi ejercicio de inventora” quienes nos invitan a honrar esa capacidad creadora que transgrede los límites de lo concebido como normal.

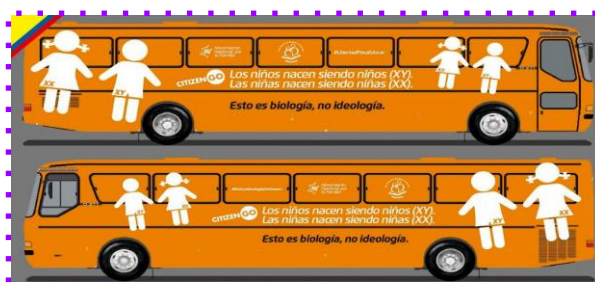
En el año 2017 en Bogotá y en otras principales ciudades del país, un bus naranja que denominaron en las noticias “bus de la libertad” en Caracol (2017) y de forma más precisa “bus de la discriminación” en El Espectador (2017) se instala en la plaza de Bolívar por un exconcejal que se hace llamar “el concejal

de la familia” Marco Fidel Ramírez. En las fotos de las noticias del bus se lee:

Los niños nacen siendo niños XY.

Las niñas nacen siendo niñas XX.

Esto es biología, no ideología.



De manera similar, el bus que rodó por

España decía “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva que no te engañen”⁴⁸. Finalmente, la disputa se conducía entre quienes consideraban que el sexo y el género son elecciones fundamentadas en la cultura y otros que consideran que son determinantes biológicos ligados a la anatomía y a la genética.

En concordancia, la definición más común que he escuchado y que incluso yo misma he usado para explicar qué es sexo y género, para mí se resume de la siguiente manera: el sexo pertenece a una condición biológica y el género a una construcción social y aprendida. Respecto al sexo, al decir que es biológico se halla la correspondencia con lo “natural” y lo natural siendo el origen es la verdad. Adicionalmente, por su carácter de verdad es inmutable y universalizante.

⁴⁸En el artículo de Paul Preciado (2013). ¿Quién defiende al niño queer?, dice: “¿Quién defiende los derechos del niño diferente? ¿Los derechos del chico pequeño que ama vestir de rosa? ¿De la chica pequeña que sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Los derechos del niño queer, maricón, tortillera, transexual o transgénero? ¿Quién defiende los derechos del niño para cambiar de género si lo deseara? ¿Los derechos del niño a la libre autodeterminación de género y sexualidad? ¿Quién defiende los derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia sexual ni de género?”

El binario sexo-género es resultado de la forma cómo se realizaba ciencia desde el positivismo, en el que se contraponen la mente y el cuerpo, la naturaleza y la cultura, la razón y los sentimientos, lo salvaje de lo civilizado, etc. En ese sentido, la separación de sexo y género tiene su germen en la separación fundante de la ciencia moderna: mente-cuerpo, un problema epistemológico que puede funcionar para ciertos niveles de lectura o de observación y para otros puede quedarse corto. Cuestión que, a mi modo de ver, se quedó corta en la manera en cómo se vivenciaba la sexualidad humana.

Así mismo, es importante seguir hilando las emergencias epistémicas sobre la contraposición de sexo y género, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX no existía la palabra género, ésta llegó según Preciado (2020) finalizando la segunda guerra mundial, de hecho, en los artículos que datan antes de ese momento aparecen otros conceptos como: hermafrodita, sodomía y eunuco; los cuales eran denominados prácticas sexuales y no como identidades. Así mismo, León (2015) dice que fue John Money quien utilizó este término por primera vez en 1955 para distinguir los modos de vida de hombres y mujeres. Adicionalmente, propuso que el género se aprendía como el habla y que hasta los 18 meses mediante el proceso de crianza se podía modificar el sexo. Money (1973) expone un modelo de identificación de género basado en los procesos de dimorfismo sexual, los cuales los clasifica en varios dominios como la genética y la endocrinología a lo largo de la vida, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. Al mismo tiempo, Milton Diamond, expuso que existían unos determinantes genéticos que producían unos gametos y éstos formaban a los hombres y las mujeres, esta idea era compartida por Money, sin embargo, se diferenciaban en la posibilidad de moldear o modificar el desarrollo sexual del humano. Ambos discursos permearon la cultura, por ejemplo, como se ve en la imagen del bus en el que se argumenta de manera discriminatoria la validez del sexo que se encuentra en la genética y en la genitalidad corresponde a la corriente de Diamond, así como el malestar subyacente al cuerpo por su no modificación:

“Pues Mariana a nivel físico yo estoy muy consciente que la disforia nunca se va a acabar porque tú de alguna manera siempre -de pronto has escuchado- hay cosas que no se pueden cambiar, que tú eres xx y yo soy xy eso yo nunca lo voy a poder cambiar tengo que vivir con eso” (Conversación con Sam, 26 años, Manizales)

Uno de los resultados favorables de hacer esta diferenciación entre género y sexo es justamente quitarle el carácter **natural** a la opresión de las mujeres y las personas negras y observar la discriminación como una matriz de **pensamiento construida** y compartida socialmente, de este modo, se comenzó a pensar en el **carácter construido de lo “natural”**. Al respecto,

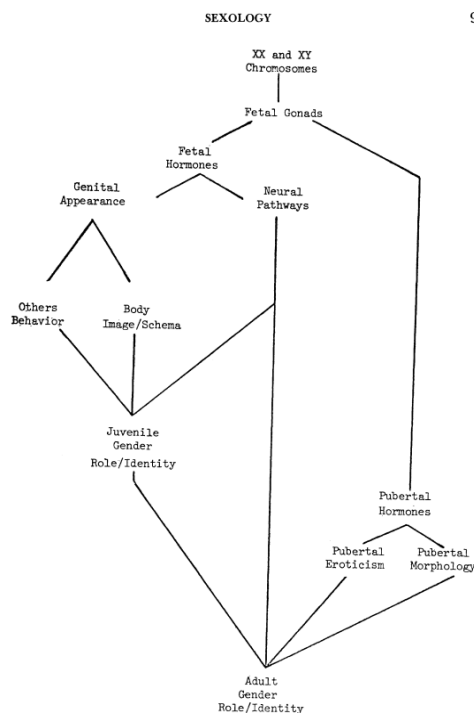


FIG. 1. The components or "instructors" of dimorphic sexual differentiation from genetics to gender role/identity.

9 Monique Wittig señala: “la categoría de «sexo» es en sí una categoría con género, conferida políticamente, naturalizada pero no natural.” (Butler, 1999. p.227); también Simone de Beauvoir expone como tesis de su libro *El segundo sexo* “No se nace mujer, se llega a serlo”, así, se sitúa al sujeto de forma activa en **la construcción de sí mismx apelando a la autonomía de lxs sujetxs y al poder de decisión sobre su cuerpo**. Este debate no sólo sucede por la decisión sobre el cuerpo en cuanto al género, también sucede en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, el uso de métodos anticonceptivos para personas menores de edad, entre otros.

Por su parte, el género en varias ocasiones fue referido como el sexo psicológico⁴⁹, éste es el campo de lo elegido, lo mutable, lo dinámico y lo aprendido. En paralelo al tomarse como una identidad, una vez se escogía ya no había vuelta atrás era fija y esencial. Es decir que hay una práctica “normalizadora” en donde se escoge ser mujer u hombre.

A propósito de esto, Ángela Hernández y Fernando Bravo (2015) señalan en su artículo *Vínculos, redes y ecología* que las creencias son ingredientes de la interacción humana estructuradas por los operadores del vínculo: la episteme, el ritual y el mito. En cuanto a la episteme se define como el conocimiento compartido por un grupo que todo ser humano uso para orientarse y ordenar el mundo; el ritual, genera signos que permiten la comunicación y la pertenencia social; por último, el mito es el organizador de la cohesión de los grupos humanos en el tiempo y que son transmitidos de generación en generación.

⁴⁹ Así lo definen un sin fin de textos.

Las epistemes

De este modo, vamos a deshilar las epistemes de algunas creencias sobre el binario sexo-género. Comencemos con la episteme de la creencia sobre el determinismo biológico y la construcción del género. Existen estudios sobre los efectos de **las creencias** cuando se lenguajean de forma esencialista, en el artículo *Gender essentialism and responses to candidates* se afirma que “*las categorías especializadas se ven como tipos naturales, con muchas similitudes profundas y no obvias (...) estos puntos en común se atribuyen a una “esencia”, que es innata, estable e inmutable*” (Swigger & Meyer 2019. p.2) la esencia según Delgado et al (2014) tiene entre otras las siguientes características: una base dada como natural o biológica; la inmutabilidad; la claridad de la discreción y la informatividad de la pertenencia a la categoría.

En cuanto al primer aspecto, en el apartado Naturaleza: Alta Tecnología se ejemplifica cómo los constructos sociales son naturalizados al designarles una base biológica. Al respecto, señala Bastian, B & Haslam, N (2006) que se ha encontrado que las personas que tienen creencias esencialistas tenían más probabilidad de explicar la diferencia entre grupos sociales referenciando características biológicas. Esto me hace pensar sobre los estudios de craneología y criminalística, en los que se median los cráneos de personas que cometían un delito y de acuerdo a sus características físicas buscaban predecir quienes podían desarrollar algún rasgo delictivo. Encuentro un aspecto fundamental sobre ello y son los efectos de las creencias. Por ejemplo, una concepción biologicista ligada a la heterosexualidad obligatoria y binaria pueden llevar a la discriminación de personas sexo-género diversas. Al mismo tiempo, se ha estudiado que creer que la identidad de género es fija y esencial pueden disminuir los niveles de violencia y discriminación (Whitley, 1990), por ejemplo que se considere que la homosexualidad es natural (Herek & Capitanio, 1995).⁵⁰

Con relación a la inmutabilidad, recuerdo que cuando trataba de organizar mi experiencia sobre cómo podía comunicarle a mi familia que me gustaban las chicas, cantaba mucho la canción Same Love de Macklemore tenía un doble sentir (ambivalencia) porque sentía que era una canción que podía levantar mucha simpatía y en el fondo al decir *And I can't change, Even if I tried, Even if I wanted to* era como si yo no tuviese la responsabilidad y el poder de decisión

⁵⁰ Estas ideas las encontré en el artículo *Creencias esencialistas sobre categorías relacionadas con la sexualidad* (Delgado et al, 2014).

sobre con quien quería vincularme sexo-afectivamente. Los siguientes versos me ponían a pensar más *For those who like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think its a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made, rewiring of a predisposition* y yo no me reconocía por supuesto como una persona de derecha conservadora y pensaba que había sido mi elección, simplemente un día me pregunté ¿Quién me ha dicho a mí que me deben gustar los hombres? y yo ¿por qué he creído que me gustan? y mi mirada se expandió, tomé el timón y vino toda mi emancipación como lésbica futurista jaja.

En lo concerniente a claridad de la discreción y a informatividad, es un factor que hace referencia a los grises que hay en una categoría. Un pensamiento que me angustiaba era que si algún día no llegase a traer una pareja mujer a la casa de mi familia de origen, ellxs invalidaran mi experiencia diciendo que había sido sólo una etapa, afortunadamente pude encontrar paz conmigo misma yendo a psicoterapia, comprendiendo que quien valida mis emociones y sentires soy yo misma y no corresponde a lxs demás hacerlo, que estaba en mi establecer un límite cuidadoso en el que no aceptara esos comentarios con el propósito de resguardar el vínculo con mi familia. De manera paralela, encuentro, que Delgado et al (2014) encontró que en los estudios de Haslam y Levy (2006) hay un alto puntaje en creer que la homosexualidad es una entidad discreta que no admite grises o gradaciones, es decir, o se es homosexual o no se es. Al mismo tiempo, se expresó que este grupo era leído en un mayor puntaje como iguales y me atrevo a decir que no sólo entre personas que se consideran homosexuales sino a todas las personas sexo-género diversas bajo la categoría de “maricas”.

Respecto al último factor: la pertenencia a la categoría; se ha encontrado que las personas transgénero se enmarcan más en este grupo que las personas cisgénero, es decir, que las personas trans declaran pertenecer al grupo trans que las personas cis o hetero que no sienten que pertenezcan a un grupo (Gallagher & Bodenhausen, 2021). También respecto a esa categoría se incluye de acuerdo con Haslam et al (2000) que la pertenencia a la categoría puede implicar tener pensamientos homogenizadores de la experiencia como “todxs lxs gays son iguales”.

Lo anterior, lo escribo con la finalidad de develar algunas epistemes identificadas sobre las creencias acerca del tránsito de género, su historicidad, y los efectos que produce en la actualidad. Además, me nutro de los modelos sistémicos que integran diferentes niveles y

puntos de observación sobre un fenómeno porque considero que organizan mejor la complejidad de la experiencia humana. Ahora bien, me propongo a relacionar las creencias con los estereotipos basados en género.

Los mitos y rituales

Al llegar a la adolescencia los exámenes sobre el género se hicieron más sofisticados, así como sus elecciones. Los repertorios sobre la feminidad me parecían muy estrictos y dolorosos: depilación; tintura capilar; cabellera abundante y lisa; pechos grandes; culo grande; cintura de avispa; esmalte en las uñas; maquillaje para ocultar manchas, granitos y arrugas; tratamiento para las estrías; dientes alineados y blancos. Vestimenta en el que se resaltara todo eso pero no demasiado, no tanta piel, ni tampoco nada de piel, porque son peligrosos los extremos de santa y de puta y no falta “*pero que parezca lo más natural posible*” toda esta exageración desmedida de mierda ¿para ocultarlas!? ¡Basta de fingir!

El ideal de la mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar un hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, a parte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista” (Despentes, 2008: 11.)

El colectivo social les enseñó a las denominadas mujeres la obediencia; a no expresar el deseo; a no decir lo que pensaban por miedo a ser señaladas como brutas o groseras; a ser sacrificadas en nombre de la familia; vetadas de la ciencia y destinadas al amor romántico heterosexual como centro, propósito de vida y realización personal; porque solteronas, nunca; infértiles, jamás.

En el colegio recuerdo tratar de acoplar mi cuerpo a todos esos rituales estéticos, que me irritaban la piel, que me dolían en el cuerpo, que me invalidaban constantemente mi manera de existir, al mismo tiempo, les tenía resistencia y reflexionaba sobre ese sentir y malestar que me causaba verme forzada a cumplir algo por obediencia, cuando cumplí quince años una tía me propuso que mi regalo fuese una rinoplastia, yo, con la edad que tenía con la rebeldía por mis

venas, dije que no, que por favor esos fondos fueran destinados a lo que sí quería hacer: un viaje. No era la idea de la cirugía lo que me molestaba sino el que otrx comentara sobre mi cuerpo y adicionalmente, quisiera “corregir” algo mal en mí.

Honrando mi linaje, por supuesto debía pasar por ser la oveja negra en mi familia, Marce una amiga maravillosa nos llevó a tomar Peyote, si algo sé es que la información generalmente se traduce en mí de manera visual y en esa ceremonia no vi mucho pero sentí bastante mi útero, era como si estuviese enraizada a la tierra y pregunté mucho por qué me dolía, eso sembró en mí una curiosidad por la historia de los úteros de mi familia, quería saber cómo habían las menstruaciones, los partos, la menopausia, todo. En otro proceso medicinal, indagué con mi abuela, sobre sus antepasadxs, para ver si podía venir algo de allí, encontré que mi bisabuela murió con mucha rebeldía y en su ley, el motivo fue la preeclampsia, ella me mostró que nadie le iba a decir cómo parir, le dio un enojo fuera de este mundo y murió luego de dar a luz. Mi abuela, se hizo secretaria de Avianca para tener independencia económica para no estar a la merced de su padre o marido, defendió su libertad tanto a pesar de que todo el sistema estaba dispuesto a arrebatarla. Mi mamá, en todos estos años me ha mostrado la valentía que hay en mostrar la transparencia de los sentimientos y en forjar bases sólidas para navegar en la vida, todas han sido medicina para mí. Y yo, aunque en ese momento no lo vi, no me podía quedar atrás de semejante fuerza.

Hablando con abuelas de otras personas sé que esto no es una historia única, hemos llegado a siquiera pensar en el orden patriarcal por su rebeldía colectiva. Los roles de género por supuesto que existen y coexisten con formas que salen de la norma, que reestructuran el orden, que interrumpen las pautas que no funcionan para compartir en convivencia.

“Como un efecto sedimentado de una práctica reiterativa o ritual, el sexo adquiere su efecto naturalizado y, sin embargo, en virtud de esta misma reiteración se abren brechas y fisuras que representan inestabilidades constitutivas de tales construcciones, como aquello que escapa a la norma o que la rebasa, como aquello que no puede definirse ni fijarse completamente mediante la labor repetitiva de esa norma.” (Butler, 2002. p. 29)

En sincronía, la persona que he visto crecer y me ha visto crecer, quien me hipnotizaba con su manera no permitida de cuidar su aspecto físico, tampoco le quedaba nada fácil: musculatura ancha; fuerza deslumbrante; pene largo y grueso; ropa de colores oscuros nada vistosos; no peinar el cabello tampoco ordenarse la barba, tener una barba y no tres pelos, y lucir lo más

desprolijo posible porque si no era marica .Aquí la violencia, aunque aparentemente oculta en algunos casos, es para todxs, nadie escapa. Al conocer de primera mano la situación, yo le pasaba la plancha de cabello e iba por los polvos de la cara para que los pudiera usar. Éramos cómplices.

Por muchos años se creyó que el género correspondía a las mujeres, dejando de lado a los hombres, sin embargo, al tener una visión más allá de los binarios con una lectura más sistémica en donde estas pautas comportamentales son experimentadas y creadas por todxs, se estudiaron a los hombres y las consecuencias de la imposición de los roles de género vinculados con la competencia, la emocionalidad restrictiva y el conflicto entre el trabajo y las relaciones familiares (APA, 2018).

Recuerdo una conversación que tuve con un amigo, le pregunté qué le gustaba de tener relaciones sexuales, frente a lo cual me respondió muy dudosx que era algo que se hacía casi como obligación, yo como -.- ¿en este siglo sientes que es algo que se hace como por inercia? ... -sí, todos lo hacen. Uy red flag, qué sufrimiento forzarse a hacerlo, mi siguiente pregunta ¿has sentido un orgasmo? ... después de pensarlo unos minutos me dijo, no sé qué es eso, diría que no. Pensé heavy, el sexo es un lugar de encuentro, cómo no poder ser allí, cómo no poder hablar con le otre, conectar con la vida. Comúnmente pensamos que las mujeres tenemos prohibido conocer y explorar nuestra cuerpo ¡Cochinas!, nos gritan. En ese momento, como si se prendiera un bombillo en mi cabeza me dí cuenta que los criados y socializados como hombres cishetero no solo les amputan la posibilidad de sentir con libertad sus emociones, sino también su cuerpo, de conocerse en el placer y no en el complacer del machirulo porno. Despentés (2018) sostiene que ese sistema patriarcal que nos atraviesa es un poder necocrático sobre la vida de hombres y mujeres:

Porque la virilidad tradicional es una empresa tan mutiladora como la asignación de la feminidad. ¿Cuáles son, exactamente, las exigencias para ser un hombre, un hombre de verdad? Represión de las emociones. Callar su sensibilidad. Avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad. Dejar la infancia brutal y definitivamente: los hombres-niños no tienen buena prensa. Estar angustiado por el tamaño de su pija. Saber hacer acabar a las mujeres sin que sepan o quieran indicar el camino que hay que seguir. No mostrar su debilidad. Amordazar su sensualidad. Vestirse con colores apagados, siempre tener el mismo calzado ordinario, no jugar con su pelo, no llevar muchas joyas, ni ningún maquillaje. Tener que dar el primer paso, siempre. No tener

ninguna cultura sexual para mejorar su orgasmo. No saber pedir ayuda. Tener que ser valiente, por más que no se tenga ganas. Valorar la fuerza, sea cual sea su carácter. Dar muestras de agresividad. Tener un acceso restringido a la paternidad. Ser exitoso socialmente, para poder pagarse las mejores mujeres. Temer su homosexualidad porque un hombre, un hombre de verdad, no debe ser penetrado. No jugar con muñecas en la infancia, conformarse con autitos y armas de plástico súper feas. No cuidar mucho su cuerpo. Ser sumiso a la brutalidad de los otros hombres, sin quejarse. Saber defenderse, por más que uno sea dulce. Estar separado de su feminidad, simétricamente a las mujeres que renuncian a su virilidad, no en función de las necesidades de una situación o de un carácter, sino en función de lo que exige el cuerpo colectivo. Para que, siempre, las mujeres le den los hijos a la guerra, y que los hombres acepten ir a la muerte para salvar los intereses de tres o cuatro cretinos de vista corta. (Despentes, 2007. p.25).

El binarismo de género y su obligatorio cumplimiento es la expresión de la experiencia de convivencia de los modos de vida, creencias y prácticas de la división sexual, cuando hablamos de masculinidad y feminidad hegemónica es el consenso colectivo sobre lo que corresponde social y culturalmente a los denominados hombres y mujeres. Por supuesto, que estas obligaciones son diferentes para hombres y mujeres, mientras que a los primeros les dotan de privilegio en varios aspectos⁵¹ y para las segundas existen una serie de condiciones que hacen la vida más precaria, es decir, desde el principio de su definición la feminidad se sitúa en un lugar de desventaja.

Pues eso ya es como más de la naturaleza o como algo de su infancia le pudo cambiar algo su objetivo o que fue lo que le atrajo más diferente a su sexo. Por ejemplo, a mí, yo nací hombre, pero a mí me gustaban como las barbies y todo eso y me gustaban mucho los tacones y los vestidos, entonces yo veía que un hombre no lo podía usar que porque no era de su sexo, entonces yo decía no, yo quiero ser mujer. (Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales)

⁵¹ Puntualizo que son varios porque existen datos de las consecuencias de la violencia de género hacia los hombres (causada en su gran mayoría por otros hombres) que son sutiles y frente a los cuales no se ha prestado mucha atención. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la salud (2020) expresó que el 79% de suicidios en América Latina son cometidos por hombres, y un gran porcentaje de ellos son realizados de forma violenta. Para ampliar información visitar: <https://manifiesta.org/suicidio-en-colombia-las-victimas-en-2021-fueron-hombres/>

Las personas que realizan un tránsito de género no están por fuera de estos sistemas de significación y de ritualización, frente a esto Louren dice:

“Las mujeres nos piden que tengamos que ser bonitas, tenemos que arreglarnos, tenemos que estar dispuestas para el hombre, que tenemos que asumir ciertos roles y eso implica unas cosas que van mucho más allá de la feminidad. Sobre los hombres qué se impone: tiene que ser exitoso, tiene que tener las posibilidades de mantener una casa, tiene que casarse con una chica de bien, etc, entonces nos ponen en unos lugares diferentes y eso hace que tanto las dinámicas de hombre trans como de las mujeres sean totalmente diferentes” (Conversación con Louren).

Así mismo, existen unas conductas ritualizadas en dependencia a los modos de existencia que se ha escogido, que son comunicadas de generación en generación:

Mi mamá en el tema de ser alguien femenino; mi hermano cuidándome y todo; mi papá comprándome la ropa, el maquillaje y todo esto. (Conversación con Thalia 16 años, Arauca, Caldas).

Ella es como mi amor mira te compro estos esmaltes, ojo con estos colores. O yo todos los días: mami esto me queda bien, no me queda muy vulgar, este labial no me hace ver muy rara, este peinado no me queda ver muy exagerado, mami me arreglé las cejas, parecen muy falsas o dos líneas ahí pintadas negras, ese tipo de cosas. Usar en la noche (...)mami esto, mami aquello, ella me da buenos consejos, mi amor esto no combina bien, mejor ponte estos zapatos en vez de estos, se te nota la tanga, con esta blusa te hace ver la espalda más ancha mejor esta. (Conversación con Sam, 26 años, Manizales).

Se llama A y J bueno D siempre me ha apoyado mucho en todo, siempre me hace ver las cosas en las que estoy haciendo mal por verme más femenino, por ejemplo que el cabello que me lo tengo que arreglar más o no sé cómo andar es que son cosas que yo he cogido al ser más varonil y encajar en la sociedad como tener las piernas muy abiertas como si me entiende, o como al rescostarme mucho en el espaldar y como muy no sé cómo lo hace, si, así, si se quiere ver como más femenina debe que caminar más (Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales)

El feminismo y el transfeminismo son luchas que reivindican siempre el **derecho a decidir** sobre nuestro cuerpo y vida. El transfeminismo es esencial para poner bajo cuestionamiento la forma en cómo las personas trans se movilizan en todo este sistema de creencias:

me pasaba manes que me dicen: me atraen más las trans porque ellas se arreglan más, ellas si se ven como mujeres; yo le dije: hay días en que yo no me arreglo, no me pongo maquillaje, me pongo una chaqueta y una sudadera y ya (...) nosotras seguimos los roles sociales femeninos extra mega multiplicado. (Conversación con Rosalía, 21 años, Bogotá).

El transfeminismo pone en duda la correspondencia de la existencia del sistema binario, el comentario que Rosalía recibió va enmarcado en estereotipar la existencia de las mujeres trans y cis, “hacerse más mujer”, dar pruebas de género. Constantemente la policía de género que está en todxs hace un seguimiento exhaustivo para verificar constantemente que nos comportemos como la heteronorma dicta.

Esta rigurosidad en checar constantemente si somos hombres o mujeres es devastador, la peor noticia es que no termina, está en todas partes y la cocreamos y reproducimos constantemente, sumidxs como estamos en la dialéctica que Schavarstein nombra producido-productor la cual yo prefiero llamar voy siendo tejido-tejedora, comprendí que los efectos de ser leída y autodenominada como mujer -no solo yo sino todas aquellxs que lo viven- son devastadores y por eso ponerse las gafas del arcoíris nos puede dar una vida más en libertad. Al mismo tiempo, es importante tener un acompañamiento psicológico a los tránsitos de género binarios justamente por las expectativas sociales que se tienen sobre hombres y mujeres y el malestar o costo social que puede causar su incumplimiento

Esto condiciona a hombres y mujeres a una existencia bajo el cumplimiento de roles adjudicados en nombre del mantenimiento de la organización moderna- industrial de la familia del siglo XIX. Al respecto, los movimientos feministas y lxs teóricxs transfeministas, decoloniales e interseccionales se ocuparon de luchar por dar un lugar al debate, a la crítica y deconstrucción de los roles preestablecidos sustentados por el determinismo biológico. Son una invitación colectiva a vivir una vida consciente de la forma en cómo nos relacionamos con la vida, siendo la vida, estando en la vida y procurando la vida.

Ahí si no sé porque yo diría a mí no me gusta ser machista, nunca me ha gustado, eso es ser muy horrible, no sé yo pensaría que prácticamente el ser hombre no te hace más

o te hace menos como el ser mujer, porque ser mujer tal cosa, es que prácticamente nada de este tienen género, tu tiene que hacer lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir libre, contigo mismo, con la sociedad(..) más que todo es sentirse bien con uno mismo (...) No puedes jugar fútbol porque eres mujer o sea que no puedes jugar con nosotros, las niñas juegan con las niñas (...) que no puedes hacer algún trabajo porque eres mujer o eres un hombre. (...) (Conversación con Lito)

En ese sentido, los roles de género cambian de acuerdo con los sistemas en interacción, en sí mismos no tienen una definición sino dependen de cómo el sistema se ha configurado y de la singularidad del mismo, si definimos un sólo rol, a mi modo de ver, se queda corto en la exploración de un mundo que está en constante dinamismo.

Colores extraoficiales

Llevo en la maleta mi vestido de baño negro, unas medias con huecos, y unos tacones. Vamos caminando con Moon por toda la 19 para llegar a una bodega del Santa Fe, he sido invitada por mi amix para que seamos bailarinas de Chocolate Remix, me da tanta emoción treparme, la show, es mi lugar, ese fué mi momento más *POSE*⁵² (serie que es de obligatorio cumplimiento verla). Esa noche llevé a otro nivel mi feminidad, una drag reggaetonera bailando como chocotorta *Como me gusta a mí* me sumerjo en un antro diluido por la vía láctea. Las preguntas que me ha conducido a draguarme como Queen y como King es ¿Qué pasaría si mañana me levanto y no soy una mujer? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué me permitiría hacer y que no?. En esta línea comienza el artículo de Tadashi Dozono (2017) recordando la pregunta realizada en la conferencia Afrofuturismo ¿Qué género tuvieses si no tuvieras que adherirte al género binario?, así mismo, retoma una entrevista que se realizó a Alok Vald Menon en la cual afirma que el género binario sigue siendo violento con las personas no conformes con el género. El binario sexo-género no fue una diferencia del español y menos de Sur América, como se puede denotar viene fundamentalmente del inglés; por lo que, me pregunto ¿qué pasaba en estos territorios?, ¿cómo se relaciona este binario con otros sistemas de creencias? y ¿cómo opera esto con el colonialismo, el patriarcado y el neoliberalismo? Los mitos reflejan narrativas de fundación en las culturas, a su vez, el mito constituye una simulación de la realidad, del orden interaccional que permite la permanencia del sistema.

En diferentes culturas existen historias en las que la diversidad sexual florece como lxs Takatapui en Nueva Zelanda, lxs Two Spirit en América del Norte, lxs Muxes en Oaxaca México⁵³. Veámos un poco sobre ellxs,

⁵² POSE es una serie creada en 2018 por Steven Canals (escritor y director), Brad Falchuk (productor) y Ryan Murphy (director y productor), en la que participaron en la escritura Our Lady Jay y Janet Mock (dos escritoras increíbles y de gran trayectoria sobre defensa de los derechos LGBTI) esta serie es hipermegacontraespectacular, muestra la historia de varias personas trans y queer en los 80's y 90's en Nueva York, en ella se muestran los Ballrooms# y toda la cultura underground LGBTI de la cual se alimentó tanto el pop de los 90's y los 2000#; época en la que las personas trans hacían arte por las noches creando sus propias galas bajo sus categorías frente a una ciudad que continuamente las violentaba. En Colombia también existieron los ballrooms en bares y sótanos de manera clandestina en los que a modo de reinado escogían a una reina de acuerdo a varias pruebas que tenían que pasar. Otra serie que toma algunos elementos de los ballrooms es RuPaul's Drag Race (2008) la cual lleva 15 temporadas en Netflix, se estrenó en un momento donde compartir con el mundo lo underground queer era insólito. Un programa que hace su propio reinado Trans escoge en cada temporada su propia reina Drag Estadounidense.

⁵³ Otros ejemplos son: Hijra de India, Winkte de Lakota en USA, Māhū de Hawai, Fa'afafine de Samoa en las Islas Polinesias; si se quiere conocer más sobre la sexualidad en Samoa revisar Margaret Mead (1939) *Adolescencia, sexo y cultura en Samoa*. Disponible en: <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2019/04/Mead.-Adolescencia-Sexo-y-Cultura-en-SAMOA.pdf>

Takatapui es un término en Maorí que significa expresiones de la sexualidad no heterosexuales, sin embargo, en las encuestas que se realizan a esta población sobre su orientación sexual escogen también gay o lesbiana (Murray, 2003), esto significa que Takatapui no se vincula solamente a estas categorías. De hecho, Aspin, C., & Hutchings, J. (2007) reconocen que existen pruebas de que la sociedad Maorí celebraba la diversidad sexual, las relaciones poliamorosas y con personas del mismo sexo.

En el libro Noa Noa de Paul Gauguin, un pintor europeo, se encuentra una serie de escritos sobre su vida en las islas Polinesias en 1891 durante dos años, nos cuenta desde una mirada colonial y europea el modo de vida de la comunidad Maorí y su relación con Tehura, unx jóven, a quien hace referencia en algunas ocasiones como ella, llamándola Vahine y en otras como él:

“Volvió a entrar acompañada de una niña que sostenía un pequeño bulto. La piel dorada de sus hombros y brazos brillaba a través de su túnica de muselina rosa muy transparente. Dos capullos brotaron y se hincharon en su pecho. Era un niño esbelto, alto, fuerte y de maravillosas proporciones. Pero en el hermoso rostro no encontré el tipo que había conocido en otros lugares de la isla. El cabello también era inusualmente tupido y ligeramente ondulado. Al sol, todo esto ofrecía una verdadera orgía de cromos.”

Con atención las autoras anteriormente citadas, subrayan que existen registros culturales que se eliminaron al poco tiempo del contacto con los europeos y en la actualidad esta población busca volver a sus raíces luego de 200 años de colonización Europea para hablar sobre sexualidad en sus términos, haciéndole frente al proyecto de cristianización de la Isla.

Por otra parte, en América del norte existen grupos indígenas que comúnmente y en las investigaciones aparecen como indígenas americanos, quienes en la década de los 90 se reunieron como pertenecientes a la comunidad LGBT para autodenominarse como Two Spirit desde una posición política, en el que se declara, que son personas que tienen una vinculación con lo femenino y lo masculino al mismo tiempo. Una característica fundamental de la definición de esta noción es la conexión que se realiza con la organización del mundo espiritual y colectivo (Walters et al, 2006).

En el Istmo de Tehuantepec en México existen indígenas Zapotecas que históricamente han honrado a lxs llamadx Muxes, ya que, se cree que estas personas tienen una vinculación con la divinidad más cercana, ellxs desempeñan roles que pueden llevar a cabo hombres y mujeres. En el documental Muxes de HBO se exponen diferentes relatos sobre los testimonios de Muxes y su relación con su comunidad, su familia, su trabajo, recomendando verlo para acercarse más a la cultura zapoteca.

“El papá no se daba cuenta Él pensaba que su hijo era varón. El se vino a dar cuenta él ya tenía 14 años. Él, por ejemplo, si le dice su papá que lo vaya a ayudar al campo, él se va. Y si yo le digo hija ayúdame en la casa o lávame, también lo hace. Por eso yo le digo a mi esposo: “mira, nos dio gusto a los dos, tu querías varón, yo quería mujer (se ríe) para que no nos peleamos, mitad y mitad.” (Hernandez, J, Chávarri, L & Vinay, S. 2022, min 22:00)

Estaba haciendo un trabajo de campo en una comunidad y asistía al evento más esplendoroso del mundo, una congregación de mujeres se reunía para conversar sobre las prácticas que sostenían sus pueblos en la alimentación, el cuidado y los saberes ecosistémicos, lo cierto es que las mujeres realizaban una gobernanza impresionante, sin embargo, era difícil que ellas participaran de decisiones sobre la administración de su territorio sobre todo en lo concerniente al relacionamiento con otros pueblos y el “mundo blanco”. Este encuentro fue mi primer acercamiento experiencial a la materialización de los feminismos indígenas y comunitarios, recuerdo mucho que ese día sentía tanto power de ellas, de estas ganas de re-establecer el orden y la armonía en sus comunidades, por supuesto hubo chicha de gran celebración por este encuentro. En la noche escuché voces hablando duro pensé yo que era que seguían en el encuentro y a la mañana siguiente me cuentan que el gobernador había golpeado a su esposa; eso me vino como una estocada, ¿de qué carajos estábamos hablando entonces?

Por supuesto que los procesos de globalización posibilitaron que se construyeran diferentes visiones del feminismo, cuestión que derivó en la exacerbación de la violencia en múltiples sociedades; en el lugar en el que yo me encontraba esto se estaba discutiendo y las mujeres de estas comunidades partían sobre la premisa de la complementariedad y la integralidad de los sexos, como una estrategia para retomar el equilibrio y la armonía en sus comunidades. Al mismo tiempo, la historia de contacto con el blanco (entiéndase esta categoría como el proyecto colonizador) transformó el sistema de creencias desde una interacción asimétrica y violenta. En ese sentido, parte del desbalance puede provenir del patriarcado occidental, que se expresa

en que los roles de las mujeres pasan como secundarios fruto del proyecto colonizador (Velandia & Padilla, 2019).

“La violencia genocida ejercida por los colonizadores sobre las naciones de Abya Yala durante el proceso de conquista territorial, dio paso a una jurisdicción que confinaba a una posición subordinada a mujeres y hombres “indígenas”. A la vez, resultó en un fortalecimiento de todos los patriarcados ancestrales preexistentes, influyendo en una lectura perversa de la complementariedad de los diferentes, implícita en cosmogonías donde las divinidades y fuerzas espirituales son duales y no unitarias y todo acto de creación es dialogal y no voluntarioso” (Gargallo, 2014 p. 50)

Gloria Anzaldúa en su texto *Movimientos de rebeldía y culturas que traicionan* expone su relato personal como chicana y cuáles son los mandatos organizados en el sistema de creencias y las instituciones de su cultura que en condiciones específicas vulneran y violentan su autonomía como ser humano. Así, ella dice: “¿Cuántas veces habré oído a madres y suegras aconsejar a sus hijos pegar a sus mujeres por no obedecerlos, por ser hociconas [big mouths], por ser callejeras [going to visit and gossip with neighbors], por esperar que sus maridos las ayuden con la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, por querer ser algo más que esposas?” (Anzaldúa, 2004, pág 72). Es la misma volteada de espalda que han ejercido otras sociedades, por supuesto, la Occidental, así como, la expulsión de sus comunidades a las traviesas Embera Katio en Santuario, Risaralda, Colombia (Tabares, 2019) y de las indígenas trans Wayuú en Uribí, Guajira, Colombia (Caribe Afirmativo, 2016).

“La colonización occidental y cristianización de las culturas nativas, atacó las concepciones nativas tradicionales de género e identidad sexual. El proceso de colonización logró socavar las tradiciones de los roles ceremoniales y sociales de dos espíritus dentro de muchas comunidades tribales, reemplazando la aceptación tradicional y la inclusión con vergüenza y condena” (Walters et al, 2006. 126)

De hecho, los feminismos afro, indígenas, chicanos tienen una apuesta por señalar ópticas desde lo territorial en cómo funcionan los sistemas sociales de manera no universalizante, no puedo dejar pasar esta ocasión para nombrar a quienes han sido mi inspiración en este camino: Kimberlé Crenshaw, Angela Davis, Gloria Anzaldúa, Cherrié Moraga, bell hooks, Monique Wittig, Audre Lorde, Silvia Rivera Cusicanqui, Sussy Shock... se me escapan un montón, pero aquí algunxs de ellxs.

Debo decir que hay un aspecto que resuena en mi cabeza y es que los ejemplos que he retratado con anterioridad muestran “lxs tercer sexo” como “hombres con género femenino” o mujeres trans, no hay muchas referencias a cómo otras mujeres han accedido a cruzar el género con otras “identidades”. Respecto a ejemplos de “mujeres” que habitan la masculinidad los estudios son menos en un gran porcentaje y se muestran como mujeres masculinizadas o se habla incluso de matriarcado. Ejemplo de ello estarían las mujeres Wayuú de la frontera Colombo-venezolana y las mujeres Bijagó en Guinea porque escogen a sus parejas para tener hijxs, esto no significa que sean una sociedad matriarcal, de hecho, pueden tener un poder patriarcal por la transacción de mujeres como regalo (Rubin,1996). También las mujeres aparecen como soldadoras en los procesos independentistas en Colombia y México (Curiel, 2021).

Por otra parte, se resalta de las mujeres que ocuparon roles de liderazgo como reinas que ejercieron su poder sin hombres a su costado. De esto me queda una idea y es que es posible que frente a las “transmasculinidades en otras culturas” se ha abordado de otra forma fuera de la comprensión binaria occidental de los sexos, o no se han estudiado lo suficiente y esto habla de la escasa investigación en la historia de las mujeres, o no he encontrado esa información.

Un dato que me parece importante señalar que parece en la Octava Versión de los Estándares de salud para las personas transgénero y género diversas menciona que aproximadamente del 25% al 50% de la población transgénero es no binaria y que es más probable que una persona no binaria se le haya designado como mujer al nacer (Coleman et al, 2022. p, 80). Para dar claridad una persona no binaria apela a una identidad de género que no se enmarca en la masculinidad o la feminidad (neutral, agénero) o que se identifica con ambas al mismo tiempo (bigénero) o tiene otras referencias como demygirl, demiboy, género fluido. También se señala:

“Nonbinary is used as an umbrella term referring to individuals who experience their gender as outside of the gender binary. The term nonbinary is predominantly but not exclusively associated with global north contexts and may sometimes be used to describe indigenous and non-Western genders. “ (Ibid, 2022. P, 80).⁵⁴

Estoy reunida con padres, madres y cuidadorxs de personas jóvenes trans, éste es un grupo de apoyo para familias, y recuerdo mucho la preocupación de una madre al decir que ya le parecía

⁵⁴ Traducción: “No binario se usa como un término general que se refiere a las personas que experimentan su género fuera del binario de género. El término no binario se asocio presomiantemenre, pero no exclusivamente, con los contextos del norte global, y a veces, se puede usar para describir los géneros indígenas y no occidentales.

exigente comprender los tránsitos de género binarios y que en esto ya había realizado un gran avance como para asimilar que su hijx se identificaba como no binario. Se preguntaba ella entonces ¿cómo podría ser la vida para su hijx si no se reconocía ni como mujer ni como hombre?

Sobre esto la WPATH afirma que estudios han indagado sobre los tránsitos de género no binarios y existen factores centrales que deben ser tenidos en cuenta como la conciencia, la exploración, la construcción de significado, y la integración y que estos pueden variar de acuerdo a las circunstancias de cada persona. (*Ibid*, 2022). Adicionalmente, debe garantizarse el acceso a la salud en el que se indague sobre cómo esa persona significa su género, expresa sus necesidades, y las expectativas que tiene sobre la atención en salud vinculadas con su expresión de género o no.

Hackear el sistema: devenir queer⁵⁵

” dentro de la tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás, sin fin.”

(Manifiesto Cyborg, Donna Haraway)

Me gustan las películas que abordan esta temática de cambios de cuerpo porque en un doble movimiento *hacen extraño lo familiar* en las pautas interaccionales de diferentes sistemas de vínculos, a su vez, permite simpatizar con otras realidades desconocidas: *Un viernes de locos* es el cambio de cuerpo entre una madre y su hija adolescente estadounidense que no se llevan muy bien y con el cambio repentino logran comprender el momento de vida de la otra y sus retos; *No soy un hombre fácil* muestra cómo sería una sociedad occidental en la que las mujeres ocuparan el lugar de los hombres de manera estereotipada -por supuesto- y al revés, entonces ellas ocupan los puestos de liderazgo, así como son quienes ejercen violencia sexual, y no se encargan del cuidado de lxs hijxs, y los hombres se dedican a labores de cuidado y tienen prácticas estéticas para satisfacer la mirada femenina; *Soul* es una película de pixar en la que ésta no es la temática central pero sucede que un alma que no quiere tener la experiencia humana en la Tierra encarna en el cuerpo del protagonista y ésto le permite reconocer y recordar que lo más valioso que tiene es el presente; y *Loobster* en donde se crea un mundo ficticio en el que no está permitida la soltería para los humanos, esta película permite denotar lo absurdo que es operar la sexualidad humana desde categorías binarias desde la normalización y es un espejo de cómo la sociedad actual gestiona, disciplina y castiga identidades y comportamientos fuera de la norma.

Así que, preguntarse sobre ¿qué pasaría si un día no existiera el género para identificarnos? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Qué pasaría con la justicia social de género? Es un ejercicio interesante. Recuerdo varias conversaciones que he tenido con Moon sobre el autodenominarse lesbiana, para mí ha sido más que una categoría que hable o delimite mi orientación sexual y del deseo, es una reivindicación política y de reconocimiento de derechos importante e histórica. No he pensado que nuestras posiciones son contrarias, más bien son temporalmente distantes para ella, es más como reivindicar la fluidez de la sexualidad que encasillarse en alguna categoría y para mí era trabajar por la equidad desde el reconocimiento de la pluralidad de la sexualidad en las categorías existente en un en un movimiento simultáneo y alterno que

⁵⁵ En varios escritos aparece como una apuesta de resistencia frente al capitalismo, el patriarcado, el extractivismo, el racismo. Sayak Valencia en *Capitalismo gore* expone que es una forma de lucha que no busca “afianzarse en elementos biologicistas, identitarios o nacionalistas dinamitando dichos preceptos” (2010.p.193)

las difuminara. He escuchado en una conferencia sobre equidad de género empresarial cuando la expositora de una manera muy valiente le dice a lxs empresarixs que había que estar a la vanguardia y comprender todo el espectro LGBTIQ+ porque cuando ya sientan que han entendido qué es esa sigla van a aparecer más identidades que aún no conocen; y me ha quedado sonando eso porque me pregunto si en algún momento simplemente habrá tanta diversidad (como la hay) humana que va ser inevitable implosionar el género, y el sexo por supuesto, como en un big bang en el que solo existan seres, y me sumo a la pregunta

¿Qué pasaría si desapareciera la categoría género? ¿cuál es el objetivo de poner en el documento sexo? ¿Qué pasaba cuando esta declaración categorial no existía? ¿Si la clasificación de género no existiese sería la estocada definitiva para acabar con las desigualdades sociales? ¿Cómo podría beneficiar a la sociedad en su conjunto la eliminación del marcador de género? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué posibilidades ofrece? teniendo como horizonte de sentido que esta eliminación sería para todxs. ¿Qué acciones podrían llevarnos a esa transición? ¿Cuáles serían las subjetividades emergentes de este sistema fluido?

En el artículo *If the State Decertified Gender, What Might Happen to its Meaning and Value?* Davina Cooper y Flora Renz (2016) realizan el ejercicio de imaginarse desde una perspectiva socio jurídica ¿qué pasaría si los Estados no asignasen el género?. Al respecto, señalan algunas preguntas que permiten imaginar escenarios futuros que me parecen interesantes explorar:

- a. ¿Qué pasaría si el Estado en vez de asignar el género se valiera de la autodeterminación de las personas?
- b. ¿Si el Estado acoge el género neutral es una forma de descertificación del género?

Las autoras señalan que los Estados han eliminado marcadores de identidad porque pueden ser discriminatorios como la orientación sexual, el grupo religioso y el grupo étnico. En el artículo *The "Numerus Clausus" of Sex* de Sonia Katyal (2017) se sugiere que el Estado puede proteger más que la identidad de género, la expresión de género, cuestión que me parece interesante porque el foco no estaría en la no conformidad con el sexo asignado al nacer sino con la posibilidad de expresar una multiplicidad de prácticas y estéticas del género, vinculadas por ejemplo al derecho a la libre expresión de la personalidad, éste cambio, según la autora podría permitir: 1. que se amplíe el género más allá del binario 2. que el género deje atrás una connotación fija y estática 3. que sea un derecho para todxs y no para una “minoría”.

En el año 2017 nació un bebé al que se le puso en el marcador de género la letra U de Undefined en la Columbia Británica de Canadá⁵⁶, ya que, su cuidadorx expresó que quería que su hijx escogiera su identidad de manera libre. En Colombia, en el año 2021 Mike Durán⁵⁷ fué la primera persona que obtuvo en su Registro Civil y en su Cédula la T en el componente de sexo. Adicionalmente, la Corte Constitucional de Colombia emitió la T-033 de 2022 en la cual se exhorta al Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil que se incluya el marcador no binario en el componente sexo y al Congreso Nacional para que en el término de dos años regule la designación del componente sexo para personas no binarias. Esto abre la puerta para pensar que pronto la información sobre el sexo será un asunto correspondiente a escenarios en los que ésto sea pertinente y no una declaración forzada a la sociedad.

“En rigor cada individuo es un transgénero distinto e incommensurable, diferente tanto de los otros como de sí mismo a cada instante de su devenir indecible” (Binetti, 2019. p.73)

Me sumo a la invitación de las autoras Davina Cooper, Flora Renz y Sonia Katval para pensar qué pasaría si el género es una elección de autodeterminación sin pasar por la designación de sexo desde el sistema médico al nacer, los escenarios posibles que imagino sobre eliminar el marcador de género agregando a la discusión es: se podrían minimizar los riesgos a la salud mental que experimentan personas transgénero y no binarias, entre esos: intento de suicidio, angustia psicológica grave, ansiedad, depresión y problemas de alimentación (Matsuno, sf). Además de desescalar la violencia que experimentan las personas trans binarias y no binarias.

58

Imagino una apuesta desde la psicología que investigue e intervenga a profundidad sobre la autodeterminación de lxs sujetos y la satisfacción con la vida en el desarrollo libre de su sexualidad. El estudio *Mental and sexual well-being in non-binary and genderqueer individuals* señala que las personas no binarias y genderqueer tienen niveles más bajos de satisfacción con la vida y autoestima sexual relacionada con la percepción corporal (Kennis M et al, 2022) respecto a las personas trans binarias y éstas respecto a las personas cisgénero

⁵⁶Veáse: <https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/05/bebe-canadiense-recibe-tarjeta-de-atencion-medica-sin-sexo-definido/>.

⁵⁷Veáse: <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mike-duran-primera-cedula-colombiana-con-letra-t-de-una-persona-trans-659280>.

⁵⁸ Revisar ponencia llamada “Don’t ask, don’t tell” (DADT) about Bio Sex. Recurso en línea. Disponible en: <https://osf.io/6ejzt/wiki/home/>

(Katz-Wise, S; Mereish. E & Woulfe, J. 2017). No sólo el síntoma de *no conforme* es la expresión de que este sistema no está funcionando para las personas trans y no binarias sino para todxs, sobretodo con el ejercicio de la violencia en América Latina sobre el cuerpo de las personas y en especial sobre el cuerpo de las denominadas mujeres.

Imagino humanos decididos a respetar la vida y a comprometerse en la convivencia grupal y en armonía con lo que le constituye, reflexionando sobre las consecuencias de los modos de producción y de relación con el lugar que habitamos: el planeta tierra. No son palabras bonitas, siento, son los requerimientos mínimos de existencia. Imagino la selva Amazónica respetada y no desangrada ni incendiada; imagino una conciencia sobre la vida como experiencia finita y cambiante, imagino una convivencia desde el amor y en el aquí y el ahora. Imagino una conciencia en la que se comprenda la legitimidad de la vida de todxs y esto implica pensar unos modos de producción distinto, repensar el mito del progreso (Waisman, 2014) como bandera del desarrollo.

La implosión del género es una reivindicación para pensar la “raza” y la “clase” vinculadas con la discriminación y la inequidad social con la concentración de la riqueza y la propiedad. La profesora Cheryl Harris (2006) examina en un texto bellísimo *La blancura como propiedad* en este relato cuenta cómo su abuela logró ser leída como blanca al ser de piel mestiza proveniente de una familia negra para dar una mejor calidad de vida a su familia, esto implicó, el silencio.

Así lo muestra la película *Passing* en donde habla más la gestualidad que las palabras, es la historia de dos mujeres que viven su negritud de forma distinta, una de ellas convive con personas negras y la otra, se ha casado con un hombre blanco, quien al final de la película (alerta spoiler) la grita en una reunión en la que comparte con el círculo social de la primera, diciéndole que lo ha engañado todos estos años, refiriéndose a su origen. En ese momento, la cámara muestra dos tomas rápidas: la de su amiga pasando su mano por su torso y la de su esposo abalanzándose sobre ella. Me quedé pensando en esto de Ser empujada a la muerte, ser empujada a negarse a sí misma.

La profesora Harris finalmente argumenta que a pesar de que se abolió la esclavitud, la blanquitud se suscribió como una identidad de privilegio y de tenencia sobre la riqueza como una propiedad, imagino ser un yo múltiple, reconocermé muchxs.

Imagino poder pasar las fronteras con tranquilidad, ser un crossroads, be a passing, sin que implique sacrificar la vida; imagino una existencia en la que se tenga tiempo para educar desde el amor porque esto es una acción de prevención de la violencia.

La utopía de una crisis del sistema heteropatraircalneoliberalnecocrático es lo que imagino y de toda crisis emerge la capacidad de afrontamiento que se refiere a la resiliencia y recuperación del sistema, no para su restablecimiento primario sino para la construcción de recursos novedosos, para idear otras relaciones interpersonales que acepten la diversidad, la creación de un contexto que permita la libertad (Schnitman, 2010), un sistema de libertades para todxs.

Punto de vista: Somewhere over the rainbow

“En espiral hacia el centro al centro del corazón, soy el tejido soy lx tejedorx, soy el sueño y lx soñadorx”

Canción de medicina.

Inhala profundo y sólo sentirás un poco de peso, ella te permite estar “consciente”. Me sentía tan sostenida, detrás mío estaba Moon acariciándome el cabello y K a mi lado tocando mi hombro, y a mi otro lado Dan y Marce, estoy con ellas: todo va a estar bien. Ellas me dan support. En ese momento, configuran mi paraíso sensorio emocional, su presencia es mi única conexión con este plano.

Estábamos sentadas como si estuviéramos en la sala de espera de un vuelo. Aquí voy inhalo 1,2,3,4,5... perdí la cuenta, la sentí en mi corazón, con los párpados cubriendo mis ojos, entre la piel y mi iris, experimentaba lo que llaman *el encuentro con Dios*.

Nunca había visto algo tan hermoso, tantos colores, formas y movimientos, era como un caleidoscopio. En medio de ese movimiento psicodélico, sentí la textura de una tela en la que surgían cosas, entre ellas yo... o nosotres o ¿todo? decir Yo me es contrario a lo experimentado, pero para lenguajearlo de algún modo: Yo, era más una mirada que una cosa individual, un point of view, literal, mi Yo se diluía en la tela. Tenía la fuerte convicción de que estaba experimentando mi muerte, mi Yo ya no existía ahí -cuando volví a mi estado de consciencia más frecuente pensaba: ¿por qué he tenido tanto miedo a la muerte? si es sólo un estado, un crossroads-. Ví sus rostros, algunos súper unknown otros me eran más familiares tenían flores de loto, bastones, estaban recubiertos de piedras preciosas, andaban en elefantes y leones, tenían mil rostros, cuerpos de todos los colores, y todxs convivían en ese mar de tela infinito. ¡Diosas! estoy con todxs lxs dioses, se me viene: -todxs existen, todxs somos unx-. Al mismo tiempo me encuentro envuelta por una lengua de dragón que es un fuego que no se apaga, y veo al Águila, al Cóndor, a la Serpiente, al Jaguar, ¡madre mía! está Jesús, la Virgen, la Coatlicue, las Auroras Boreales, SOY todxs ellxs. Así en X porque no hay divisiones sólo expresiones de una misma creación.

⁵⁹ Concepto de Gloria Anzaldúa y Cherie Móruga

Allí y aquí me sentía tan amada, Maturana dice: el amor es “dejar que el otro aparezca”, justo eso fué lo que experimenté: puro amor, pura emergencia y manifestación de muchxs, de todxs, de nosotrxs. Todxs eran una energía creadora y no me refiero a la reproducción, sino a la transformación, al cambio. No existían los binarios, no estaba bien o mal/ sano o enfermo/ blanco o negro/ pobre o rico/ mujer u hombre, no hay frontera, sólo cruce como diría mi querida Gloria Anzaldúa. Esta manera de estar me hacía sentir feliz.

Ví que todo en cuanto creemos, crea y se recrea.

Estaba en quinto semestre cuándo el profesor Ballén⁶⁰ nos dejó un trabajo final que era reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿El mundo existe así porque es así o porque nosotrxs lo configuramos?

Recuerdo que esa vez pensaba que era muy androcéntrico decir que el mundo existe de este modo porque existimos, y a la vez, no tenemos otro recurso que la materialidad que tenemos y creamos para conocer el mundo del modo en que la experimentamos. Pero la pregunta me suscitaba dos cosas: o era una pregunta por la realidad o era una pregunta por la percepción. Años más tarde me encontré con este fragmento divino de Ximena Dávila y Humberto Maturana (2016):

“La noción de realidad como algo trascendente que usamos como un referente a algo que existiría con independencia de nuestro operar como observadores, es una invención explicativa que ya no necesitamos pues, ahora, sabemos que, en tanto sabemos que en la experiencia no distinguimos entre ilusión y percepción, sabemos que los mundos que vivimos son ámbitos de configuraciones de coherencias sensoriales-operacionales-relacionales de nuestro vivir -convivir que surgen de la realización de nuestro vivir de la unidad ecológica organismo-nicho que integramos en nuestro existir como sistemas autopoieticos moleculares” (p. 166)

Entonces es una pregunta sobre la percepción, es decir, sobre nuestro modo de conocer el mundo, no sobre su existencia o sobre la realidad, es decir, no es sobre la verdad. Eso, que podemos conocer lo configuramos en el modo en que vivimos la vida. En pocas palabras, lo que creo, crea.

⁶⁰ Gracias por inspirarme a cruzar las fronteras de las disciplinas como un acto creativo y de comprensión compleja del mundo.

Con la medicina me dí cuenta de que la divinidad existe por las múltiples versiones de cada unx, no hay una verdad, no hay un otro legítimo, aquí estamos todxs siendo.

A pesar de relacionarnos coordinadamente con la ingesta de la misma medicina cada Yo o punto de vista, vió algo distinto, tuvo un encuentro distinto, construyó un mirar diferente, canalizó y dotó de sentido una información en particular ¡Maravilloso! Que eso suceda es lo que constituye la llamada diversidad, que no es un otrx sino que es una cualidad de todxs nosotrxs. Es tan lindo que la bandera LGBTIQ+⁶¹... tiene la idea de todos los colores, de los brillos, del amor. Eso SOMOS.

Intento abrir los ojos y me caen mil luces en los párpados TODO está vivx. Gracias diosas del universo por ese encuentro, por su bendición y por esta vida que he podido experimentar en este cuerpo. Gracias a las plantitas por ser naves espaciales, y a quienes me acompañan por ser un canal de amor.

.....

Este abordaje que propongo es con toda la mireya, con mi compromiso vital por la defensa de la diversidad humana, por el derecho a imaginar otros modos de convivencia, por la libertad de corporizarnos desde el afecto, por la memoria de los actos resilientes colectivos y por lo inevitable: por pensar cómo conservar la vida de todxs. Entonces, voy acompañada por quienes son puntos de referencia para mí: Vandana Shiva, Ximena Dávila, Humberto Maturana, Judith Butler, Paul, B, Preciado, Chimamanda Ngozi Adichie, Yuderkis Espinosa, Gloria Anzaldúa, Keneth Gergen, Gregory Bateson, Margaret Mead, Sylvia Rivera, Marsha P, Jhonson, Julieta Paredes, Andrea Becerra, Marcela Lagarde, Audre Lorde, Ilya Priogogine, Virgine Despentès, Donna Haraway, Pedro Lemebel, Linda McDowell, Sussy Shock, Blas Radi; en este apartado expondré un acercamiento a los sistemas relacionales emergentes a la experiencia de tránsito de género y la integración de las voces desde la mirada de la persona que atiende la mirada.

Quisiera exponer que nuestro rol como psicólogxs es investigar e intervenir en sistemas sociales humanos para promover el bienestar, la justicia social y la equidad. Es por eso que me propongo abordar varios frentes de acción:

4. Investigar sobre las consecuencias que traen las creencias binarias y la negación de la transformación del ser humano como condición de su existencia.

⁶¹ Ver este video: <https://www.youtube.com/watch?v=ww4d26DkBIw>

5. Investigar sobre los efectos de la discriminación estructural en la configuración de la salud de las personas.
6. Investigar sobre modelos de atención humanizada y justa para promover la libertad y la autonomía de las personas.

Antes de hacerlo quiero proponer una lectura sobre cómo los sistemas sociales que creamos y recreamos han discriminado en los últimos siglos a diferentes grupos sociales, expondré su configuración, operación y relacionamiento en la actualidad. Así como el sistema de creencias que los sustentan y su posibilidad de generar o negar la vida, evidencia de la crisis climática y social sustentada por el capitalismo y el patriarcado. Veamos cómo.

Un dolor compartido: la convergencia de sistemas que discriminan

El siglo XIX comenzó transicionando en medio de un cambio social en el sistema político-económico europeo y una transformación de las relaciones humanas con el proyecto de establecer el capitalismo como el sistema regulador de la vida. De esta manera, algunos actores dispusieron de una institucionalidad y un cuerpo organizativo que permitió la acumulación del capital dado por la plusvalía de los trabajadores y las trabajadoras que se incorporaban a trabajos industriales, configurándose la relación Burgués- Proletarix, donde el primero era dueño de los medios de producción que constituían su riqueza y el segundo, vendía su fuerza de trabajo por un salario. En sincronía, se establecía la institucionalidad del Estado-Nación bajo la demarcación de los territorios y las fronteras colonizados por los europeos en América Latina y África.

En este orden de ideas, se sostenía por la ostentación de un poder necro-crático, en que el genocidio era la forma de colonizar para la constitución del Estado-Nación y las mujeres quedaban fuera del acceso a los medios de producción, sólo entraban al sistema por su función útero-reproductiva. Virgine Desportes en su libro Teoría King Kong (2018) señala: *“el cuerpo de las mujeres pertenecía a los hombres; en contrapartida, el cuerpo de los hombres pertenecía a la producción en tiempos de paz; y al Estado, en tiempos de guerra. La confiscación del cuerpo de las mujeres se da al mismo tiempo que la confiscación del cuerpo de los hombres. Los únicos que salen ganando en este negocio son los dirigentes”* (p.24).

En el texto *La psicología como ideología* de Ian Parker se expresan dos argumentos de los que me valgo para sustentar la tesis anterior sobre la relación de coevolución del capitalismo y el patriarcado: 1) El sistema capitalista separó sexualmente el trabajo, a los hombres se les asignó el trabajo de la fábrica y a las mujeres el trabajo doméstico, añadido yo: esto configuró la instauración de la diferencia de lo privado y lo público. 2) La constitución de un nuevo sistema sustituyó el trabajo local manufacturero por el de producción en masa industrial.

Es por esto que los sistemas como complementarios designaron espacios de experiencia específicos sustentados en discursividades que apelan al determinismo biológico⁶², paradigma que a su vez transforma los sentidos sobre la naturaleza y en específico sobre la reproducción sexual de las especies. Haraway (1991) señala:

“Tratan la profunda constitución de la naturaleza en la biología moderna como un sistema de producción y de reproducción, es decir, de trabajo, con todas las ambigüedades y las dominaciones que acarrea tal metáfora. ¿De qué manera se hizo realidad que las historias de un grupo cultural dominante y con inmenso poder convirtiesen a la naturaleza en un sistema laboral, dirigido por la división jerárquica del trabajo, en el que las desigualdades de raza, sexo y clase adquieren carta de naturaleza como sistemas funcionales de explotación? ¿Cuáles fueron las consecuencias para las visiones de las vidas de los animales y de las personas?”
(Haraway. 1991. P, 63)

Kimberlé Crenshaw desde los feminismos afroamericanos propone el concepto de Interseccionalidad el cual funciona como una unidad de análisis para comprender el entrecruzamiento o solapamiento de las desigualdades sociales, y por tanto, apunta a tener una mejor estrategia para las luchas sociales. Es así como, la modernidad produjo el patriarcado capitalista racista como un sistema excluyente que subsiste gracias a la extracción desmedida de la naturaleza como bandera del desarrollo y la violencia hacia las mujeres, las personas sexo-género diversas y los pueblos no occidentales “*‘por qué hemos de ver la ciencia moderna como un gran adelanto para la humanidad cuando se logró solo a costa del deterioro de la condición social de la mayoría de la humanidad, de las mujeres y de las culturas no occidentales’*” (Shiva,

⁶² Al respecto, la teórica Brigitte Baptiste sostiene que la Naturaleza es Queer, afirma que los estudios comparados nos permiten comprender que las especies humanas y no humanas tienen formas corporales y reproductivas cambiantes, dinámicas, diversas y plurales; es decir, el ser humano como parte y forma de la naturaleza es transformado y transformador de sí y sus sistemas de vida.

1995: 67). En realidad, estas relaciones de exclusión no sólo se dan entre personas, el modelo económico extractivista que tiene Colombia habla de la relación política que tenemos como sociedad con lo vivo. Es el mismo aparato Estatal el que promueve el extractivismo y el fracking, y el que legisla sobre el reconocimiento del río Atrato como un sujeto de derechos.

Otra forma de colonización ha sido la universalización para la dominación, en el libro *Dar cuenta de sí mismo*, Butler pone en escena el problema de las categorías universales y del riesgo de generalizar homogéneamente las realidades, ocultando las particularidades, esto desdibuja la diversidad y permite el control sobre un colectivo homogéneo fácil de conquistar. Esto sucede con la generación de estereotipos discriminatorios y también sucedió dentro del feminismo.

Las principales críticas de los movimientos feministas latinoamericanos, negros, indígenas, chicanos y trans, es la consideración de un único sujeto del feminismo que es mujer, clase media, blanca, heterosexual. Esto ha llevado, a autoras como Yuderkys Espinosa, Gloria Anzaldúa, Francesca Gargallo -para nombrar algunas de ellas- hablar sobre descolonizar el feminismo a través del reconocimiento de la historia de una diversidad de sujetxs - negros,trans,indígenas,chicanos- que salen de dicho cuadro universal y normativo . Algo semejante afirmaba bell hooks “*A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras <<el >> análisis y << el >> programa de liberación.*” (hooks,2004: 45). La universalidad del binario sexo-género supone la negación de la transformación humana y sus efectos pueden constituir actos de discriminación.

La negación del amar

Paul Preciado en diciembre del 2019 compartió un discurso frente a 3.500 psicoanalistas⁶³ de la Escuela de la Causa Freudiana en un evento en París en donde se discutía sobre la incorporación de actualizaciones a las teorías sexuales psicoanalíticas, éste discurso posteriormente ha sido publicado como libro debido a que el escrito es más largo que el tiempo que se disponía para su intervención oral en el congreso. En un momento dice:

“Todo lo que de terrible y temible hay en la transexualidad no se encuentra en el proceso mismo de la mutación, sino en cómo las fronteras de género castigan y amenazan de muerte a aquel que pretende cruzarlas. No es la transexualidad lo que es temible y peligroso, sino el régimen de la diferencia sexual.” (p. 53).

¿Cómo puede ser que el régimen de la diferencia sexual castigue y amenace la vida de las personas trans? ¿Cómo puede ser que el régimen de la diferencia sexual pueda garantizar los derechos de las mujeres? ¿Quiénes encarnan el régimen de la diferencia sexual? ¿Cuáles son las condiciones históricas que mantienen el problema de la discriminación y la exclusión de las personas trans en los sistemas sociales? Es un debate que es vigente y que he decidido abordarlo a partir de la videocolumna de Carolina Sanin llamada “las mujeres y el mundo siguiente” y todo el escenario social que respondió a la misma. Es así como voy a retomar puntos que me parecen importantes abordar. En esta columna, Carolina Sanin habla sobre las implicaciones futuras que tendría eliminar la diferencia sexual, entre ellas nombra:

- La eliminación de las mujeres y la garantía de sus derechos.
- Una guerra cultural futura.
- La pérdida del capital simbólico y cultural que existe en la denominación trans para mujeres y hombres trans.

Coincido con ella con que la abolición del régimen de la diferencia sexual implica la eliminación de las mujeres, y me distancio profundamente, con que esto traería consecuencias desfavorables para la garantía de los derechos de las mismas, por el contrario, es un escenario

⁶³ Discurso completo de Preciado a la conferencia de psicoanalistas, disponible en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=sztXYnuIsrQ&t=1225s>.

En este mismo año en el mes de junio en Nueva York La Asociación Psicoanalítica Estadounidense emite una disculpa atrasada a la comunidad LGBTQ en su comunicado afirmaron: “Ya es hora de reconocer y disculparnos por nuestro papel en la discriminación y el trauma causado por nuestra profesión” dijo Lee Jaffe presidente de APSaA. La única Asociación Médica que conozco hasta la fecha se ha disculpado.

creativo de transformación social y de amplitud de derechos y libertades, y del reconocimiento de la diversidad humana con todos sus grados y escalas existentes. La abolición implicaría también la eliminación de los hombres, y en realidad, del sistema de designación arbitraria que sitúa a las mujeres desde el acto de su designación en una posición de desigualdad.

En un momento de la intervención de Carolina, ella habla del derecho a la performatividad, lo nombra de manera suelta y escueta como una posibilidad, en realidad lo dice tan rápido como una idea poco realista, aquí encuentro otro punto de convergencia con ella y es ése, la lucha por la libertad de la performatividad, tal como lo señala Paul Preciado en *Dysphoria Mundi*, en el que dice que abolir la asignación de sexo en documentos administrativos nos ahorraría las luchas por la producción de identidades y los procesos de normalización de las mismas (matrimonio homosexual, adopción homoparental, cambio de nombre y sexo en documentos de identificación, etc).

En realidad, la humanidad no siempre ha estado organizada desde el régimen de la diferencia sexual, en el libro *La revolución Reflexiva* de Humberto Maturana y Ximena Dávila (2021) exponen que hace unos tres millones de años atrás en lo que hoy conocemos como Europa habitaron culturas matrísticas, que vivían en armonía con el medio y en cooperación entre seres humanos, además adoraban a la Diosa Madre que dicen los autores podría contrastarse en lo que conocemos en América Latina como Pachamama, así lo demuestra la antropóloga Marija Gimbutas.

Pensando en que no siempre hemos tenido los mismos modos de vivir, recuerdo, por ejemplo, la cédula de mi padre nacido en 1971 en la que no está la inscripción de sexo, aparece su nombre, su lugar de nacimiento, su estatura y una categoría que hoy no tienen los documentos de identidad: color; lo cual me hace pensar que ésa era una categoría designada como marcador de discriminación importante para la época.

Lo que ocurrió luego de la publicación de esa columna -que fue realizada a modo de desarrollo de una columna anterior sobre los pronombres- fue que se le llamó a la autora como transfóbica y TERF, la cual es una sigla en inglés que significa Feminismo radical trans excluyente, en el que se sustenta que las mujeres trans no son mujeres porque tienen pene, y que esto, sería por la capacidad de penetrar. Incluso, en la columna, nombra cómo existen lesbianas que no se

relacionan sexo afectivamente con mujeres trans justamente porque son portadoras de un pene y que ellas han sido tildadas de transfóbicas.

Aquí pienso que hay que hacer una distinción y es que el consentimiento sexual pasa por la decisión de cada persona de involucrarse con quien quiera y que todo acto de obligatoriedad es violencia provenga de donde provenga. Por otra parte, fuera de todo esto estamos las personas que guardamos un arsenal de dildos y los usamos como tecnología de cuerpo, y por supuesto las personas intersexuales que no caben en el binario, y no por eso, son inexistentes; quiero sumar a esto que llamarla transfóbica ha sido una estrategia para que ella pueda regularse y medir sus palabras, tal como evidentemente lo hizo.

Posteriormente, hubo un live en el que Ana Bejarano, columnista de la revista CAMBIO y Matilde González abogada transfeminista estuvieron conversando sobre varios puntos vinculados con las acusaciones hacia Carolina sobre transfobia y si éstas pueden poner en riesgo la libertad de expresión. Al respecto, hubo varios momentos en los que Matilde habló señalando que los comentarios de Carolina eran transfóbicos porque aquello que dice, nutre y mantiene el prejuicio, y sabemos que existen crímenes por prejuicio, frente a los cuales expresa que facilitan la violencia y la justifican cuando ocurre.

A mí me hace pensar sobre el sistema de creencias que sostiene el pensamiento de Carolina Sanin, veo que tiene una preocupación por los derechos de las mujeres, y allí convergemos todxs, al mismo tiempo, esto no puede suponer negar la existencia de las personas trans y menos tacharlas de amenazantes frente a otras existencias, en este caso, la existencia de las mujeres, porque ahora sí, más allá de las identidades políticas, son las vidas, los cuerpos encarnados, los que son vistos bajo sospecha y peligro ¿la posición que en primera medida tomó Sanin promueve la justicia social?. Señalo este caso en particular porque esta matriz de pensamiento va más allá de Carolina, de hecho, es socialmente compartida por varios sectores y personas, por lo que quiero señalar que no pretendo en absoluto sumarme a la cancelación de la escritora, sino abordar este fenómeno social.

En ese sentido, quiero decir que existen consecuencias reales y materiales que trae decir eso, no como ella lo asegura en su video que si un día yo decido ser menor de edad pues que se reconozca mi autodeterminación, porque no opera y no se configura de ese modo, existe una correlación corporal, somos seres que integramos la experiencia, la escogencia de ser una personas trans no es una elección de conveniencia jurídica, en otras cosas, porque no existen

privilegios al respecto; por el contrario, la dominación y la concentración del poder si trae consecuencias de beneficio para unos y de precariedad para otros. Como se ha visto la experiencia de vida trans no ocurre en lo abstracto tiene una relación corporal, prácticas, rituales, sistemas sociales en movimiento, sistemas de creencias, que se configuran de acuerdo con la trayectoria vital de cada persona y los contextos que la posibiliten.

También, siento que el debate debe darse bajo condiciones de igualdad, de esto se tiene que hablar más allá de la existencia de las mujeres, considero crucial debatir sobre los modos de vida que llevamos, el convivir con otrxs, la función que trae teorizar y pensar qué existencia queremos elegir. Entonces bienvenido el debate como sustenta Ana Bejarano, diría yo bienvenida la reflexión.

Todo este asunto me ha llevado a preguntarme sobre la discriminación, volviendola verbo, discriminar, que es una acción ¿en qué consiste?, ¿qué acciones se vinculan con la discriminación? y ¿cuáles son sus consecuencias?

En el artículo *Measures of racism, sexism, heterosexism, and gender binarism for health equity research: from structural injustice to embodied harm—an ecosocial analysis* de Nancy Krieger (2020) expone la importancia de estudiar el racismo, el sexismo, el heterosexismo, y el binarismo de género como sistemas sociales de dominación que son dañinos y que estructuran desigualdades en salud. También señala que existen muchos estudios de discriminación autopercebida por parte de personas trans pero no hay mucho desarrollo sobre las consecuencias en salud sobre la discriminación estructural. La autora se pregunta cómo la injusticia da forma a la salud de la población, pregunta que me parece sumamente interesante y se me vienen muchos casos a la cabeza, entre ellos el de Alejandra.

El 28 de mayo de 2020 Alejandra empezó a tener dificultades para respirar, Alejandra era una mujer trans que vivía con Leidy una amiga suya a quien cocinaba y hacía el aseo de la casa, además de ser vendedora informal, con la llegada de la pandemia Alejandra no salía de casa. Esa noche Leidy, su amiga, llamó una ambulancia que tardó 40 minutos después de la llamada, los paramédicos le hicieron una auscultación y dijeron que tenía dificultad respiratoria severa que no había de qué preocuparse porque posiblemente podría ser consecuencia de una sobredosis de alguna sustancia psicoactiva (Alonso, 2020). Cuando Leidy le dijo al paramédico

que Alejandra vivía con VIH el paramédico se alejó y dijo que eso debía ser pasajero, así que la ambulancia se fué, y unos minutos después Alejandra falleció.

Yo me pregunto ¿por qué los paramédicos se fueron? ¿por qué no le tomaron una prueba de COVID? ¿por qué no le dieron oxígeno? ¿por qué no la trasladaron a un hospital? no se puede decir que el paramédico tenía un odio hacia las personas trans, lo que sí, es que operando bajo sus estereotipos (las personas trans son consumidoras de sustancias psicoactivas y abusan de ese consumo) y su desconocimiento (el contagio del VIH se realiza con solo tocar el cuerpo) hubo negligencia médica y que quizá reflexionar sus estereotipos e informarse sobre el VIH, pudo haberle salvado la vida a Alejandra. Es decir que, pensar cómo pienso crea realidad, creer lo que creo, elabora conducta. Adicionalmente, esta conducta estereotipada señala Krieger tiene una alineación con ismos discriminatorios, en este caso, sexismo, binarismo de género y clasicismo (2020, p. 48).



Me duele profundamente una de las últimas escenas de la película *Boy's dont cry* (1999) en la que se muestra a Brandon Teena (un chico trans) antes de ser violado sexualmente -asesinado en la vida real- a quien hacen pasar por un examen de comprobación de su “verdadero sexo”, ya hemos visto cómo se configura esta creencia en el binario sexo-género. En el sistema heteronormativo los hombres son educados para tener el poder correccional sobre el cuerpo de las mujeres, es una violencia que está mediada por la creencia de una superioridad moral castigadora y correccional basada en estereotipos de género. En este caso, Brandon es castigadx por el colectivo masculino. La genitalidad entonces es el veredicto final y la violación la forma correccional para eliminar a Brandon.

“El travesticidio/transfemicidio es el extremo de un continuum de violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en la prostitución/el trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la

*violencia policial. Esta trama de violencias constituye el espacio de experiencia de travestis y mujeres trans y se espeja en su menguado horizonte de expectativas. En él, la muerte no tiene nada de extraordinario, por el contrario, al decir de Octavio Paz “vida y muerte son inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente” (1961: 58). “*⁶⁴

En este hilo, un informe⁶⁵ de varias organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe expusieron que en el periodo de tiempo transcurrido entre los años 2014-2019 en Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia existieron 1.292 homicidios a personas LGBTI. En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo (2020) señala que en el primer año de la Pandemia por el CoronaVirus SARS Cov-2, se registraron 63 homicidios por prejuicio contra personas identificadas como LGBTI, en su mayoría, a mujeres trans. Generalmente las investigaciones de estos casos resultan ser señaladas como crímenes pasionales, sin embargo, la categoría de violencia por prejuicio ha permitido la identificación de los actos que buscan la dominación y la eliminación de las personas sexualmente diversas.

Otros actos de discriminación se relacionan con lo que Blas Radi señaló como el continuum, de violencias, en la serie La Veneno, Valeria le dice a su madre:

“Mamá dijiste que Cristina es una persona peligrosa. Pero, ¿sabes que? Peligroso es tener una madre que te maltrata, peligroso es tener que huir de tu casa a los 13 años, peligroso es que en cada esquina de tu pueblo te llamen maricón y que tu mayor tortura sea el deseo de que te amen o sentirte sola porque nadie ve quién eres, eso es peligroso, mamá. Ella supo luchar sí, pero no es una mujer peligrosa. Son mujeres. Bueno, somos mujeres para las que el mundo es peligroso, no me quiero ir de casa mamá, no quiero hacer este proceso sola, pero depende de ti.”

⁶⁴ En el artículo de Blas Radi no se referencia el libro que se cita de Octavio Paz. Sin embargo, se encuentra en una compilación de ensayos llamada Del Modernismo a nuestros días. Antología literaria hispanoamericana de Alberto Acereda y Justo S Alarcón. New York, Hispanic Studies: 2011. Página 297. Disponible aquí: <https://books.google.com.co/books?id=8FREAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=twopage&q&f=false>

⁶⁵ Para obtener más información al respecto se recomienda revisar los informes anuales de Colombia Diversa: <https://colombiadiversa.org/publicaciones/> y Caribe <https://caribeafirmativo.lgbt/publicaciones/informes/> Afirmativo:

A su vez, esto tiene consecuencias importantes en la garantía de derechos y el acceso a la justicia, en el artículo Afectación de la discriminación sobre los derechos económicos y sociales de las mujeres transgénero en el municipio de Sincelejo, Sucre citan lxs investigadorxs que la discriminación coloca a las personas trans en posiciones de desigualdad de condiciones para llevar a cabo su proyecto de vida *“abandonar la educación ha reducido las oportunidades laborales, las ha excluido de uno de los regímenes del sistema de salud, les ha negado cualquier posibilidad de obtener una pensión y les ha reducido la capacidad de hacer movilidad social”* (Loaiza, Martinez & Rodriguez 2020:47). En otro artículo leí la pregunta ¿quién se beneficia de que esta desigualdad continúe? En ese sentido, estas afectaciones configuran los determinantes sociales de la salud (Thurston, et al. 2023) para que existan escenarios donde las personas puedan llegar a su máximo potencial y se encuentren en armonía con la vida navegando los problemas cotidianos que en ella suceden.

La creencia de que las personas trans son enfermas o hay algo que corregir en ellas han supuesto prácticas como lo hemos visto las prácticas de tortura para la conversión, la expulsión del hogar a edades tempranas, la negligencia médica. Con esto quiero señalar que no es lo mismo un transfeminicidio a comentarios discriminatorios, sin embargo, lo que sí sucede es que el sistema se retroalimenta, veamos un ejemplo.

El mejor estudio sobre el sufrimiento que deviene de la desigualdad social y la discriminación es el que he terminado de leer hoy, se llama *Las Malas* de Camila Sosa Villada, me he reído, llorado y enfurecido a su lado, como si viviéramos en dimensiones diferentes siento que la acompaño en su escritura. Me pican los ojos de tanta injusticia, las letras se te meten por todo el cuerpo, de la misma manera en que ella lo ha escrito. Camila en este libro nos comparte las historias de las travestis del Parque Sarmiento en Córdoba, Argentina, esos seres míticos, como las describe ella, quienes fueron sus amigas, quienes la salvaron de la muerte, quienes se reunieron a compartir la vida. Así que pondré aquí el momento del libro que me rompió el corazón en mil pedazos de cuarzo rosa:

“Hay cada vez más desapariciones. Hay un monstruo ahí afuera, un monstruo que se alimenta de travestis. De un día para el otro ya no estamos, simplemente. Mientras menos lazos tenemos entre nosotras más fácil es hacernos desaparecer. Yo estoy frente a la puerta de la pensión de La Tía Encarna porque me enteré de que ha dejado de llevar al niño a la escuela, después de que él fuera víctima de todas las violencias posibles. El Brillo guardó silencio frente a cada una de esas injusticias. Da terror el

maltrato al que se lo sometió. Y el pobre santo no contó nada, nunca le dijo a su madre lo que sufría en la escuela. Un día llegó a casa con los dedos hinchados y de color violáceo, no tenía fuerza ni para sostener el peso de la tasa en las manos. Unos compañeros le habían apretado los dedos con una puerta hasta dejárselos así.

—¿Por qué?—preguntó La Tía Encarna.

—Porque soy hijo tuyo—Contestó El Brillo.

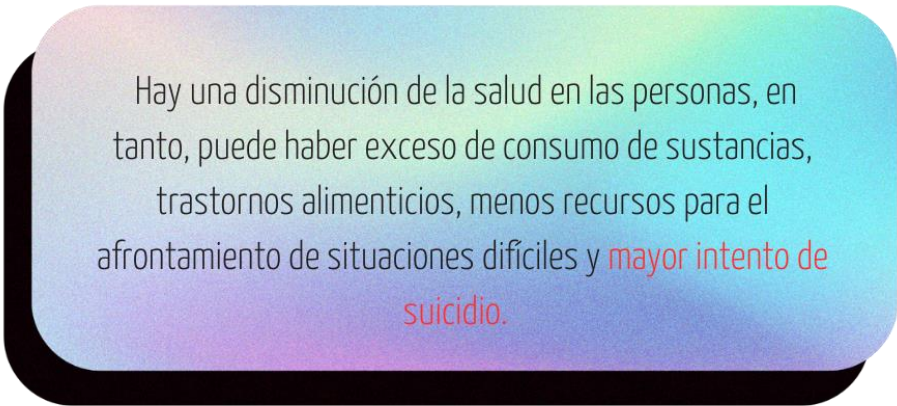
La Tia Encarna le preguntó si quería seguir yendo a la escuela o preferiría que una maestra fuese a darle clases a domicilio. El Brillo no contestó, así que decidió ella. Pegó carteles en los postes de luz del barrio: Se busca maestra particular que sea amorosa y comprensiva. Pero las pocas que llegaban a tocar el timbre se espantaban al ver la barba y las tetas fajadas de La Tia Encarna. (...) <<Vas a terminar tirada en una zanja>>, me decía mi papá desde la punta de la mesa. <<Tenés derecho a ser feliz>> nos decía La Tia Encarna desde su sillón en el patio. >>La posibilidad de ser feliz también existe>>. En nombre de ese recuerdo cruzo avenidas llego hasta esas calles que alguna vez sentí como propias. (...). Falta una cuadra y media para llegar cuando veo unas luces rojas y azules que titilan con brutalidad delante de la puerta de La Tía Encarna. (...). El bombero me dice que el cuarto estaba sellado desde adentro (...) Van a caraturarlo como suicidio y asesinato << Que se matara ella, vaya y pase. Pero arrastrar a la criatura es imperdonable>>, dice el bombero (Sosa, 2019. p .214,215,216,217,218).

Cada persona con su gota aportó a que lo desafortunado ocurriera, tanto he escuchado yo: “*es que la sociedad en la que vivimos...*” yo soy la sociedad, tú que me estás leyendo, todxs somos y no podemos permitir que esto siga ocurriendo, eso se llama CORRESPONSABILIDAD, todxs somos responsables. ¿Qué podemos hacer frente a la discriminación? somos nosotrxs los que hemos creado este sistema que excluye vidas, tenemos en nuestras manos el poder de decidir y crear otros sistemas que posibiliten y conserven la vida. Lxs vecinxs de La Tia Encarna llevaban mucho tiempo lanzándole comida a su casa, pintando letreros con ofensas, persiguiéndola, todo el sistema es responsable de que ella decidiera darle fin a su vida y a la vida de su hijx, porque somos quienes configuramos una no salida para las personas sexo-género diversas, todxs hemos configurado unos espacios pocos, restringidos y precarizados para las personas sexo-género diversas, todxs al callar ante el odio, y no se trata de vulnerar la libertad de expresión, se trata de pensar que aquello que yo diga puede promover la eliminación del otro.

¿Qué piensas tú sobre esto?

Ahora bien, veamos algunos estudios sobre los efectos en la salud de personas trans que perciben discriminación.

En el artículo *Impacto en la salud del estigma, la discriminación y los prejuicios experimentados por las personas transgénero: una revisión sistemática de estudios cuantitativos* (Kerry Drabish y Laurie A. Theeke, 2022) se consultaron 15 estudios sobre los efectos que esto tiene en la salud y se encontró que:



Hay una disminución de la salud en las personas, en tanto, puede haber exceso de consumo de sustancias, trastornos alimenticios, menos recursos para el afrontamiento de situaciones difíciles y **mayor intento de suicidio.**

En otro estudio llevado a cabo por Aparicio-García ME, Díaz-Ramiro EM, Rubio-Valdehita S, López-Núñez MI, García-Nieto I (2018) con 856 jóvenes en España entre los 14 y los 25 años de edad de los cuales 532 fueron identificados como cisgénero, 180 como transgénero, y 70 como personas no binarias. Este grupo encontró que **las personas trans y no binarias (TNBI) tienen más riesgo de experimentar actos de violencia y discriminación que las personas cisgénero, estas reciben menos apoyo de sus familiares y tienen bajos indicadores de salud física y psicológica respecto a las personas cisgénero.** De este modo, señalan:

Las TNBI⁶⁶ son particularmente vulnerables a problemas de salud mental y angustia psicológica [25 , 26 , 27 , 28], riesgo elevado de depresión [29 , 30], altas tasas de prevalencia de ansiedad [31] y menos autoestima [32]. Las experiencias de discriminación y transfobia se han relacionado estrechamente con el intento de suicidio y las autolesiones no suicidas. ⁶⁷

⁶⁶ Significa: Trans, non-binary, intersex or gender variant. En español se encuentra como Transgénero, género no binario, intersexual o de género variante.

⁶⁷ En paréntesis se encuentran estudios que respaldan las ideas de lxs autores en el estudio.

Al mismo tiempo, Federica Pinna et al (2022) exponen un trabajo valiosísimo de revisión de 165 estudios sobre factores de riesgo (consumo de drogas, experiencia de trauma y estrés, trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, etc.) en personas trans y se encontró que las personas con experiencia de vida trans muestran altas afectaciones a su salud y una mayor prevalencia de trastornos psicológicos, siendo la ansiedad uno de los más comunes y 13 veces mayor el suicidio consumado respecto a las personas cisgénero. Todo esto contenido por factores que sostienen el problema como falta de apoyo familiar, discriminación, barreras de acceso a educación y trabajo, prejuicio y violencia.

El proyecto de Transrespect muestra cómo el mundo avanza por los derechos de las personas trans⁶⁸, existen muchos avances en Colombia que afortunadamente no han mostrado retrocesos, al mismo tiempo, en lo que va corrido de este año 2023 en Estados Unidos existen 380 proyectos de ley que buscan eliminar derechos que protegen a las personas trans en 44 estados (Caribe Afirmativo, 2023). Frente a esto, un estudio realizado a 301 adultos trans en diferentes estados de USA en los que se estaban promoviendo leyes antitrans, las personas que tenían conocimiento al respecto señalaron que aumentaban su sentimiento de desesperanza y, por lo tanto, incrementaron sus síntomas de depresión y ansiedad. (Tebbe, EA, Simone, M., Wilson, E. y Hunsicker, M. 2022: 27).

Finalmente, ¿Cómo operan las creencias que pueden producir discriminación en el campo de la salud? Las barreras de acceso a la salud no se acaban con tener alguna afiliación al sistema de salud en términos de cobertura sino de acciones discriminatorias que hacen que las personas no quieran acceder al sistema tales como: lxs profesionales de la salud se nieguen a tocar a las personas sexo-género diversas, lxs profesionales de la salud utilizan un lenguaje abusivo o son físicamente abusivos (CIDH, 2015.p. 132), lxs profesionales de la salud realizan preguntas que he denominado de “chismografía” que hacen sentir incómodxs a las personas trans, lxs profesionales no cuentan con la información sobre salud trans y sean los paciente quienes asumen intentar educar a lxs profesionales de la salud (Bauer, G. R., et al. 2009).

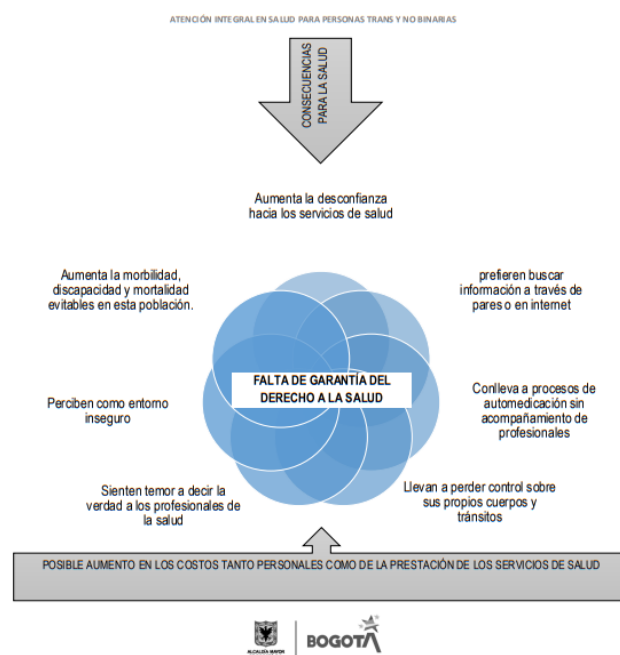
Respecto a este último punto: sobre los conocimientos del personal de la salud frente a los tránsitos de género, en el estudio *Modelo de prestación de servicios de salud con enfoque*

⁶⁸ La página web en donde se puede consultar es esta: <https://transrespect.org/es/legal-and-social-mapping-publications/>

diferencial para personas con experiencia de vida trans en una IPS de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Abril, et al. 2019) se encuestaron a 196 profesionales de la salud que trabajaban en la misma IPS y se encontró que sólo el 22% sabía la diferencia entre orientación sexual e identidad de género.

En el estudio *Experiencias de atención en salud de personas LGBT y significados del personal de salud que les atiende*, Silvia Arenas (2018) entrevistó a 8 personas que se reconocieron como LGBT en Bogotá de las cuales dos personas se reconocieron como personas trans quienes expresaron que en ocasiones habían solicitado citas en medicina general pero que lxs profesionales habían negado su atención. Situación que es similar a la reportada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Robert Eads, “un hombre trans al que le diagnosticaron cáncer de ovarios y se reportó que al menos doce profesionales de la salud se negaron a dale tratamiento por miedo a que el tratamiento de este caso de variación de género pudiera dañar la reputación de sus prácticas médicas.” (CIDH, 2015. p. 133).

Este tipo de situaciones discriminatorias conducen a que las personas trans no accedan a los servicios de salud y por lo tanto, gestionen incluso sus tránsitos de manera personal, constituyéndose como un riesgo para la salud. En el documento *Atención integral en salud para personas trans y no binarias* realizado por las Secretarías de Salud y Planeación de la Alcaldía de Bogotá, se expone el gráfico de la derecha (2021.p.28) en el que se expone los efectos de la falta de garantía del derecho a la salud, lo cual, repercute incluso en los costos económicos personales y del sistema si las personas deciden no acudir al mismo, costos vinculados con la automedicación y las intervenciones artesanales.



En ese sentido, uno de los principales retos para trabajar en prevención de la discriminación es sobre las creencias del personal médico. Esta es una herramienta para poder reflexionar sobre las creencias propias, éstas se pueden realizar de la siguiente manera:

Creencia	¿De dónde viene esta creencia?	¿Cuáles son las consecuencias para lx paciente el que yo opere bajo esta creencia?	Preguntas para reflexionar sobre la creencia
Es necesario pedirle un examen de VIH a una persona trans desde la consulta del médico general	Es posible que venga de la creencia vinculada con que las personas LGBTIQ+ son personas que tienen una vida sexual desbordada y mucho más activa que la del promedio de las personas. Es posible que esta creencia venga de pre-concebir que todas las personas trans ejercen el trabajo sexual sin protección.	Una de las consecuencias puede ser que las personas desistan de seguir en el sistema de salud.	*¿Operar bajo esta creencia traerá bienestar a mi paciente? *¿Sería diferente si quien asistiera a mi consulta fuese una persona cisgénero?
La sentencia de tutela 218 de 2022 expone el caso en el	Esta creencia puede estar vinculada a que los tránsitos de	La consecuencia que resultó de esta acción fue que no se	*¿Operar bajo esta creencia traerá bienestar a mi

que una especialista sostuvo que el tratamiento no se podía llevar a cabo porque el accionante no cumplía la mayoría de edad y ordenó un conjunto de exámenes “ <i>para descartar que no estuviera pensando ‘esas cosas’ como consecuencia de algún desorden hormonal</i> ”.	género ocurren por un desorden hormonal, en este caso, típico de la adolescencia.	le dio nuevamente una cita al menor y estuvo varios meses dentro del sistema intentando pedirla. Al momento de la resolución de la tutela ya no quería entrar al sistema de salud por el proceso de tránsito de género, además manifestó, sentir altos niveles de ansiedad sobre este asunto.	paciente? *Si necesito informarme más al respecto ¿Qué podría decirle hasta elaborar un concepto propio?
Las mujeres transgénero experimentan disforia de género de por vida debido a una asignación de género al nacer que es incongruente con su identidad de género (Tangpricha, V., & den Heijer, M. (2017).	La creencia que sostiene esta es que el tránsito de género es una enfermedad que acompaña a la persona el resto de la vida.	Operar bajo esta creencia nos diría que las personas trans siempre estarán de manera permanente dentro del sistema y que el malestar de género proviene de un proceso individual irresoluble.	*¿Esta creencia cómo promueve la salud para las personas trans?

A la vez, preguntarse ¿de dónde esta creencia? y ¿qué me permite hacer o me impide hacer esta creencia? es crucial para reflexionar sobre la práctica médica y no reproducir actos de discriminación en el sistema de salud.

Otra de las herramientas para lo que se ha denominado desarticular el prejuicio, el estigma y la discriminación es entender el proceso de tránsito de manera individual y poder conocer y conectar con personas trans. Así Aristegui (2015) señala:

Sobre la base de la descripción de Brehm et al, (2002) con respecto a cómo desarticular prejuicios y romper con la escalada de discriminación, a partir de establecer contactos individuales con las personas y no darles un trato como entidad grupal; y a partir de las dimensiones de valores propuestas por el mismo Schwartz y sus colegas (...) podría pensarse que el foco debería estar en aquellos valores asociados a la apertura al cambio y la auto-trascendencia, ya que tienden a promover la búsqueda por lo novedoso, el juicio independiente así como el respeto por la igualdad y el bienestar de los otros. (p.106).

Los miedos

El reconocimiento de la diversidad sexual y de género no implica la pérdida de la estructuración de la vida social, porque eso es imposible, nuestra mente expandida y social está configurada para dar orden a la experiencia, esto se encuentra en nuestra filogenética mediante el lenguaje, vivimos ahí. Lo que sí puede significar es configurar un orden que posibilite la vida de todxs, que no prohíba la existencia y la experimentación de nuevas formas de ser. Los tránsitos de género no binarios no son una moda, de hecho, son ancestrales. De lo que se trata es de configurar un orden que respete la vida, la vida no puede ser valiosa si hay amenaza perpetua de muerte⁶⁹.

Saoko de Rosalía fué mi mantra un año, es una canción que da un montón de ejemplos sobre la transformación y eso se vincula con la trascendencia, todo está en constante cambio ¿qué es aquello que se conserva o permanece? Imagino cientos de miles de años atrás, a nuestrxs ancestros observando y organizando esta experiencia, dándose cuenta del cambio, ritualizando la transformación. La diversidad sexual y de género no son elementos que quedan detrás del rito, por el contrario, existen múltiples ritos alrededor de la misma expresada en la cotidianidad como en los carnavales y las fiestas. Amo el libro de *Borderlands: La frontera la nueva mestiza* de Gloria Anzaldúa, es un libro que he llorado y reído, conecto con su mística porque Anzaldúa

⁶⁹Desarrollo este aspecto en el apartado La negación del amor.

víncula la espiritualidad con la diversidad de género y sexual apelando a la configuración de su frontera. Cruzar las fronteras territoriales y de género es un asunto de la transformación.

¿Por qué teorizamos?: sobre la ética psicológica transfeminista

¿Cómo es el ejercicio de una psicología trans, muxe, antirracista, antipatriarcal, mutante, marica? La psicología como disciplina no puede quedarse atrás de la marcha Trans del barrio Santa fé, o atrás de los testimonios de las víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado de la Comisión de la verdad, o atrás del debate por la Educación Sexual Integral en los colegios, tenemos la gran responsabilidad de investigar e intervenir para aportar al bienestar social y la armonía de la vida.

El Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC)⁷⁰ ha hecho 3 tweets en referencia a la población LGBTIQ⁷¹ que se relacionan con la celebración del día del orgullo, se han realizado otros 3 tweets respecto al Diagnóstico de disforia de género en 2018 por una conferencia realizada por el entonces director Bernardo Useche. Producción que no ha sido muy significativa al tener 48.000 colegiados inscritos.

Por otra parte encontré, que Miguel Chaparro y Reinel Rueda son representantes por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic ante la Red IPsyNet (International Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues) la cual es una red que trabaja por la generación de conocimiento de personas sexo género diversas y tienen un sólo video de YouTube hablando un poco sobre qué es la red ¿será esto suficiente?

En el año 2015 la Corte Constitucional pidió a algunos actores de la Academia un concepto sobre las consecuencias en el desarrollo psicosocial de niños, niñas y adolescentes la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo; teniendo en cuenta que en Colombia, ya existía la siguiente matriz jurídica:

*La sentencia C-577 de 2011 en la que la Corte Constitucional reconoce que las familias homoparentales son familia.

⁷⁰ Hago esta nota al pie como una sugerencia no pedida: es preciso actualizar el nombre de esta organización gremial, si de mayorías se trata debería ser de Psicólogas, sin embargo sugiero Psicólogxs.

⁷¹ No se encontró ninguno frente a estos thesaurus de búsqueda: queer, cuir, eunuco, hermafrodita.

*La sentencia T-276 de 2012 en la que la Corte Constitucional enuncia que la orientación sexual no debe interferir en un proceso de adopción.

*La sentencia SU-617 de 2014 en la que la Corte Constitucional aprueba la adopción consentida a parejas del mismo sexo; es decir, la adopción que se le otorga a la pareja o conyúgue de un padre o una madre biológico de un(x) niñx demostrando convivencia ininterrumpida de no menos de dos años.

Es curioso porque para ese año las parejas del mismo sexo podían adoptar de forma individual o acudir a la adopción consentida, sin embargo, todavía faltaba la aprobación de la adopción

"Los estudios realizados hasta la fecha sobre la inocuidad de la evolución de los niños adoptados por personas del mismo sexo no han sido concluyentes porque carecen del rigor científico necesario para sacar conclusiones debidas fundamentalmente al pequeño tamaño de la muestra y por no ser aleatorizados, sin grupos de control adecuado.

Por otro lado si algo se ha podido salvar de estos estudios es que los niños han presentado baja autoestima, estrés, inseguridad respecto a su vida futura en pareja y tener hijos, trastornos de la identidad sexual, rechazo del compañero o compañera del progenitor homosexual como figura materna o paterna y preferencia a vivir con el otro progenitor, es más frecuente trastornos de conducta como drogodependencia, disfunciones alimentarias, fracaso escolar, mal comportamiento en clase y que sufran con más frecuencia experiencias traumáticas por ruptura de la pareja, situación que es mucho más frecuente que cuando se trata de matrimonios estables de un hombre con una mujer. La presencia de conductas o identidades homosexuales es del orden de 8 veces más frecuente que la media.

conjunta para estar en igualdad de derechos con parejas de sexos opuestos. Es así como varias universidades y organizaciones hicieron llegar a la Corte su

concepto. Una de ellas fué la dictaminada por el director del programa de Medicina de la Universidad de la Sabana, Álvaro Enrique Romero⁷² quien emite un concepto sobre estudios que no cita ni hace referencia de manera rigurosa, así que no se saben de dónde provienen, por lo tanto, conocer cómo se llevaron a cabo, los alcances y limitaciones de los mismos u otros factores asociados a dichos resultados (como la discriminación, por ejemplo) no se encontraron.

El resultado de la revisión de los estudios es la correlación directa entre orientación sexual y trastornos de la conducta -que el mal nombra como enfermedades mentales- tales como consumo excesivo de sustancias psicoactivas, promiscuidad y abuso sexual. A pesar de que la APA haya sacado la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) desde los

CONCLUSIÓN

Los artículos estudiados nos muestran un panorama claro y dejan una duda razonable respecto a los daños que sufre un niño adoptado por una de estas parejas y que aconsejan claramente una familia formada por un padre y una madre para la crianza de los hijos, una pareja estable. Pensando en el mejor bienestar para los hijos es evidente que una "familia" sin el modelo para el hijo del padre y de la madre, inestables, constituida por personas con riesgos alto de consumo de sustancias psicoactivas y con índices altos de suicidio no son más adecuadas, el adoptado está en mayor riesgo de sufrir abusos sexuales.

⁷² Fragmento del concepto de la Universidad de la Sabana para la Corte Constitucional en la coyuntura sobre la adopción homoparental en el año 2015. Concepto completo disponible en: <https://fddocuments.ec/document/concepto-adopcion-igualitaria-universidad-de-la-sabana-medicina.html>

años 70's, la Universidad de la Sabana en aras de defender la unidad familiar madre-padre cisgénero y heterosexual, pasa por alto los avances de la despatologización en la psicología y la psiquiatría.

Es importante puntualizar que el concepto devela una comparativa entre las relaciones heterosexuales como un vínculo normalizador y el de las relaciones homosexuales como un vínculo ligado a la anomalía, asociando la heterosexualidad a la salud y la homosexualidad a la enfermedad. Es decir, que dicho proceso es el que denominaría Monique Wittig como el de la heterosexualidad obligatoria. Señala Preciado que una de las consecuencias desfavorables de leer el mundo en estos binomios es que dichas denominaciones se han convertido en identidades y por lo tanto, son encarnadas por personas, es decir, son una forma de gestión de la vida. ¿Cuáles son las condiciones de un entorno protector que sólo garantiza la familia biparental heteronormativa para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo la orientación sexual se involucra en dichas condiciones? ¿En realidad, qué es aquello que se quiere conservar de la familia “tradicional”?

El concepto emitido tiene serios fallos a la ética, en tanto, se justifica el prejuicio mediante la interpretación parcial de estudios científicos. Y es que la producción científica no escapa del mundo social, evidentemente se suscribe en un nicho ecológico que la posibilita y reproduce, por lo tanto, hubo varios sectores sociales y políticos que apoyaron este concepto ¿Este concepto qué tanto posibilita la vida o la muerte de las personas? ¿Qué tanto trae armonía a los seres de la tierra? ¿Esta posición cómo vislumbra la convivencia humana?

Paul.B. Preciado en su texto Testo Yonki señala: *“cuando un cuerpo abandona las prácticas de la sociedad en la que vive le autoriza como masculino o femenino, se desliza progresivamente hacia la patología”* (2008:173) esto es tan absurdo que un buen ejercicio para reflexionar al respecto es pensar ¿qué pasaría si sucediese al revés?, me refiero, a que pasaría si un día despertáramos y fuese anormal la heterosexualidad y ser cisgénero ⁷³.

⁷³ Este ejercicio lo hicieron el canal de divulgación de YouTube Stereotipas en el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=ujm-ZcYCCL4>

Reproducir estas creencias sin atravesar por un proceso reflexivo conlleva al ejercicio automático de prácticas de violencia hacia personas sexo-género diversas, veámos un ejemplo. En mayo de 2022 el congresista Colombiano Mauricio Toro⁷⁴ radicó un proyecto de ley para eliminar las mal llamadas “terapias de conversión”, y se han denominado mal llamadas porque es una práctica que está lejos de proporcionar bienestar y nada tienen de terapéuticas, un nombre más a fin podría ser: procedimientos de violación a los derechos humanos o procedimientos de tortura psicológica. Es importante resaltar que estas prácticas no están avaladas y son rechazadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes incluso señalan que realizar estos procedimientos representan un riesgo para la salud, así que estas prácticas se han restringido a realizarse en lugares clandestinos que en su mayoría están relacionados con grupos religiosos.

En conjunción con el proyecto de ley, la ciudadanía firmó la campaña de All Out *¡Por el fin de las terapias de conversión en Colombia!*⁷⁵ con 28,818 firmas registradas hasta la fecha, adicionalmente la revista feminista Volcánicas realizó un reportaje llamado *Inconvertibles*⁷⁶ en el que se encuentran testimonios de personas sexo-género diversas que pasaron por estos procedimientos por grupos religiosos. En el reportaje citan a Sofía Poiré, coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance A.C. quien señala que el término más ajustado para estas prácticas es Esfuerzos de Cambios e Orientación Sexual, Identidad de género o Cambio de expresión de género (ECOSIEG) el cual engloba un conjunto de experiencias violentas y desorganizadas que no siempre implican un procedimiento y que tienen como objetivo eliminar las identidades de sexo y género que salen de la heteronorma.

“Una vez a los 17 me llevó engañada a la iglesia cristiana de ella y entonces yo ya conocía al pastor porque vive en la misma cuadra de nosotros, cuando él estaba acercándose a la gente les echaba aceites de unción principalmente. Cuando yo le dije a mi mamá, mamá que no me vaya a tocar a mí. Ella ya lo tenía planeado, cuando el tipo se venía a acercar a mi ella me agarró como de acá y el tipo lo que hizo fue ponerme el aceite y tirarme la silla cuando todos los ayudantes se vinieron como 5 o 6 a rodearme como para armar el showcito y el tipo me cogió acá y casi me rompe la

⁷⁴ Para ampliar la información se puede consultar: <https://www.camara.gov.co/historico-representante-mauricio-toro-radica-proyecto-de-ley-para-ponerle-fin-a-las-mal-llamadas>

⁷⁵ Puedes ampliar la información en el siguiente enlace: <https://campaigns.allout.org/es/colombia-conversion-therapy>

⁷⁶ Puedes ver el reportaje completo aquí: <https://volcanicas.com/inconvertibles-la-lucha-en-contra-de-las-mal-llamadas-terapias-de-conversion-una-tortura-para-las-personas-lgtbiq/>

mandíbula y me cogió el codo impresionante y yo si me estaba soltando me cogían como dos de cada lado cuando ya me estaban tapando, el daba entender que se me estaba saliendo un espíritu un demonio y él decía: sal demonio de la transitoriedad, sal de este cuerpo, abandona este cuerpo y todo el mundo decía amén, amén y yo quedé traumada” (Conversación con Emilia, 23 años, Manizales).

En esta misma línea el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual e identidad de género Víctor Madrigal Borloz, escribió un informe en julio de 2020 en el que señala que existen tres estrategias principales usadas por estas prácticas discriminatorias, las cuales pueden ir desde la amenaza hasta la tortura:

- La intervención desde un campo denominado como “psicológico” para modificar una conducta indeseable.
- Prácticas médicas basadas en la idea de la existencia de un error biológico
- Intervención religiosa basada en la idea de que hay un “mal” en las identidades sexuales y de género diversas.

Uno de los aspectos que señala el investigador es que estos métodos son determinados por proveedores públicos y privados de salud mental, Toro (sf) señala que uno de los puntos en común de los relatos del reportaje fué la patologización de la diversidad sexual y de género.

“Las personas trans en Colombia son sometidas a patologización y psiquiatrización forzadas para poder acceder a ciertos derechos. Para que se les garantice un verdadero y efectivo acceso al sistema de salud, es decir, a tratamientos, a cirugías plásticas y al acompañamiento de un médico durante la transición, en caso de que elijan este camino, las personas trans deben primero cumplir con un tratamiento psiquiátrico que certifique que padecen de un “Trastorno de Identidad de Género” (OutRight, 2016).

La patologización hace referencia a concebir los tránsitos de género como una enfermedad y esto supone una mirada biologicista y la medicalización de los mismos. Entonces el diagnóstico aparece como la aceptación de una enfermedad mediante la cual, antes del 2018, se podía acceder a la salud constituyéndose al mismo tiempo como una barrera al acceso a la salud. La respuesta a esto han sido las intervenciones realizadas desde un enfoque afirmativo de género que vamos a ver más adelante.

Como lo hemos visto con anterioridad la historia de la patologización del tránsito viene desde finales del siglo XVIII -como lo describiría Foucault- con el nacimiento de la clínica que se refiere a la emergencia de las instituciones disciplinares que operan de manera coordinada, de este modo, se cristaliza el binomio médico-jurídico. En este sentido, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) desde 1966 hasta 1978 el travestismo junto con la homosexualidad apareció como desviaciones sexuales; posteriormente, en 1990 se denotó el travestismo como trastorno de la identidad de género. De este modo, en el año 2013 el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales⁷⁷ en su quinta edición lo cataloga como Disforia de género. La última actualización que tenemos al respecto es la de 2018, año en el cual la Organización Mundial de la Salud saca la disforia de género del espectro de los trastornos y la ubica como una condición de la sexualidad humana.

El diagnóstico señala la inconformidad de la identidad de género con el sexo asignado al nacer, este malestar proviene de la rigidez del sistema cisheteronormativo, su raíz fundamentalmente es social, me pregunto yo, si fuese cotidiano que cada persona tuviese la libertad de escoger de qué manera quiere expresar su sexualidad (gestos, vestimenta, comportamientos, rituales) si existiría este diagnóstico. Al respecto, Liberarte (2020) afirma que la disforia de género es *“el malestar de género que pueden experimentar algunas personas trans en algunos momentos de su vida”* El malestar de género no viene de forma innata, sino que se configura de acuerdo al contexto y la situación que vive cada persona en algún momento de su vida.

Otro aspecto señalado por Víctor son las estadísticas, de este modo, expone que 1 de cada 5 personas LGBTIQ+ y 1 de cada 3 personas trans se han sometido de manera voluntaria o involuntaria a las “terapias de conversión”, de ellas 4 de cada 5 personas tenían 24 años o menos, de acuerdo con el estudio *Estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia: resultados de una encuesta nacional* el 21% de las personas LGBT de las 4.867 encuestadas, informaron que en alguna ocasión habían recibido tratamiento de alguien para modificar su orientación sexual o identidad de género (Choi, et al. 2019:48). Esto me lleva a pensar sobre la cantidad de personas que, como Emilia, siendo menores de edad y sin su consentimiento son sometidas a estos procedimientos.

⁷⁷ Es importante recordar como se ve en la primera parte de este escrito que el diagnóstico médico ha estado permeado por la información resultante de la interacción con el sistema jurídico y religioso.

Cualquier teoría o estudio científico que segrega y discrimina no es de ninguna manera ético, ni aporta al desarrollo, ni al bienestar social humano; de hecho, atenta contra la vida de las personas, y en este caso en particular, frente a la vida de las personas sexo-género diversas. Quiero poner un fragmento de esta entrevista que le hacen a Carolina Herrera y Simón Torres psicólogos clínicos del consultorio psicoterapéutico Liberarte acerca de la ética:

Entrevistadorx pregunta: “¿Qué significa ejercer la profesión en el marco de una ciencia, unos campos de estudio y de unas leyes que a menudo están a la par con los últimos estudios y que califican como anormal, enfermedad o patología, algunos tipos o formas de ser?

Carolina responde: “creo que eso implica tener... y lo hablamos mucho con Simón, tener una postura ética desde lo profesional también muy clara y para nosotros es clarísimo que nuestra función en ningún momento es ser entes de control social ni normalizar los cuerpos, las vidas, las subjetividades sino por el contrario lo que pretendemos siempre es potenciar la diversidad, creemos en eso como un criterio ético básico.” (...)

Simón responde: “Yo sólo quisiera agregar a esto que estás diciendo tú, que no solamente es el entorno del consultante, si no cómo nosotros también somos parte de ese entorno, en el momento en que las personas se sientan acá, ¿sí? nosotros no somos un ente externo sino entramos a ser parte de esto y como también la misma pregunta que yo le hago, cuando la gente se sienta, está cristalizando o no ese malestar, está cristalizando esa mirada que patologiza... Por eso es que nosotros nos metemos dentro de la ecuación, la mirada que yo tengo, las preguntas que le hago, por dónde yo guío la entrevista, lo que yo privilegio, los silencios que hago, toda mi intervención está privilegiando estás comprensiones que la persona se está llevando de sí, por eso es que hablamos de una postura ética, no solamente de su entorno, sino que nosotros somos parte de ese entorno y para nosotros la piedra angular sí es poder potenciar la diversidad (...)”

Reconocer el poder que tenemos como ciencia es un primer paso para no ser rápidxs al emitir un concepto o realizar una intervención.

Modelos de intervención psicológica

En las últimas dos décadas se han incrementado los estudios sobre modelos de intervención psicológica en los procesos de tránsito de género, en las investigaciones se encuentran los siguientes: el modelo patologizante o tradicional, el modelo basado en el consentimiento informado y el modelo afirmativo de género o transafirmativo.

También existe un modelo de intervención que ha sido desarrollado por Liberarte, el cual es un consultorio psicológico que se ha especializado por varios años en la investigación a personas sexo-género diversas, el cual también me gustaría exponer. Adicionalmente, poco a poco se está tratando de establecer una ruta de acompañamiento a pares liderado por las organizaciones de base, al respecto, tengo conocimiento de manera más cercana, los procesos pedagógicos que lleva a cabo la Liga de salud trans, ya que, participé como observadora en la pandemia de su proceso formativo con Liberarte y acompañé el trabajo realizado por pasantes de la Universidad Externado de Colombia en la construcción de las rutas de atención internas de la organización. De este modo, me gustaría hablar sobre el acompañamiento a pares, el cual ha sido, una fuente de resiliencia importante. A modo de cierre quisiera finalizar con algunas recomendaciones que me parecen que son clave para tenerlas presente. Sin más preámbulo, comencemos.

En el artículo *De la patologización a la politización de las identidades de género diversas. El rol de los profesionales de la salud en los tránsitos de género* de Carolina Herrera y Simón Torres (2018 B) se encuentra la siguiente tabla que recoge las diferencias epistemológicas entre el modelo patologizante y el modelo basado en el consentimiento informado:

Tabla 1. Diferencias epistemológicas entre el modelo patologizante y el modelo basado en el consentimiento informado.		
	Modelo patologizante	Modelo basado en el consentimiento informado
Comprensión de las identidades de género diversas	Trastorno, enfermedad o desviación que debe ser diagnosticada y tratada para ser curada	Variaciones humanas que emergen y se desenvuelven en la interacción con múltiples contextos y dimensiones de la vida.
Concepción de las personas trans	Personas que nacieron con un problema en su identidad de género (determinismo biológico) o que por circunstancias traumáticas de su infancia tienen una identidad de género diferente. Requieren intervención médica para adaptar sus cuerpos a su identidad y así aliviar su "disforia".	Personas que exploran y construyen su género de forma diversa y que se enfrentan a estructuras sociales binarias y patologizantes, frente a las cuales cuentan con capacidades y vulnerabilidades cambiantes para afrontarlas. Cuentan con experiencias de vida, necesidades y recursos muy variados.
Rol de los/as profesionales de la salud	Diagnosticar y tratar el "trastorno de la identidad de género" o la "disforia de género" a través de transformaciones corporales que ayuden a la persona adaptarse socialmente y a aliviar su malestar.	Pueden hacer parte de la estrategia multidisciplinaria y compleja que la persona emplea para explorar su género y/o desarrollar su tránsito. Informar a la persona de las diferentes opciones que la medicina ofrece para transformar el cuerpo, reconociendo que el proceso vital implicado en la construcción identitaria es mucho más amplio y que en el malestar (que puede o no presentarse) se conjugan múltiples factores de orden subjetivo, interaccional y social que la medicina no puede resolver por completo. Facilitar la toma de decisiones por parte de la persona en cuanto al plan de atención médica.
Participación de la persona trans en el proceso	Pasiva: el profesional dirige el proceso diagnóstico y terapéutico, usualmente desde el modelo triádico (diagnóstico psiquiátrico, hormonación y cirugías).	Activa: la persona trans dirige la construcción de su identidad de género y diseña con el apoyo de los/as profesionales y otras personas significativas una estrategia que le ayude a alcanzar sus objetivos.
Relación médico-paciente	Jerárquica. El profesional es el experto que indica a la persona lo que le ocurre y la manera de curar su malestar.	Heterárquica: los profesionales y las personas trans complementan sus experticias. Los profesionales como expertos en crear condiciones de cambio para que las personas realicen sus proyectos en el ejercicio de su autonomía, y las personas trans como expertas en la manera en que conducen sus vidas y en la que quieren reorganizarlas.

Fuente: De la patologización a la politización de las identidades de género diversas. El rol de los profesionales de la salud en los tránsitos de género, realizada por Carolina Herrera y Simón Torres (2018 B).

Frente a esto, me gustaría centrarme en el rol del psicólogo específicamente, como vemos, la patologización conlleva a que el psicólogo sea un fiscal del sufrimiento y un policía del género, lo cual sitúa a los profesionales de la salud en una trampa ética en la que pasan por encima de la autonomía de los consultantes (y de paso la propia) el respeto por la decisión de la identidad y la expresión de género de cada persona, al mismo tiempo, esto configura la relación médico-paciente.

Como veníamos puntualizando Herrera y Torres señalan que nuestra labor no está en verificar si las personas con experiencia de vida trans “en verdad lo son” (ya hemos visto un poco de dónde viene esto con el desarrollo sobre el sexo verdadero) o tratar de conducir toda la intervención a estar “seguros que se sienten en un cuerpo equivocado”.

“Te pregunta ¿está segura de lo que quiere hacer? o ¿ya va de falda? o tipo ¿ya le dicen mujer o ya hace como...? o sea quiere pruebas de vida como para poder aceptar que uno si quiere eso, como que si usted va donde el endocrino quiere ser mujer pero va con ropa de hombre no lo va a aceptar no ha llegado como se dice. (Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales)

Al mismo tiempo en el documento *Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans: Un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans en Colombia* de Min Interior y PAIIS (2018) se señala que la concepción del diagnóstico es binaria, por lo tanto “esto lleva a una evaluación de si la persona se identifica con la mayoría de ideas socialmente “aceptadas” sobre lo que significa ser un hombre o una mujer.” (p.153).

“veo algunas cosas innecesarios, como el psicólogo o el psiquiatra sino uno se siente seguro de lo que va a hacer o lo que piensa hacer, segurísimo y está en un médico que para poder hormonarse, obviamente el psicólogo y la psiquiatra es como para asegurar ese hecho mental que uno quiere, pero obviamente lo quiere hacer y va donde ese psicólogo ese psiquiatra y empiezan a hacer preguntas, uno empieza a dudar, yo no lo hice porque yo estoy clara con lo que yo quiero, yo voy a hacer mujer y me quiero hormonar y me voy a operar y no sé lo que tenga que hacer pero otras personas empiezan a dudar y empiezan a sentir que están en contra de uno como que quieren evitar ese cambio.”(Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales).

De este modo, Herrera y Torres, quienes constituyen el consultorio Liberarte, apuestan por un modelo de consentimiento informado, el cual epistemológicamente entiende al sujeto como ecodependiente, con la capacidad de decisión sobre su cuerpo, con autodeterminación y en la cual subrayan Herrera y Torres citando a Hernández-Córdoba “*cuya autonomía relativa puede verse limitada por dificultades de orden físico, psicológico, social, económico, geopolítico, cultural, histórico, entre otras*” (2018. p.21). En este modelo el rol del psicólogo es acompañar procesos a los que puede acceder la persona de forma voluntaria y no como un requisito para acceder a otros servicios médicos.

En el mismo hilo, la American Psychiatry Association (2022) dice que le profesional de la salud debe incluir una exploración abierta de los sentimientos y experiencia de expresión de género. En ese orden de ideas el rol del psicólogo se configura como:

“Los terapeutas son conductos de posibilidad ya que tenemos una visión de lo que es posible. Trabajamos para aumentar las posibilidades ayudando a las personas a eliminar los obstáculos en sus vidas y permitiéndoles sentirse empoderados. También es terapéutico ayudar a las personas a tolerar la incertidumbre que es inevitable en la vida y en el proceso de desarrollo del género y la transición. Los terapeutas facilitan el cambio positivo, a nivel individual a través de la práctica terapéutica y a nivel macro al involucrarse en la comunidad de psicoterapeutas y en el campo de la salud transgénero.” (Rachil, K. 2022: 99).

Adicionalmente, nuestra labor como psicólogos es elaborar conocimiento para el cierre de brechas de género y aportar a la justicia social que configuran determinantes sociales de la salud⁷⁸, trabajando en conjunto con lxs consultantes para aumentar su autonomía y autodeterminación. Nuestros campos de actuación son múltiples y en todos ellos podemos tomar acción.

En complemento con el modelo de consentimiento informado se encuentra el modelo transformativo que en realidad yo lo denominaría como una práctica, no es en oposición al

⁷⁸ De acuerdo, la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud se definen como: “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana.” (OPS, sf). La lectura de estos determinantes de la salud puede hacerse de forma interseccional, no es lo mismo los determinantes de la salud de una mujer trans perteneciente a un grupo étnico indígena del departamento de Risaralda de 20 años a un hombre trans de la ciudad de Bogotá de 40 años residente de la localidad de Chapinero.

modelo del consentimiento, sino que recoge una serie de prácticas adicionales como: cambiar el nombre, la supresión de la pubertad, la administración de hormonas; denominadas como prácticas afirmativas. Así mismo, puede encontrarse en la investigación el concepto de *gender affirmative lifespan approach* (GALA) en el que se busca que las personas: 1. desarrollen resiliencia 2. exista alfabetización en género 3. vayan más allá del binario 4. promueva una sexualidad positiva 5. facilite conexiones empoderadoras (aumente la autonomía). Quiero resaltar que este modelo es un modelo usado para personas de género trans y persona no binarias porque desde este modelo se concibe el género como fluido o expansivo. A su vez se rige por los siguientes principios: cuidado transafirmativo; interseccionalidad; transparencia; diferencias de desarrollo en la atención y a lo largo de la vida; y un enfoque interdisciplinar. (Rider, et al 2019).

Es así como la Asociación Psicológica Americana reconoce en su guía 11 la importancia del modelo transafirmativo para el fortalecimiento del apoyo social de adolescentes y adultos trans (2015: 26) y su uso por parte de lxs profesionales en psicología es en la realización de intervenciones que disminuyan la violencia y otros malestares como la depresión. La práctica transafirmativa se basa en el cuidado respetuoso, consciente y que apoya las identidades y experiencias de vida de las personas TNCG⁷⁹ (Korell & Lorah, 2007).

Sobre el diagnóstico considero importante, dejar de lado su raíz patologizante para ser la manifestación de la emergente necesidad de acompañar a las personas en su realización personal en medio de una situación altamente exigente como lo es el tránsito de género, en el que se movilizan los sistemas sociales de todas las personas de todas las edades, diversificados en la adultez, en el cual cada momento de la vida tiene retos diferentes.

Es relevante decir que, el espacio psicoterapéutico debe ser un lugar protector (seguridad para ser) y de confianza (legitimidad para ser). Hoy, con el movimiento de despatologización⁸⁰ de las experiencias de vida trans desde el año 2018 en Colombia no es necesario ir con unx psiquiatra o psicólogx para acceder a intervenciones corporales sean procesos de hormonización o cirugías o cualquier procedimiento que esté acorde a la construcción identitaria. Con anterioridad se encontraba la Sentencia T-771 de 2013 en la que se resaltaba

⁷⁹ Significa Trans Non Conforming Gender.

⁸⁰ Para ampliar información sobre esto la despatologización se puede consultar: <https://ilga.org/es/cie-11-despatologiza-identidades-trans-genero-diverso>

que el diagnóstico de disforia de género era necesario para poder acceder a la atención médica con procedimientos relacionados con la reafirmación sexual⁸¹. Por esos años se decía:

“las personas trans en Colombia son sometidas a patologización y psiquiatrización forzadas para poder acceder a ciertos derechos. Para que se les garantice un verdadero y efectivo acceso al sistema de salud, es decir, a tratamientos, a cirugías plásticas y al acompañamiento de un médico durante la transición, en caso de que elijan este camino, las personas trans deben primero cumplir con un tratamiento psiquiátrico que certifique que padecen de un “Trastorno de Identidad de Género” (OutRight, 2016).

Debates contemporáneos sobre el consentimiento de adolescentes en su propio proceso de tránsito de género esto se puso con más fuerza sobre la mesa cuando un adolescente trans y su padre demandaron legalmente a la única clínica de género para jóvenes en Inglaterra llamada The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, debido a que el joven ha decidido destransicionar, apelando que los jóvenes no pueden dar un consentimiento médico para tomar bloqueadores de la pubertad antes de los 18 años. Posteriormente, la decisión del tribunal superior de Londres ha sido que menores de 16 años no pueden acceder a tratamiento médico de afirmación de género a menos que obtenga una orden judicial (Vries et al, 2021) argumentando que *“es muy poco probable que los niños puedan dar su consentimiento para tomar bloqueadores de la pubertad”*

El corazón de este debate es sobre el consentimiento, la libertad y la autonomía de cada persona para construir una forma particular de estar en el mundo, un debate que, de hecho, se ha encontrado en otros escenarios. Quisiera compartir entonces en qué va esta conversación porque puede ser un escenario que podamos vivenciar como país. Debo decir que en las bases de datos encuentro que se han realizado una serie de papers que entre las diferentes posiciones se han contestado, si se quiere seguir un poco la conversación se puede revisar, quiero comentar que esta discusión está tan buena como la tiradera de J Balvin y Residente.

⁸¹La no conformidad, no deviene en cuanto al sexo, porque el sexo biológico en sí mismo no constituye una identidad per-se. La identidad la otorga el género, es por esto que, la incongruencia sigue siendo bajo el género. Se ha demostrado que la genitalidad no constituye en sí misma una identidad. Por eso se encontró que muchos centros de salud o clínicas de género llaman a la intervención quirúrgica de modificación de los genitales afirmación de género.

El rifirrafe:

-Stephen B. Levine, E. Abbruzzese & Julia W. Mason (2022) Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults, Journal of Sex & Marital Therapy, 48:7, 706-727, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2046221

-Annelou LC de Vries (2023) Garantizar la atención de los adolescentes transgénero que la necesitan: respuesta a 'Reconsideración del consentimiento informado para niños, adolescentes y adultos jóvenes identificados como trans', Journal of Sex & Marital Therapy, 49:1, 108-114, DOI : 10.1080/0092623X.2022.2084479

-Stephen B. Levine, E. Abbruzzese y Julia W. Mason (2023) ¿Qué les estamos haciendo a estos niños? Respuesta a los comentarios de Drescher, Clayton y Balon sobre Levine et al., 2022, Journal of Sex & Marital Therapy, 49:1, 115-125, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2136117

-Jack Drescher (2023) Informed Consent or Scare Tactics? A Response to Levine et al.'s "Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults", Journal of Sex & Marital Therapy, 49:1, 99-107, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2080780

Puntos de conversación entre lxs científicxs:

Retomando el artículo de Cox Carrasco (2020) en el que señala que no hay dentro de lxs profesionales de la psicología un consenso sobre los siguientes asuntos y que hoy se discuten:

*¿La no conformidad con el género configura un malestar, es decir, produce disforia?

*¿Cómo se forma la identidad de género?

*¿Las personas menores de edad pueden brindar su consentimiento para acceder a tratamientos de afirmación de género?

*¿Qué sucede con las personas que han alcanzado la mayoría de edad pero que no cuentan con los recursos para brindar su consentimiento?

Puntos de convergencia entre lxs científicxs:

No hay suficiente información y estudios de carácter longitudinal sobre los efectos de la supresión de la pubertad, por muchas cuestiones, entre ellas, la financiación de estos. Al mismo

tiempo, se admite que existen estudios que han evaluado luego de 1 año y medio cómo la supresión ha ayudado a la mejoría de la calidad de vida (Achille et al.,2020; Kuper et al.,2020). También ambas posturas señalan que deben realizarse las evaluaciones pertinentes para evaluar la capacidad de la persona al brindar su consentimiento.

Puntos de divergencia entre lxs científicxs:

El desencuentro se vincula principalmente porque unxs autorxs piensan que los estudios actuales tienen un sesgo social y que no se han realizado desde el rigor médico-científico y existen otrxs que dicen que esto ha tenido rigor y sobre todo es el trabajo de muchas personas por más de dos décadas.

Reflexiones propias:

Es hora de estudiar con rigor y seriedad el binarismo de género y construir nuevas categorías con las que podamos conversar y poner en el orden del lenguaje lo que sucede. Siento abrumadora toda esta expansión identitaria tanto como la cantidad de personas que habitamos este mundo ¿será el momento de refocalizar la discusión? Para mí el problema subyace desde el binarismo de género como pauta del desarrollo normal del lxs sujetxs y en ese sentido la disforia de género que sigue siendo una condición de la sexualidad humana, para mí, en ese orden de ideas, caduca.

De acuerdo con la entrada ¿Qué es la disforia de género? de la American Psychiatric Association en el que se define la disforia de género como *“trastornos del desarrollo sexual denotan desviaciones somáticas de la normalidad innatas al aparato reproductor y/o discrepancias entre los indicadores de varón y mujer”*⁸², con este horizonte a continuación se retoman los criterios del DSM-5 con los cuales se diagnostica:

- “Una marcada incongruencia entre el género experimentado/expresado y las características sexuales primarias y/o secundarias (o en adolescentes jóvenes, las características sexuales secundarias anticipadas).

⁸² Me conflictúa, en realidad, ¿Necesitamos una historia de origen de la infancia o la adolescencia para certificarnos trans? o ¿Una historia marcada por la represión de sí mismx para ser trans? u ¿Odiar nuestro cuerpo?

- Un fuerte deseo de deshacerse de las características sexuales primarias y/o secundarias debido a una marcada incongruencia con el género experimentado/expresado (o en adolescentes jóvenes, un deseo de prevenir el desarrollo de las características sexuales secundarias anticipadas).
- Un fuerte deseo por las características sexuales primarias y/o secundarias del otro género.
- Un fuerte deseo de ser del otro género (o algún género alternativo diferente al género asignado).
- Un fuerte deseo de ser tratado como el otro género (o algún género alternativo diferente al género asignado).
- Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro género (o algún género alternativo diferente al género asignado).” (DSM-5, 2022).

Me pregunto entonces ¿Cuál es esa función deseante de las personas que son diagnosticadas como disforia? y ¿qué se refiere específicamente? Siento que aquí se está pensando en los tránsitos de género binarios ¿qué sucede entonces con los tránsitos de género no binarios? ¿cómo el tribunal se posiciona frente a los mismos?

También se señala que el malestar puede acompañar la congruencia entre el género expresado y su género asignado y que no todos los sujetos lo experimentan, de hecho, este malestar puede emerger si no se acceden a intervenciones físicas deseadas.

Al respecto varios puntos:

1. ¿Cuáles son los efectos de los bloqueadores de la pubertad?
2. ¿El debate sobre el consentimiento en menores en qué otros contextos se encuentran?

1.¿Cuáles son los efectos de los bloqueadores de la pubertad?

Las intervenciones en adolescentes tienen otro proceso que se relaciona con la administración de bloqueadores de pubertad, al respecto el estudio de Lieke JJJ Vrouwenraets, Martine C. de Vries, Irma M. Hein, Marijn Arnoldussen, Sabine E. Hannema & Annelou LC de Vries (2021) afirman que este proceso se desarrolló como un mecanismo para “*brindar tiempo para la exploración antes de buscar un tratamiento médico de afirmación de género (GAMT) con efectos irreversibles.*” un tiempo tanto para los adolescentes, como para los cuidadores (para

el acoplamiento al nuevo rol de género asumido por su hijx) y lxs médicos (para la realización de un diagnóstico mejor desarrollado).

Es importante decir que la supresión de la pubertad en sí misma no va a acabar el molestar porque como hemos visto la transición de género es un proceso biopsicoetoeológico, si se suprime y no hay apoyo en la familia o en círculos de apoyo cercano, va a continuar el malestar. La supresión de la pubertad se vincula con la autoimagen, con la decisión de verse como se ha decidido, bajo los propios ojos.

Ahora bien, Vries et al (2021) han señalado que la decisión de lxs adolescentes frente a la supresión de la pubertad no significa tomar una decisión frente al tratamiento de hormonización que tiene efectos irreversibles, esta decisión será tomada en la adultez, incluso será una decisión con más información disponible al respecto. Además, recomendaciones de Min Interior dicen que las dificultades psicológicas, sociales o familiares que pudieran interferir con el tratamiento tiene que haber sido manejadas de forma satisfactoria y el/la adolescente es consciente de su decisión respecto al tratamiento (Min Interior y PAIIS, 2018. P. 49).

Es importante reconocer que los bloqueadores de pubertad son una intervención reversible y su intención es prevenir el sufrimiento psicológico por producir cambios físicos no deseados. Recuerdo que Anastacia, una de las chicas con las que conversé, experimentaba en ese momento de angustia por los cambios físicos propios de la adolescencia:

“He escuchado pues los cambios que puedan llegar así, y que pienso de ellas y a veces pienso que el endocrino debería acelerar más el proceso porque desde una forma está obstaculizando o obstruyendo la felicidad de uno porque uno siempre quiere empezar lo antes posible y como dijo Mara en una entrevista dijo que mi cuerpo cada día más está produciendo más una gota de testosterona y uno quiere como que contrarrestar esto y he tenido que esperar tanto exámenes la receten o algo así y como que cada día más uno se va sintiendo como más hombre como que se está desarrollando de una forma que no quiere y yo quiero contrarrestar eso porque obviamente uno quiere como verse más femenina como que el cuerpo se le empiece en la pubertad a desarrollar más femenino, no sé y saber que uno está empezando como rápido esa hormonización y saber que cada día unx más tiene testosterona en el cuerpo o que cada día más algo en el cuerpo está cambiando a un masculino y no femenino eso es algo que mentalmente uno como se destruye y es un sentimiento que es muy difícil porque de alguna forma y

uno cada día más y no ha empezado las hormonas se va volviendo cada día más hombre y no es lo que uno quiere y unx no quiere esperar los 18 que ya como que ha acabado el desarrollo para empezar unas hormonas que se supone que es para tener un cuerpo más femenino o la piel más lisa o los gestos de la cara, o el cabello crezca más y evitar la calvicie todas esas cosas y es algo como que uno se siente como no sé obstruido, uno se mata así, porque es como se acaba el desarrollo masculino y empezar un desarrollo femenino como que se junta hace como una cosa rara, no sé es lo que pienso.”
(Conversación con Anastacia, 16 años, Manizales).

Otros aspectos para tener en cuenta es que los procesos no son lineales, en el estudio de Lealah Pollock y Esteban Eyre (2011) realizan un ejercicio por describir el desarrollo de la identidad de jóvenes transgénero, en mi interpretación, estas etapas no se ven como un proceso escalonado sino como parte del curso del proceso de tránsito, entre ellas se encuentran:

- *creciente sentido del género (recuerdos y discordancias con los roles de género).
- *reconocimiento de la identidad transgénero (a mi modo de ver se vincula con explorar quién es cada unx y con los sentimientos de valía sobre sí mismo).
- *ajuste social (cómo participan los sistemas sociales y las redes de apoyo de las personas trans en su proceso)
- * integración (cómo yo puedo seguir tomando decisiones para el futuro).

Existen otros modelos como el propuesto por Marty A. Cooper, Seojung Jung & Jamie L. Gordon (2022) en el que se destaca tres procesos: asimilación, acomodación y equilibrio, los cuales pueden variar de acuerdo a las situaciones que enfrenta cada persona, es de señalar que este modelo no tiene comprobación empírica, es un modelo teórico.

Adicionalmente, los criterios sugeridos de la WPATH⁸³ para los tratamientos hormonales para adultos y adolescentes trans son:

⁸³ E. Coleman, AE Radix, WP Bouman, GR Brown, ALC de Vries, MB Deutsch, R. Ettner, L. Fraser, M. Goodman, J. Green, AB Hancock, TW Johnson, DH Karasic, GA Knudson, SF Leibowitz, HFL Meyer-Bahlburg, SJ Monstrey, J. Motmans, L. Nahata, TO Nieder, SL Reisner, C. Richards, LS Schechter, V. Tangpricha, A. C. Tishelman, MAA Van Trotsenburg, S. Winter, K. Ducheny, NJ Adams, T. M. Adrián, LR Allen, D. Azul, H. Bagga, K. Başar, DS Bathory, JJ Belinky, D. R. Berg, JU Berli, RO Bluebond-Langner, M.-B. Bouman, ML Bowers, PJ Brassard, J. Byrne, L. Capitán, CJ Cargill, JM Carswell, SC Chang, G. Chelvakumar, T. Corneil, KB Dalke, G. De Cuypere, E. de Vries, M. Den Heijer, AH Devor, C. Dhejne, A. D'Marco, EK Edmiston, L. Edwards-Leeper, R. Ehrbar, D. Ehrensaft, J. Eisfeld, (2022) Estándares de atención para la salud de personas transgénero y de género diverso, versión 8, International Journal of Transgender Health, 23:sup1, S1-S259, DOI: [10.1080/26895269.2022.2100644](https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644)

Recomendaciones para la hormonización	Adolescentes	Adultos
La incongruencia de género es marcada y sostenida.	X	X
Cumple con los criterios de diagnóstico de incongruencia de género antes del tratamiento hormonal de afirmación de género en regiones donde es necesario un diagnóstico para acceder al cuidado de la salud.	X	X
Demuestra capacidad para dar su consentimiento para los fines específicos del tratamiento hormonal de afirmación de género.		X
Demuestra maduración emocional y cognitiva obligada para dar el consentimiento informado para el tratamiento.	X	
Otras posibles causas de aparente inconformidad de incongruencia de género han sido identificadas y excluidas.		X
Problemas de salud mental (si los hay) que pueden interferir con claridad diagnóstica, capacidad de consentir y tratamientos médicos de afirmación de género que han sido ordenados, para que se pueda proveer el tratamiento médico de reafirmación de género.	X	
Ha sido informado de los efectos en la reproducción, incluyendo la pérdida de la fertilidad y las opciones para preservarla.	X	
Ha alcanzado la etapa 2 de Tanner	X	
Han sido evaluados y discutidos los riesgos y		X

beneficios del tratamiento desde la salud mental y las condiciones físicas.		
Entiende el efecto de la afirmación de género del tratamiento hormonal en la reproducción y tiene la posibilidad de explorar opciones reproductivas.		X

Los criterios sugeridos de la WPATH para los tratamientos de cirugías para adultos y adolescentes trans son:

Recomendaciones para la intervención quirúrgica	Adolescentes	Adultos
La incongruencia de género es marcada y sostenida.	X	X
Cumple con los criterios de diagnóstico de incongruencia de género antes del tratamiento las cirugías de afirmación en regiones donde es necesario un diagnóstico para acceder al cuidado de la salud.	X	X
Demuestra capacidad para dar su consentimiento para los fines específicos de la cirugía de afirmación de género.		X
Demuestra maduración emocional y cognitiva obligada para dar el consentimiento informado para el tratamiento.	X	
Otras posibles causas de aparente inconformidad de incongruencia de género han sido identificadas y excluidas.		X
Problemas de salud mental (si los hay) que pueden interferir con claridad diagnóstica, capacidad de consentir y tratamientos médicos de afirmación de	X	

género que han sido ordenados, para que se pueda proveer el tratamiento médico de reafirmación de género.		
Ha sido informado de los efectos en la reproducción, incluyendo la pérdida de la fertilidad y las opciones para preservarla.	X	
Han sido evaluados y discutidos los riesgos y beneficios del tratamiento desde la salud mental y las condiciones físicas.		X
Entiende el efecto de la afirmación de género de la cirugía de afirmación de género en la reproducción y tiene la posibilidad de explorar opciones reproductivas.		X
Estabilidad en el tratamiento hormonal de afirmación de género (que puede incluir al menos 6 meses o un periodo más largo de tratamiento hormonal necesarios para lograr el resultado quirúrgico deseado, a menos que no se desee la terapia hormonal ⁸⁴ o esté médicamente contraindicado).		X
Al menos 12 meses de terapia hormonal de afirmación de género necesarios para lograr el resultado quirúrgico deseado incluyendo aumento de senos, orquiectomía, faloplastia, metoidioplastia y cirugía facial como parte del tratamiento de afirmación de género, a menos que no se desee la terapia hormonal o esté médicamente	X	

⁸⁴ Se denota que no todos los protocolos médicos tienen en cuenta que las personas se estén hormonando para realizar las cirugías de afirmación de género. Se recomienda ver el live realizado por la Liga de Salud Trans al doctor Álvaro Rodríguez. Disponible en el siguiente link: <https://ne-np.facebook.com/ligasaludtrans/videos/liga-de-salud-trans-en-vivo-con-el-dr-alvaro-rodriguez-cirujano-pl%C3%A1stico/681711322677611/>

contraindicado).		
------------------	--	--

Tabla de Elaboración propia

Por lo tanto, creo fundamental investigar en Colombia bajo nuestros contextos cómo pensar sobre las intervenciones psicológicas de tránsito de género con menores, al mismo tiempo, de encontrar cómo se experimenta la fluidez de género en toda la población.

2. ¿El debate sobre el consentimiento en menores en qué otros campos se encuentra?

Las limitaciones a la capacidad de otorgar el consentimiento informado para menores de edad, constituyen por regla general, medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, la jurisprudencia constitucional en diversos ámbitos, especialmente en los asuntos de alto impacto en la autonomía y el proyecto de vida , tales como: la reasignación de sexo, la eutanasia, la interrupción voluntaria del embarazo, las cirugías estéticas, la modificación de los componentes del estado civil para que se ajusten a la identidad de género, ha resaltado la necesidad de asegurar la autonomía de los menores de edad y ha precisado que, si bien la edad es un referente sobre la capacidad evolutiva, no permite establecer, de forma objetiva y exclusiva, la posibilidad de emitir el consentimiento.

Esto es importante porque en las prácticas compartidas socialmente que un menor de edad materne o paterne no entra en un debate exhaustivo, de hecho, en el año 2022 en Colombia, hubo 77.634 nacimientos de madres entre los 15 y los 19 años, un asunto de salud pública vigente y bajo el cual debemos seguir trabajando. En paralelo, no pongo este ejemplo para equiparar los resultados del abordaje que ha tenido el fenómeno del embarazo adolescente sino para poner bajo la lupa, una discusión dilatada sobre la capacidad de decisión de los adolescentes sobre la gestión de su vida y los marcos legales que la protegen.

En Colombia de acuerdo con la Sentencia 218 de 2022, para los menores de edad el consentimiento informado para los tránsitos de género opera de la siguiente manera: (i) la concurrencia de la voluntad de los padres y el hijo; (ii) el concepto de los médicos que demuestre que la transición de género ha sido medicamente implementada; (iii) la cercanía a la mayoría de edad; (iv) la trascendencia de la decisión, sus efectos secundarios y las posibilidades de revertirla; y (v) la decisión libre, informada y cualificada del menor de edad.

Los miedos

La irreversibilidad del cambio, éste es un miedo que puede ser común para lxs profesionales de la salud al momento de brindar atención a personas trans y no binarias, de este modo, es importante saber que si bien las destransiciones⁸⁵ como se han llamado no son muy frecuentes, si es un hecho que pueden ocurrir y que existirán elementos corporales de los que no habrá vuelta atrás. Es una preocupación que puedo compartir en su sentir, no por el género, sino cuando pienso en la irreversibilidad del cambio por el modelo de producción en el que nos encontramos, por ejemplo, lo irreversible que es la extinción de especies, la erosión del suelo, la escasez del agua. En ese sentido, he leído que es importante tener protocolos para la destransición si ésta se llegase a presentar y yo sumaría una ruta de atención y acompañamiento para las personas que destransicionen.

Uno de los mayores temores que encuentro es a diagnosticar de manera errada, por ejemplo leí en un concepto de disforia de género *“el paciente sexo anatómico masculino e identidad de género femenino, ha sido sujeto de evaluación y análisis por medio de entrevista psicológica, contexto en el cual manifiesta claridad y juicio coherente en relación a su construcción y vinculación con las asignaciones sociales y psicológicas asociadas a dicho género. A raíz de esto se descarta diagnóstico de psicosis y rasgos de una organización límite de su personalidad”*. Recordemos que para transicionar actualmente no se necesita de diagnóstico y de la aparición de malestar, basta con desearlo, ya que, se reconoce como una condición de la sexualidad del ser humano.

Para concluir considero importante tener en el horizonte que la transformación y la incertidumbre son parte del ser humano y si no se tiene suficiente información, se puede ampliarla acudiendo a grupos científicos como lxs miembros de la WPATH en Colombia o en otros países⁸⁶, profesionales que hacen parte de la división 44 de la APA en Colombia, leer los lineamientos y normas que tiene Colombia para la atención y acompañamiento de personas trans en diferentes contextos, entre otros recursos.

⁸⁵ Hace referencia a un proceso de retransición orientado al cumplimiento estereotipado del género en alineación con el sexo asignado al nacer. Importante poder acuñar otros términos destransición suena a quitar de lado el proceso vivido y arrepentirse de éste, cuestión que a mi modo de ver, aumentaría el malestar.

⁸⁶ Puedes encontrar el listado de miembros de la WPATH en el siguiente enlace: <https://www.wpath.org/member/search>

Nuestro encuentro se iba a dar a las 10 am en el Hospital San Juan de Dios de Manizales era el día en el que Thalia saldría de la clínica de su más reciente hospitalización, no era la primera vez que estaba internada, en situaciones anteriores fue llevada por urgencias por su familia y en otras situaciones ella misma había decidido internarse. En realidad, supuse que el hospital era un punto de referencia para ir a otro lugar a conversar, más no el lugar de encuentro en sí mismo. Así, decido que será un encuentro informal, y pensé como propósito conocer a Thalia y a su mamá que eran participantes de la organización con la que pude hacer una alianza. Esperamos unos minutos en una sala pequeña, esperando el llamado del médico psiquiatra para que le ordenara la salida a Thalia, hicieron el llamado por el nombre que ella escogió y entramos, allí estamos las tres y el médico le pregunta sobre cómo se ha sentido, Thalia responde que se siente mucho mejor. Él sigue haciendo preguntas esta vez relacionadas con las citas que ha tenido con psicología, Thalia dice que no le gusta ir a psicología porque siente que está perdiendo el tiempo, frente a lo cual su madre se queja de ella con el psiquiatra expresando que ha sido difícil tratar este asunto con Thalia diciendo que ella es grosera. De este modo, el psiquiatra realiza preguntas a Thalia, al mismo tiempo, espera que la madre apruebe o ratifique la información que proporciona Thalia. Posteriormente, siguen recetando litio para su tratamiento sin una explicación clara del procedimiento de medicación.

Salimos del hospital y tenemos una conversación informal, allí me entero de que Thalia va al psicólogo desde temprana edad y para ese momento estaba diagnosticada con disforia de género y trastorno bipolar desde hace muchos años. Posteriormente, Thalia me comparte que a ella no le gustan los encuentros que tiene con la psicóloga porque ésta en varias oportunidades se ha enojado con ella porque no logra entablar una conversación y una relación de confianza con Thalia, utilizando la manipulación y la amenaza de que, si no responde sus preguntas de alguna manera, ella como profesional podría obstruir su proceso de tránsito.

Esta situación configura varias barreras al acceso a la salud por dos aspectos: 1. No hay una relación de horizontalidad entre el médico-paciente, por lo que, no se tiene en cuenta la participación de Thalia en su propio proceso de construcción de identidad. 2. Negarle a una persona trans algún procedimiento que es necesario para la construcción de su identidad es un incumplimiento a la ética y una mala práctica médica que tiene consecuencias jurídicas

importantes.⁸⁷ Un año después en el marco de esta investigación, conversamos con Thalia sobre el sistema médico, al respecto ella comenta:

Entrevistada: Por ejemplo, Sebastián y Mariana y Diana han sido los tres sexólogos que me han visto siempre y me siento muy apoyada con ellos porque siempre me ayudan a resolver conflictos personales con mis dudas y siempre están ahí para mí; de segundo pondría algunas especialidades dentro del tránsito por ejemplo, endocrinología, y pues porque me han ayudado a hormonizarme y todo este tema y de tercera, creo que pondría psicología, siempre me ha ido muy mal con la psicología y la ayuda que me han dado no es la mejor entonces por eso la pondría de tercera.

Entrevistadora: ¿Qué crees que podría mejorar la psicología ahí?

Entrevistada: ¿Qué podría mejorar? No, no soy una persona muy abierta, entonces como abrir mis problemas a alguien más no me gustaría entonces por eso no me gusta la psicología y no entraría a una sesión de estas. Actualmente, estoy entrando a psicoterapias mandadas por el psiquiatra, sino tampoco estaría.

En el artículo *Missteps in psychotherapy with transgender clients: Promoting gender sensitivity in counseling and psychological practice*. Se resalta que las experiencias psicoterapéuticas que parten desde la patologización pueden agravar el malestar y disminuir la posibilidad de búsqueda ayuda por parte del consultante, algunos temas que pueden incluir estas prácticas desfavorables son: la subestimación de la capacidad de autonomía, la estigmatización de las experiencias, no brindar la información necesaria, actualizada y suficiente a lxs consultantes sobre su proceso de tránsito. (Mizock & Lundquist, 2016). Unido a esto en la investigación *Implicaciones psicosociales de la despatologización de la disforia de género en Colombia* se resalta la patologización como: “la principal barrera para el desarrollo personal, la cual ha prohibido tener tratamientos adecuados en las transformaciones de sus cuerpos; la manera por la cual se les vulnera sus derechos, principalmente el derecho a la salud; y la causante y reforzante de algunos imaginarios negativos, la cual surge como una estrategia indigna que invisibiliza sus sentires.” (Verástegui, 2013:155).

⁸⁷ La sentencia T-918 de 2012 se dice que “de ninguna manera la Corte considera que el transgenerismo constituye una enfermedad o una categoría psiquiátrica, o que se requiera el diagnóstico de disforia de género para acceder a los servicios de salud relacionados con su identidad”

En 2013, Lasso documentó que los obstáculos en el sistema de salud llevan a las personas trans a autointervenirse corporalmente y describió que esto era consecuencia de la lógica patologizante y binaria que impera en las intervenciones a personas trans. En 2021, el informe *Sin curas ni remedios* de Temblores ONG mostró que las personas LGBT “*no acceden al sistema de salud porque las violencias se replican en estos espacios o sufren revictimizaciones de manera continua*”. Asimismo, la discriminación en el sistema de salud también se manifiesta en negación de la identidad, violencia sexual, juicios de valor y negligencia médica.

Por otro lado, el GAAT refirió lo manifestado por madres y padres de niñas, niños y adolescentes con experiencias de vida trans acerca de que en el sistema de salud “*no todas las personas profesionales en salud tienen conocimiento del tema, las EPS remiten a NNA a IPS que no cuentan con la posibilidad de brindar un servicio integral (Comité interdisciplinario) en el que algunas veces incluso se les pregunta si quieren ‘regresar’*”. Igualmente, no existen rutas especializadas para atención de personas con experiencias de vida trans en etapa de infancia. Incluso en los casos que existen protocolos, se presentan problemas como las barreras en la oportunidad de atención de los médicos especialistas. Denuncian que muchos profesionales “*no reconocen la voluntad o la capacidad de las/os NNA que asisten a obtener servicios relacionados con procesos de reafirmación de género*”.

Es importante reconocer que cuando se habla del acceso a la salud para personas trans no se habla solamente de procedimientos o intervenciones relacionadas exclusivamente con su tránsito de género. La adecuada formación del personal médico tiene que estar capacitado para atender otro tipo de coyunturas alrededor de la salud con un enfoque de género (T-234 de 2007). Por ejemplo, personas trans pueden tener afectaciones a la salud relacionadas con el cáncer de próstata o con cualquier dificultad en salud que emerja para cualquier persona.

Es así como me gustaría señalar otras prácticas que encontré que no aportan al bienestar de las personas por parte de psicólogos.

Prácticas psicológicas favorables para el acompañamiento de jóvenes trans

Los tránsitos de género cuentan con la atención de un equipo médico transdisciplinar, sin embargo, es posible que no operen desde la interdisciplinariedad. Esto implicaría que exista

una estrategia para cada persona en conjunto y colaborativa. Hoy por hoy, el sistema de salud colombiano está en crisis, así lo afirma la Ministra de Salud y Protección social, Carolina Corcho en una entrevista que le hace la revista CAMBIO (2023), diciendo que los profesionales de la salud no son los suficientes para la cantidad de personas que se precisan, sus sueldos son precarios, y están concentrados en los cascos urbanos con especificidad en las grandes ciudades, señalando que éste es un punto crucial para la actual Reforma a la Salud.

Lo anterior se señala porque debe existir un cambio estructural que permita que el personal médico pueda operar de manera conjunta para pensar en estrategias sincronizadas y orientadas a los problemas de cada persona. Al mismo tiempo, de forma protocolar esto podría darse en las Juntas médicas de los hospitales cuando se revisan casos, idear una forma de intervención en la que más que un ejercicio individual de actualización sobre los lineamientos en salud se busca que el sistema de salud sea como sostiene Miguel Rueda de la organización Pink Consultores una red de apoyo para las personas trans.

Para ampliar más información sobre los lineamientos, protocolos y recomendaciones en salud para la atención y acompañamiento de personas trans, se encuentran los siguientes documentos:

- Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia de Min Justicia (2019).
- Atención integral en salud para personas trans y no binarias de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2022).
- Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans: Un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans en Colombia de Min Interior y PAIIS (2018).
- La octava edición de los Estándares de Atención de la WPATH y las Guías de Práctica Clínica de la Endocrine Society.

En estos documentos se destaca que desde la psicología se comienza por: preguntar sobre el motivo de consulta, revisar la historia clínica con toda la valoración integral en salud, abordar los temas que son una necesidad para el consultante, hacer uso de herramientas como los genogramas y mapa de redes para identificar los sistemas vinculantes de las personas: su sistema familiar, escolar/trabajo, comunitario/organizacional, salud y las redes de apoyo y los recursos con los que cuenta cada persona. Una vez se realiza el encuadre en conjunto del

problema se exploran soluciones en conjunto y estrategias para acompañar a las personas en la transformación de sus sistemas vinculares y el aumento de su autonomía.

Hasta el momento todo lo dicho debe realizarse por lxs profesionales a cargo. Desde le profesional de la psicología es importante tener en cuenta el momento de la vida en la que se encuentra la persona, de acuerdo con la teoría del ciclo vital es importante considerar que más allá de la Infancia, la adolescencia o la adultez, existen momentos que suponen ser valorados con atención, tal como: ingreso al colegio, mudanza, conformación de la pareja, nacimiento de lxs hijxs. Es por esto que de acuerdo a su correspondencia etarea con la infancia, la adolescencia o la adultez, se pueda develar alguna situación por la que esté pasando la persona sumada a su experiencia de tránsito de género.

A continuación, me gustaría resaltar buenas prácticas que realizaron psicólogos que atendieron a los jóvenes con lxs que conversé:

Relato Emilia (23 años, Manizales):

“Y ella me iba a echar y una de las condiciones para que no me echara fue que me llevaran a un psicólogo porque yo tenía problemas, entonces el psicólogo, era un doctor de psicología de la Universidad de Manizales, y le dije que no (...) él informa, que yo estaba bien, que era normal (...) Entonces mi mamá decía que esa gente estaba loca, entonces me enviaron donde un psiquiatra y el psiquiatra le dijo lo mismo, que no me iba a volver a recibir porque yo no tenía problemas, que la del problema era ella, por no aceptarme, que a ella si la recibía que veía que tenía muchos problema de esos, y ella armó un escándalo en esa jurídica y así, hasta que luego dijo: hágame el favor vamos a un psicólogo, pero un psicólogo cristiano.”

Relato Antonio (22 años, Bogotá):

“Algo así como bienestar. "Unión" se llamaba no me acuerdo las siglas que decía, pero ella siempre estuvo como muy pendiente de mí, de mi tránsito como a las exposiciones, lo de salud emocional, lo de las hormonas, todo eso y pues yo siempre que me sentía que necesitaba a hablar con alguien, iba a hablar con ella sobre mi vida.”

Relato Sam (26 años, Manizales):

“Yo voy feliz a mis citas de soxología, psiquiatría y psicología y con la doctora L que es una psicóloga muy jóven bueno el doctor B me ayuda más al proceso físico a afrontar los cambios a derivarme con los especialistas y la doctora L son temas de mi personalidad lo que te decía ahora , de toda esa psicoterapia a no promediar los momentos sino que fluyan a romper como dice ella escenarios negativos, cómo es, no me acuerdo como dice ella, a romper esa serie de escenarios negativos, como yo te comentaba ahora yo hablo libremente, al principio, me daba terror, pánico y con ella aprendí, de Sam no vas a conspirar contra la humanidad, y yo sí doctora, y si vas a un almacén a comprar ropa no vas a hacerte amiga de las demás compradoras ni las vendedoras y vendedores, vas a comprar ropa y eso es lo que les interesa a las empresas: vender, la utilidad y punto; y es cierto, entonces es como romper, ella lo llama mucho de mi personalidad como afrontar esos cambios emocionales y demás y soy feliz cuando voy.”

Relato Lito (17 años, Arauca, Caldas):

Entrevistado: Me toca psicología en estos días, pero la pedí más que todo porque hay algunos temas de mi mamá que piensa que no.

Entrevistadora: ¿Qué no?

Entrevistado: Que no, que me voy a estancar ahí. No, ma vamos a hablar con el psicólogo para que le explique bien como son las cosas, para que usted no se estanque ahí.

En todas estas situaciones lxs psicólogos emergen como un apoyo importante en varios sentidos: para dialogar con los otros sistemas vinculares como la familia, para identificar las herramientas de afrontamiento con la que cuentan y fortalecerlas, para brindar apoyo organizando la experiencia. Éstas buenas prácticas están enmarcadas en la no patologización y aportan al bienestar de lxs consultantes y la justicia al acceso a la salud.

Una práctica que me gustaría traer es la del proyecto Fenway Health (Reisner, Bradford & Hopwood, 2015) en la que existe una alineación tecnológica con los casos y para un mismo caso hay un historial clínico en el que se exponen las necesidades del paciente, así como, la

junta médica hacen uso de sus dispositivos electrónicos para monitorear el seguimiento de las intervenciones realizadas por diferentes profesionales, tales como: exámenes de próstata o mamografías o exámenes de rutina de control de hormonas, entre otros; y se programan recordatorios para su monitoreo.

Otra práctica que podemos encontrar es la realizada por Liberarte, que es un consultorio psicológico clínico de Carolina Herrera y Simón Torres que es inspirador para mí, en una entrevista que encontré en el repositorio de la Universidad Javeriana, ellxs cuentan cuáles fueron los orígenes de Liberarte, y en esto Carolina comenta que cuando ellxs se preguntaron sobre las necesidades de la población LGBTI en atención clínica lxs profesorxs siempre decían que se usaban las mismas herramientas que con personas cisgénero-heterosexuales “que eso era lo mismo”, al respecto, Simón dice que encontraron en sus prácticas que los consultantes tardaban varias sesiones en comunicarle a su terapeuta que eran personas sexo-género diversas y/o con orientaciones sexuales diversas⁸⁸. Es por esto que nace Liberarte como un espacio psicoterapéutico en donde desde un inicio se declare una apertura de conocimiento frente a la diversidad sexual humana.

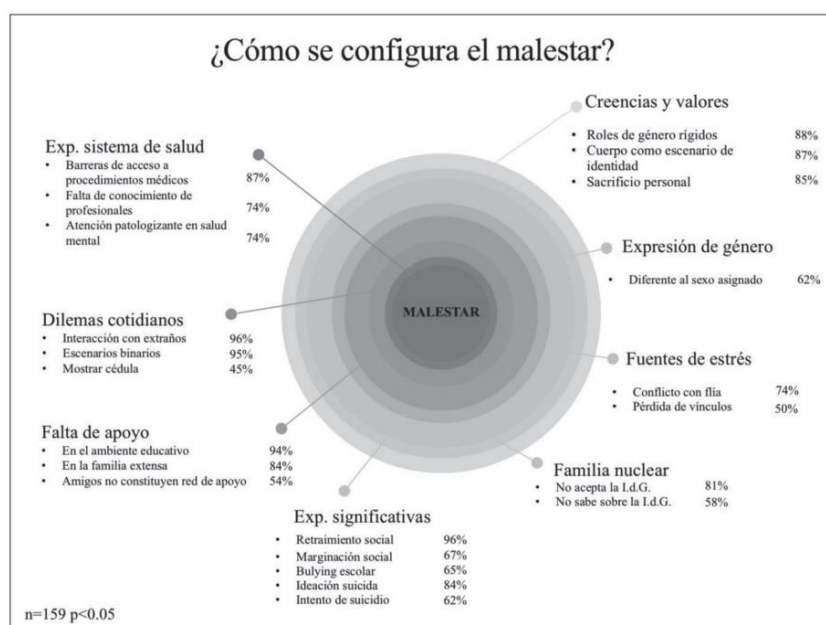
En un live realizado por Colpsic⁸⁹ sobre el rol del psicólogo en el acompañamiento a personas sexo-género diversas, Torres explica el modelo del consentimiento informado llevado por Liberarte, en este se concibe que:

- Lxs profesionales de la salud somos parte del sistema de apoyo, pero no son quienes autorizan el comienzo del proceso de tránsito.
- No hay meta para llegar a ser, sino que emergen situaciones en la vida de las personas trans que merecen tomar decisiones, es así como le psicólogo le acompaña a navegar y explorar las soluciones que cada persona diseña para sí.
- Los procesos de tránsito de género están sujetos a las necesidades y deseos de cada persona.
- No se necesita del malestar para hacer un cambio, es suficiente con desearlo, me encanta el ejemplo que pone Simón porque dice que lo mismo sucede con una mujer cis que quiere quedar

⁸⁸ Resalto aquí la palabra diversas de manera que sea un lenguaje común para el lector. Al mismo tiempo, quiero puntualizar que de manera personal no encuentro que la diversidad esté encasillada, por el contrario, considero que una de las características fundamentales de la sexualidad humana ES la diversidad, tanto como personas existan en el mundo.

⁸⁹ Lives que encontré de COLPSIC en las regiones. Live El rol del Psicólogo en el acompañamiento a los tránsitos de género. ColPsic Eje Cafetero: <https://www.facebook.com/colpsicejecafetero/videos/el-rol-del-psic%C3%B3logo-en-el-acompa%C3%B1amiento-a-los-tr%C3%A1nsitos-de-g%C3%A9nero/314796343626869/>

en embarazo, no necesariamente debe tener un malestar profundo para que su decisión movilice sus sistemas vinculares.



Fuente: Modelo realizado por Carolina Herrera y Simón Torres (2018B) en el artículo “¿Cómo se configura el malestar de género en personas trans? Sistematización de las comprensiones de LIBERARTE”

-Le psicólogx acompaña a las personas a dialogar con lo que denominan universo circundante.

-La configuración del malestar de género no tiene una raíz en el cuerpo, sino que se configura a partir de los entramados sociales. La imagen que se encuentra a la izquierda es realizada por Liberarte en su artículo ¿Cómo se configura el malestar de género en personas trans?

Sistematización de las

comprensiones de LIBERARTE (2018 B) basadas en el análisis de correlaciones en 159 personas.

Con base en esta representación de la configuración del malestar emergen los recursos que se potencian de acuerdo a las situaciones particulares de cada persona. Cuando existe pérdida de los vínculos familiares y sociales, se crean otros; por consiguiente, el siguiente apartado tiene la intención de mostrar cuáles son los recursos emergentes y nuevos vínculos para cursar el tránsito de género.

Cuiranderismo⁹⁰

Entré al Teatro Queer, yo que para ese entonces era la oveja negra en mi familia, me identificaba cien por cien allí, con ese apellido que me daba curiosidad y fuerza, yo alucinaba. Moon me acompañó a la audición y por cosas de la vida de una manera no planeada audicionó también, en un acto de improvisación honró la memoria de su primo, Sebastián, la casa en Teusaquillo que lleva tu nombre es un espacio de cuidado y protección para todas las personas que se reconocen sexo-género diversas. ¡Yo me fuí por una escena de cabaret mixeado con danza contemporánea y un texto, y chas! estábamos las dos dentro. ¡Ayyyyy qué emoción! tantas personas maravillosas, me enseñaron a hacer la show y a soltar mireya como gabete.



Esta experiencia me permitió ampliar mi marco de experimentación y politizar mi lucha por la justicia social de género, así que en el teatro tuve un nombre y una voz: Coral, un ser de mar. Su historia se repite 4.190⁹¹ veces, es el patrón de la discriminación vivenciado por miles de personas LGBTI en el país de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV). Coral es una ficción colectiva que nos recuerda el dolor que ha supuesto la pretensión por el poder y el control por la existencia del otro.

Esos años fueron la experiencia encarnada de lo potente que son las redes de apoyo comunitarias, todxs allí tratábamos de lenguajear en el arte un dolor compartido. Las organizaciones sociales y los colectivos cumplen un rol fundamental en el apoyo social a las personas trans. Se ha encontrado que el apoyo de pares por parte de otras personas TNCG es un moderador entre la discriminación antitrans y la salud mental (APA, 2015: 27).

⁹⁰ Palabra que aprendí en el curso de Pedagogías trans de la maestra Alanis Bello, es una palabra que proviene de convertir al español el título del poema *Queeranderismo* de Berenice Dimas que se encuentra en el libro *Fleshing the spirit. Spiritual and activism in chicana, latina and indigenous women's lives*.

⁹¹ Caribe Afirmativo (2021). Hay 4.190 personas LGBT víctimas del conflicto armado y sin embargo, aún existe un alto subregistro de estas cifras. Recurso en línea. Disponible en: <https://caribeafirmativo.lgbt/hay-4-190-personas-lgbt-victimas-del-conflicto-armado-y-sin-embargo-aun-existe-un-alto-subregistro-de-estas-cifras/>

Para lxs jóvenes con los que conversé el tránsito de género estuvo acompañado por la organización El Faro, que tiene un grupo de personas profesionales y líderesxs que interlocutan con los diferentes sistemas vinculares de lxs chicxs. El Faro es un espacio interaccional de apoyo entre pares, quienes acompañan a personas que llegan a la organización con diferentes necesidades, y los pares cumplen el rol de ser referentes y guías para su proceso.

Relato de Emilia (23 años, Manizales):

Entrevistada: El Faro, o sea El Faro es apoyo y es como donde empiezan mcuhas chicas y eso, cuando yo llegué allá yo ya estaba, pues era quien soy y no entraba tanto a un apoyo a una chica.

Entrevistada: Ah tu haces el acompañamiento y cómo ha sido esa labor ¿qué has encontrado?

Entrevistada: Experiencias muy duras muy similares a lo que yo viví hace años, cosas que todavía se ven ahora, que las mamás no apoyan a las hijas, que se cambien el nombre y las siguen tratando como hombres, que les bajan el autoestima. (...) a mi me buscan, pues desde lo más mínimo, como mirá conozco a Emilia, cómo hago aquí para que no se me note hasta que hago para que mi mamá me apoye o no me echen de mi casa, entonces yo les cuento mis experiencias, todo lo que yo he pasado de mi mamá, de la iglesia.

Así mismo, en Manizales la Fundación El Faro ha brindado acompañamiento a familias diversas para orientarlas y apoyarlas en el proceso de tránsito de sus hijxs:

Relato de Lito (17 años, Arauca, Caldas):

Vienen los del Faro (...) yo le dije que yo quería que hablara con unos amigos (...) ellos le explicaron tan bien el tema (...) entonces ellos me ayudaron mucho demasiado, yo no lo veía a mi mamá tanta entrega hasta ahí. Ellos le decían antes era tu niña ahora es tu niño, trátalo como a un niño y ella cambió. Ella prácticamente me dice mi niño, este sábado cumplo años, ella me dice voy a ir a Manizales a comprarte la ropa, yo sé que ella me va a comprar la ropa, una camisa, una polito, un pantalonsito y ella me decía que me va a comprar los boxer.

Son las redes las que han sostenido y como se ha mostrado cumplen diferentes funciones. Por lo tanto, en el año 2020 se comenzó por parte de la Liga de Salud Trans y Liberarte una formación sensible a pares que pudiesen ofrecer unos lineamientos más claros sobre los procesos de intervención, así como recomendaciones para brindar una asesoría adecuada y un acompañamiento que posicione como protagonista de la historia a cada persona.

Según Lucas Platero en su investigación resaltó las herramientas que permiten a las personas con experiencia de vida trans continuar, así que describió cuatro aspectos cruciales, los cuales acogió del estudio de Cherie Moody y Nathan Grant Smith (2013)⁹² los cuales son:

Tener razones para vivir

Tener resiliencia

Apoyo social

Optimismo

En Colombia existen muchos grupos de apoyo para personas trans, en el año 2018 si no estoy mal tuve la posibilidad de conversar con Laura Weinstein la directos del GAAT y quiero ubicar varios fragmentos de esta entrevista para resaltar varias de las funciones que cumplen las redes de apoyo comunitarias:

-A nivel comunitario: son quienes propician la juntanza, el compartir y el apoyo mutuo entre personas trans que ayudan a sortear las dificultades propias de la vida y de los efectos de vivir en una sociedad que las discrimina.

-A nivel de incidencia política: se investiga sobre casos de discriminación y crímenes hacia personas trans y se realiza un trabajo de agenciamiento para situar esta problemática en la agenda pública.

-A nivel educativo: en muchos casos las redes son quienes ejercen pedagogía para las personas trans en términos del cuidado de sí, para las familias, la escuela, la empresa, la universidad, con el fin de apaciguar los niveles de violencia que vivencian las personas trans.

⁹² Moody, C., & Smith, N. G. (2013). Suicide protective factors among trans adults. Archives of sexual behavior, 42(5), 739–752. <https://doi.org/10.1007/s10508-013-0099-8>

-A nivel familiar: surte como espacio de convergencia y contacto entre familias que se reconocen como género diversas y en ellos se pueden aclarar dudas y llevar procesos institucionales o emocionales a los que se enfrentan en colectivo.

-A nivel de memoria: las redes son aquellas que reconocen la existencia de sus integrantes y honran su memoria como parte de la historia compartida de este país por la lucha por la justicia social y las libertades.

Relato Laura Weinstein:

“El GAAT inicia como un grupo de apoyo solamente entonces veníamos los martes, y los martes veníamos a hablar un poco sobre nuestros tránsitos de cómo nos soñábamos, y yo recuerdo que era como tips de cómo maquillarse, de cómo arreglarse no se que. No quiere decir que no siga pasando actualmente, sigue pasando, pero digamos que hemos evolucionando, porque no sólo nos interesa mantener un grupo de apoyo donde las personas trans puedan lograr hacer unos tránsitos cocientes y también con conocimientos sobre las implicaciones que tiene esto y acompañamiento sino que también hemos ido transformando un poco, porque creemos que es importante no solamente quedarnos en un grupo sino llevarlo al común de la gente. Algo que tratamos de hacer muy comúnmente es lograr hacer transformaciones socioculturales, pero también incidencia política es algo diferente a ese escenario en diferentes espacios porque creemos que es la única manera que realmente vamos a poder hacer una transformación; la gente tiene unos imaginarios muy fuertes sobre las personas trans y es como que las personas trans habitan por allá, no; y entonces las personas trans vistos todas las personas trans visten igual, y a todas les interesa lo mismo y nos interesa nada más y tiene esa afinación por eso. Entonces algo que el GAAT ha venido haciendo es transformando un poco esto, diciendo como: no, es importante llegar a otros espacios, a otros lugares a hacer la toma de espacios públicos, a acompañar a nuestras compañeras y compañeros que son en algún momento sujetos de violencias y demás y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, lo que se ha venido transformando. Empieza con un (no se entiende 10:46) pero que va cambiando, entonces ahora trabajamos no solamente con personas con experiencia de vida trans, nosotras no hablamos solamente de personas trans, sino personas con experiencia de vida trans porque creemos que los tránsitos, existen una multiplicidad de transitar en los géneros y es como generalmente nos lo han pintado que solamente es un tránsito

corpóreo, y hay otras maneras de poder transformar y de poder transitar en los géneros y eso hemos descubierto, que a partir de ese inicio a este momento nos damos cuenta de que todas las personas trans no quieren lo mismo. Hay unas que seguramente quieren unas modificaciones en sus cuerpos, hay otras que dicen sencillamente yo solamente quiero esto, o tal vez no quiero esto, yo solamente quiero cambiar, transformar esto. Por eso hablamos de personas con experiencia de vida trans y para nosotros es importante sus familias, también trabajamos con niñas y niños porque creemos que en la medida en que nosotros logramos transformar una familia, una familia puede reconocer el tránsito de su hijo o su hija eso es un niño o una niña o una persona que su vida es romper con la cadena o con el círculo de miseria, pobreza, exclusión, alta peligrosidad y también todo lo que implica ser una persona trans en contextos de vulneración y de violencia porque cuando una persona es acompañada por su familia esa persona no va a esos lugares, y eso lo hemos comprobado a partir del trabajo con las familias.

Entrevistadora: Entonces digamos el trabajo acá no es solo con individuos explorar toda la red.

Entrevistadx: Todas las posibilidades, vamos hasta los colegios también, en fin. Porque para nosotras es importante trabajar con todo esto. Es que no solamente estamos hablando de que es una persona la que hace esto, son un mundo de personas que hacen el tránsito entonces en la medida en que esas personas puedan lograr reconocer el tránsito, va a ser mucho más fácil para esa persona poder lograr realmente un tránsito exitoso. Porque para nosotros el éxito no es que seamos muy femenina o muy femenino o muy masculino o muy masculina, sino que logre llegar a las lugares en igualdad que cualquier otra persona.(...) O sea es que no solamente podemos hablar de sujeto, es que el sujeto necesita unos acompañamientos, necesita afrontar algunas realidades y demás, pero realmente no es esta persona la que crea el estigma, la violencia, la discriminación, sino es todo su entorno y si logramos llegar a su entorno y se logra transformar su entorno la realidad de esta persona es diferente. Porque a veces la gente llega y dice no es que es el individuo y todo el mundo se centra. Ofertamos sobre el individuo, entonces el mercado, pero es que oiga pilas, es solamente estamos tocando al individuo, pero es que el individuo es sobre quien se gesta toda esta violencia, pero ¿quiénes la ejercen? el primer lugar de violencia de una persona trans es su familia,

entonces si logramos atacar ese primer lugar de violencia pues eso cambia y lo hemos visto.”

Los tránsitos te ponen en lugares de alta vulneración y eso es algo que la sociedad no entiende, entonces eso es algo que a veces la gente no lo ve así. Entonces bueno el GAAT se va transformando y cuando me ponen a mí en la coordinación fue muy chistoso porque dije esto hay que cambiarlo, entonces empezamos a hacer el cambio, ahora es un poco más de comenzar a tomar espacios y claro a muchas activistas que estaban un poquito más grandes les incomodó también eso, porque como que tu llegas y dices cómo así que me traes a una reunión donde hay tres pelagatas hablando y nadie más puede y nosotras cinco qué, más chiquitas, menos recorridas tal vez, porque nuestras voces no cuentan entonces eso hubo una ruptura allí cuando surgen esas cosas. Y eso es lo que más o menos hace el GAAT, a nosotras nos interesa conformar redes, porque creemos en la importancia de las redes.

Entrevistadora: ¿Y cómo es el trabajo con la persona, como la empiezan a explorar, cómo es el equipo, es interdisciplinar?

Entrevistadx: digamos que algo que tenemos claro es que el trabajo es entre pares, entonces aquí, por ejemplo, llegó la persona trans se encuentran un poco y ya, donde se dan cuenta de que la realidad de esta no es tan diferente de la mía y donde todos comienzan a hablar (No se entiende minuto 26:22-24) también como ustedes saben en todos los grupos se van creando unas parcerias, unos amiguismos, entonces llega otra persona nueva y cómo la incorporamos. Entonces también trabajo con ellas y ellos y decirles que cualquier persona que llegue al espacio es tan válida y tenemos que acercarlos. Ya cuando necesitan atención psicológica tenemos voluntarias y voluntarios que hacen este trabajo y los atendemos en esto, entonces el grupo de apoyo está coordinado y manejado por personas que son profesionales, ya sean practicantes o voluntarios peor que generalmente se asocien a la rama de psicología.

Entrevistadora: Ya como último ¿cómo crees que podríamos trazar puentes entre el activismo, la organización y la academia? digamos a veces la academia está muy desligada de las realidades completas de las personas.

Entrevistadx: No está desligada, es que no está ligada, es que ni siquiera se lo plantean, no. Una de las cosas es que yo creo que la academia debe rehabilitarse, tiene que buscar la manera de rehabilitarse con respecto al sujeto de su investigación. Se les olvida que eso que ellas y ellos saben es la praxis de todo un trabajo, de unas vivencias, de unas realidades, y la academia se ha olvidado de eso. Entonces termina siendo las voces de la academia diciendo lo que a ellas les parece que son las necesidades que tiene una población, como en este caso, la población trans, y se olvidan de sus objetos de investigación cuando son ellas y ellos los que realmente saben cómo es, cómo son las cosas.

Por qué no más bien no buscamos una mediación donde el egocentrismo de la academia se deje de lado y entienda que también el conocimiento se genera a partir de estos lugares, comunitarios, donde se encuentra la gente, donde la gente habla de sus realidades y cómo pueden ser sus voces, también hablando y hablando a partir de encontrarnos como academia y construir conocimiento conjuntamente, pero no pesándose que como es que yo sé de la investigación y me voy por acá y la hago por allá y es que a mí me parece y es que lo cualitativo y que lo no sé. Pero eso no cambia la realidad de las personas trans termina siempre siendo estudios puestos en un arnaquel que no los lee nadie, o a veces si es que lo ponen, porque de pronto puede ser que sea tan chévere que lo hacen (no se entiende 31:26) de lo contrario puede ser que solamente quede por ahí en unas cuantas hojas que pidieron y quedó en el olvido, entonces creo que esto es una manera de poder conformar conocimiento, y es poder encontrarnos para dialogar de esas realidades. La propiedad del conocimiento no es de la academia es de la gente, que se enfrenta constantemente a estas prácticas de lucha, de encontrar, de aprender, de dialogar, de construir hasta su propio lenguaje, aunque a veces la academia nos dice cómo tenemos que llamarnos, entonces se olvida que nosotras son quienes nos nombramos. Yo creo que la academia debe replantearse cómo está haciendo sus investigaciones y no tener un miedo acercarse a la práctica de las personas, entonces quédese estudiando los puestos, y los pupitres, que eso puede llegar a ser más interesante.

El artículo *Psicología Comunitaria y Personas Trans: Construcción de Memoria Comunitaria para la transformación personal, social y política desde el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans -GAAT* resalta que los lineamientos del GAAT son: la autonomía; la autoaceptación; el crecimiento personal; el control sobre sus vidas y tránsitos; el cumplimiento de sus metas individuales; la salud física y mental; las oportunidades educativas y laborales; el aumento de condiciones objetivas que se materializan en inclusión social (Verástegui. 2020: p157).

Como nombraba con anterioridad existen varias organizaciones y redes que realizan este tipo de acompañamiento en Colombia, en el informe *El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas*: prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal* de la Liga de Salud Trans se realizó un mapeo sobre las estrategias de cuidado con base a 7 grupos focales realizados en las ciudades de Medellín, Cali, Santuario, Quibdó, Chaparral y Bogotá, las prácticas que se rastrearon fueron:

- *Acompañamiento de procesos de autoidentificación y trámites jurídicos y/ o médicos (relacionado o no con el tránsito).
- *Espacios de reunión para compartir experiencias.
- *Constitución de veedurías para el correcto ejercicio estatal.
- *Espacios de reunión para conversar sobre nuevas masculinidades.
- *Círculos de palabra para apoyar a familias diversas.
- *Acompañamiento en plan de vida y educación.
- *Realizar ollas comunitarias como un espacio de confianza.
- *Espacios que ofrecen distintas actividades vinculadas con los oficios y las artes.
- *Creación de sistemas para denunciar la violencia.
- *Acompañamiento integral: apela a atender diferentes necesidades.

Gaia y otros sistemas vinculares

Desde el paradigma lineal el sujeto se comprende como resultado de las circunstancias que provocaron su existencia, es decir, un sujeto *determinado (genética o socialmente) y estático*; que el sistema institucional gestó como *pasivo* en la autonomía de su vida y *esencial* es decir un sujeto individual contenedor de algunas características que unidas conforman su *identidad* fijas e inamovibles. Concepción heredera del pensamiento binario cartesiano el cual lleva como premisa la división mente-cuerpo, un ejemplo de esto fue la clasificación de los seres humanos por medio de la medición de cráneos (craneología) o de su Coeficiente Intelectual con las pruebas de Binnet, o los estudios de juicio moral de Milgram; todos ellos abordados desde una causalidad lineal.

En coexistencia con el mismo el paradigma sistémico, concibe lo vivo y los fenómenos sociales como sistemas (Bertalanffy, 1976) y por sistema se entiende que es un conjunto elementos que se relacionan entre sí y están en constante intercambio e *interdependencia*, de esta manera un cambio en las partes implicaría un cambio en el todo -sucede lo mismo en el sentido contrario. Precisamente, Edgar Morin (2010) en su libro *El método. El conocimiento del conocimiento* de cara a la dicotomía mente-cuerpo afirma que “la actividad del espíritu es una producción del cerebro, pero la concepción del cerebro es una producción del espíritu” (p. 83) así estas dos instancias no existen la una sin la otra, en efecto, se co-construyen en la relación y se retroalimentan.

Hay que mencionar que la *retroalimentación* es un principio del pensamiento sistémico el cual consiste en que entra una información al sistema y ésta cuando regresa al punto de partida cambia en su forma. Un ejemplo de este principio puede ser la alteración del agua por actividades mineras en el país, como bien sabemos en varios territorios se desarrolla la práctica laboral de la extracción artesanal de oro en yacimientos de agua, al ser una práctica artesanal son las personas quienes utilizan elementos como el mercurio y el cianuro para separar el oro de otros minerales de poco valor; de esta manera el agua que es utilizada para esta actividad productiva también lo es para el consumo y preparación de alimentos lo cual supone un riesgo para la salud de las personas y de la fauna del ecosistema, de esta manera, es cuando estas desviaciones que serían el ingreso de sustancias tóxicas y vuelven al consumo son indicadores del equilibrio del ecosistema.

En este sentido, los trastornos psicológicos históricamente han sido tratados en su mayoría desde el paradigma lineal, en el cual las personas como individuos portan una suerte de identidad del trastorno, por ejemplo, “yo soy depresivo” o “yo soy ansioso”. En el caso concreto de mi trabajo de investigación el diagnóstico de disforia de género y su falta de comprensión en el subsistema médico ha conllevado a una patologización de la vida. Contrario a esto desde los modelos sistémicos de terapia familiar y la teoría de la comunicación, se comprende que los trastornos no son una entidad inamovible en la cual las personas porten. Recogiendo los planteamientos de Covini, Fiocchi, Pasquino & Selvini (1987) en *Hacia una nueva psiquiatría* afirman que:

“las raíces de la enfermedad mental no hay que buscarlas dentro del individuo, por lo tanto, ni en su bioquímica ni una psique, sino prioritariamente en aquellos juegos interpersonales que se producen entre los seres humanos, en las familias y en cualquier sitio en el que la relación adquiera un valor fundamental de supervivencia física y afectiva” (p. 23).

Por lo cual, el proyecto de validación estaba pautado por la objetividad, contexto bajo el cual el psicólogo o la psicóloga en la relación terapéutica se situaba en una posición de observador externo que declara la verdad sobre el sujeto. Con la II Cibernética se entiende que el observador está inmerso en el entramado relacional -como un tercero que rompe el pensamiento binario y las relaciones por diadas-, teniendo conciencia de que el observador observa y al mismo tiempo es observado es así como la mirada se devuelve.

Otra de las reflexiones que me suscita Morin es que desde la epistemología empírico-analítica existe una materialidad de la substancia psíquica humana, es decir, desde Wundt y toda la herencia de pensamiento subsiguiente como el conductismo y el cognitivismo se había intentado reducir lo psicológico a aquello que puede ser observable y medible, es así como se realizaron en un primer momento estudios cuantitativos sobre la percepción, la memoria y el aprendizaje. De este modo, desde este paradigma sistémico se entiende que lo humano sólo puede existir en la interacción y dicha relación no tiene una materialidad medible-observable, situación que amplió el panorama cognoscible de lo humano, al mismo tiempo, implicó un campo de tensión entre los constructos de validación del conocimiento. Un ejemplo de lo anterior es el psicoanálisis, el cual se suscribe como una episteme fundamentada en la existencia de estructuras psíquicas como el inconsciente, el pre-consciente y el consciente que

no tienen una localización en el cuerpo biológico humano, y por tanto, no cumplió en su época con las reglas de validación científica.

Por otra parte, entender y abordar al sujeto desde el paradigma sistémico lleva consigo un cambio en el modo en el que comprendemos las dimensiones espacio-temporales. Ahora bien, quisiera exponer que uno de los aprendizajes más significativos fue el abordar la temporalidad de una forma distinta de tal manera que entiendo el tiempo como: a) un flujo continuo en el que el pasado se actualiza en el presente para crear las posibilidades de futuro. b) la teoría del ciclo vital de Belart, A., y Ferrer, M. (2000) me permitió entender que la vida está entrecruzada por múltiples temporalidades, no hay una meta de mejoramiento de lo humano o un desarrollo escalonado del mismo en el que hay avances y retrocesos, sólo vivimos bajo la co-construcción de pautas que nos permiten ser y cómo los momentos de transición como la conformación de una relación de pareja, la pérdida de un ser querido, una mudanza, el tránsito de género de una persona, crean nuevas configuraciones interaccionales.

En este orden de ideas es liberador pensar que no hay un determinismo sino una multiplicidad de posibilidades de construcción de caminos *mundos posibles* para vivir, el principio que me permitió comprender esto es el de *equifinalidad* que es lo opuesto a la linealidad y es pensar las múltiples y diversas alternativas de llegar a un fin, recordando a Bertalanffy el va a decir que “*la equifinalidad, la tendencia a un estado final característico a partir de diferentes estados iniciales y por diferentes caminos, fundada en interacción dinámica*” (p. 46). Lo anterior implica reconocer que las trayectorias de vida de los sujetos conformadas por la incertidumbre, la emergencia y el caos el cual ordenamos e integramos.

En cuanto a la comprensión sobre el territorio, quisiera traer la teoría de Gaia de Bruno Latour (2017), en la cual el territorio es “*aquello de lo que uno depende para subsistir*” (p. 293) y la territorialización es un proceso múltiple que lo configura. De esta manera, me posiciono como investigadora para abordar el fenómeno de los sistemas vinculares emergentes de la experiencia de tránsito de género, los sistemas como territorios interdependientes que posibilitan la existencia del ser humano. De este modo, en las entrevistas invocamos los sistemas sociales de los que hacen parte lxs jóvenes e identificamos los recursos que posee para su subsistencia y bienestar.

Familias, mundos posibles

La primera vez que tomé Ayahuasca tenía un dolor muy profundo en el corazón, lo estaba llevando hacía algunos años atrás y creo que no me permitía sentirlo para continuar con la vida. Por fortuna, iba con Moon, algo bueno debí haber hecho en esta vida o en la pasada o en la futura para que nos encontráramos, ella me cuidó y me acompañó en esta experiencia, estar en el refugio de su mano es una imagen muy maravillosa, ella me recuerda lo poderoso que es la conexión y por más enchumada que pudiese estar, sentirla cerca hacía que todo fuese más llevadero. Tengo muy presente las imágenes que me dio esta plantita tan hermosa y las atesoro como un regalo, esa noche fue la noche más larga que haya vivido y con la intención muy puesta en sanarme, me cayó la noche cuando pensé que ya amanecía.

Vi como yo era parte de un sin fin de abuelas que me antecedieron, que yo era un punto en una secuencia de vida interminable, tenía tantas abuelas como árboles había en ese bosque, y vi a mi mamá, en esos años yo estaba lejos de ella porque sentí que si seguíamos cerca iba a ser peor y no quería perder su amor, al mismo tiempo, en esos años por intentar que ella comprendiera mi decisión de estar con una mujer y no me patologizara; la juzgué muy fuerte y todo ese sentir lo llevaba conmigo, me hacía nudos en la garganta, me hacía ríos de lágrimas, y me apretujaba el estómago, así que vomite y vomite y vomite, y con todo eso la vi, de verdad la ví, en su humanidad y me reconocí en ella.

Entonces en un movimiento en espiral -literalmente- recordé, volví al corazón, la vi siendo muy joven, de 19 años cogiendo fuerza de donde no había para darnos una buena vida a mí y a mi hermano, parirnos fue cosa de otro mundo, no sé de dónde has sacado tanta fuerza para sostenernos, te vi como una Coatlicue sacando de la tierra lo que sea para darnos alimento, cobijo, amor. Sentí una gratitud desbordada, entendí que no estaba en mis manos decirte qué hacer, cómo actuar o pensar, el amor iba a hacer lo suyo, confiaba en que nuestro vínculo era más fuerte de todo lo que te habían dicho que era normal. Salí callejera como la abuela, y te preocupaba que algo pudiese pasarme, habías pasado por tanto dolor mamita, que finalmente comprendí que ésa era tu forma de cuidarme.

Estar lejos nos permitió vernos, y empezamos otra vez a cultivar nuestro lazo, en un movimiento doble ambas nos pedimos perdón, la reconciliación de los corazones es lo más lindo. Los discursos discriminatorios, tienen consecuencias muy profundas, desvinculan y

desconectan los corazones. Escribo esto porque siento que en este proceso es importante que las familias y cuidadorxs tengan herramientas con las que puedan organizar e integrar este proceso que es exigente en varios niveles.

Minuchin (2005) en su libro *Familias y terapia familiar* dice que la familia es “*un grupo social natural (...) su organización y estructura tamizan y califican la experiencia de los miembros de la familia. En muchos casos se la puede considerar como parte extracerebral de la mente*” (p.27) además señala que éstas tienen historia, lugares de procedencia, pautas relacionales, rituales compartidos, etc. El proceso de tránsito de género implica una reorganización familiar, y su abordaje debe ser protagónico en los procesos vinculados a la niñez y la adolescencia.

Es importante saber que, de acuerdo con la teoría del ciclo vital, existen momentos de reorganización del sistema familiar como lo es: la conformación de la pareja, el ingreso de lxs hijxs al colegio, las mudanzas, la salida de lxs hijxs de casa, entre estos momentos, se encuentra el proceso de tránsito de género. Al respecto el artículo *Family matters: transgender and gender diverse peoples' experience with family when they transition* en el que se entrevistaron a 13 cuidadores en Australia se señala que:

“Los cambios en el sistema familiar ocurren cuando un miembro de la familia cambia de género. La transición puede percibirse como una interrupción de la vida familiar que se ha construido en torno a suposiciones sobre el género asignado a la persona en transición. Las familias pueden tener dificultades debido al miedo a la estigmatización, la vergüenza, el dolor, la ira y/o la confusión por 'perder' a un hijo o una hija, o por cambios relacionales imprevistos en el sistema familiar. Esto no significa que las familias no puedan reconstruir y seguir adelante.” (Doussa, Power & Riggs, 2020: 283).

Lxs jóvenes con los que conversé, excepto una jóven, tenían apoyo de su familia para realizar el tránsito de género. Recordemos que el apoyo de las familias es vital para niñxs y adolescentes, para realizar su proceso de tránsito con el sistema vincular del que dependen biológica y económicamente y aumentar sus niveles de resiliencia, para esto es necesario elevar los niveles de apoyo a las familias (Aramburu 2018).

Para las jóvenes trans las madres cumplen el rol de consejeras, asesoras de la feminidad, con quienes comparten espacios en los que antes no podían acceder como las labores del hogar y del cuidado, son quienes acompañan de forma más constante los tránsitos dentro del sistema médico y son las principales colaboradoras para interlocutar con otros actores de la familia, incluyendo los padres:

Relato Sam (26 años, Manizales):

“mi nivel más cercano es mi mamá, ella ha sido como ese angelito maravilloso, que ha estado ahí desde mis malgenios, desde todo lo que pasó al principio de la terapia hormonal que me daba mucho depresión, tristeza, todavía pero ya más controlado, ya todo está más equilibrado, ella fue quien me acompañó a las citas, ella es la que ha estado ahí para escucharme absolutamente todo y pues ya (...) los cambios de mi cuerpo, no, solo a mi mamá, como contarle mami me está creciendo esto, esto se fue, me ha pasado esto con ciertas partes de mi cuerpo. Ella es mujer, cierto, mami ¿que me echo para el cabello? mami qué hago con esto, mami ayúdame con las uñas”.

Relato Lito (17 años, Arauca, Caldas):

“Entonces yo ese día me motilé y subí y prácticamente a mí la opinión de él, me importaba, pero no tanto como la de mi mamá. (...) Entonces yo solo le sonreía y cuando me quitó la capota y me dijo: Usted es igual de lindo a sus hermanos, y ella lloraba y yo le dije: mami yo no me he muerto, yo estoy vivo. Me hace acordar mucho de su hermano (...), y ella me miraba y me tocaba la cabeza y me decía: no, quedó divino.”

Relato Thalia (16 años, Arauca, Caldas):

“Mi papá, mi mamá y mi hermano han sido los que más me han asesorado en todo este tema. Mi mamá en el tema de ser alguien femenino; mi hermano cuidándome y todo; mi papá comprándome la ropa, el maquillaje y todo esto.”

Relato Anastacia (16 años, Manizales):

Entrevistada: Mi mamá es muy cercana entonces en el 1.

Entrevistadora: ¿De qué manera ella estuvo acompañándote?

Entrevistada: Pues me daba mucho apoyo me ha comprado ropa, no ropa, ha hablado con mi papá para que me pueda comprar ropa, me ha dado de su ropa, me dice que no

tengo por qué sentirme mal conmigo misma, que soy bonita, y pues me hace sentir bien y siempre ha estado conmigo, toda la vida y pues en este momento de vida también entonces ella ha sido un gran apoyo en mí.

Los padres siguen siendo los proveedores económicos de la casa y no se vinculan a profundidad con los apoyos en el tránsito de género. Como vemos en el relato de Lito, la actitud de su padre es común, en el estudio longitudinal a catorce padres de 12 niñas y jóvenes trans (no se expone de qué lugar del mundo) *Supporting families of transgender children/youth: Parents speak on their experiences, identity, and views* se expone que las primeras reacciones de lxs cuidadores suelen ser confusión, preocupación y posteriormente convicción de apoyar a su hijo (*ibid.*)

Relato Lito (17 años, Arauca, Caldas):

“Cuando yo salí mi papá se quedó mirándome y cogió el bolso y se fue y no me dijo nada. a mi papá sí le dió duro los primeros días. (...) me dijo que lo disculpara que le había dado muy duro, que yo era una de las adoraciones de él, la niña de los ojos de él, que lo entendiera que para él había sido muy duro-.- Y yo le dije tranquilo, yo a usted lo entiendo, yo lo entiendo completamente-. Él es uno de los que respeta mucho eso, él no habla mucho de eso.”

Relato Emilia (23 años, Manizales):

Entrevistada: Pues no me ha apoyado pero tampoco me va dando chuzadas, le da igual.

Entrevistadora: ¿qué te gustaría que papá hiciera?

Entrevistada: Eh, ay no sé, como que abriera más la mente y ya lo aceptara del todo, igual no hay nada que aceptar las cosas son.

Es preciso decir que las familias siguen teniendo problemas del curso de la vida y que éstos repercuten en la salud mental de lxs jóvenes, por ejemplo, Lito relata que su familia fué desplazada y que luego de esta situación su padre se vuelve alcohólico, así como el padre de Anastacia que se encuentra en otro país y su madre que es su principal cuidadora tiene algunas dificultades con él:

Relato Anastacia (16 años, Manizales):

“Mi papá un 2 porque un 2 o sea el hecho de que no esté a mi lado no significa que no me esté apoyando porque pues uno puede recibir como un apoyo emocional así tenga una gran distancia solo que pues es debido a la diferencia como el horario entre los países entonces no puedo hablar mucho con él y las veces que lo hago pues me apoya muy bien.”

Relato Sam (26 años, Manizales):

No, yo no tenía esas expectativas, como te digo yo pensé, como te digo el hermano de mi papá es sumamente machista, es mecánico es un buen hombre muy trabajador y todo, pero pues hace años yo me había enterado de los hijos de cómo los maltrataba de los comentarios que hacía, cierto, de personas gays y demás. Yo digamos me visioné de alguna manera y como que premeditaba algún tipo de situación y que no estaba totalmente ajena a la realidad, él fue uno de los que le dijo a mi papá: no vayan a dejar los hijos, son para amarlos y es mejor una hija viva que un hijo muerto, así le dijo. El que lo haya dicho él es algo maravilloso y también porque ahorita tiene una mujer que la esposa que no tenemos lazos de sangre, pero desde el principio ha estado Sam esto, Sam aquello, ven a mi casa, hagamos esto, como una amistad muy linda. Yo estaba totalmente equivocada con la percepción de la realidad, yo pensaba que no iba a ver aceptación y por el contrario hubo más aceptación de lo normal, que hasta hay veces como que no me lo creo como que me extaseo de tanta felicidad y es raro porque yo nunca sentía eso hace muchos años, sentía que no iba a ver momentos así, situaciones así de lindas y resultó que no.

La familia escogida, lxs amigxs son una parte fundamental de la vida a partir de la adolescencia, son los vínculos que podemos realizar más allá de la familia de origen. Lito, se negaba a recibir el apoyo de sus amigxs porque quería la presencia de su familia, al mismo tiempo, reconoce que son un gran apoyo en su vida porque es con ellxs con quien comparte la mayor parte del tiempo, también son la red que sostiene cuando no existe el apoyo por parte de lxs cuidadores y quienes aconsejan sobre la estética:

Relato Lito (17 años, Arauca, Caldas):

“No, pues como practicante yo quería más el apoyo de mi familia, y no es que ellos estuvieran tan lejos, sino que es como: mira si necesitas algo, avísame. Si quieres hablar con alguien, dale de una. Porque al primero que yo le dije de todo lo que yo

sentía fue a mi mejor amigo. (...) es como mucha la unión y más de los amigos que tengo acá, muchos amigos del 41, de Manizales, ellas me brindan mucho apoyo, son 4 mujeres y 1 sólo hombre, pero interactuamos mucho todos con todos porque hay veces donde decimos, no vamos a acampar cerca a Arauca, esto somos todos muy unidos. (...) Mis amigos hombres son unas personas muy extrovertidas, ellos, es tanto que hay uno que se hace pasar por gay cuando va a pedir permiso por alguna niña, ellos se meten tanto en el mundo de nosotros que como que nos entienden y cuando uno necesita una charla ellos están ahí”.

Relato Emilia (23 años, Manizales):

“Pues apoyo de mis amigos, o sea mi mamá me encerraba en la casa yo no tenía amigos y vine a tener amigos cuando salí de la casa de mi mamá y una de mis mejores amigas fue ella Melisa, y ella si me apoyó demasiado como la seguridad y así mucha gente, porque yo pasaba gente, me avergonzaba, me iba, pues yo tenía muchas inseguridades.”

Relato Anastacia (16 años, Manizales):

“D en un 1, de hecho todas, otra se llama A y J bueno D siempre me ha apoyado mucho en todo, siempre me hace ver las cosas en las que estoy haciendo mal por verme más femenino, por ejemplo que el cabello que me lo tengo que arreglar más o no sé cómo andar es que son cosas que yo he cogido al ser más varonil y encajar en la sociedad como tener las piernas muy abiertas como si me entiende, o como al rescostarme mucho en el espaldar y como muy no sé cómo lo hace, si, así, si se quiere ver como más femenina debe que caminar más”.

También en los relatos emergieron otros vínculos familiares como las abuelas, lxs hermanxs y lxs tixs, quienes pueden dar apoyo mediante promover la aceptación dentro de la familia, ampliar el campo de sus creencias religiosas para no discriminar, brindar soporte económico o defender a la persona frente a la mirada discriminadora de otros.

Relato Thalia (16 años, Arauca, Caldas):

En segundo pondría a mis hermanos porque ellos también me han apoyado pero no de una forma tan cercana como la de mis papás y de tercero pondría al resto de mi familia, mi familia me ha apoyado nunca me han dicho nada sobre mi tránsito o sobre mi

expresión, tal vez ahora que me expresé de una forma muy masculina pero uso femenino y choco con ellos pero si me han apoyado demasiado, a través de los años.

Entrevistadora: ¿De qué manera te han apoyado?

Entrevistada: Cuidandome, por ejemplo, si alguien se empieza a burlar de mi o a decirme algo, ellos siempre han estado ahí para defenderme, ellos han sido un factor muy importante en mi tránsito.

Relato Anastacia en referencia a uno de sus hermanos:

“Él siempre lo ha visto muy normal en mí y él le da igual, contal que me vea bien y todo eso y de hecho fue uno de los primeros que me empezó a llamar por el nombre que yo quería y siempre me ha apoyado y siempre me ha visto como muy normal entonces le da igual.”

La familia como institución garantiza la reproducción del capital humano que servirá a los Estados-Nación para la acumulación de la riqueza, toda idea que amenace su cohesión interna y la trascendencia de esta, corre el riesgo de ser excluida. De acuerdo con la APA (2022) *“El rechazo familiar y social a la identidad de género es uno de los predictores más fuertes de las dificultades de salud mental entre las personas transgénero”*.

Relato Emilia (23 años, Manizales):

“Mi mamá me echó de la casa como a los 18 años, ella nunca me acogió, ella si fue desde que yo empecé a tomar hormonas la primera semana a los 14 años, ella se dio cuenta de todo y nunca me apoyó y ella pues no, yo a veces lo asimila o anda con dos adelante y dos hacia atrás. Además, influye mucho que ella es cristiana y ella dice no: Adán y Eva que es pecado”.

El apoyo familiar es importante sobre todo para las infancias y adolescencias trans señala la lideresa e investigadora Laura Weinstein:

“para nosotros es importante sus familias, también trabajamos con niñas y niños porque creemos que en la medida en que nosotros logramos transformar una familia, una familia puede reconocer el tránsito de su hijo o su hija eso es un niño o una niña o una persona que su vida es romper con la cadena o con el círculo de miseria, pobreza, exclusión, alta peligrosidad y también todo lo que implica ser una persona trans en

contextos de vulneración y de violencia porque cuando una persona es acompañada por su familia esa persona no va a esos lugares, y eso lo hemos comprobado a partir del trabajo con las familias.”

Para ver recomendaciones sobre prácticas que protegen el vínculo dentro de la familia cuando unx de sus integrantes se reconoce como una persona sexo-género diversa por favor leer el Anexo 4 que se encuentra al final de este documento.

Políticas Postmortem⁹³ Transfeministas

Tanto manoseo de la palabra inclusión ya me sabe a mierda, es una palabra friendly para decir: haremos todo lo posible para que no sean excludxs pero mantenemos las distinciones y las distancias. Tantas veces he escuchado: *“Con todo respeto, pero en mi opinión no entiendo cómo es que existen este tipo de personas”, “Yo tengo amigxs gays y lesbianas a quienes quiero pero no significa que lo comparta”, “No tengo nada en contra pero con tal de que no se me acerquen, todo bien”*. No soporto su discriminación, su mensaje de asepsia.

Me resulta difícil leer: las personas trans son sujetos de especial protección constitucional, así como las mujeres, los niños y las niñas, las personas migrantes. Desde cuándo se volvió normal tener políticas diferenciales cuando lo que nos caracteriza como humanidad es nuestra diferencia, a veces siento que estamos enfocándonos en una parte muy pequeña cuando el panorama es muy amplio, ¿dónde están las políticas de la regulación del consumo y la capacidad adquisitiva desmedida? no veo ninguna regulando y poniendo un freno a tanto desafore; ¿dónde están las políticas para las personas adictas al poder? por el contrario en todos los ámbitos se sigue reforzando la idea del éxito a costa propia, de dominar a costa de la vida de lxs otrxs, de ganar prestigio, de la competencia como una habilidad “para la vida”; ¿dónde están las políticas que regulan cómo se abordan los discursos de odio? no me refiero a censurar a las personas que los dicen sino que se gestionen en espacios conversacionales para que no sean tiros al aire, sino abordados como problemas de convivencia.

Conversar para convivir en armonía

⁹³ Hace referencia al concepto elaborado por Sayak Valencia, el cual significa, a las acciones posteriores a la exposición y la vivencia de la violencia desmedida, es aquello que las personas logran re-elaborar para hacer frente a la necropolítica.

Me gustaría desarrollar más este último punto sobre los escenarios conversaciones en el ámbito político del país. Estoy frente al computador leyendo el siguiente titular “*Cartilla sobre discriminación sexual en colegios dividió el país*” (El Tiempo, 2016) el cual hace referencia al lanzamiento de las Cartillas sobre Ambientes Escolares Libres de Discriminación del Ministerio de Educación como parte de un trabajo colaborativo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) la cual habla sobre conceptos básicos tales como: sexo, género, orientación sexual e identidad de género; allí se expone que el binario macho - hembra es una construcción social y que el espectro humano no se reduce a encajar en estas dos posibilidades de existencia. Revisando algunos tweets de agosto del 2016 de la comunidad en general de Twitter en Colombia, muchas personas expresaron tener una preocupación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes respaldada por su creencia en que éstos son incapaces de decidir por sí mismxs sobre su género o su orientación sexual, además de los traumas que esto podría generarles al “confundirlxs” sobre los roles que tienen hombres y mujeres en la sociedad reducida a su función reproductiva enmarcada en la familia.

Antes de que se produjera el lanzamiento de las Cartillas, en Internet varios medios de comunicación compartieron la noticia falsa de www.costanoticias.com en la que se difundió una imagen de un comic llamado *In bed with David and Jonathan (2006)* de Tom Bouden



Fuente: Cuenta personal de Twitter Álvaro Uribe, tweet del 01 de octubre de 2016.

diciendo que éste era el material que se estaba difundiendo en los colegios por parte del Ministerio de Educación. Lo que causó un revuelo social sin precedentes y del cual se tendría resonancia hasta el plebiscito por la paz en el mismo año.

El apartado sobre conceptos básicos sólo representaba el contenido del primer capítulo de la Cartilla, los capítulos siguientes versaban sobre algunos lineamientos y recomendaciones para realizar una actualización de los manuales de convivencia escolar en los colegios, en los que debería ser explícito su compromiso con la garantía de los derechos de los

niños, niñas y adolescentes; entre ellos sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la libre determinación y a la libre expresión en su desarrollo.

Es así como las Cartillas tenían un gran peso institucional y social para el país, la forma en cómo el debate público se dió alrededor de una categoría -hasta ese momento desconocida- la Ideología de género, dejó entrever el gran reto que supone hacer política para todos, todas y todxs en este país bajo la lógica de un ejercicio que promovía la condición mínima para la interacción social basada en la legitimidad de la emergencia del otre: la no discriminación.

En efecto la forma en cómo distintos actores se posicionaron frente a la idea de la implementación de las cartillas en los colegios causó polarización en el debate social, ya que, se restringió a la conformación de dos grupos: las personas que estaban de acuerdo en que las Cartillas fueran implementadas en los colegios y las personas que decían que éstas promovían la mal llamada: Ideología de género. Pocas veces hay un espacio conversacional social, la mayoría de veces lo que se encuentra es un debate que tiene por objetivo tratar de convencer a lxs opositorxs y anular (eliminar) su punto de vista. Lo devastador vino cuando se develó el uso instrumental de este debate para polarizar al país frente a la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, tal y como se puede ver en las anteriores imágenes de Twitter.

En esta línea de pensamiento afirma el monseñor Luis Augusto Castro presidente de la Conferencia Episcopal en una entrevista con El Tiempo (2015):

“Es que no se trata simplemente de que el niño tenga una familia, sino que tenga un papá y una mamá” es decir, dos personas que encarnen estos roles de género que aseguran la reproducción de la familia y que sólo pueden ser encarnados por una “mujer con sexo biológico femenino” y un “hombre con sexo biológico masculino”. ¿De dónde viene este pensamiento?



Fuente: Cuenta personal de Twitter Alejandro Órdoñez, tweet del 18 de octubre de 2016

Encuentro algunos hilos por aquí: para el siglo XVIII el poder médico se consolidaba con el poder del Estado Nacional, el cual obtuvo su estatus desde el siglo XIV bajo la alianza entre la

burguesía y la nobleza contra el movimiento revolucionario de los siervos convertidos en campesinos libres luego de la peste negra en Europa, siendo este *“el gestor supremo de las relaciones de clase y en el supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo —una función que continúa realizando hasta el día de hoy.”* (Federicci,2004. p.82).

El Estado, la iglesia y la ciencia controlan entonces la producción humana tal como lo señala Silvia Federicci en Calibán y la Bruja:

“Este proceso requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Fundamentalmente, requirió la destrucción del poder de las mujeres que, tanto en Europa como en América, se logró por medio del exterminio de las «brujas” (ibid, p. 90).

En ese sentido, la vida de las personas queda bajo la tutela del Estado que debe garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Al respecto Virgine Despentes en Teoría King Kong (2007) señala: *“los cuerpos de las mujeres sólo les pertenecen a los hombres a cambio de que los cuerpos de los hombres le pertenezcan a la producción, en tiempos de paz, y al Estado, en tiempos de guerra”* (Despentes, 2007. P. 24). De este modo, todo aquello que pueda obstruir este proyecto de fecundidad que al mismo tiempo era de acumulación de riqueza, será criminalizado.

En el artículo Construcción y validación de una escala de actitudes negativas hacia personas trans en Argentina en el proceso de validación de la escala se encontró que: *“la validación externa de la EANT sugiere que las personas con mayor intensidad del sentimiento religioso y con mayor frecuencia de asistencia al culto presentan mayores niveles de actitudes desfavorables hacia personas trans, mientras la educación y el NSE impactan de forma inversa, reduciendo el nivel de prejuicio evidenciado.”* (Páez, Hevia, Pesci & Rabbia. 2015:181). Considero importante seguir estudiando bajo escalas propias las correlaciones políticas con los niveles de aceptación de personas trans.

Por otra parte, la Política Nacional de Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos de Colombia (2014) dice en su apartado 3.5 *Diferenciación entre sexualidad y reproducción, que, si bien la reproducción tiene que ver con la sexualidad, ésta última se relaciona con varias*

dimensiones del ser humano y está vinculada con la autonomía corporal. Dentro de la política se contempla la reproducción asistida y la adopción como un derecho. Muestra de esto son las nuevas tecnologías reproductivas, actualmente se hacen estudios para la implantación de úteros en mujeres trans para que ellas puedan tener un embarazo⁹⁴ (Alireza Hamidian Jahromi, Sydney R. Horen, Amir H. Dorafshar, Michelle L. Seu, Asa Radix, Erica Anderson, Jamison Green, Lin Fraser, Liza Johannesson, Giuliano Testa & Loren SM Schechter, Loren Schechter. 2021); (Vikram G. Mookerjee y Daniel Kwan. 2020); (Elizabeth Dietz. 2021) y de criogenización de óvulos y espermatozoides como una medida que garantice la fertilidad, la cual se hace antes de iniciar la terapia hormonal y es un derecho reproductivo de las personas trans decidir cómo gestionar su fertilidad.

Otra de las coyunturas que ocurrieron en el año 2016 fué #Firmes por papá y mamá es la abreviación discursiva que utilizaron y utilizan varias personas, colectivos y partidos políticos en redes sociales para defender una experiencia de mundo vincular familiar. Expresión que niega otras estructuras familiares compartidas por millones de personas. Es así como en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación basado en los datos del DANE, para el 2016 el 40% de los hogares en Colombia no tenían una estructura familiar⁹⁵ nuclear biparental o monoparental.

La “ideología de género” nunca se ha definido, no existen teorías que la hayan abordado, en sí misma no es un concepto sino es una noción que hace referencia al carácter dogmático de instruir en género y diversidad sexual, en el que “aceptar la diversidad” es de carácter obligatorio y, a su vez, pone en jaque la estructura familiar conformada por un hombre y una mujer cisgénero, y por tanto, la reproducción humana. Es así como el debate público tiene otro aspecto fundamental que va más allá de la tipología de estructura familiar, es justamente

⁹⁴ Si quieres saber más sobre este tema, recomiendo leer los artículos citados (en la bibliografía se encuentran los links disponibles) y los Estándares de Montreal que emiten uno de los conceptos más importantes sobre trasplante de útero.

⁹⁵ Las estructuras de conformación familiar reconocidas por el Departamento de Planeación Nacional son y se definen de la siguiente manera:

Hogares nucleares = núcleo conyugal biparental con o sin hijos; o núcleo conyugal monoparental con hijos

Hogares extensos = hogares nucleares + otros parientes

Hogares compuestos = hogares nucleares (con o sin otros parientes) + otros no parientes

Hogares familiares sin núcleo = no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija, pero existe una relación de hermanos u otras relaciones de parentesco

Hogares no familiares sin núcleo = no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija, no existe una relación de hermanos ni otras relaciones de parentesco.

¿quiénes logran conformar la tipología familiar biparental heteronormativa? ¿Qué es aquello fundamental de esa estructura familiar nuclear biparental heteronormativa que se quiere conservar en nombre de los niños, niñas y adolescentes?

La posición conversacional frente al uso de términos como la Ideología de género creado por las mismas personas que afirman defender la unidad familiar heterosexual, aluden al mismo argumento al cual se contraponen y es la imposición de un modelo de vinculación familiar y de gestión de la vida, posición que interrumpe la autonomía de lxs sujetxs y rompe con el tejido social, porque el modelo familiar heteronormado no es un modelo compartido por todxs, y en esencia, la vinculación no es de ninguna manera una sino es un entramado relacional con múltiples diferencias que permiten la supervivencia de lxs sujetxs.

Es importante mencionar que la intención del uso de las Cartillas por parte de los colegios era que éstas fuesen una herramienta para que los Manuales de convivencia se actualizaran conforme a lo declarado por la ley. Además, la Corte Constitucional en el año 2015 fallo a favor de la tutela puesta por la madre de Sergio Urrego, Alba Reyes ordenándole al Ministerio de Educación que tenía un año para revisar todos los manuales de convivencia del país asegurándose de la no discriminación dentro de los mismos (MEN 2016).



Recuerdo el vacío me dejó leer la noticia sobre el suicidio de Sergio Urrego en el año 2014, un chico que vivió una serie de actos discriminatorios por parte de la rectora, la psicóloga y los profesores del colegio, personas adultas que en teoría debían velar por su bienestar y su desarrollo personal con libertad en el ámbito educativo. Esto pone en evidencia que la discriminación sólo lleva consigo la negación de la existencia del otrx y por tanto, su muerte, como se ha mostrado con anterioridad.

¿De qué manera los sistemas patriarcales se configuran para castigar, oprimir, discriminar la existencia de unas personas, que en realidad puede ser cualquiera, dependiendo de la necesidad colonizadora?

Lo político pasa por el reconocimiento de la existencia de la diversidad. En mi revisión sobre datos estadísticos de personas trans en Colombia me enfrenté con que la información no está unificada para tener un dato a nivel nacional, por lo tanto, es imprecisa. Así lo señala el Departamento Nacional de Planeación (2021) en su informe *Situación de las personas trans en Colombia*: “esto se debe principalmente a que se han dado pocos avances en la generación de información a través de encuestas y registros administrativos” (p.10).

En primera medida, los censos y las encuestas que ha realizado el DANE antes del año 2019 no han tenido en cuenta las categorías de transgénero, transexual, intersexual, gay, lesbiana y bisexual. César Rodríguez, director de Dejusticia, ha dicho para un artículo de El Tiempo que lo anterior “*es una forma de decirle a una persona: usted no existe, usted no registra*”. Frente a esto, el DANE dice que los censos no son el único método de conocimiento poblacional y que en estos no se debe preguntar sobre la intimidad de las personas. Por su parte, Sofía, mujer transgénero y política afirma que “*no hay nada más íntimo que el respeto por la identidad*”.

Como he resaltado con anterioridad, para el año 2019 el DANE tuvo en cuenta los datos sociodemográficos de género y orientación sexual para la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancia Psicoactivas, siendo una información todavía limitada porque sólo se realizó en cabeceras urbanas, de esta encuesta se informa que las personas trans son el 0,05% de la población en Colombia.

En segunda medida, Medicina Legal es otra de las fuentes estadísticas importantes, en sus informes sobre mortalidad tampoco contaban con dichas categorías en sus formatos de registro. En este sentido, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Fundación Santamaría en su informe de violencia hacia personas LGBT en Colombia expusieron que:

“Hasta el año 2014, Medicina Legal utilizó la categoría “homosexual” para registrar a las personas LGBT víctimas de homicidio, por lo cual sólo era posible identificar de manera precisa su orientación sexual o identidad de género al triangular la información con otras fuentes. En 2015, en cambio, identificó de manera diferenciada a mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales o trans que murieron de manera violenta” (2015: 30-31).

Por su parte, el portal Sentiido en su artículo *Colombia LGBT en cifras*, hipotetiza sobre la cantidad de personas LGBT en Colombia, refiere que la ONU expone que cerca del 10 y 15% de la población global es gay, bisexual, lesbiana y trans; en estos términos estipulan que en Colombia podría haber cerca de 4'894.464 y 7'341.696 personas LGBT. Esto sin contar con los datos de personas Intersex.

Considerando así el asunto, indagué en los informes y boletines de la Política pública LGBTI de Bogotá, uno de ellos, el boletín número 13 se trata de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 y presenta información sobre la orientación sexual y divergencia de género de la siguiente manera:

Tabla 2. Identidad de Género

Pregunta EBC	Categoría	Número	Porcentaje
130.¿Usted se identifica como una persona de género...?	Femenino	3.006.371	48,48%
	Masculino	2.660.775	42,91%
	Transgenerista	3.175	0,05%
	No sabe	497.269	8,02%
	No responde	33.194	0,54%

Fuente: Observatorio de la PPLGBTI con base en la EBC 2015

Fuente: Cuadro tomado del Boletín número 13 de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 sobre los principales resultados de los sectores LGBTI en Bogotá de la Secretaría Distrital de Planeación.

Debo agregar otros dos datos importantes: a) Aproximadamente el 2% de la población en Bogotá pertenece a algún sector LGBTI. b) Las localidades que tuvieron más presencia de personas trans fueron Usaquén, Rafael Uribe, Santa Fe, Kennedy, San Cristóbal, Antonio Nariño y Bosa. En el año 2018 se realizó una línea base en Bogotá en el que se obtuvo que existen 52.704 personas que se identifican como LGBTI, en el que se señala que existen 3.070 mujeres trans y 322 hombres trans.

Por otra parte, en Manizales, tampoco se encuentran datos sobre la población LGBT de manera confiable, existen algunos datos que se encuentran registrados en la política pública LGBT de Manizales, allí se realizaron 45 encuestas a personas trans de la ciudad 38 eran mujeres y 7 hombres; casi la mitad de lxs encuestadxs ejercían trabajo sexual, seguido de estilismos y se

encuentran estudiando. De ellas, el 71% terminó la secundaria y sólo el 4% accedió a la educación superior.

Cuando comencé esta investigación no encontrar los datos me dejaba una sensación de vacío, lo considero una práctica de borrado, de inexistencia. En el documento antes citado *Aniquilar la diferencia* muestran que “la experiencia del ocultamiento sea por mandato explícito o por supervivencia, se ha constituido en un daño en la subjetividad y el desarrollo personal al no poder vivir con seguridad y libertad la propia orientación sexual o identidad de género.” (2015:320). Así que realicé otro tipo de búsquedas vinculadas con la literatura y los registros fotográficos almacenados en archivos queer.

La transhistoria⁹⁶⁹⁷ en Colombia nos relata la importancia de vivir una vida auténtica (es decir bajo las decisiones, autonomía y gobierno de cada persona) y nos devela la cualidad dinámica y moldeable de los seres humanos, ha sido el movimiento trans el que ha abanderado por ésta máxima libertad humana Han sido ellxs lxs que llamaron Orgullo al acto de no permitir que otras personas vulneren, violenten y eliminen la vida de otrxs, haciendo memoria e historia de la trayectoria de vida de las personas trans.

Han sido ellxs lxs que alzaron su voz para develar que el proyecto de “normalización” sexual y de género cobra vidas a diario y que esa necropolítica no puede ser el paradigma de desarrollo

social. En la revisión del Archivo Queer de la Fundación Arkhé encontramos que éste ha sido alimentado por los álbumes de fotos de varias activistas LGBTI, que donaron sus recuerdos pictográficos para alimentar las historias comunes de las personas trans, para no olvidar que las personas sexo-género diversas



⁹⁶ Si quieres conocer un trabajo exhaustivo de la transhistoria te invito a escuchar el podcast Radiotituta en todas las plataformas de podcast y la cuenta de Instagram @colombiatranscuirhistory

⁹⁷ Los registros fotográficos de este collage pertenecen a las carpetas 27 y 15.

existimos. Charlotte Callejas⁹⁸ relata que antes de los movimientos de León Zuleta y Manuel Velandia en los años 80's las personas trans ya trabajaban sobre la construcción del cuerpo y el ejercicio del trabajo sexual, una de las lideresas que resalta es Trina del Barrio Santa fé, quien aglomeraba a personas trans para discutir sobre la garantía de derechos del trabajo sexual, problemática que por ejemplo estuvo reflejada en el cuento de Besacalles escrito por Andrés Caicedo en 1969: *“Pero antes de que yo reaccionara me levantó agarrándome de los hombros y me arrancó la blusa y sacó los papeles y los algodones gritando que su vida era la vida más puta de todas las vidas, y dándome patadas en los testículos y en la cabeza hasta que se cansó. Cuando se fue, no sé si estaba llorando o se estaba riendo a carcajadas.”* (Caicedo, 2008).

Esteban Duperly, en la revista Arcadia (2014), hizo un artículo titulado *“Benjamín de la calle, enamorado de la imagen. El extraño caso de la mujer-hombre”* en el que cuenta la historia de una persona que fotografió Benjamín de la Calle quien fué ladrona en Medellín en 1912. Tuvo gran impacto ya que era leída como hombre y se travestía de sirvienta para entrar a las casas, robar y luego huir, así mismo afirman que dicha persona se rehusaba a usar ropa “masculina” ya que su madre siempre le había puesto ropa “femenina”.

Sin lugar a duda, desde la creación de la marcha del Orgullo en 1982, varios procesos organizativos tuvieron como pilares -no el único- la visibilidad en el espacio público de personas gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans. Debido a que la mayoría de los procesos de tránsito de género se dan en la clandestinidad y el ocultamiento de las redes más cercanas, es decir, de la familia, la escuela /universidad, el trabajo.

En la década de los 90's apareció el proceso Planeta Paz, en el que se organizaron distintos activistas LGBTI y discutieron sobre su proyecto organizativo en términos de definirse como comunidad, sector, o movimiento social. Adicionalmente, se reflexionó sobre las identidades, los cuerpos y la relación con el conflicto armado en Colombia, cabe resaltar que este proceso permitió la articulación con personas negras, indígenas y sindicales. En esta misma década en el ámbito de la jurisprudencia se garantiza el derecho al cambio de nombre y sexo en la cédula, y en el nuevo milenio con la instauración de la mesa LGBTI en la alcaldía de Garzón se

⁹⁸ Esta intervención se encuentra en: Gámez, A. (2008). *Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos. Una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de oportunidad y la política cultural*. Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana.

consolidan los lineamientos de la política pública y se abren los centros de atención a la diversidad sexual en Bogotá.

Siguiendo el testimonio de Callejas, los colectivos Transer se destacan como una apuesta de acompañamiento al tránsito. Por ejemplo, Cotransgénero emerge como espacio de encuentro trans en el que se discutía sobre violencia policial, cedulación y trabajo con madres comunitarias. Posteriormente se han desarrollado otros procesos organizativos como: La liga de salud trans, Red Comunitaria Trans, Gaat, Colectivo de hombres trans, Colombia Diversa, Corporación Red somos, Alienhadas, entre otros en Bogotá. Corporación El Faro, Armario Abierto, Las Guapas, Fundación Polari entre otros en Manizales.

Territorios Indomptables

A vosotros, la tierra; a mí, el espacio sin límites.

Herculine Barbin

Este trabajo de tesis se suscribe en el Área de investigación Procesos Sociales, territorio y medio ambiente del Centro de Investigación del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia. El espacio físico a la vez es un espacio mental, la organización de la ciudad es un pensamiento, las calles se formaron como una metáfora del sistema circulatorio humano (Sennett, 1984, p. 283), quienes nos coordinamos como habitantes somos sus redes neuronales, y esto pasa por la individualidad, expandir los horizontes de pensamiento pasa por el derecho a la ciudad.

La ciudad es un organismo vivo que se ha organizado de manera binaria, dando lugar a unas existencias que se integran y otras que se excluyen de acuerdo con los parámetros de lo normal, como señala Linda McDowell los cuerpos “fuera de lugar” son aquellos que causan una perturbación en el espacio haciendo referencia a cuerpos trans, personas gestantes, cuerpos enfermos. La ciudad es un espacio generizado.

La diversidad de género catalogada como un virus y como enfermedad fortalece la idea de que estas existencias deben ser retenidas, puestas en cuarentena, por supuesto tiene otros componentes como algo que se debe “limpiar” y detrás de esto una lógica racista de “lo blanco”. Sé que reciben otro nombre, pero se les llama comúnmente Zonas de Tolerancia o Zonas de alto impacto, son espacios de la ciudad en los que se ha confinado lo diferente y lo merecedor de alto control y vigilancia. El Santafé en Bogotá y la Galería en Manizales son

espejos de la misma lógica, son una frontera espacial, un borderland como decía Gloria Anzaldúa, y quienes atraviesan el proceso de tránsito son migrantes del género como dice Paul Preciado. Federicci expone que:

“En la Edad Media, la migración, el vagabundeo y el aumento de los «crímenes contra la propiedad» eran parte de la resistencia a la pobreza y a la desposesión; y estos fenómenos alcanzaron proporciones masivas. En todas partes —si damos crédito a las quejas de las autoridades del momento— los vagabundos pululaban, cambiaban de ciudad, cruzaban fronteras, dormían en los pajares o se apiñaban en las puertas de las ciudades —una vasta humanidad que participaba en su propia diáspora, que durante décadas escapó al control de las autoridades.” (p. 124)

En el Boletín #5 de la Escuela de Estudios de género de la Universidad Nacional, Sofía Zaragocin habla sobre cómo incorporar al espacio en los estudios de género es una oportunidad para hacer concreto la Interseccionalidad, conforme a esto afirma. “la teorización sobre la interseccionalidad ha puesto muy poca atención al significado del espacio en los procesos de formación del sujeto, lo cual significa que en espacios particulares existen sistemas dominantes que producen momentos de exclusión para ciertos grupos sociales.”(p.45). En este sentido, se comprende que el espacio es dinámico, fluido e interconectado con múltiples aspectos de la experiencia de la vida cotidiana.

Tengo más afinidad con la palabra somateca que con la palabra cuerpo porque no es un espacio material, es un sistema global de gestos, performatividades, creencias y rituales con el que nos movilizamos por los sistemas que configuramos y nos coordinamos con otros organismos. Para Fernando Hernández y Joan Pujol el cuerpo no es un espacio neutro o transparente, está atravesado por lo que ellos denominaron los procesos de constitución del poder y del sistema político global.

En ese sentido, una de las primeras preguntas que me propuse era ¿Cuáles son los espacios de posibilidad de ser? - ¿Qué espacios de la ciudad son espacios indispensables para tu vida? Si estuviera en amenaza un espacio, lugar, territorio de la ciudad y usted tuviese que defenderlo ¿Cuál sería?

Laura es muy sonriente, su mirada firme habla de años de antaño en los que el GAAT comenzó como un grupo de apoyo entre amigos, quiero escuchar su voz, siempre tan precisa y pertinente. Laura ya no está en esta dimensión, sólo deseo honrar lo que me contaste en esa tarde, que es una parte de tu lucha por una sociedad para todxs.

Aceptaste hablar conmigo y yo no podía estar más contenta y nerviosa. Moon me acompañó y eso hacía que todo fuera más liviano. Pero al entrar por la puerta de la oficina me recibiste con tanta familiaridad como si nos conociéramos de toda la vida y fuéramos a echar rulo.

Es 21 de enero de 2019 Empezamos a conversar y te cuento un poco lo que me proponía a hacer, llenamos los papeles de la investigación. Luego de esto te doy un papel donde está el mapa de Bogotá dividido por localidades y te pido que por favor señales los lugares de posibilidad de ser para personas trans dentro de la ciudad y me dices con total honestidad:

“Lugares donde posiblemente se puede ser entonces que en realidad yo creo que hablar las posibilidades de ser en un entorno tan violento como esta ciudad que está tan jerarquizada es como muy complejo, yo creo que más bien son lugares de hacinamiento más que ser lugares seguros en realidad sino son lugares donde históricamente se han puesto a las personas trans como una forma de decirles ése es el lugar donde ustedes pertenecen más que lugares seguros. Porque por ejemplo, acá estamos entre Mártires y Santa Fé son zonas donde habitan, pues se me ocurrió como un puente, como que estos lugares son lugares donde aunque tampoco es que se pueda ser, pero son lugares donde históricamente han habitado o históricamente no, hace algunos años han vivido las personas trans, pero no porque sea un lugar que realmente represente seguridad sino que han sido lugares que han sido confinadas a vivir las personas trans.”

Me señalas que en toda la ciudad hay personas trans pero no hay un lugar seguro. Cuando te pregunto sobre un lugar que se quiera erradicar o eliminar de la ciudad que merece ser defendido me dices:

“Es que yo creo que no debería haber un lugar, porque el espacio el territorio debe ser para habitarlo todas las personas porque eso es solamente cuando uno les dice es que en ese lugar si podría llegar a habitar, automáticamente le estoy poniendo en un lugar de jerarquización sobre el otro y es que realmente la ciudad es el espacio de todos y

todos habitemos, o sea yo como persona trans no no debería decir, es que este lugar me representa mayor seguridad así como para ninguna mujer, así como para ningún niño, todos los espacios deberían ser seguros para todas y todos, eso es lo que, no sé si eso te pueda dañar un poco la investigación. “

Debo decir que sí me la dañó jaja mentiras, esa conversación con Laura fué ilustradora, amplió mi marco de comprensión, me empecé a preguntar cuál era el sentido de hacer todo esto.

El derecho a la ciudad es el poder de decisión sobre la ciudad, es un derecho que tenemos todxs, es un concepto propuesto por Henri Lefebvre (1967) que surge por promover la participación de la clase obrera a decidir sobre la ciudad, y esto se vincula con los espacios de participación política para personas sexo-género diversas. En segundo lugar, David Harvey (2013) en el libro Ciudades rebeldes del derecho a la ciudad a la revolución urbana nos dice que el derecho a la ciudad es un derecho humano, sin embargo, los derechos humanos tienen una lectura capitalista, ya que, por lo general se han abordado de forma individual y no colectiva; así el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, es por esto, que las organizaciones sociales han sido fundamentales para la garantía de derechos, pareciesen destinados hacia las personas trans, sin embargo, ésta es la trampa de la “inclusión” , los derechos son para todxs.

Relato de Sam (26 años, Manizales):

“Es que la ciudad es pequeña, pero todos, o he dicho una cosa y siempre la digo cuando un muchacho me invita a salir o un amigo, en qué lugar te sientes cómoda y que no te sientas como atosigada o que te vaya a pasar algo. Y yo digo, en el lugar donde esté yo me voy a sentir cómoda porque lo apropio porque es mi lugar y punto porque tengo derecho a estar ahí, cierto, entonces cualquier lugar es para mi. O no Mariana si me dicen vamos a ir a cierta iglesia, obviamente no me metería ahí van y hasta me pueden hacer algo, entonces tampoco es como buscar el peligro y ser muy consciente y prevenida frente a este tipo de situaciones o de pronto me invitan a un barrio peligroso, ya tomo ciertas medidas, ir con estas personas, ir de día, pues no sé.”

Los roles de género asignaron espacios de existencia *“For a woman in my culture there used to be only three directions she could turn: to the church as a nun, to the streets as a prostitute, or to the home as a mother.”* (Anzaldúa. 1987:17), el hogar, la prostitución y la iglesia: santas, putas o madres, son los espacios que ha posibilitado la sociedad para las leídas mujeres. Es así

como la experiencia de las mujeres trans también pasa por la violencia que conlleva habitar el espacio público.

Relato de Rosalía (21 años, Bogotá):

“En realidad siempre he sido una persona muy andrógina, entonces realmente ya pasar a un contexto femenino (no se entiende 19:25-19:30) por ejemplo me han pasado situaciones de acoso en transmilenio más que todo hombres mayores que no se dan cuenta que yo soy trans. Yo he entrado en esa crisis que no sé qué hacer, yo generalmente me alejo, me bajo y espero. Si veo que me está siguiendo pues me bajo y me voy y me vuelvo a meter. Digamos he entrado en esa crisis que no sé qué hacer en ese sentido en cuanto al acoso sexual porque yo digo, yo grito acá y aquí la travesti, la marica. Entonces la gente va a decir -es un invento- porque hay mujeres cisgénero que son las de por si reportan como estás dinámicas así, y no las apoyan, yo porque si super wow no apóyenme (niega la cabeza) (...) Una vez también me pasó una situación, pero no tanto como de acoso sexual, yo estaba subida en Transmilenio y yo estaba esperando y un hombre me empezó a hacer miradas, y yo cuando lo voltee a mirar sino como qué pasa y me sonreía y todo. Yo me baje y él se bajó, luego y me hizo como que habláramos en otra parte, pues yo me devolví y me dijo. pues la verdad me pareces muy linda, no sé qué”.

Cruzar los espacios de estos roles ha sido la lucha feminista, ahora no sólo queremos ocupar los lugares masculinizados, queremos desde el transfeminismo poner sobre la mesa, cuestionar sobre el ordenamiento de la ciudad no sólo por género, sino por clase, etnia, edad. El derecho a la ciudad se relaciona con el derecho a la movilidad humana, los procesos organizativos que emergen de los barrios Santa Fé y la Galería son poderosos, son lugares de protección y cuidado.

El cuidado es no dejarse morir; es no permitir que la indiferencia del Estado y la violencia de la sociedad destruyan nuestras mentes; es encontrar un espacio donde podamos prosperar y crecer. La búsqueda y creación de ese espacio es a lo que muchas personas trans dedican su vida, porque de eso depende. Sus cuerpos se acercan y trabajan juntos. Cocinan y comen juntas. Mientras tanto, se preguntan acerca de lo que les hace falta, y si alguna de ellas falta. Crear ese espacio es el primer paso para alcanzar la libertad y la justicia que las personas trans y no binarias tanto han anhelado. (Rocha, Carlos; Ruiz, Yoko y Salamanca, Juli 2022, p. 6).

Gracias otra vez

Gracias por leer este documento y conversar conmigo, deseo que esta información aporte a vivir una vida auténtica y en libertad. La obra se completa con tu lectura.

Lo que dejo por escrito

No está tallado en granito

Yo apenas suelto en el viento

Presentimientos

Pido lo que necesito

Tinta y tiempo, tinta y tiempo

Tinta y tiempo, tinta y tiempo

Jorge Drexler

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2022) Atención integral en salud para personas trans y no binarias. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/atencion_integral_salud_personas_trans_no_binarias.pdf
- All Out (2021). ¡Por el fin de las terapias de conversión en Colombia! Recurso [en línea]. Disponible en: <https://campaigns.allout.org/es/colombia-conversion-therapy>
- Alonso, I (2020). Cuando la pandemia aprieta: Alejandra y la desatención a las vidas trans. Revista Sentiido. Recurso [en línea]. Disponible en: https://sentiido.com/cuando-la-pandemia-aprieta-alejandra-y-la-desatencion-a-las-vidas-trans/?fbclid=IwAR1T3DQEf-I4eLqs5SEFDezPz4HdhpzpD-yCxKW5iuuQoNW_Sf-dH-PIZNg
- American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. American Psychologist, 70(9), 832-864. <http://dx.doi.org/10.1037/a0039906> Link: <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines-transgender-spanish.pdf>
- American Psychological Association, Boys and Men Guidelines Group. (2018). APA guidelines for psychological practice with boys and men. Retrieved from <http://www.apa.org/about/policy/psychological-practice-boys-men-guidelines.pdf>
- American Psychiatry Association (2022). ¿Qué es la disforia de género? Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria>
- Ángel, K; Daza, L; Maldonado, D; Ruiz, Y; Sánchez, M (2020) Encorazonadas. Memorias Trans desde el Barrio Santa Fe. Instituto Caro y cuarzo: Bogotá.
- Anzaldúa, G. (1996). "To Live in the Borderlands Means You." *Frontiers: A Journal of Women Studies* 17, no. 3 (1996): 4-5. doi:10.2307/3346863.
- Anzaldúa, G. et al. (2004) Otras inapropiables. Traficantes de sueños.
- Anzaldúa, G (2016). "Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan", en: Borderlands/ La frontera. España: Capitan Swing. Disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Giro_descolonizador/Frontera-Gloria_Anzaldua.pdf
- Aparicio-García ME, Díaz-Ramiro EM, Rubio-Valdehita S, López-Núñez MI, García-Nieto I. Salud y bienestar de jóvenes cisgénero, transgénero y no binarios. *Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública* . 2018; 15(10):2133. <https://doi.org/10.3390/ijerph15102133>
- APsaA. (2019). La Asociación Psicoanalítica Estadounidense emite una disculpa atrasada a la comunidad LGBTQ. Disponible en: <https://apsa.org/content/news-apsaa-issues-overdue-apology-lgbtq-community>
- Aquelarre Trans. (2015). Comunicado de prensa: Organizaciones celebran Decreto para que las personas trans puedan cambiar el sexo en sus documentos en notaría y esperan más acciones contra la discriminación. Recurso en línea. Disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0450/pdfs/Anexo_2.pdf
- Aramburu C (2018) Supporting families of transgender children/youth: Parents speak on their experiences, identity, and views, *International Journal of Transgenderism*, 19:2, 132-143, DOI: [10.1080/15532739.2018.1450798](https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1450798)
- Aristegui, Ines. (2015). Cultura y valores en el proceso de discriminación de las personas transgénero. *Journal de ciencias sociales*, 3(5). <https://doi.org/10.18682/jcs.v0i5.458>
- Ashley, F. (2019b). Homophobia, conversion therapy, and care models for trans youth: Defending the gender-affirmative approach. *Journal of LGBT Youth*, 17(4), 361–383. <https://doi.org/10.1080/19361653.2019.1665610>

- Aspin, C., & Hutchings, J. (2007). Reclaiming the past to Inform the Future: Contemporary Views of Maori Sexuality. *Culture, Health & Sexuality*, 9(4), 415–427. <http://www.jstor.org/stable/20460942>
- Augé, M. (sf). Los no lugares del anonimato. Gedisa Editorial.
- Bakker, A., Herrn, R., Taylor, M. T., & Timm, A. F. (2020). *Others of My Kind*. University of Calgary Press. Available from: <https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/57691/9781773851228.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Barrow, K., & Apostle, D. (2018). Addressing mental health conditions often experienced by transgender and gender expansive children. In C. E. Keo-Meier & D. E. Ehrensaft (Eds.), *The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children*. American Psychological Association <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1chrwv9>
- Bastian, B & Haslam, N (2006). Psychological essentialism and stereotype endorsement. *Journal of Experimental Social Psychology* Volume 42, Issue 2, March 2006, Pages 228-235, Scienca Direct, <https://doi.org.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/10.1016/j.jesp.2005.03.003>
- Bauer, G. R. , Hammond, R. , Travers, R. , Kaay, M. , Hohenadel, K. M. & Boyce, M. (2009). “I Don't Think This Is Theoretical; This Is Our Lives”: How Erasure Impacts Health Care for Transgender People. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 20 (5), 348-361.
- BBC (2010) El niño que fue criado como niña. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101125_cambio_genero_sexualidad_men
- BBC. (2022). Christine Jorgensen, la primera mujer famosa por haber sido hombre. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-61884907>
- Berg, D & Edwards-Leeper, L. (2018). Child and family assessment. In C. E. Keo-Meier & D. E. Ehrensaft (Eds.), *The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children* (pp.101–124). American Psychological Association. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1chrwv9>
- Bertalanffy, L. (1994). Teoría general de los sistemas. Bogotá: Fondo de cultura económica.
- Bhugra, D., Eckstrand, K., Levounis, P., Kar, A. y Javate, CR (2016). Declaración de posición de la WPA sobre identidad de género y orientación, atracción y comportamientos hacia el mismo sexo. *Psiquiatría mundial*, 15(3), 299–300. <https://doi.org/10.1002/wps.20340>
- Binetti, M. (2019). La Queerización Postfeminista: Del Constructivismo Trans/Genérico a La Eliminación De Las Mujeres. *La Aljaba, Segunda Epoca. Revista de Estudios de La Mujer*, 23(1), 59–79. Disponible en: <https://search-ebshost-com.banrep.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=146161146&lang=es&site=ehost-live>
- Botero-Rodríguez, Felipe, & Acevedo González, Juan Carlos. (2019). Síndrome de Brown-Séquard desde su descubrimiento. *Universitas Medica*, 60 (2), 58-66. <https://doi.org/10.11144/javeriana.umed60-2.sequ>. Disponible también en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-08392019000200058
- Bränström, R., Stormbom, I., Bergendal, M., & Pachanakis, J. (2022). Transgender-based disparities in suicidality: A population-based study of key predictions from four theoretical models. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 52, 401–412 <https://doi.org/10.1111/sltb.12830>
- Britzman, D (2002). *La pedagogía transgresora y sus extrañas técnicas*. En: Rafael Mérida Giménez (Ed.) *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer*. España: Icaría. Pp. 197-228.

- Brown, E. & Mar, K. (2018). Culturally responsive practice with children of color. In Keo-Meier, C. and Ehrensaft, D., (Eds), *The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children*. American Psychological Association.
- Butler, J. (1988). *Performative Acts and gender constitution. An essay in phenomenology and feminist theory*. Theatre Journal, 40 (4), 519-531.
- Butler, J. (2001). "Sujetos de sexo/género/deseo". En: *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós, UNAM-PUEG. México.
- Butler, J (1999). *Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity*. Routledge, Nueva York.
- Butler, J (2001). "Sujetos de sexo/género/deseo". En: *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós, UNAM-PUEG. México.
- Butler (2002) *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. -1 ed. - Buenos Aires - Paidós.
- Butler, J. (1988). *Performative Acts and gender constitution. An essay in phenomenology and feminist theory*. Theatre Journal, 40 (4), 519-531.
- Caicedo, A (2008). *Calicalabozo*. Carvajal Education.
- CAMBIO (9 de abril de 2023). Entrevista a Carolina Corcho [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=jsK1gDc6zSo>
- Caicedo, A. (1969). *Besacalles*. Recurso en línea. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/260950159/Besacalles-de-Andres-Caicedo>
- Canner JK, Harfouch O, Kodadek LM, et al. Tendencias temporales en la cirugía de afirmación de género entre pacientes transgénero en los Estados Unidos. *Cirugía JAMA*. 2018;153(7):609–616. doi:10.1001/jamasurg.2017.6231. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2673384>
- Caribe Afirmativo (2016). *Wanejána Wayaa, una fundación indígena LGBTI en Colombia*. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://caribeafirmativo.lgbt/wanejana-wayaa-una-fundacion-indigena-lgbti-en-colombia/>
- Caribe Afirmativo (2023). En EE.UU. incrementan políticas anti-derechos LGBTIQ+ y de invaludación de las identidades trans. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://caribeafirmativo.lgbt/en-ee-uu-incrementan-politicas-anti-derechos-lgbti-y-de-invalidacion-de-las-identidades-trans/>
- Caro, F (2022). *Los Felipitos. Revisionismo e historia queer de Colombia*. Revista Transhumante Núm 20. Universidad de Antioquia. DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n20a04>
- Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (2012). *Vínculos, individuación y ecología humana, hacia una psicología clínica compleja*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud , vol. 10, núm. 1, págs. 687-689. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77323982046>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). *Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano*. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID - OIM.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). *Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano*. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID - OIM.

- Charbonnier, Elodie & Graziani, Pierluigi (2016) El estrés asociado con el proceso de salida del armario en la población de adultos jóvenes, *Journal of Gay & Lesbian Mental Health*, 20:4, 319-328, DOI: [10.1080/19359705.2016.1182957](https://doi.org/10.1080/19359705.2016.1182957)
- Chen, D., Hidalgo, M. A., Leibowitz, S., Leininger, J., Simons, L., Finlayson, C., & Garofalo, R. (2016). Multidisciplinary care for gender-diverse youth: A narrative review and unique model of gender-affirming care. *Transgender Health*, 1(1), 117–123 <https://doi.org/10.1089/trgh.2016.0009>
- Choi S, Divasalar S, Flórez-Donado J, Kittle K, Lin A, Mayer I, Torres-Salazar P (2019). Estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia. Resultados de una encuesta nacional. Williams Institute. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/Academics/1912_Colombia_Report_Spanish_FINAL.pdf
- CIDH Comunicado de prensa No. 153A/14 (2014) Una mirada a la violencia contra personas LGBTI: Un registro que documenta actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, Anexo al Comunicado de Prensa No. 153/14. 17 de diciembre de 2014. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/Anexo-Registro-Violencia-LGBTI.pdf>
- Cohn, J (2022) Some Limitations of “Challenges in the Care of Transgender and Gender-Diverse Youth: An Endocrinologist’s View”, *Journal of Sex & Marital Therapy*, DOI: [10.1080/0092623X.2022.2160396](https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2160396)
- Colombia Diversa. (2016). Encuesta de clima escolar LGBT en Colombia. Recurso [en línea]. Disponible en: <http://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2016/11/IAE-Colombia-Web-FINAL-2.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Documentos oficiales OEA. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf>
- Cooper, Marty; Jung, Seojung & Gordon, Jamie (2022) Identity Process Treatment Model for Transgender and Gender Nonconforming Clients, *Studies in Gender and Sexuality*, 23:2, 112-122, DOI: [10.1080/15240657.2022.2072574](https://doi.org/10.1080/15240657.2022.2072574)
- Córdoba, Ángela H., & León, F. B. (2015). VÍNCULOS, REDES Y ECOLOGÍA. *Hallazgos*, 1(1). <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2004.0001.08>
- Córdoba,D; Sáez,J & Vidarte,P. (2005). Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Segunda edición. Madrid: Editorial Egales
- Corte Constitucional, Sentencia T-771 de 2013. M.P. Maria Victoria Calle Correa. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-771-13.htm>
- Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2022. M.P. Cristina Pardo Schleseinger. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-033-22.htm>
- Cox P, Carrasco MA. Disforia de género en niños y controversias en su tratamiento: dos concepciones distintas sobre la identidad de género. *Pers bioet*. 2020;24(1):57-76. DOI: <https://doi.org/10.5294/pebi.2020.24.1.5>
- Crocetti, D., Monro, S., Vecchietti, V., & Yeadon-Lee, T. (2020). Towards an agency-based model of intersex, variations of sex characteristics (VSC) and DSD/dsd health. *Culture, Health & Sexuality*, 23(4), 500–515 <https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1825815>
- Curiel, R. A. (2021). Mujeres rifle: Masculinidad femenina en el evento fotográfico de la Revolución Mexicana. *Hispania*, 104(2), 169–185. <https://www.jstor.org/stable/27095255>

- Dávila, X & Maturana, H. (2021). La revolución reflexiva : una invitación a crear un futuro de colaboración (Cuarta edición.). Paidós.
- Delgado-Acosta, Elena; Betancor, Verónica; Rodríguez-Pérez, Armando & Delgado, Naira (2016) Creencias esencialistas sobre diferentes categorías relacionadas con la sexualidad, *International Journal of Social Psychology*, 31:1, 1-28, DOI: [10.1080/02134748.2015.1101311](https://doi.org/10.1080/02134748.2015.1101311)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2019) Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas.
- Despentes, V.(2008). Teoría King Kong. Barcelona: Editorial Merlusina
- Devor, A. (2004). Witnessing and mirroring: A fourteen stage model of transsexual identity formation. *Journal of Gay & Lesbian Mental Health*, 8(1), 41–67. <https://doi.org/10.1080/19359705.2004.9962366>
- Deutsch, Madeline (2012) Uso del modelo de consentimiento informado en la provisión de terapia hormonal cruzada: una encuesta de las prácticas de clínicas seleccionadas, *International Journal of Transgenderism*, 13:3, 140-146, DOI: [10.1080/15532739.2011.675233](https://doi.org/10.1080/15532739.2011.675233)
- Dietz, Elizabeth (2021) Normal parents: Trans pregnancy and the production of reproducers, *International Journal of Transgender Health*, 22:1-2, 191-202, DOI: [10.1080/26895269.2020.1834483](https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1834483)
- Dozono, T. (2017). Teaching Alternative and Indigenous Gender Systems in World History: A Queer Approach. *The History Teacher*, 50(3), 425–447. <http://www.jstor.org/stable/44507259>
- Drabish, K y Theeke, L (2022) Impacto en la salud del estigma, la discriminación, los prejuicios y los prejuicios que experimentan las personas transgénero: una revisión sistemática de los estudios cuantitativos. *Problemas de enfermería de salud mental*, 43:2, 111-118, DOI: [10.1080/01612840.2021.1961330](https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1961330) Link: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01612840.2021.1961330>
- Drescher, Jack (2023) Informed Consent or Scare Tactics? A Response to Levine et al.'s "Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults", *Journal of Sex & Marital Therapy*, 49:1, 99-107, DOI: [10.1080/0092623X.2022.2080780](https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2080780)
- Dueña, L (2011). Descripción epidemiológica del fenómeno de violencia interpersonal. Colombia, 2011. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá.
- Duperly, E (2014). Benjamín de la calle, enamorado de la imagen. El extraño caso de la mujer-hombre. *Revista Arcadia*. .Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.revistaarcadia.com/impresa/especial/articulo/el-extrano-caso-mujer-hombre/37704>
- E. Coleman, AE Radix, WP Bouman, GR Brown, ALC de Vries, MB Deutsch, R. Ettner, L. Fraser, M. Goodman, J. Green, AB Hancock, TW Johnson, DH Karasic, GA Knudson, SF Leibowitz , HFL Meyer-Bahlburg, SJ Monstrey, J. Motmans, L. Nahata, TO Nieder, SL Reisner, C. Richards, LS Schechter, V. Tangpricha, A. C. Tishelman, MAA Van Trotsenburg, S. Winter, K. Ducheny, NJ Adams, T. M. Adrián, LR Allen, D. Azul, H. Bagga, K. Başar, DS Bathory, JJ Belinky, D. R. Berg, JU Berli, RO Bluebond-Langner, M.-B. Bouman, ML Bowers, PJ Brassard, J. Byrne, L. Capitán, CJ Cargill, JM Carswell, SC Chang, G. Chelvakumar, T. Corneil, KB Dalke, G. De Cuypere, E. de Vries, M. Den Heijer , AH Devor, C. Dhejne, A. D'Marco, EK Edmiston, L. Edwards-Leeper, R. Ehrbar, D. Ehrensaft, J. Eisfeld, (2022) Estándares de atención para la salud de personas transgénero y de género diverso, versión 8, *International Journal of Transgender Health*, 23:sup1, S1-S259, DOI: [10.1080/26895269.2022.2100644](https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644)
- Ehrensaft, D., Giammattei, S. V., Storck, K., Tishelman, A. C., & Keo-Meier, C. (2018). Prepubertal social gender transitions: What we know; what we can learn—A view from a gender affirmative lens. *International Journal of Transgenderism*, 19(2), 251–268.
- Eisenberg, M. E., McMorris, B. J., Rider, G. N., Gower, A. L., & Coleman, E. (2020). "It's kind of hard to go to the doctor's office if you're hated there." A call for gender-affirming care from transgender

and gender di-verse adolescents in the United States. *Health & Social Care in the Community*, 28(3), 1082–1089 <https://doi.org/10.1111/hsc.12941>

-El Espectador. (2016). La explosiva carta de Viviane Morales contra la ministra Gina Parody. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/politica/explosiva-carta-de-viviane-morales-contraministra-gina-articulo-648486>

-El Espectador (2018). *Mataron a una trans...y a su familia*. Usted podrá encontrar el documental completo en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=gfTw-lDdY-o>

-El Tiempo (2016). Cartilla sobre discriminación sexual en colegios dividió el país.

-El Tiempo (2022). Mike Durán, el primer colombiano con la ‘T’ de trans en su cédula. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mike-duran-primera-cedula-colombiana-con-letra-t-de-una-persona-trans-659280>

-Espert, R. (2010). Las jacas: Hembras insaciables. [Archivo de Video]. Recuperado de: <https://www.dailymotion.com/video/xdxch4>

-Federici, S. (2004) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Editorial Traficantes de Sueños: España. Disponible en: <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf>

-Foucault, M (2009). Vigilar y castigar. Cap 3. El panóptico. Siglo XXI.

-Foucault, M (2019). Historia de la sexualidad 4: Las confesiones de la carne. Siglo XXI de España Editores: España. Disponible en: https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Michel%20Foucault%20-%20Historia%20de%20la%20sexualidad%20IV.%20Las%20confesiones%20de%20la%20carne.pdf

-Gaard, Greta. (2011). Rumo ao ecofeminismo queer Towards a queer ecofeminism. *Estudios feministas*, 19(1), 197–223. <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000100015>

-Gallagher, N & Bodenhausen. G (2021). Gender essentialism and the mental representation of transgender women and men: A multimethod investigation of stereotype content. Kellogg School of Management, Marketing Department, USA. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104887>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/basesbiblioteca.uexternado.edu.co/science/article/pii/S0010027721003103?via%3Dihub>

-Gómez, A. (2008). Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos. Una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de oportunidad y la política cultural. Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana.

-García Becerra, A (2009). Tacones, siliconas, hormonas y otras críticas al sistema sexo-género. *Feminismos y experiencias de transexuales y travestis*. *Revista Colombiana de Antropología*, 45 (1), 119-146. [fecha de Consulta 27 de Enero de 2023]. ISSN: 0486-6525. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105012398005>

-García, M. Ortiz, A y Prats, M (eds.) (sf). Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para ciudades inclusivas. Editorial Icaria.

-García, M; Ortiz, A & Prats, M (eds.) (sf). Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para ciudades inclusivas. Editorial Icaria.

-Gargallo, F (2014). *Feminismos desde Abya Yala*. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Editorial Corte y Confección, Ciudad de México. Disponible en: <https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>

-Gauguin, P (2020). *Noa Noa*. Libro traducido por Luise Wolf del proyecto Gutenberg. Libro [en línea]. Disponible en: <https://www.gutenberg.org/files/62800/62800-h/62800-h.htm>

- Gergen Kenneth J (2007). Construcciónismo social, aportes para el debate y la práctica / Kenneth Gergen; traductor y compilador, Angela María Estrada Mesa, Silvia Díazgranados Ferrás — Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología, CESO, Ediciones Uniandes. Disponible en: https://www.taosinstitute.net/images/PublicationsFreeBooks/Gergen_construccionismo_social.pdf
- Giraldo Botero, C. (2001). *Homoerotismo femenino en la Nueva Granada (1745-1822)*. Disponible en el siguiente enlace: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/53100/Homoerotismo%20femenino.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Gonzales, G (2014). Disputas de la disidencia sexual latinoamericana. Sujetos y Teorías. Disponible en: http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.2014_eje_6_ortuno.pdf
- González M (2017). Diversidad y transformación social. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NELDFEaBxCY&t=427sc>
- González R., R. (1943). Un caso de hermafroditismo. *Revista De La Facultad De Medicina*, 11(12), 710–714. Recuperado a partir de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/24634>
- Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo editorial norma.
- Harvey, D (2013). Ciudades rebeldes del derecho a la ciudad a la revolución urbana. España: Ediciones Akal.
- Haslam, N., Rothschild, L. y Ernst, D. (2000). Creencias esencialistas sobre las categorías sociales. *Revista británica de psicología social*, 39, 113 – 127. doi: 10.1348/014466600164363
- Herek, G. y Capitanio, J. (1995). Las actitudes de los heterosexuales negros hacia las lesbianas y los hombres homosexuales en los Estados Unidos. *Revista de Investigación Sexual*, 32, 95 – 105. doi: 10.1080/00224499509551780
- Hernández, F & Pujol, J. (2016). Geopolitics and the body. Privacy among men and state sponsored homophobia in Africa. *Alteridades*, México, v. 26, n. 52, p. 107-115. Recurso [en línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172016000200107&lng=en&nrm=iso
- Hernandez, J, Chávarri, L & Vinay, S. (2022). Muxes [Documental]. HBO Productora.
- Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual frame-work for clinical work with transgender and gender non-conforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. *Professional Psychology: Research and Practice*, 43(5), 460–467 <https://doi.org/10.1037/a0029597>
- Herrera, C y Torres, S. (2018 A). De la patologización a la politización de las identidades de género diversas. El rol de los profesionales de la salud en los tránsitos de género. *Anamnesis Revista de Bioética*, Bogotá (Colombia), N° 13. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/1728506/5453420/anamnesis_13.pdf/32a08c20-eb3a-521d-04e6-a00c61903759?t=1651168728350
- Herrera, C y Torres, S. (2018 B). ¿Cómo se configura el malestar de género en personas trans? Sistematización de las comprensiones de LIBERARTE. *Anamnesis Revista de Bioética*, Bogotá (Colombia), N° 13. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/1728506/5453420/anamnesis_13.pdf/32a08c20-eb3a-521d-04e6-a00c61903759?t=1651168728350
- Hidalgo, M. A., Ehrensaft, D., Tishelman, A. C., Clark, L. F., Garofalo, R., Rosenthal, S. M., Spack, N. P., & Olson, J. (2013). The gender affirmative model: What we know and what we aim to learn. *Human Development*, 56(5), 285–290. <https://doi.org/10.1159/000355235>
- Jahromi, Alireza; Horen, Sydney; Dorafshar, Ami; Seu, Michelle; Radix, Asa; Anderson, Erica; Green, Jamison; Fraser, Lin; Johannesson, Liza; Testa, Giuliano & Schechter, Loren (2021) Trasplante uterino y donación en personas transgénero; prueba de concepto, *International Journal of Transgender Health*, 22:4, 349-359, DOI: 10.1080/26895269.2021.1915635 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15532739.2019.1599764?src=recsys>

- Houck, J (2003). "What Do These Women Want?": Feminist Responses to "Feminine Forever", 1963-1980. *Bulletin of the History of Medicine*, 77(1), 103-132. <http://www.jstor.org/stable/44447695>
- Jácome, A. (2019). Descubrimiento de la testosterona. *Revista Colombiana De Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 6 (3), 231-235. <https://doi.org/10.53853/encr.6.3.538>
- Katyal, S. K. (2017). The "Numerus Clausus" of Sex. *The University of Chicago Law Review*, 84(1), 389-494. <http://www.jstor.org/stable/44211837>
- Katz-Wise, S; Mereish, E & Woulfe, J. (2017). Associations of Bisexual-Specific Minority Stress and Health Among Cisgender and Transgender Adults with Bisexual Orientation, *The Journal of Sex Research*, 54:7, 899-910, DOI: 10.1080/00224499.2016.1236181
- Kennis M, Duecker F, T'Sjoen G, Sack A, Dewitte M (2022) Mental and sexual well-being in non-binary and genderqueer individuals, *International Journal of Transgender Health*, 23:4, 442-457, DOI: 10.1080/26895269.2021.1995801
- Keo-Meier, C. L., & Ehrensaft, D. (2018). Introduction to the gender affirmative model. In C. Keo-Meier & D. Ehrensaft (Ed.), *The gender affirmative model: An inter-disciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children* (pp. 3-19). Washington, DC: American Psychological Association
- Klotz, L. P. (1950). Diagnóstico del sexo del feto durante el embarazo. *Revista colombiana de obstetricia y ginecología*, 1(2).
- Krieger, N (2020). Measures of Racism, Sexism, Heterosexism, and Gender Binarism for Health Equity Research: From Structural Injustice to Embodied Harm—An Ecosocial Analysis. *Revisión Anual de Salud Pública* 41 : 1 , 37-62. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094017>
- Lambda Legal, When Health Care Isn't Caring Lambda Legal's: Survey on Discrimination against LGBT People and People Living with HIV [Cuando el cuidado de salud no es cuidado. Encuesta de Lambda Legal sobre la discriminación contra las personas LGBT y personas viviendo con VIH], 2010, pág. 10
- Latour, B. (2017). Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. *Papers: Revista de Sociología*, 3.
- Lefebvre, H. (1975). El derecho a la ciudad. 3.a ed. Barcelona: Península. [1967].
- Leibowitz S, Green J, Massey R, Boleware A, Ehrensaft D, Francis W, Keo-Meier C, Olson-Kennedy A, Pardo S, Rider N, Schelling E, Segovia A, Tangpricha V, Anderson E, T'Sjoen G & on behalf of the WPATH, USPATH, and EPATH Executive Committee and Board of Directors (2020) Statement in response to calls for banning evidence-based supportive health interventions for transgender and gender diverse youth, *International Journal of Transgender Health*, 21:1, 111-112, DOI: [10.1080/15532739.2020.1703652](https://doi.org/10.1080/15532739.2020.1703652)
- Lev, A. I. & Wolf-Gould, C. (2018). Collaborative treatment across disciplines. In C. E. Keo-Meier & D. E. Ehrensaft (Eds.), *The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children*. American Psychological Association <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1chrwv9>
- Levine, Stephen; Abbruzzese, E & Mason, Julia (2022) Reconsideración del consentimiento informado para niños, adolescentes y adultos jóvenes identificados como trans, *Journal of Sex & Marital Therapy*, 48:7, 706-727, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2046221
- Levine, Stephen; Abbruzzese, E & Mason, Julia (2023) ¿Qué les estamos haciendo a estos niños? Respuesta a los comentarios de Drescher, Clayton y Balon sobre Levine et al., 2022, *Journal of Sex & Marital Therapy*, 49:1, 115-125, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2136117

- Loaiza M, Martínez K, Rodríguez L (2020). Afectación de la discriminación sobre los derechos económicos y sociales de las mujeres transgénero en el municipio de Sincelejo, Sucre. Corporación Universitaria del Caribe. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.cecar.edu.co/bitstream/handle/cecar/2636/AFFECTACI%C3%93N%20DE%20LA%20DISCRIMINACI%C3%93N%20SOBRE%20LOS%20DERECHOS%20ECON%C3%93MICOS%20Y%20SOCIALES%20DE%20LAS%20MUJERES%20TRANSG%C3%89NERO%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20SINCELEJO%2C%20SUCRE..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- López, Silvia. (2020). El ecofeminismo en Vandana Shiva. Dos Bigotes. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://uniandes-odilok-es.ezproxy.uniandes.edu.co/info/01169609>
- Lytle, MC, Blossich, JR y Kamen, C. (2016). La asociación de identidades múltiples con violencia autodirigida y depresión entre personas transgénero. *Comportamiento suicida y que amenaza la vida* , 46 (5), 535 – 544 . doi: 10.1111/sltb.12234.
- Manifiesta Media (2022) Suicidio en Colombia: 81% de las víctimas en 2021 fueron hombres. Manifiesta Org. Artículo [en línea]. Disponible en: <https://manifiesta.org/suicidio-en-colombia-las-victimas-en-2021-fueron-hombres/>
- Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición, Texto Revisado (DSM-5-TR) . Asociación Americana de Psiquiatría. 2022
- Matsuno E, Webb, A, Hashtpari H, Budge S, Krishnan M, Basam, K. (sf). Nonbinary fact sheet. The society for the psychology of the sexual orientation and gender diversity. Disponible en: https://www.apadivisions.org/division-44/resources/nonbinary-fact-sheet.pdf?_ga=2.75671125.1909719616.1679831461-1295627599.1673287350
- Mayor, AB (2016). Experiencias de adultos mayores transgénero y de género no conforme en psicoterapia: un estudio cualitativo. *Psicología de la Orientación Sexual y la Diversidad de Género*, 3 (2), 180–186. <https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1037/sgd0000154>
- McCallion, S., Smith, S., Kyle, H., Shaikh, M. G., Wilkinson, G., & Kyriakou, A. (2021). An appraisal of current service delivery and future models of care for young people with gender dysphoria. *European Journal of Pediatrics*, 180(9), 2969–2976. <https://doi.org/10.1007/s00431-021-04075-2>.
- McDowell, L. (2000). Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: Ediciones Cátedra.
- McDowell, L. (2000). Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: Ediciones Cátedra.
- McLaughlin, R. J., & Sharp, R. N. (2018). Working with parents/guardians and caregivers when conflicts arise. In C. Keo-Meier & D. Ehrensaft (Eds.), *The gender affirmative model: An Interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children* (pp. 157–172). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000095-009>
- Mejía, J. A. (2021). *Una perspectiva bioética a la medicalización y patologización de las personas transgénero*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/58186>.
- Mendoza, Abril; Merchán, A & Ricardo Y (2019). *Modelo de prestación de servicios de salud con enfoque diferencial para personas con experiencia de vida trans en una IPS de Salud Sexual y Salud Reproductiva*. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/handle/unicolmayor/3540/Modelo%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicios%20de%20salud%20con%20enfoco%20diferencial%20%281%29%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mieli, M. (1977). Elementos de crítica homosexual. Anagrama: Barcelona.

- Ministerio de Justicia. (2019). Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/PublicacionesMinJusticia/Documento%20Criterios%20de%20Justicia%20Inclusiva.pdf>
- Ministerio del interior & PAIS (2018). Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas trans*: un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención humanizada de personas trans* en Colombia. Bogotá: Ministerio del interior.
- Minuchin, S. (2005). Familias y terapia familiar. España: Editorial Gedisa.
- Mizock, L., & Lundquist, C. (2016). Missteps in psychotherapy with transgender clients: Promoting gender sensitivity in counseling and psychological practice. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 3(2), 148–155. <https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1037/sgd0000177>
- Money, J. (1973). Sexology: Behavioral, Cultural, Hormonal, Neurological, Genetic Etc. *The Journal of Sex Research*, 9(1), 2–10. <http://www.jstor.org/stable/3811442>
- Money, J. (2003). History, Causality, and Sexology. *The Journal of Sex Research*, 40(3), 237–239. <http://www.jstor.org/stable/3813318>
- Moody, C., & Smith, N. G. (2013). Suicide protective factors among trans adults. *Archives of sexual behavior*, 42(5), 739–752. <https://doi.org/10.1007/s10508-013-0099-8>
- Morrison, M.A., Bishop, C.J., Morrison, T.G. (2018). What is the best measure of discrimination against trans people?: A systematic review of the psychometric literature *Psychology and Sexuality*, 9 (3), pp. 269-287. Cited 8 times
- Morrison, Melanie; Bishop, CJ & Morrison, Todd (2019) A Systematic Review of the Psychometric Properties of Composite LGBT Prejudice and Discrimination Scales, *Journal of Homosexuality*, 66:4, 549-570, DOI: 10.1080/00918369.2017.1422935
- Murray, D. A. B. (2003). Who Is Takatāpui? Māori Language, Sexuality and Identity in Aotearoa/New Zealand. *Anthropologica*, 45(2), 233–244. <https://doi.org/10.2307/25606143>
- Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del alto Comisionado. (2020). Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/stories/2020/07/conversion-therapy-can-amount-torture-and-should-be-banned-says-un-expert>
- Observatorio de la política pública LGBT (2017). Encuesta Bienal de Culturas 2015 principales resultados sobre sectores sociales LGBTI en Bogotá. Boletín número 13. Recurso [en línea]. Disponible en: <http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticapoliticasyLGBTI/Observatorio/Boletin%2013%20ENCUESTA%20BIENAL%20DE%20CULTURAS.pdf>
- Oquendo-Villar, Carmen. (30 de mayo 2016). “Teaser” documental “Diana de Santa Fe” Documental [en línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=L5vIqXlbsII>
- Organización Panamericana de la Salud (sf). Determinantes sociales de la salud. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
- Organización Panamericana de la Salud. (2011). POR LA SALUD DE LAS PERSONAS TRANS Elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe. Disponible en: <https://www3.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf>
- Páez J, Hevia G, Pesci F, Rabbia H (2015). Construcción y validación de una escala de actitudes negativas hacia personas trans. *Revista de Psicología* Vol. 33 (1). Universidad Nacional de Córdoba-Argentina.
- PARCES ONG (2016). Ley entre comillas. Bogotá. Recurso [en línea]. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B7kzpd_g1V21cm5FWjR3cGdRWtQ/view?usp=sharing

- Parker, Ian (2010). *La psicología como ideología*, Catarata: Madrid.
- Pinna, F; Paribello, P; Somaini, G; Corona, A; Ventriglio, A; Corrias, C; Frau, I; Murgia, R; Kacemi, S; Galeazzi, G; Mirandola, M; Amaddeo, F; Crapanzano, A; Converti, M; Piras, P; Suprani, F; Manchia, M; Fiorillo, A; Carpiniello, B & The Italian Working Group on LGBTQI Mental Health (2022) Salud mental en personas transgénero: una revisión sistemática, *International Review of Psychiatry*, 34:3-4, 292-359, DOI: 10.1080/09540261.2022.2093629. Link: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09540261.2022.2093629?needAccess=true&role=button>
- Pollock, Lealah & Eyre, Stephen (2012) Growth into manhood: identity development among female-to-male transgender youth, *Culture, Health & Sexuality*, 14:2, 209-222, DOI: [10.1080/13691058.2011.636072](https://doi.org/10.1080/13691058.2011.636072)
- Potter, E (2001). *Gender and Boyle's Law of Gases*. Indiana University Press.
- Pratto, F. y Stewart, AL (2012). El dominio del grupo y la semiciguera del privilegio . *Revista de Cuestiones Sociales* , 68, 28 – 45 . doi: 10.1111/j.1540-4560.2011.01734.x [Referencia cruzada] , [Web of Science ®], [Google Académico]
- Preciado, P B. (2003). *Multitudes queer. Notas para una política de “los anormales”*.
- Preciado, P B (2008). *Testo Yonki*. Espasa: España. Disponible en: <https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/preciado-testo-yonqui.pdf>
- Preciado, P. (2013). ¿Quién defiende al niño queer? El País. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://paroledequeer.blogspot.com/2014/08/quien-defiende-al-nino-queer-paul-preciado.html>
- Preciado, P (2019). *Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce*. Editorial Anagrama, Barcelona.
- Preciado, P (2020). *Yo soy el monstruo que os habla*. Informe para una academia de psicoanalistas. Editorial Anagrama: España. Disponible en: https://desprendidacom.files.wordpress.com/2021/09/preciado_yo-soy-el-monstruo-que-os-habla.pdf
- Preciado, P. (2022). *Dysphoria mundi*. Editorial Anagrama.
- Prieto, S. (2017). Reflexiones sobre el género, el cuerpo y el poder: cinco voces trans en diálogo con Judith Butler. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. *Revista Multitudes*, N° 12. Disponible en: <http://www.hartza.com/anormales.htm>
- Quintero, Inés, *Mirar tras la ventana, Testimonios de Viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo XIX*. Transcripción de Boussingault (1822-23), Alter Libris y secretaria UCV, p. 158. Disponible en el siguiente enlace: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/53100/Homoerotismo%20femenino.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Rachlin, K. (2022). Confianza en la incertidumbre: la estructura terapéutica de la posibilidad, los puntos de inflexión y el futuro de la psicoterapia con personas transgénero, no binarias y de género diverso. *Estudios de género y sexualidad*, 23 (2), 93–101. <https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1080/15240657.2022.2072572>
- Radi, Blas y Sardá-Chandiramani, Alejandra (2016). *Travestimiento / transfeminismo: Coordenadas para pensar los crímenes de travestis y mujeres trans en Argentina*. Publicación en el Boletín del Observatorio de Género.
- Rad MS, Shackleford C, Lee KA, Jassin K, Ginges J (2019) Teorías populares de género y actitudes antitransgénero: diferencias de género y preferencias políticas. *PLoS ONE* 14(12): e0226967. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226967>
- Rahim, Z. (2017). *Bebé canadiense recibe tarjeta de atención médica sin sexo definido*. Noticias CNN. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/05/bebe-canadiense-recibe-tarjeta-de-atencion-medica-sin-sexo-definido/>

- Reisner, SL, Bradford, J., Hopwood, R. *et al.* Atención médica integral para personas transgénero: el modelo clínico y de salud pública que afirma el género de Fenway Health. *J Urban Health* 92, 584–592 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11524-015-9947-2>
- Rider, Nic; Vencill, Jennifer; Berg, Dianne; Becker-Warner, Rachel; Candelario-Pérez, Leonardo & Spencer, Katherine (2019) The gender affirmative lifespan approach (GALA): A framework for competent clinical care with nonbinary clients, *International Journal of Transgenderism*, 20:2-3, 275-288, DOI: [10.1080/15532739.2018.1485069](https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1485069)
- Rocha, Carlos; Ruiz, Yoko y Salamanca, Juli (2022). El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas*: prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal. *Liga de Salud Trans*: Bogotá D.C.
- Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: Notas sobre la economía política del sexo. *Revista Nueva antropología*, noviembre, año/vol VIII, número 030. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. pp.95-145.
- Rubin, Gayle (1996): El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política del sexo". en *La construcción cultural de la diferencia sexual*, comp. Marta Lamas, México DF: UNAM. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/159/15903007.pdf>
- Sayegh, R., Awwad, JT (2017). Cinco décadas de investigación en terapia hormonal: lo largo, lo corto y lo no concluyente. En: Pal, L., Sayegh, R. (eds) *Essentials of Menopause Management*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42451-4_2
- Schnitman, D (2010). Perspectiva generativa en la gestión de conflictos sociales. *Revista de Estudios Sociales* No. 36. pp 51-63.
- Scott, J. (1996). “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, James y Amelang y Mary Nash (eds.), Edicions Alfons el Magnanim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990. La traducción es de Eugenio y Marta Portela. Recurso [en línea]. Disponible en: https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_economicos_sociales_culturales_genero/El%20Genero%20Una%20Categoria%20Util%20para%20el%20Analisis%20Historico.pdf
- Sennett R (1984) *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Alianza Editorial.
- Sierra Osorio, AM, Rivera, MA, & Tovar, H. (2018). Género disfórico/género incongruente. *Terapia hormonal en adultos*. *Revista Colombiana De Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 5 (4), 32–36. <https://doi.org/10.53853/encr.5.4.452>
- Sor Juana Ines de la Cruz. (1994). *Obra Selecta I*. Biblioteca Ayacucho AGN, Colonia, Criminales T. 96. f. 2 19r., 1803. Disponible en: <https://biblioteca.org.ar/libros/211689.pdf>
- Sosa Villada, Camila (2019). *Las Malas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tusquets Editores.
- Starhawk (2003). *Femmes, magie et politique. Les emprecheurs de penser en rond*. Paris.
- Sterling, J., & Garcia, M. M. (2020a). Cancer screening in the transgender population: A review of current guide-lines, best practices, and a proposed care model. *Translational Andrological Urology*, 9(6), 2771–2785. <https://doi.org/10.21037/tau-20-954>
- Suárez, Á. G. (2010). Los sistemas sexo/género en distintas sociedades: modelos analógicos y digitales/Sex/Gender Systems in Different Societies: Analogical and Digital Models. *Reis*, 130, 61–96. <http://www.jstor.org/stable/27799048>
- Swigger, N., & Meyer, M. (2019). Gender essentialism and responses to candidates' messages. *Political Psychology*, 40(4), 719-738. doi:10.1111/pops.12556. Disponible en: <https://www.scopus-com.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057477657&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Gender+Essentialism+and+Responses+to+Candidates%e2%80%99+Messages&sid=507f613290>

[3fd9a6080b8eb7875e3bc4&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Gender+Essentialism+and+Responses+to+Candidates%e2%80%99+Messages%29&relpos=0&citeCnt=9&searchTerm=](https://www.academia.edu/44068303/VOLVER_AS%C3%8D_DE_WERA_FA_A_TRAVIESAS_ALEGOR%C3%8DAS_TRANS SOBRE MUJERES EMBERA EN SANTUARIO RISARALDA)

-Tabares, J (2019). Volver así de Wera Fa a Traviesas. Alegorías Trans sobre mujeres en Santuario Risaralda. Universidad de Caldas. Disponible en: https://www.academia.edu/44068303/VOLVER_AS%C3%8D_DE_WERA_FA_A_TRAVIESAS_ALEGOR%C3%8DAS_TRANS SOBRE MUJERES EMBERA EN SANTUARIO RISARALDA

-Talero, M. (2006). Utopía del ser. En Serrano, J. Otros cuerpos, otras sexualidades. (pp. 34-53). Bogotá: Instituto Pensar, Universidad Javeriana. Recurso en línea. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/48707/1/9586838943.pdf>

-Tangpricha, V., & den Heijer, M. (2017). Oestrogen and anti-androgen therapy for transgender women. *Lancet Diabetes & Endocrinology*, 5(4), 291–300 [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(16\)30319-9](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30319-9)

-Tebbe, EA, Simone, M., Wilson, E. y Hunsicker, M. (2022). Una visibilidad peligrosa: efectos moderadores de los esfuerzos legislativos antitrans en la salud mental trans y de género diverso. *Psicología de la Orientación Sexual y la Diversidad de Género*, 9 (3), 259–271. <https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1037/sgd0000481>

-Thurston I, Alegría M, Hood K, Miller G, Wilton L, Holden K (2023). How Psychologists Can Help Achieve Equity in Health Care—Advancing Innovative Partnerships and Models of Care Delivery: Introduction to the Special Issue. *American Psychological Association*. Vol. 78, No. 2, 73–81 ISSN: 0003-066X <https://doi.org/10.1037/amp0001153>

-Truth, S; Wells, I ; Hill Collins, P; Davis, A; Stack, C; Carby, H; Parmar, P; Ifekwunigwe, J; Lygate, M .(2012) *Feminismos negros. Una antología. Traficantes de sueños Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos* (2014). Edición Txalaparta.

-Toro, M (sf). Histórico: Representante Mauricio Toro, radica proyecto de ley para ponerle fin a las mal llamadas “Terapias de Conversión”, una forma de tortura contra la diversidad. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.mauriciotoro.co/historico-representante-mauricio-toro-radica-proyecto-de-ley-para-ponerle-fin-a-las-mal-llamadas-terapias-de-conversion-una-forma-de-tortura-contra-la-diversidad/>

-Vale K; Johnson T, Jansen M, Lawson K, Lieberman T, Willette K & Wassersug R (2010). The Development of Standards of Care for Individuals with a Male-to-Eunuch Gender Identity Disorder. *International Journal of Transgenderism*, 12:1, 40-51, DOI: [10.1080/15532731003749095](https://doi.org/10.1080/15532731003749095)

-Valencia, S (2010). *Capitalismo Gore*. Barcelona: Melusina.

-Velandia, Manuel (28 de junio de 2022). Reconocimientos líderes LGBTQ+ Colombia, junio 28 de 2022. . [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ctRPb01qfYw&t=197s>

-Verástegui, D (2013). Implicaciones psicosociales de la despatologización de la disforia de género en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/20277/4458618.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

-Verástegui, D (2020). *Psicología Comunitaria y Personas Trans: Construcción de Memoria Comunitaria para la transformación personal, social y política desde el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans -GAAT*. Universidad Nacional de Colombia. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79118/8160815.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

-Vikram G. Mookerjee y Kwan, D (2020) El trasplante de útero como opción de fertilidad en la atención médica transgénero, *International Journal of Transgender Health*, 21:2, 122-124, DOI: [10.1080/15532739.2019.1599764](https://doi.org/10.1080/15532739.2019.1599764)

-Volcánicas. (2021). Inconvertibles: La lucha en contra de las mal llamadas “terapias de conversión” una tortura para las personas LGBTQ+. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://volcanicas.com/inconvertibles-la-lucha-en-contra-de-las-mal-llamadas-terapias-de-conversion-una-tortura-para-las-personas-lgtbiq/>

-Von Doussa, H; Power, J & Riggs, D (2020) Family matters: transgender and gender diverse peoples' experience with family when they transition, *Journal of Family Studies*, 26:2, 272-285, DOI: [10.1080/13229400.2017.1375965](https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1375965)

-Vries; A; Javier, C; Crimston C; Barlow F (2011). *Suppression in Adolescents With Gender Identity Disorder: A Prospective Follow-Up Study*, *The Journal of Sexual Medicine*, Volume 8, Issue 8, Pages 2276-2283, ISSN 1743-6095, <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01943.x>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609515336171>.

- Vries A, Richards C, Tishelman A, Motmans J, Hannema S, Green J &. Rosenthal S (2021) Bell v Tavistock and Portman NHS Foundation Trust [2020] EWHC 3274: Sopesando el conocimiento actual y las incertidumbres en decisiones sobre el tratamiento relacionado con el género para adolescentes transgénero, *International Journal of Transgender Health*, 22:3, 217-224, DOI: [10.1080/26895269.2021.1904330](https://doi.org/10.1080/26895269.2021.1904330)

-Vries, Annelou (2023) Garantizar la atención de los adolescentes transgénero que la necesitan: respuesta a 'Reconsideración del consentimiento informado para niños, adolescentes y adultos jóvenes identificados como trans', *Journal of Sex & Marital Therapy*, 49:1, 108-114, DOI: [10.1080/0092623X.2022.2084479](https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2084479)

-Vrouenraets, L. J. J., de Vries, M. C., Hein, I. M., Arnoldussen, M., Hannema, S. E., & de Vries, A. L. C. (2021). Perceptions on the function of puberty suppression of transgender adolescents who continued or discontinued treatment, their parents, and clinicians. *International journal of transgender health*, 23(4), 428–441. <https://doi.org/10.1080/26895269.2021.1974324>

- Waisman, Lucía M, 'El mito del progreso', *Ars Brevis. Anuario de la Cátedra Ramón Llull Blanquerna*, 20 (2014), 136–67 (p. 150). Disponible en: <https://raco.cat/index.php/ArsBrevis/article/view/295322/383981>

-Walters, Karina; Evans-Campbell, Teresa; Simoni, J; Ronquillo, Theresa & Bhuyan, Rupaleem. (2006) “*Mi espíritu en mi corazón*”, *Journal of Lesbian Studies*, 10:1-2, 125-149 , DOI: [10.1300/J155v10n01_07](https://doi.org/10.1300/J155v10n01_07)

-Wilson, Robert and Wilson, Thelma (1963). "The Fate of the Nontreated Postmeno- pausal Woman: A Plea for the Maintenance of Adequate Estrogen from Puberty to the Grave," *J. Amer. Geriatr. Soc.*, 11: 347-62, quotation on p. 3. Disponible en: DOI: [10.1111/j.1532-5415.1963.tb00068.x](https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1963.tb00068.x)

- Whitley, BE (1990). La relación de las atribuciones de los heterosexuales a las causas de la homosexualidad con las actitudes hacia las lesbianas y los hombres gay. *Boletín de Personalidad y Psicología Social*, 16, 369 – 377. doi: [10.1177/0146167290162016](https://doi.org/10.1177/0146167290162016)

-Zaragocin, S. (2016). Interseccionalidad constituida en el espacio. Boletín # 5 de la Escuela de estudios de género de la Universidad Nacional.

Otros recursos

Informes sobre el estado jurídico de los derechos de las personas trans:

-Departamento Nacional de Planeación. (2021). Situación de las personas trans en Colombia. Recurso [en línea]. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documentos/Investigacion_situacion_de_las_personas_trans_en_Colombia.pdf

-Chiam Z., Duffy S., Gonzalez M., Goodwin L., Mpemba N. (2020). Trans Legal Mapping Report 2019: Recognition before the law (Geneva: ILGA World, 2020). Recurso [en línea]. Disponible en: https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf

Informes sobre el registro de violencias hacia personas trans:

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Una mirada a la violencia contra personas LGBTI. Un registro que documenta actos de violencia. Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014. Recurso [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/Anexo-Registro-Violencia-LGBTI.pdf>

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra Personas Lesbiana, Gay, Bisexuales, Trans e Intersec en América. Recurso [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf>

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf>

-Mena, M. (2021). Los países con más asesinatos de personas trans. Statista. Recurso [en línea]. Disponible en: <https://es.statista.com/grafico/23552/personas-trans-y-genero-diversas-asesinadas-y-paises-con-mas-victimas/>

Anexos

Anexo 1

Consentimiento informado

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.

La presente investigación es conducida por Mariana Velandia Nova, de la Universidad Externado de Colombia. El objetivo de mi proyecto de tesis es *Develar la configuración de los sistemas relacionales e interaccionales en los que emerge las narrativas de las personas transgénero sobre la ciudad de Manizales*.

Si usted accede a participar en este proyecto, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 45 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas. Desde ya le agradezco su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por _____. He sido informado de la meta de este estudio.

En caso de que la persona sea un menor de edad: Yo _____ identificado (a) con el número de cédula _____ en mi facultad de acudiente y responsable de _____ autorizo a que mi hijo sea grabado para estos fines.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Mariana Velandia Nova al teléfono 3017257641.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.

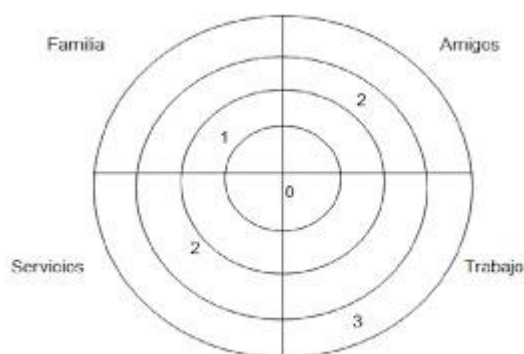
Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha



Anexo 3



Anexo 4

Andar de nuevo

Esto es para padres, madres y cuidadores.

Entiendo que hay un huracán de pensamientos cuando sus hijxs les dicen algo frente a lo cual no están preparadx como se dice “nadie nació aprendido” y yo la verdad no tengo una receta mágica, un az bajo la manga o una solución, sólo voy a esbozar algunas cosas que a mi modo de ver son fundamentales. Deseo que esto sea de ayuda para ustedes.

1. No es el fin del mundo: El proceso de tránsito de género es un momento crucial en la vida de una persona, de acuerdo con la Teoría del Ciclo Vital existen otros momentos de “crisis”: como la conformación de la pareja, independizarse de lxs cuidadores, tener un hijx. El tránsito de género es más bien como una persona que desea gestar un hijx, necesita de ayuda y todos sus sistemas vinculares se modificares, de ese tamaño es la exigencia, pero no por eso debemos tener miedo, su intuición puede marcarles que es un momento de alto respeto por la autonomía de sus hijxs.
2. Ama sin importar qué: Una vez una profesora dijo en clase: lo mejor que le puede pasar a una persona es ser amada. ¿Qué implica el amor? ¿Qué responsabilidad asumimos cuando decimos que amamos? ¿De qué se trata? Aquí sólo pondré algunas cosas que he encontrado sobre el amor. Humberto Maturana es un científico chileno que decía que el amar es dejar que el otro aparezca, esto quiere decir reconocer su existencia; esto implica que la única persona que puede decidir sobre la vida de sus hijxs son ellxs mismos, como cuidadorxs son guías del camino, para que cada unx brille en su propia vida.

Esto también quiere decir que no es importante tratar de diseñar una identidad para tu hijx ni poner expectativas no resueltas en ti, en tu hijx. Esto traerá malestar pata todxs, incluso si tu hijo no pasa por un tránsito de género.

Amar es también validar su voz, no porque sean niñxs o adolescentes debemos “desconfiar” de lo que dicen, por el contrario, debemos poner en altavoces esa sabiduría interna, porque siempre que respetes su opinión cuando sea adulto le será más fácil escucharse a sí mismx y tomar decisiones en la danza de la vida.

3. No todos los procesos de tránsito lucen igual, no todos los procesos de tránsito son binarios, es decir, se proponen bajo la lógica de hombre-mujer y no todos presentan un malestar. Tampoco el tránsito de género es parte de una confusión o un retraso en el desarrollo, es simplemente parte de la vida.
4. Tus hijxs te necesitan: Las personas con las que interactué en este estudio son en su mayoría adolescentes, no te conviertas en el dictadorx de su vida.
5. No estás solx, tienes una sombrilla legal que te protege a ti y a tu hijx, que garantiza tus derechos o que los reestablece en caso de ser vulnerados; es importante poder asesorarte y ampliar tu red, tú también puedes ser acompañadx en esto, no tienes por qué transitarlo solx, en realidad, hay muchas familias que han vivido situaciones similares y que pueden compartir contigo su experiencia. Existen grupo de apoyo a familias como el ofrecido por el GAAT en Bogotá y de manera virtual y también puedes asistir a asesorías en las clínicas de género del país como el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili de manera presencial en Cali o virtual.
6. Recuerda que no todos los tránsitos de género deben cumplir con una serie de requisitos para validar la identidad de tu hijx: no le des una lista de cosas de debe o no hacer porque ahora se identifica como un hombre o como una mujer, mejor será si amplias su libertad y su capacidad de decisión.
7. Uno de los mayores miedos que tienen las personas que experimentan un tránsito de género es el que sus cuidadores y/o familiares no las apoyen, existen preguntas del tipo ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo les hago saber sin que esto signifique que sea rechazadx? Existe un fuerte miedo al rechazo, que en esa situación experimentaría cualquier ser humano, como hemos visto existe una diferencia abismal entre una persona que recibe apoyo y otra que no.